



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1 Perkembangan Kelembagaan Secara Historis (Sejarah)	6
2.2 Visi	6
2.3 Misi	6
2.4 Motto	6
2.5 Nilai Budi Utama	6
2.6 SOTK	7
BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI	8
3.1 SDM	8
3.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi dan Kebutuhan)	8
3.1.2 Orientasi	13
3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	15
3.1.4 Evaluasi Kinerja Staf	19
3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan	19
3.3 Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi	20
3.3.1 Penunjang	20
3.3.1.1 Farmasi	20
3.3.1.2 Radiologi	28
3.3.1.3 Laboratorium	30
3.3.1.4 Rekam Medis	33
3.3.1.5 Gizi	36
3.3.1.6 CSSD – Laundry	38
3.3.1.7 Unit Kamar Jenazah	42
3.3.2 Pelayanan	43
3.3.2.1 IRJA	43
3.3.2.2 IRNA	47
3.3.3 Umum	80
3.3.3.1 Humas – Marketing	80
3.3.3.2 IPSRS	82
3.3.3.3 <i>Cleaning Service</i>	94
3.3.3.4 Gudang	96
3.3.3.5 <i>Security</i>	98
3.3.3.6 Asuransi Center	102
3.3.3.7 PIPP	104
3.3.3.8 IT-SIMRS	108
3.3.3.9 Keuangan	108
3.3.4 Program Nasional (PROGNAS)	111
3.4 Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3	152
3.4.1 Fasilitas Kesehatan	152
3.4.2 Gedung dan Bangunan	163
3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	168
3.5 Kinerja Produktifitas Komite Mutu	171
3.5.1 Mutu Nasional	171
3.5.2 Mutu Prioritas Rumah Sakit	207
3.5.2.1 Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	203
3.5.2.2 Mutu Pelayanan Klinis Prioritas	207
3.5.2.3 Mutu terkait Tujuan Strategis Rumah Sakit	233
3.5.2.4 Mutu terkait Perbaikan Sistem	234

3.5.2.5 Mutu terkait Manajemen Resiko.....	258
3.5.3 . Mutu prioritas Internal Unit.....	260
3.6 Kinerja Produktifitas Komite PPI	277
3.7 Kinerja Produktifitas Tim PKRS.....	287
3.9 Kinerja Produktifitas Produktifitas Komite Farmasi Terapi	288
3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA	301
3.13 Kinerja Produktifitas Komite Medis.....	310
3.14 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kesehatan Lain	312
BAB IV KINERJA KEUANGAN.....	313
4.1 Pendapatan Tahun 2024 (Tarif RS)	313
4.2 Biaya Tahun 2024	314
4.3 Rasio Keuangan	314
4.4 Kinerja Piutang.....	314
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	316
BAB VI PENUTUP.....	317
LAMPIRAN.....	318

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rumah sakit harus mengacu pada prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi.

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus berlandaskan peraturan dan undang undang yang berlaku, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perumahan sakitan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
3. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit

-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Rumah Sakit Prima Husada Malang tahun 2024 adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Perkembangan Kelembagaan Secara Historis (Sejarah)

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	Akreditasi Paripurna
Desember 2022	Akreditasi Paripurna

2.2. Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.3. Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.4. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.5. 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.6. SOTK



BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL
YANG DICAPAI

3.1 SDM

3.1.1 Ketenagaan

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DES
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Farmasi	S1 Apoteker	11	11	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
		S1 Farmasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Farmasi	17	17	21	21	21	21	21	16	16	16	19	19
		SMK	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	3	3
		S1 Akuntansi	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		SMK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	CSSD	D3 Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
		D3 Farmasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMK	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
		D3 Terapi Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		D4 Terapi Wicara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		D4 Ahli Gizi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		D3 Ahli Gizi	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		SMK	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		SMA	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

		SMP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Humas & Marketng	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	8	7	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4
		D3 Keperawatan	7	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
15	IGD	Profesi Ners	8	8	10	10	10	10	10	11	11	11	10	11
		Profesi Kebidanan	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		D3 Keperawatan	9	10	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10
		D4 Kebidanan	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
		D4 Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		D3 Kebidanan	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2
16	IKO	Profesi Ners	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		D3 Keperawatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	IPSRS	S1 Tenik Elektro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Teknik Elektromedis	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	IRJA	Profesi Ners	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		D3 Keperawatan	13	13	13	13	13	13	13	16	16	16	15	15
		Profesi Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		D4 Perawat Gigi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Kebidanan	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
20	IRNA 2C	Profesi Ners	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4
		D4 Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		D3 Keperawatan	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	9	9	9	9	9	9	9	16	16	16	16	16
		D3 Keperawatan	9	9	9	9	9	9	9	4	4	4	4	4
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
		D4 Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Keperawatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		D3 Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
		D4 Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

		D3 Keperawatan	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
		D4 Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4
		D3 Keperawatan	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
		D4 Kebidanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		D3 Kebidanan	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
26	Neonatologi	Profesi Ners	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
		D3 Keperawatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		D3 Kebidanan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		S1 Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
		S1 Fisika	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		S1 Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	1
		SMK	4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	1	3
		SMA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
		D3 Analisis Kesehatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
29	Laundry	SMK	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
		SMA	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
		SMP	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S1 Ilmu Sosial	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		S1 Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		D4 Manajemen	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		D4 Destinasi Wisata	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		D3 Asuransi Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		SMK	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
		SMA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
		D4 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
		D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

33	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Cleaning Service	SMK	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25
		SMA	5	5	5	5	5	5	5	9	9	9	9	15
		SMP	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	15
40	Security	SMK	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
		SMA	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		SMP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
48	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
49	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4
50	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
51	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

52	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
53	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
56	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
57	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
58	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
59	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
60	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total			423	421	433	433	433	433	433	456	456	458	454	469

3.1.2 Orientasi

Pada tahun 2024 terdapat sebanyak **48 staf** yang mengikuti orientasi.

NO	NAMA	UNIT	PROFESI	TMT	AWAL ORIENTASI UNIT	AKHIR ORIENTASI UNIT
1	Haris Fadilah, Amd. Kep	IRNA 3A & 4A	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
2	Renata Devisa Ramadhani, Amd. Kep	IRNA 3A & 4A	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
3	Neneng Aprilia Pangestuti, A.Md.Kep	IRNA 3A & 4A	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
4	Arnanda Nuryunita, Amd. Kep	IRNA 5C	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
5	Lennisyah Yulia Artha, Amd. Kep	IRNA 6A & 7A	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
6	Rini Mukti Andini, S. Kep., ns	IRNA 6A & 7A	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
7	Agustina Kusuma Wardani, S. Tr. Keb	Maternitas	Bidan	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
8	Adhita Krisna Prastiti, S. Tr. Keb., Bdn.	Maternitas	Bidan	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
9	Rizky Dinda Maulidya, Amd. Kep	Neonatologi	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
10	Susanti, S.Farm.,Apt	Farmasi	Apoteker	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
11	Amaliya Nur Shafa Adityani, Amd. Farm	Farmasi	TTK	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
12	Sherlina Ahmalia, Amd. Farm	Farmasi	TTK	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
13	Elzada Sofi Ananda, Amd. Kes	Rekam Medis	Perekam Medis	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
14	Naufal Basyasyah Brayoga	Umum Cleaning Service	Umum	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
15	Maulana R S	Umum Cleaning Service	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
16	Rizki Maulana Oktavinanta	Umum Cleaning Service	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
17	Yoga Kurniawan	Umum Cleaning Service	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024

18	Salma Gita Pramesti, A.Md.T.	IPSRS	ATEM	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
19	Usamah Al Idhar Mukhdor	Security	Umum	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
20	Devi Kartika Sari, Amd.Kep	IRJA	Perawat	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
21	Nurul Azizah Jihad Fisabillillah, S.Tr.Keb, Bdn.	IRJA	Bidan	Selasa, 23 Januari 2024	Selasa, 23 Januari 2024	Senin, 22 April 2024
22	Dita Ariesa Putri Prajoko, S.Farm., Apt.	Farmasi	Apoteker	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
23	Noviati Ayu Utami Dewi, Amd.Farm.	Farmasi	TTK	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
24	Achmad Nur Rochman, Amd.Farm	Farmasi	TTK	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
25	Salma Taris Maf'ula	Laundry	Umum	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
26	Nuril Hidayati	Umum Cleaning Service	Umum	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
27	Putri Wahyuning Gusti	Umum Cleaning Service	Umum	Sabtu, 02 Maret 2024	Sabtu, 02 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
28	Irna Ismawati	Umum Cleaning Service	Umum	Minggu, 03 Maret 2024	Minggu, 03 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
29	Yudha Eka Setiyawan	Security	Umum	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 01 Maret 2024	Jumat, 31 Mei 2024
30	Aulia Rahmatul Amani, A.Md.Kep	IRNA 5C	Perawat	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
31	Niken Eka Lidiani, A.Md.Farm	Farmasi	TTK	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
32	Mayputri Nabila, A.Md.Kes	Rekam Medis	Perekam Medis	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
33	Dea Rira Panduwinata, A.Md.Aktr	Pendaftaran	Umum	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
34	Yeni Khikmatus Sholikhak, A.Md.Aktr	Pendaftaran	Umum	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
35	Maharani Juwita Zhalsabilla, S.Tr.Par	Pendaftaran	Umum	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
36	Lola Novira Risdiyanti, A.Md.Kep	CSSD	Perawat	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
37	Hamzah Zulfikar Jonas	Laundry	Umum	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
38	Anistya Pebryani Widoastoro, S.Ak	Keuangan & Akuntansi	Umum	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024

39	Rifky Eka Prasetya	Umum Cleaning Service	Umum	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
40	Muhammad Riza Kurniawan	Umum Cleaning Service	Umum	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 01 Mei 2024	Rabu, 31 Juli 2024
41	Yanti	Gizi (Penyaji)	Umum	Senin, 01 Juli 2024	Senin, 01 Juli 2024	Senin, 30 September 2024
42	Amalia Lusyanti, A.Md.Fis	Rehab Medik	Fisioterapis	Senin, 29 Juli 2024	Senin, 29 Juli 2024	Senin, 28 Oktober 2024
43	Bdn. Deya Nahdah Amany, S.Keb	Maternitas	Bidan	Kamis, 01 Agustus 2024	Kamis, 01 Agustus 2024	Kamis, 31 Oktober 2024
44	apt, Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm	Farmasi	Apoteker	Kamis, 01 Agustus 2024	Kamis, 01 Agustus 2024	Kamis, 31 Oktober 2024
45	Irwindi Neila Fitria, S.Tr.Kes	Rehab Medik	Terapis Wicara	Selasa, 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024	Senin, 16 Desember 2024
46	Davit Krisdianto	Umum Cleaning Service	Umum	Selasa, 01 Oktober 2024	Selasa, 01 Oktober 2024	Selasa, 31 Desember 2024
47	Dimas Guntur Sujud	Umum Cleaning Service	Umum	Jumat, 01 November 2024	Jumat, 01 November 2024	Rabu, 31 Januari 2024
48	Renaldi Salsabila, A.Md.Rad	Radiologi	Radiografer	Senin, 09 Desember 2024	Senin, 09 Desember 2024	Sabtu, 08 Maret 2025

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO	JENIS KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan	Rapat Penentuan Diklat	Manajemen	Terlaksana
		Pengajuan Diklat ke Direktur RS	Manajemen	Terlaksana
		Pengajuan Diklat ke Direktur PT	Manajemen	Terlaksana
DIKLAT INTERNAL				
		PPI Dasar	Semua Staf	Terlaksana
		CSSD	Staf CSSD	Terlaksana
		Triage	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
		Kriteria Keluar Masuk ICU	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
		Transfer dan Rujukan	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
		Hak Pasien dan Keluarga	Semua Staf	Terlaksana

	Komunikasi Efektif	Semua Staf	Terlaksana
	Komunikasi Efektif untuk PPA	PPA	Terlaksana
	Manajemen Pasien menjelang Akhir Kehidupan	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Pengelolaan darah dan pemberian transfusi darah	Laboratorium, Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	BHD	Semua staf	Terlaksana
	BHD lanjutan	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	EWS	Perawat dan Bidan	Terlaksana
	Manajemen risiko jatuh	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Manajemen restrain	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	PMKP	Semua staf	Terlaksana
	PMKP untuk pulpa	Pulpa	Terlaksana
	Pemasangan dan Pelepasan infus	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Pemasangan dan Pelepasan Kateter	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Perawatan Luka	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Pemasangan NGT & OGT	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Hecting	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Manajemen Bencana	Semua Staf	Terlaksana
	PPK, CP, Rencana Asuhan	Dokter, Apoteker, Gizi, Perawat dan Bidan	Terlaksana
	Identifikasi Pasien	Semua Staf	Terlaksana
	Keselamatan pasien operasi	Dokter, Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana
	Medication Error	Apoteker, TTK, Perawat dan Bidan	Terlaksana
	Teknik aseptik sedasi	Apoteker, TTK, Perawat dan Bidan	Terlaksana
	PPRA	Apoteker, TTK, Perawat dan Bidan	Terlaksana
	Pelatihan pemberian sedasi	Perawat dan Bidan	Tidak terlaksana

		Pelatihan koding	Rekam Medis	Tidak terlaksana
		Pelatihan E-RM	PPA	Terlaksana
		Pelatihan PONEK	Bidan dan Perawat PONEK	Terlaksana
		Pelatihan Down Time	IT dan PPA	Tidak terlaksana
		Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Pangan	Gizi dan Dapur	Tidak terlaksana
		Manajemen Fasilitas dan Keamanan	Seluruh Staf	Terlaksana
DIKLAT EKSTERNAL				
		PPGDON	Bidan	Terlaksana
		BTCLS	Perawat	Tidak terlaksana
		ACLS	Dokter	Tidak terlaksana
		ESQ	Semua Staf Baru	Terlaksana
		Phlebotomi	Analisis Kesehatan	Tidak terlaksana
		ICU Dasar	Perawat ICU	
		Manajemen Bangsal	Kepala Ruang	Tidak terlaksana
		NICU	Perawat	Terlaksana
		Instrumen	Perawat	Tidak terlaksana
		Teknis Kelistrikan RS	Staf IPSRS	Tidak terlaksana
		Teknis Bangunan RS	Staf IPSRS	Tidak terlaksana
		Teknis tata kelola udara RS	Staf IPSRS	Tidak terlaksana
		Preceptorship	Kepala Ruang	Tidak terlaksana
		APN	Bidan	Tidak terlaksana
		CTU	Bidan	Tidak terlaksana
		MU	Bidan	Tidak terlaksana
		CWCC	Perawat poli bedah	Tidak terlaksana
		Pelatihan dispensing	Apoteker	Tidak terlaksana
		Resusitasi Neonatus	Perawat	Terlaksana
		Perawatan Bayi BBLR	Perawat	Terlaksana
		Instrumen Kamar Bedah	Perawat IKO	Tidak terlaksana
		MPP	Perawat	Tidak terlaksana
		PICU	Perawat	Terlaksana
		HCU	Perawat	Terlaksana
		Manajemen Kamar Operasi	Kepala Ruang Kamar Operasi	Tidak terlaksana

		Pelatihan Hygiene sanitasi bagi penjamah makanan	Gizi (Dapur)	Tidak terlaksana
		Pelatihan Eksternal Coding bagi tenaga koder Rumah Sakit pada program JKN	Perekam Medis	Terlaksana
		Pelatihan internal Coding bagi tenaga koder Rumah Sakit pada program JKN	Perekam Medis	Tidak terlaksana
		Diklat Strategi Marketing Rumah Sakit	Humas Marketing	Tidak terlaksana
		Pelatihan Teknis Ke Rumah Sakitan	IPSRS	Tidak terlaksana
		Pelatihan Teknis Bangunan dan Gedung		Tidak terlaksana
		Pelatihan Kelistrikan		Tidak terlaksana
		Pelatihan Utilitas dan Pendukung		Tidak terlaksana
		Pelatihan K3RS		Tidak terlaksana
		Pelatihan Kesehatan Lingkungan		Tidak terlaksana
		Seminar & Workshop Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan	Tidak terlaksana
		Seminar & Workshop Penanganan Limbah	Kesehatan Lingkungan	Tidak terlaksana
		Pelatihan handle komplain	PIPP	Tidak terlaksana
		Pelatihan manajemen Cleaning Service Rumah Sakit	Cleaning Service	Tidak terlaksana
Kesehatan & Keselamatan Staf				
		Pemeriksaan kesehatan staf baru	Seluruh Staf	Terlaksana
		Pemeriksaan kesehatan berkala	Seluruh Staf	Terlaksana

3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf

3.1.4.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan Tahun 2024



Analisa :
Evaluasi Kinerja karyawan mengalami progress kenaikan yang baik semenjak awal tahun hingga akhir tahun. Kategori Cukup dan Baik berubah menjadi Sangat Baik

3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN
BIDANG UMUM KEUANGAN		
1.	Humas Marketing	1. Meningkatkan kunjungan MCU 2. Bayi baru lahir gratis Baby Spa 3. Meningkatkan digital marketing (promosi di sosial media)
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN		
1.	IRJA	1. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien Poliklinik Sakura 2. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien Poli Pedodontis (Kedokteran Gigi Anak)
2.	IRNA	Pembuatan <i>playground</i>
3.	Foto Aesthetic Bayi	Meningkatkan kualitas foto Aesthetic Bayi
BIDANG PENUNJANG		
1.	Farmasi	1. Pengembangan website PRIMANTARA dengan menggunakan vendor 2. Pengembangan KPO Elektronik (e-KPO) 3. Pembangunan ruang LAF
2.	Pendaftaran	Mengaplikasikan Anjungan Pasien Mandiri
3.	Laboratorium	Pengembangan BDRS
4.	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan 2. Pengembangan Prima Healthy Meal
5.	CSSD - Laundry	1. Mengajukan mesin sterilitator (steam plasma) 2. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg. 3. Membuat digital form untuk permintaan linen

3 Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi

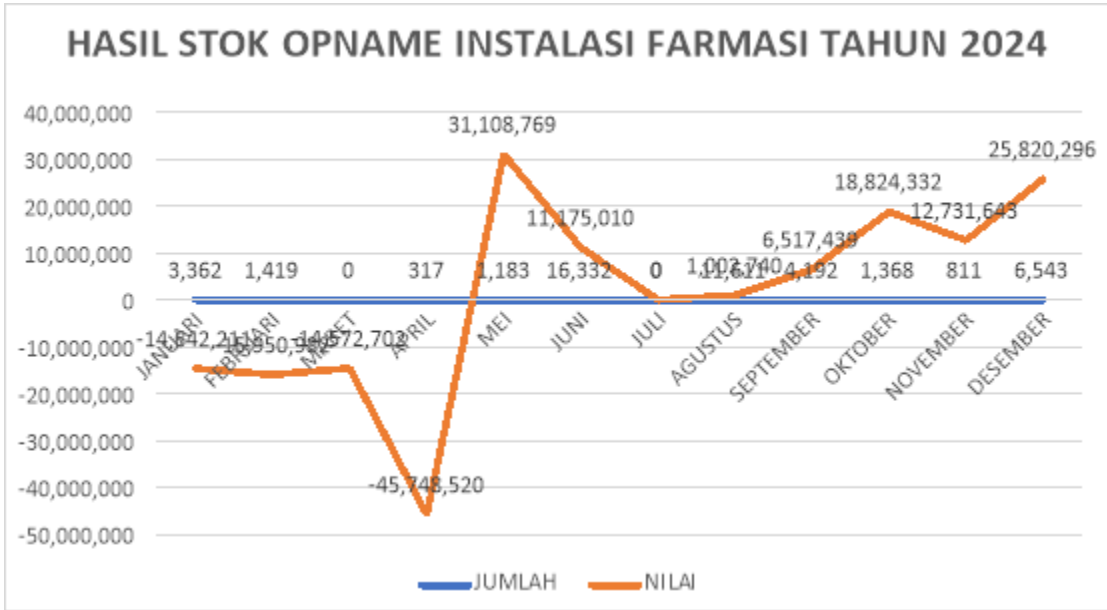
3.3.1 Penunjang

3.3.1.2 Farmasi

3.3.1.2.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Selama Tahun 2024

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN											
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	735.600	2.561.629.453	679.804	2.240.257.442	710.923	2.236.456.285	827.695	2.636.209.307	996.346	2.798.211.553	819.115	2.593.871.439
	SISTEM	733.878	2.556.135.842	680.965	2.241.669.310	710.525	2.239.403.929	827.596	2.636.251.350	996.419	2.797.062.885	827.882	2.613.227.305
	SELISIH	1.722	+5.493.612	-1.161	-1.411.868	398	-2.947.644	99	-42.044	73	+1.148.668	8.767	-11.866
DEPO FARMASI	FISIK	133.141	510.663.309	147.755	522.406.860	159.192	542.617.009	151.747	572.037.503	161.916	588.267.127	136.177	513.147.816
	SISTEM	137.472	532.085.951	147.868	539.693.830	158.781	554.695.835	151.756	599.325.620	162.503	561.320.647	129.153	493.659.843
	SELISIH	4.331	-21.422.639	113	-17.286.966	411,00	-12.078.825	9	-27.288.109	541	26.946.480	7.024	+19.487.974
IKO	FISIK	2.301	98.223.311	2.054	80.248.129	2.280	91.906.359	2.340	79.752.911	2.398	91.503.256	1.733	77.805.982
	SISTEM	2.968	96.829.013	2.199	77.500.275	2.344	91.422.514	2.598	97.779.672	2.602	88.033.712	2.017	85.864.060
	SELISIH	667	+1.394.300	145	+2.747.852	64	+483.846	258	-18.026.757	200	3.469.544	284	-8.058.077
GUDANG RETURE	FISIK	0	0	0	0	0	0	0	0	102	87.437	0	0
	SISTEM	86	107.484	0	0	50	30.086	149	391.610	471	543.360	257	243.021
	SELISIH	86	-107.484	0	0	50	-30.086	149	-391.610	369	-455.923	257	-243.021
TOTAL SELISIH		3.362	-14.642.211	1.419	-15.950.982	0	-14.572.702	317	-45.748.520	1.183	+31.108.769	16.332	+11.175.010
UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN											
		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	0	0	732.380	2.267.670.139	733.807	2.350.377.739	807.380	2.420.406.240	717.819	1.984.154.958	983.735	2.518.895.161
	SISTEM	0	0	732.927	2.285.414.509	734.059	2.350.612.541	807.236	2.411.603.005	717.782	1.984.197.437	983.726	2.518.670.283
	SELISIH	0	0	547	-17.744.369	-252	-234.802	144	+8.803.236	37	-42.479	9	+224.878
DEPO FARMASI	FISIK	0	0	147.379	519.778.015	141.256	513.820.725	144.667	497.691.225	142.908	492.912.632	156.369	509.482.707
	SISTEM	0	0	136.326	510.064.361	136.874	508.681.432	143.338	491.060.927	142.238	486.169.397	149.849	485.639.487
	SELISIH	0	0	11.053	+9.713.656	4.382	+5.139.293	1.331	+6.630.304	670	+6.743.243	6.520	+23.843.225
IKO	FISIK	0	0	2.479	111.929.273	2.275	99.246.881	2.304	104.523.149	2.455	99.561.444	1.876	81.525.792
	SISTEM	0	0	2.490	102.895.820	2.213	97.633.933	2.411	101.132.358	2.351	93.530.564	1.862	79.773.599
	SELISIH	0	0	11	+9.033.453	62	+1.612.948	107	+ 3.390.792	104	+6.030.879	14	+1.752.193
GUDANG RETURE	FISIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SISTEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SELISIH		0	0	11.611	+1.002.740	4.192	+6.517.439	1.368	+18.824.332	811	+12.731.643	6.543	+25.820.296

3.3.1.2.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Selama Tahun 2024



Analisis dan Tindakanlanjut :

Selisih stok opname farmasi selama tahun 2024 mengalami fluktuatif dari segi jumlah persediaan dan nominal selisih.
Namun, ada perbaikan dalam 6 bulan terakhir, tidak ditemukan selisih negatif.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan alur serta system stok opname, perubahan alur floorstok IKO dan masih ada human error.

Berikut analisisnya :

NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
GUDANG FARMASI		
1.	Beberapa faktor yang menyebabkan selisih kurang adalah sbb ; 1. Terdapat barang yang muncul di Rak Kerja SIMRS sedangkan barang tersebut tidak ada di daftar master barang. 2. Petugas tidak melakukan release pada system ketika barang sudah diberikan kepada unit. 3. Terdapat jumlah isi satuan master barang yang berubah. Contoh : awalnya master dengan kode barang F04155 isi satuannya adalah 25. Kemudian pada tanggal 12/06/2024, barang datang dengan kemasan yang berubah menjadi isi satuan 100. Sehingga dilakukan input penerimaan dengan penyesuaian master barang, yang awalnya 31 box isi satuan 100 disesuaikan menjadi 124 box isi satuan 25. Pada tanggal 13/06/2024 dilakukan permintaan update master barang isi satuan menjadi 100, dan sudah dirubah oleh programmer pada tanggal 13/06/2024. Akan tetapi jumlah penerimaan di hari sebelumnya berubah kembali menjadi isi	1. Memperbaiki alur serah terima barang dengan unit. 2. Programmer membuat untuk update isi satuan pada master barang agar transaksi sebelumnya di lock, sehingga tidak ada pergerakan data.

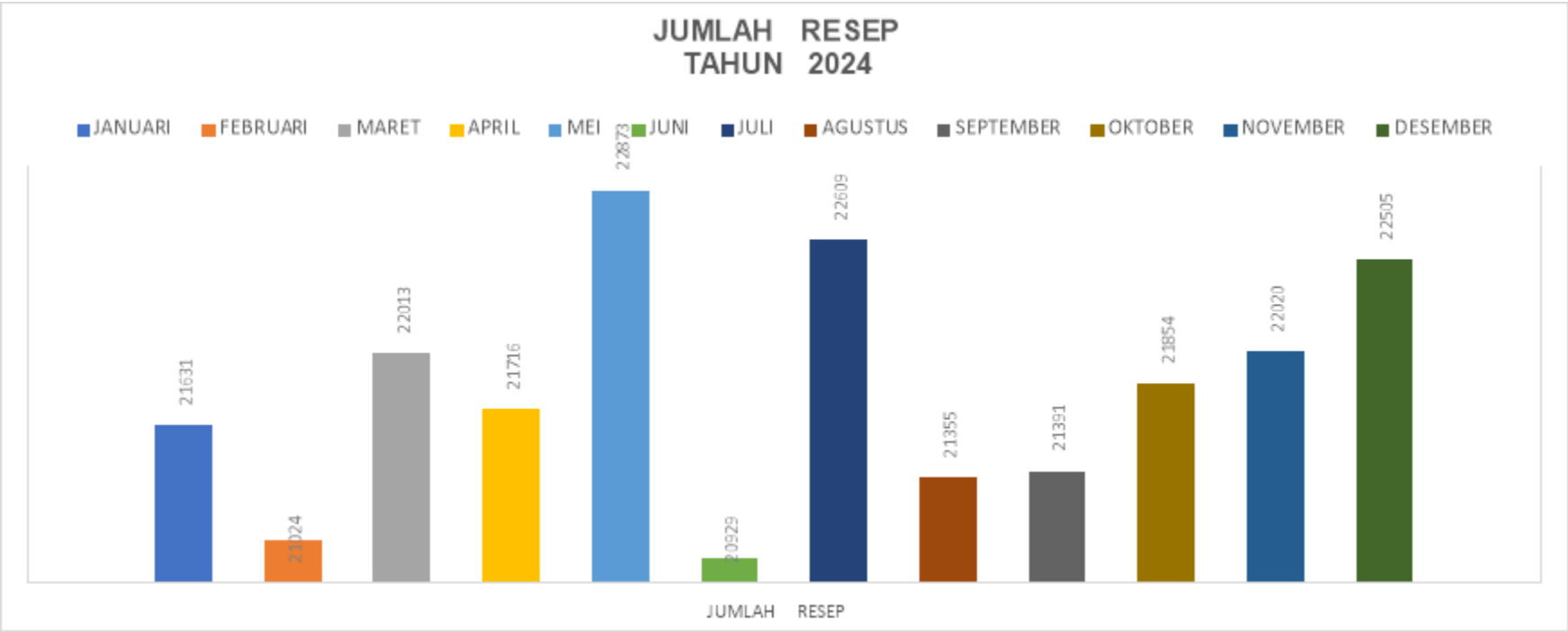
	satuan 100, yang seharusnya isi satuannya adalah 25. 4. Serah terima barang antar unit tidak berjalan dengan baik.	
2.	Beberapa factor yang menyebabkan selisih lebih adalah sbb ; Sistem mengalami error. 1. Sistem mengalami error. Contoh : Master barang di Gudang Farmasi diinputkan sejumlah sesuai fisik tetapi hasil adjustment menampilkan nominal yang tidak sesuai dengan inputan ketika stok opname sehingga berakibat selisih lebih pada bulan selanjutnya. Kasus tersebut ditemui pada Bulan Oktober 2024. 2. Terdapat barang reture dari unit yang tidak dilakukan penerimaan pada system. 3. Petugas terlewat hitung jumlah fisik saat mengisi lembar kerja karena penataan barang di Gudang Farmasi kurang rapi. 4. Permintaan BMHP yang sudah disiapkan oleh Gudang Farmasi tidak diambil oleh unit dan tidak dilakukan penerimaan pada system.	1. Menjalakan scan barcode dan RFID untuk pemasukan dan pengeluaran barang secara sistem elektronik. 2. Serah terima barang unit setiap waktu yang ditentukan, jika tidak diambil maka segera lakukan reture H+1. 3. Melakukan penataan rak menggunakan mika dan sekat untuk memisahkan barang per ukuran dan merk.
DEPO FARMASI		
1.	Ditemukan penyebab selisih karena adanya barang yang sama tetapi beda master barang. Contoh : - F01403 gelang pasien biru dewasa – one med dan F01405 gelang pasien dewasa biru di rak alkes (dinonaktifkan salah satu). - F02329 kasa hydrofil steril ukuran 16x16 dan F01529 kasa steril 16x16 cm – nasaco (dalam lembar kerja system), namun Kode F01529 di master barang : Sterimar Baby Spray (non aktif).	1. Menertibkan penulisan kartu stok. 2. Melakukan pendataan untuk item yang selalu muncul selisih pada beberapa bulan stok opname dan melakukan random stok setiap harinya. 3. Perbaiki prosedur inputan resep dari ruangan sesuai master barang dan jumlah yang akan digunakan.
2.	Ditemukan selisih stok yang sangat tinggi di Depo Farmasi, hal ini disebabkan juga oleh : - Inputan resep dan yang digunakan tidak sesuai. Selisih lebih di Depo Farmasi dikarenakan retur barang dari ruangan yang masih belum ada inputan di SIMRS. - Inputan sharing dose dan paket partus. Contoh : Phytomenadion inj diinput 1 amp di SIMRS, namun disuntikkan sharing dose untuk 2 pasien. Saat paket dikembalikan ke Farmasi tidak dilakukan retur penjualan. Paket sc, kuret, dan paket partus retur barang dijadikan satu dalam 1 box sehingga farmasi tidak bisa melakukan telusur pencocokan retur penjualan (SIMRS). - IGD masih sering permintaan resep manual dan belum ada inputan resep di SIMRS.	1. Melakukan penulisan resep manual 2 ply oleh perawat IGD untuk saling cek antara resep dengan inputan. Jika resep belum terinput, maka resep akan dishare oleh petugas farmasi di Grup, perawat IGD wajib mengirimkan bukti inputan di SIMRS. 2. Perbaiki prosedur retur barang yang tidak terinput di sistem maka Karu wajib membuat berita acara yang diketahui oleh Kabid Keperawatan kemudian diserahkan ke Kains untuk dilakukan penerimaan barang. Retur barang ke depo farmasi wajib sesuai di hari yang sama dengan inputan retur penjualan.

		Hal ini dilakukan sebagai bukti ketidakpatuhan perawat dalam melakukan retur obat. 3. Pemakaian sharing dose di rawat inap dihilangkan. Perawat input dan menggunakan barang sesuai yang diinput, jika ada sisa maka stok dibuang. 4. Bidan wajib retur paket per box sesuai nama pasien (box diberi nama pasien) agar farmasi bisa cek sesuai inputan retur penjualan di SIMRS.
3.	Rak system dan rak kerja tidak sesuai.	1. Dilakukan centralisasi master barang oleh PT. 2. Koordinasi antara Kains dan Keuangan untuk update rak dan kertas kerja.
FLOORSTOK IKO		
1.	Telusur selisih sharing dose dengan progamer, ditemukan inputan sharing dose yang berjalan saat ini adalah pembulatan, sedangkan yang dilakukan oleh IFRS PHM adalah sesuai dengan sisa stok desimal (tertera pada tabel pemakaian), sehingga menimbulkan selisih SO.	1. Melakukan diskusi dengan Kabid dan Keuangan PT selaku tim audit stok opname untuk menyelesaikan permasalahan terkait selisih stok opname dan floorstok IKO. 2. Kesepakatan dengan programmer terkait input sharing dose dilakukan pembulatan. Jika saat stok opname ada sisa stok maka dimusnahkan dan stok disimrs diinput ke pasien. 3. Penginputan sharing dose disesuaikan dengan tabel penggunaan obat anastesi di IKO.
2.	Terdapat ketidaksesuaian rak kertas kerja dengan SIMRS, sehingga stok tidak diinput ketika stok opname.	Koordinasi antara Kains dan Keuangan untuk update rak dan kertas kerja
3.	Ditemukan barang sisa operasi yang masih utuh di Ruang Operasi tetapi tidak dilakukan retur penjualan. Hal ini disebabkan pemakaian tidak sesuai dengan inputan.	Melakukan reture barang per nama pasien, dbantu oleh admin IKO untuk input pada system.
4.	Alur yang kurang sesuai. Contoh : Petugas IKO mengambil stok terlebih dahulu, dilakukan penginputan diakhir operasi, hal ini menyebabkan inputan tidak real.	1. Perbaiki alur, input permintaan resep terlebih dahulu sebelum mengambil barang. 2. Menerapkan SE yang ditetapkan oleh PT terkait beban selisih SO.
GUDANG RETUR		
1.	Selisih juga terjadi pada Gudang Retur Farmasi karena Gudang sudah melakukan input penerimaan retur sesuai jumlah resep obat tertinggal tetapi petugas kurang realese stok pada Gudang Retur ke Depo Farmasi sehingga terdeteksi selisih ketika stok opname, sisa stok di monitoring stok Gudang Retur Farmasi muncul angka minus karena adanya adjustment stok hasil centralisasi master barang di Bulan Juli 2024.	Perbaiki alur retur barang, setelah barang diterima maka diinputkan penerimaan lain-lain dan dilakukan release ke Depo Farmasi. Sudah ada perbaikan, tidak ada selisih sejak Bulan Agustus 2024-Desember 2024.

3.3.1.2.3 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Tahun 2024

UNIT	JUMLAH RESEP																							
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC	RC	NRC
IRNA	203	7340	266	7764	230	8351	246	8108	292	8528	249	7744	188	8187	195	7484	265	8036	229	7705	263	7918	253	8481
IRJA	2159	9570	1909	8853	2011	8851	2007	8717	2012	9406	1895	8782	2115	9891	2170	9397	2081	8804	2282	9123	2204	8879	2.073	8797
IKO	0	445	0	426	0	408	0	394	0	480	0	443	0	468	0	446	0	458	0	663	0	825	0	810
IGD	116	1798	127	1679	220	1942	257	1987	195	1960	152	1664	107	1653	86	1577	89	1658	107	1745	107	1824	121	1970
TOTAL	21631		21024		22013		21716		22873		20929		22609		21355		21391		21854		22020		22505	

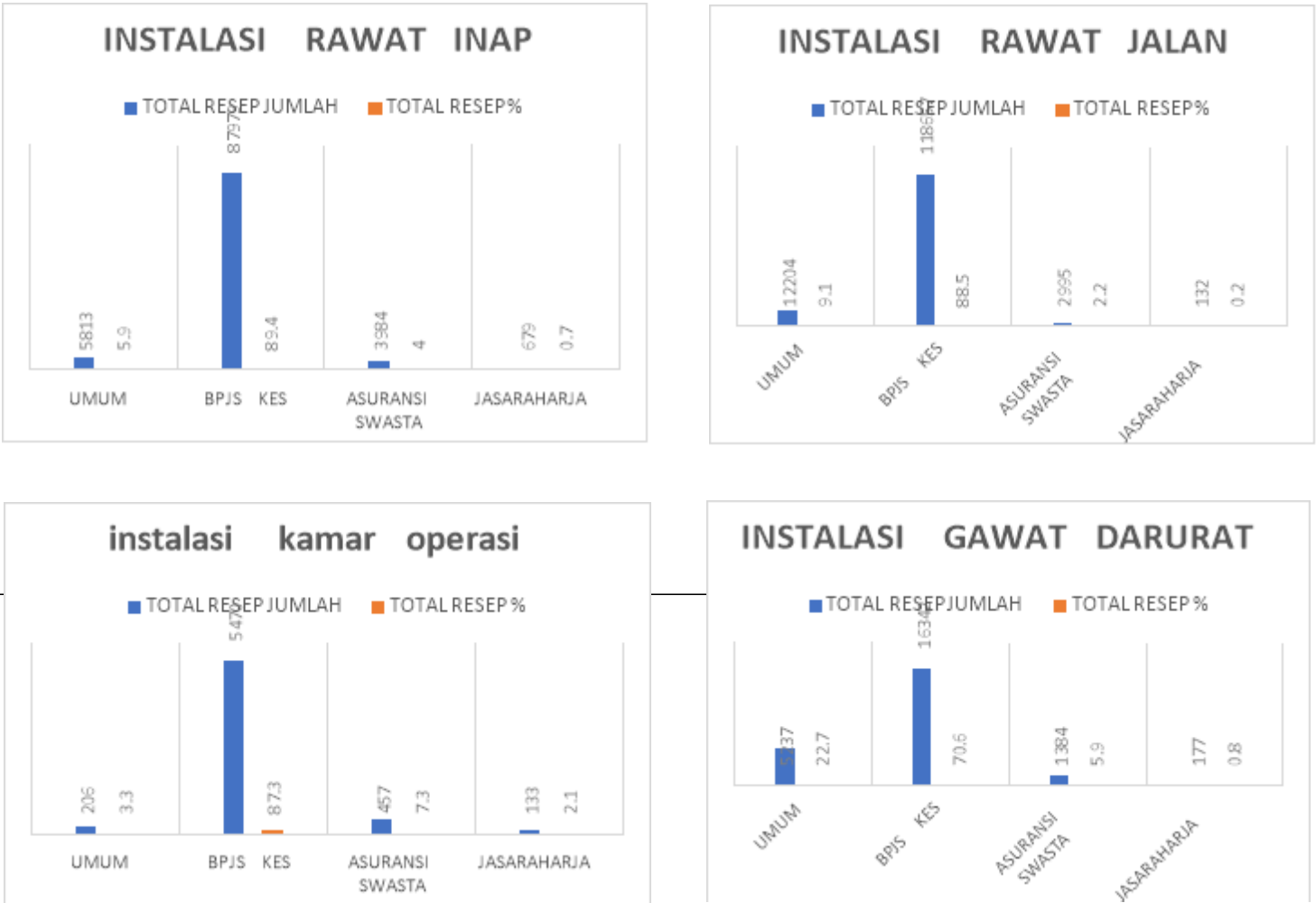
3.3.1.2.4 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Tahun 2024



3.3.1.2.5 Tabel Pelayanan Resep Berdasarkan Jaminan selama Tahun 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN KE-												TOTAL		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH	%	TOTAL RESEP
1.	IRNA	UMUM	377	325	489	396	902	384	667	517	413	358	384	601	5813	5,9	98455
		BPJS KES	6801	7402	7677	7520	7529	7198	7301	6701	7411	7180	7459	7800	87979	89,4	
		ASURANSI SWASTA	295	262	361	362	337	302	360	344	402	352	306	301	3984	4,0	
		JASARAHARJA	70	41	54	76	52	109	47	117	75	44	32	32	679	0,7	
2.	IRJA	UMUM	1008	789	953	988	705	964	1093	1220	1061	1126	1110	1187	12204	9,1	133988
		BPJS KES	10495	9749	9649	9485	10414	9457	10610	10084	9560	10009	9726	9419	118657	88,5	
		ASURANSI SWASTA	221	220	244	237	291	246	287	242	250	256	243	258	2995	2,2	
		JASARAHARJA	5	4	16	14	8	10	16	21	14	14	4	6	132	0,2	
3.	IKO	UMUM	13	6	19	6	17	15	25	25	12	14	30	24	206	3,3	6266
		BPJS KES	398	384	345	343	435	374	406	387	400	571	714	713	5470	87,3	
		ASURANSI SWASTA	25	26	30	31	26	33	33	23	37	68	69	56	457	7,3	
		JASARAHARJA	9	10	14	14	2	21	4	11	9	10	12	17	133	2,1	
4.	IGD	UMUM	377	338	400	441	492	462	389	440	439	431	441	587	5237	22,7	23140
		BPJS KES	1422	1368	1622	1689	1532	1197	1237	1099	1183	1268	1338	1387	16342	70,6	
		ASURANSI SWASTA	99	89	117	96	115	133	124	107	114	141	143	107	1384	5,9	
		JASARAHARJA	16	11	23	18	16	24	10	17	11	12	9	10	177	0,8	

3.3.1.2.6 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Selama Tahun 2024



3.3.1.2.7 Tabel Analisa dan Tindakanlanjut Pelayanan Resep Selama Tahun 2024

NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Dari data pelayanan resep selama tahun 2024, diketahui bahwa jumlah resep fluktuatif berbanding lurus dengan jumlah kunjungan pasien per bulannya.	- Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di social media RS agar kunjungan pasien meningkat. - Kolaborasi dengan Humas & Marketing dan PKRS.
2.	Selama tahun 2024, jumlah resep paling banyak yaitu : - Bulan Mei 2024 sebanyak 22.873 resep. - Bulan Agustus 2024 sebanyak 22.609 resep. - Bulan Desember 2024 sebanyak 22.505 resep. Hal ini disebabkan jumlah hari aktif lebih banyak dibanding bulan lainnya dan berbanding lurus dengan jumlah kunjungan.	- Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
3.	Jumlah pelayanan resep selama tahun 2024 masih didominasi oleh pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan, diikuti dengan	- Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran IGD untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan Kesehatan lebih dari 1 untuk

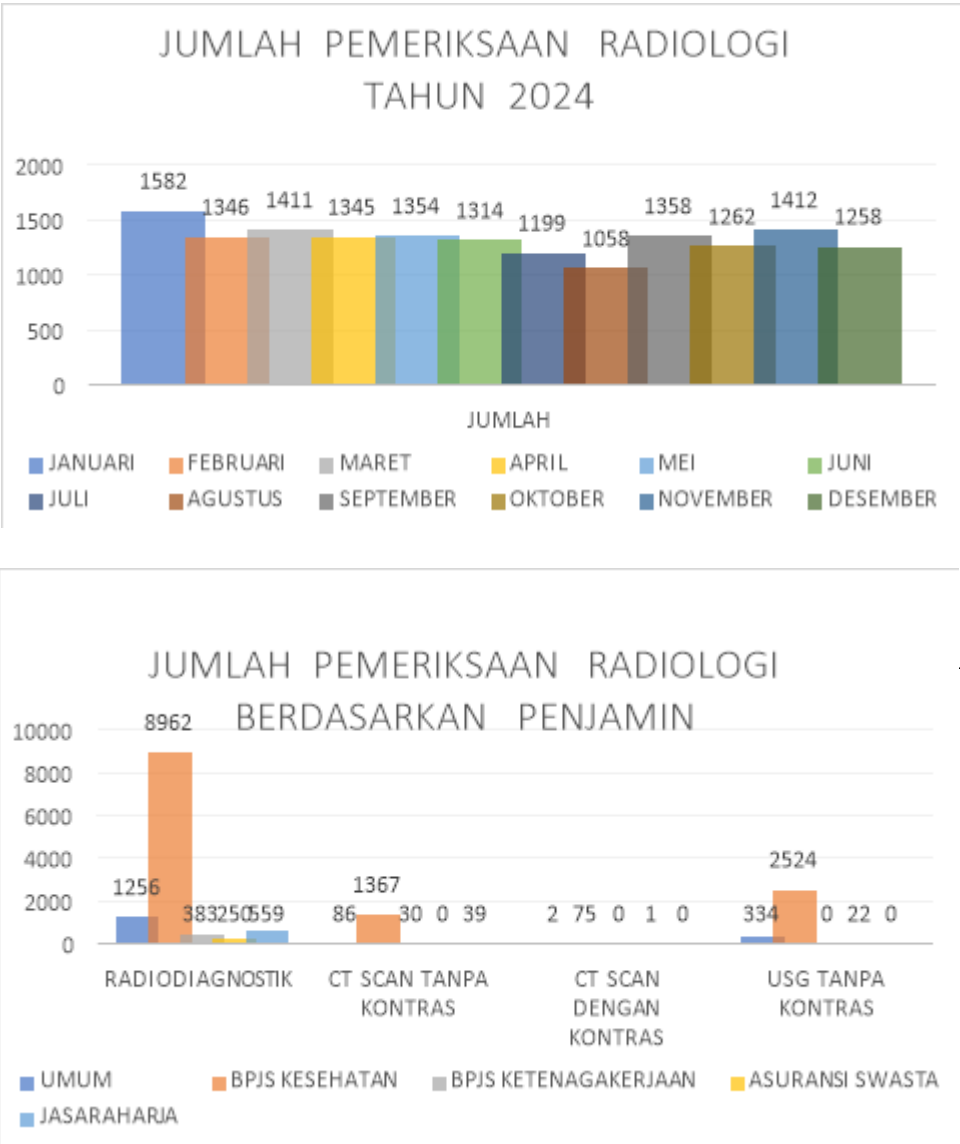
	jumlah pasien umum, jumlah pasien asuransi swasta dan pasien jasaraharja.	menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
4.	Jumlah kunjungan pasien jasaraharja selama tahun 2024 tidak lebih dari 10% dari keseluruhan total kunjungan.	- Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk menjalin kerjasama dengan pihak polisi LAKA dan ambulance PSC untuk mengirimkan pasien LAKA ke RS Prima Husada Malang. - Mempermudah proses rujukan pasien dari RS luar ataupun pihak luar (ambulan resita/ambulance gratis lainnya).
5.	Perbedaan jumlah resep dapat disebabkan dari berbagai hal seperti ; - Kunjungan pasien rawat jalan, IGD, IKO dan pasien rawat inap dengan penjamin BPJS Kesehatan sebagai pilihan utama. - Pasien memiliki asuransi swasta tetapi tidak dipilih karena benefit yang didapat sesuai dengan diagnosa yang tertera pada polis asuransi, dan berpotensi selisih biaya di akhir. - Target PRB rawat jalan dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil. - jumlah dokter yang tidak praktek atau izin atau cuti, - jumlah tanggal merah atau hari libur pada bulan tersebut, - obat tertinggal yang tidak ambil oleh pasien sehingga dilakukan penerimaan obat hibah lainnya.	- Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver. - Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien. - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal dikirim secara gratis, jumlah pasien yang menggunakan layanan pengantaran obat selama tahun 2024 yaitu sebanyak 9897 pasien.

3.3.1.2 Radiologi

3.3.1.2.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Selama Tahun 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN KE-												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	RADIO DIAGNOSTIK (RONTGEN)	UMUM	437	20	29	20	18	19	26	55	40	62	288	242	1256
		BPJS KES	720	666	814	907	820	841	800	700	738	800	570	586	8962
		BPJS TK	40	35	47	30	45	15	25	25	9	14	84	14	383
		ASURANSI SWASTA	80	65	55	15	30	5	0	0	0	0	0	0	250
		JASARAHRJA	100	90	75	10	20	80	15	15	81	13	36	24	559
	TOTAL		1377	876	1020	982	938	960	866	795	868	889	978	866	11410
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	0	29	15	11	17	10	0	0	4	0	0	0	86
		BPJS KES	11	201	164	137	137	115	47	22	118	133	140	142	1367
		BPJS TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
		ASURANSI SWASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JASARAHRJA	0	0	0	0	0	26	0	0	11	2	0	0	39
	TOTAL		11	230	179	148	154	151	47	22	133	135	170	142	1522
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		BPJS KES	0	7	6	11	18	5	2	2	16	2	2	4	75
		BPJS TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		JASARAHRJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	7	7	11	18	5	2	2	16	2	3	5	78
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	44	35	18	9	24	38	24	15	40	30	30	27	334
		BPJS KES	150	198	187	184	217	160	250	224	301	206	233	214	2524
		BPJS TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	8	4	22
		JASARAHRJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		194	233	205	193	241	198	284	239	341	236	271	245	2880
TOTAL KESELURUHAN			1582	1346	1411	1345	1354	1314	1199	1058	1358	1262	1412	1258	15890

3.3.1.2.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi selama Tahun 2024



- Analisis :**
- 1. Pelayanan pemeriksaan selama Tahun 2024 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Selama Tahun 2024 pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - a. Radiodiagnostik : 11410
 - b. USG Tanpa Kontras : 2880
 - c. CT Scan Tanpa Kontras : 1522
 - 2. Pada Tahun 2024, pemeriksaan terbanyak ada pada Bulan Januari, yaitu sebanyak 1582 pemeriksaan, hal ini dikarenakan kunjungan radiologi meningkat, kunjungan dari Poli Spesialis untuk menegaskan diagnosis dan menetapkan pasien stabil untuk dikembalikan ke FKTP.
 - 3. Pada Tahun 2024, kinerja produktivitas CT Scan pada Bulan Januari, Juli dan Agustus 2024 menurun secara drastis karena Alat Ct Scan rusak, sehingga pasien dirujuk ke RS PH Sukorejo untuk pemeriksaannya.
 - 4. Jumlah total pemeriksaan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 15890 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
- 3. Melakukan review tarif tindakan yang dibutuhkan DPJP atau bisa dilakukan di RS, namun belum ada di Billing. Contoh : CTA Cardiac.
- 4. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT

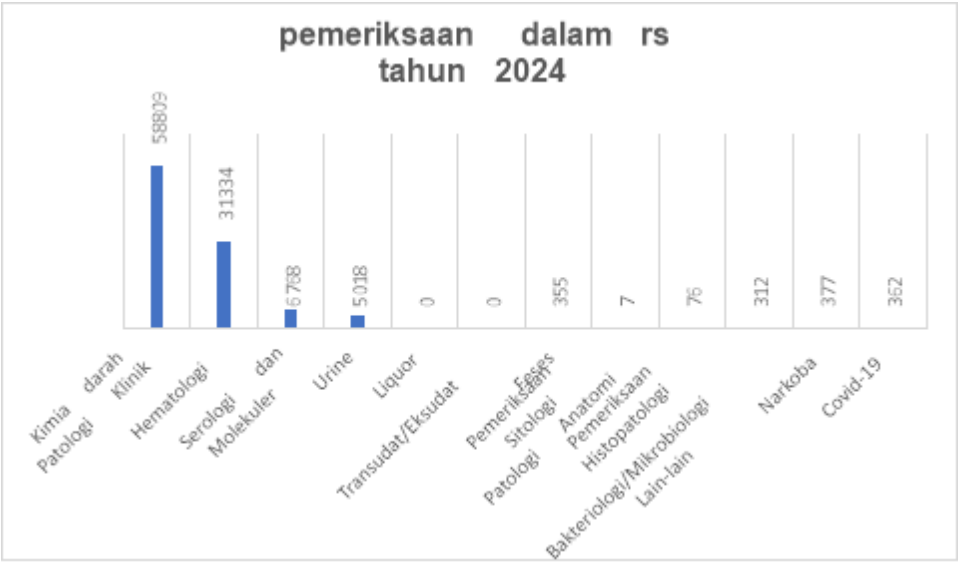
3.3.1.3 Laboratorium

3.3.1.3.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar RS Selama Tahun 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BULAN												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dilakukan di Dalam RS														
1.	Patologi Klinik													
	Kimia darah	4915	4931	5059	4965	5291	4844	4880	4799	5063	4568	4821	4673	58809
	Hematologi	2406	2377	2799	2858	3251	2859	2688	2444	2441	2581	2572	2058	31334
	Serologi dan Molekuler	568	507	638	640	663	528	523	453	522	536	650	540	6768
	Urine	371	372	371	374	459	399	382	521	518	451	397	403	5018
	Liquor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Feses	54	43	57	35	30	30	22	32	19	7	8	18	355	
TOTAL														102284
2.	Patologi Anatomi													
	Pemeriksaan Sitologi	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
	Pemeriksaan Histopatologi	25	34	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
TOTAL														83
3.	Lain-lain													

	Bakteriologi/Mikrobiologi	11	14	17	20	15	20	34	27	23	37	43	51	312
	Narkoba	67	22	20	34	34	31	57	35	21	23	14	19	377
	Covid-19	69	73	55	37	33	32	17	17	7	8	6	8	362
TOTAL														1051
Dilakukan di Luar RS (dirujuk)														
1.	Patologi Klinik													
	Kimia darah	1	0	3	0	2	2	0	1	1	0	2	1	13
	Hematologi	0	3	0	4	5	0	7	1	2	6	1	0	29
	Serologi dan Molekuler	24	3	7	14	10	5	8	5	14	16	10	4	120
	Urine	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	Liquor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Feses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL														164
2.	Patologi Anatomi													
	Pemeriksaan Sitologi	7	6	14	11	8	14	3	2	2	12	5	4	88
	Pemeriksaan Histopatologi	66	40	47	68	77	65	83	79	72	87	70	79	833
TOTAL														921
3.	Lain-lain													
	Bakteriologi/Mikrobiologi	19	14	5	3	4	1	0	6	20	11	6	13	102
	PCR	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Tumor Marker	20	2	1	0	1	0	3	0	2	1	2	0	32
	Cholinesterase	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL														139

3.3.1.3.2 Grafik Pemeriksaan Laboratorium di Dalam Rumah Sakit Selama Tahun 2024



3.3.1.3.3 Grafik Pemeriksaan Laboratorium di Luar Rumah Sakit Selama Tahun 2024



Analisis :

- 1. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya selama tahun 2024, yaitu :
 - a) Patologi Anatomi : 921 sampel
 - b) Patologi Klinik : 164 sampel
 - c) Bakteri/Mikrobiologi : 102 sampel
 - d) Tumor Marker : 32 sampel
- 2. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada Tahun 2024 mencapai 921 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang (PA) untuk kebutuhan klaim.

Rencana Tindak Lanjut

- 1. BDRS sudah berjalan mulai akhir November 2024, petugas magang di PMI Kabupaten Malang secara bergantian. Rencana kedepannya BDRS RS PH Malang bisa melayani permintaan labu darah dari luar.
- 2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 3. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- 4. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- 5. Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- 6. Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.

3.3.1.4 Rekam Medis

3.3.1.4.1 Tabel Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan pada Tahun 2024

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	8153
2.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	5067
3.	M54.5	LBP (Low Back Pain)	3359
4.	I69.3	Sequelae of cerebral infarction	2779
5.	I25	Chronic ischemic heart disease	2548
6.	M17	Gonarthrosis (arthrosis of knee)	2502
7.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	2463
8.	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	2098
9.	N40	BPH / Hyperplasia of prostate	2076
10.	K30	Dyspepsia (1130)	2071

Analisis :

- 1. Dari rekap data dan perbandingan tahun 2023 ke 2024, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan pasien penderita DM. Dimana tahun 2023 sejumlah 10.647 pasien, pada tahun 2024 8153 pasien, penurunan sebanyak 30,59% yaitu 2494 pasien.
- 2. Hal ini bisa disebabkan dengan adanya target PRB yang dilakukan oleh DPJP, sehingga pasien dengan kondisi stabil dikembalikan ke FKTP. Pasien dengan rujuk internal menjadi alih rawat.
- 3. Jumlah pasien DM tertinggi berbanding lurus dengan tingginya jumlah kunjungan pasien ke Poli Penyakit Dalam.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengadakan program senam kaki untuk penderita DM, masuk kedalam kegiatan senam lansia.
- 2. Memberikan penyuluhan kelompok terkait penyakit DM.
- 3. Membagikan leaflet tentang senam kaki untuk penderita DM.
- 4. Berikut link data pasien yang menderita penyakit Diabetes Melitus
- 5. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iR8zsxrFcoSHngD25HwDmUUMbPyDbbe6/edit#gid=1804187649>
- 6. Hasil dari follow up humas dan marketing :
 - a. Senam diabetes melitus nanti bisa di agendakan di acara senam geriatric.
 - b. Program pemeriksaan gula darah juga sudah dilakukan.

- c. Leaflet mengenai DM sudah tersebar di seluruh unit rawat inap.
 - d. Ada komunitas penderita DM.
7. Mengadakan rapat koordinasi dengan Asuransi Center dan Admisi terkait perubahan alur.

3.3.1.4.2 Tabel Diagnosa terbanyak di Rawat Inap pada Tahun 2024

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	4872
2.	T14	Injury of unspecified body region	1640
3.	O80.9	Persalinan Tunggal Spontan, tak terklasifikasikan / Single spontaneous delivery, unspecified	1055
4.	E86	Volume depletion	1012
5.	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	973
6.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	913
7.	R06.0	Dyspnea	788
8.	P03.4	Bayi Lahir dengan SC / Newborn affected by cesarean delivery	784
9.	A90	Dengue Fever (DF)	682
10.	A01.0	Typhoid Fever (TF)	590

Analisis :

Dari rekap data dan perbandingan tahun 2023 ke 2024, peringkat utama masih sama adalah kode R50.9 yaitu Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris) sebanyak 4872 kasus, meningkat sebesar 27% dari Tahun 2023.

Masalah :

- 1. Kasus Febris sedang disoroti oleh BPJS Kesehatan, penyakit tersebut masuk kedalam daftar 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk ke RS, penyakit febris dapat merajuk pada poin 1 (kejang demam), poin 50 (demam tifoid), poin 92 (demam dengue DHF), poin 93 (malaria) dan penyakit lainnya.
- 2. Ada beberapa diagnose dari 10 diagnosa terbanyak yang masuk kedalam 144 penyakit.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Membuat poster 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk ke RS, dan dipasang di IGD dan Pendaftaran Central.
- 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan konsultan PT DPM terkait strategi klaim, tetap menerima pasien yang datang meskipun termasuk dalam daftar 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk ke RS dengan menggali dan memperkuat indikasi sesuai dengan PPK yang sudah dibuat.
- 3. Kolaborasi dengan PIC BPJS yang ditugaskan di RS untuk membantu mengedukasi pasien.

3.3.1.4.3 Grafik Kelengkapan ERM Rawat Jalan Selama Tahun 2024



Analisis :

1. Validasi Data E-RM pada Bulan Januari 2024 masih cukup rendah angka kelengkapan untuk ERM IRJA, dikarenakan masih progress pengembangan pelayanan di Poli dan IGD.
2. Pada Bulan Februari 2024 hingga Bulan Juni 2024 masih fluktuatif di karenakan ada kendala kendala yang harus di tindak lanjuti oleh programmer yang mempengaruhi cara “penyimpanan” pada data ERM
3. Progress membaik setiap bulannya, karena dilakukan evaluasi dan perbaikan alur. Sehingga sudah mencapai 99.94% di akhir Tahun 2024.
4. Masih ditemukan fitur ERM yang tidak terbaca oleh Rekam Medis, seperti Skrining IGD.
5. Masih ditemukan layanan IRJA yang belum E-RM, yaitu Poli KIA dan Poli Gizi.

Masalah :

1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
2. Masih ditemukan ketidak lengkapan pengisian form e-rm meskipun sudah sangat meningkat, antara form igd, poli dengan rekam medis masih belum sinkron.
3. Pencatatan Poli Gizi masih menggunakan lembar konsultasi manual, resiko hilang dan tidak terekap dengan baik pada system sehingga DPJP tidak bisa membaca hasil pada Billing E-RM.
4. Ditemukan kunjungan Poli KIA saat petugas RM melakukan review dan belum masuk kedalam E-RM.
5. Berikut link permasalahan yang ditemui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik setiap bulannya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.

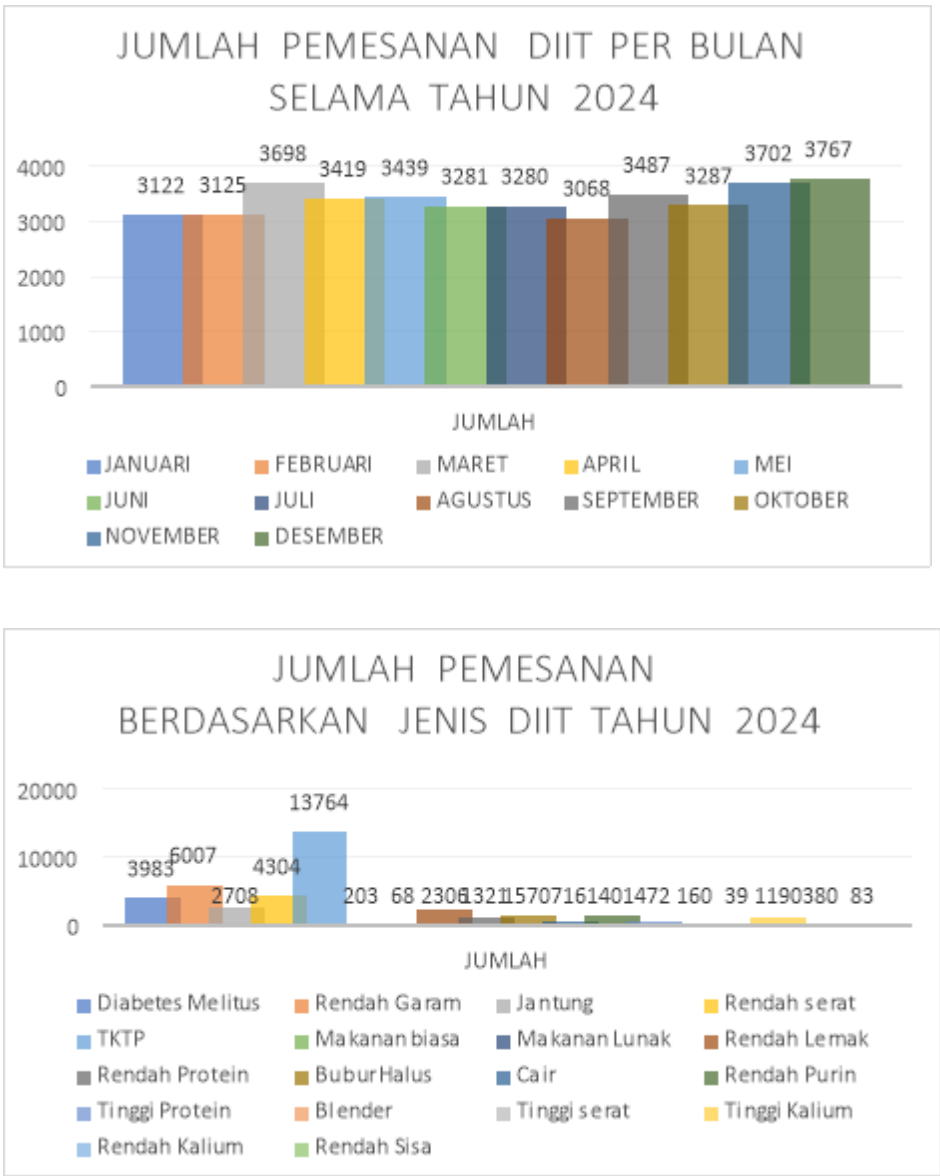
- Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- Setelah selesai dilakukan validasi oleh petugas rekam medis, perawat menyetorkan berkas ke kasir jaminan.
- Pada akhir Bulan November 2024 casemix yang disetor sudah tidak dicetak, RS sudah menerapkan E-Casemix.
- Melakukan pencatatan kunjungan pasien harian setiap DPJP pada google spreadsheet untuk dilakukan cek kesesuaian dan kelengkapan data oleh Petugas RM dan Verifikator RS.
- Flow Chart alur pelayanan Poli Gizi sudah diberikan kepada Programmer PT

3.3.1.5 Gizi

3.3.1.5.1 Tabel Pemesanan Diit Selama Tahun 2024

NO	NAMA DIIT	BULAN												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Diabetes Melitus	298	288	285	333	284	294	409	352	373	287	379	401	3983
2.	Rendah Garam	389	408	528	463	520	575	344	392	593	468	700	627	6007
3.	Jantung	176	223	190	209	221	224	205	205	247	237	252	319	2708
4.	Rendah serat	354	352	373	292	242	284	425	340	445	397	373	427	4304
5.	TKTP	1158	1079	1424	1270	1322	1109	1170	1066	997	1100	1074	995	13764
6.	Makanan biasa	34	24	16	10	20	7	4	7	26	19	10	26	203
7.	Makanan Lunak	17	20	10	10	7	1	0	2	0	1	0	0	68
8.	Rendah Lemak	165	160	239	208	213	174	166	171	205	178	238	189	2306
9.	Rendah Protein	102	87	79	93	94	107	86	88	106	177	112	190	1321
10.	Bubur Halus	133	92	171	118	128	127	143	155	121	115	128	139	1570
11.	Cair	60	72	71	61	50	36	50	63	57	60	62	74	716
12.	Rendah Purin	79	102	97	75	92	104	92	105	136	118	239	162	1401
13.	Tinggi Protein	45	24	23	40	36	37	51	48	40	39	38	51	472
14.	Blender	23	17	21	11	13	19	12	4	15	4	4	17	160
15.	Tinggi serat	0	3	0	8	3	1	2	3	11	0	5	3	39
16.	Tinggi Kalium	65	123	131	166	141	148	65	49	79	61	60	102	1190
17.	Rendah Kalium	24	42	30	48	47	27	41	11	35	15	21	39	380
18.	Rendah Sisa	0	9	10	4	6	7	15	7	1	11	7	6	83
TOTAL		3122	3125	3698	3419	3439	3281	3280	3068	3487	3287	3702	3767	40675

3.3.1.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Selama Tahun 2024



- Analisis :**
1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak pada Tahun 2024 adalah TKTP sebanyak 13764, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Febris dengan kebutuhan diit TKTP.
 2. Jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP dan berbanding lurus dengan peningkatan ataupun penurunan pasien di rawat inap.
 3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
 3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.

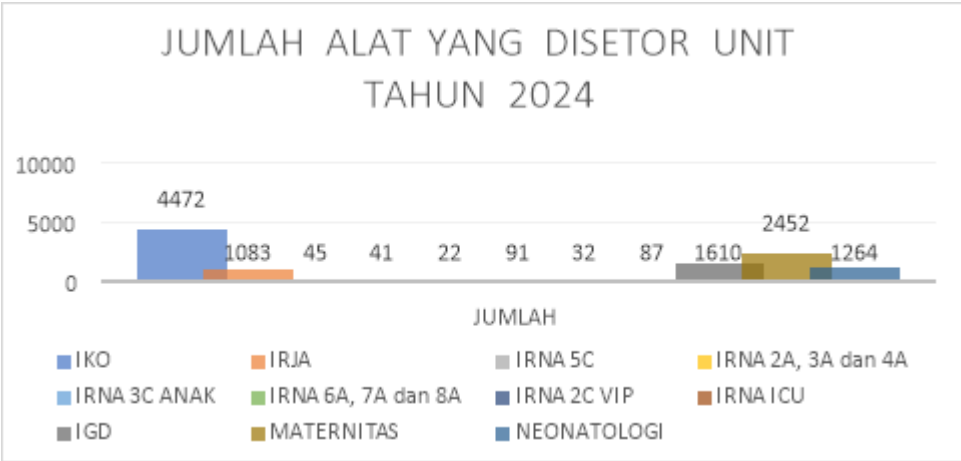
- Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
- Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media

3.3.1.6 CSSD – Laundry

3.3.1.6.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD selama Tahun 2024

N O	HAL	BULAN TAHUN 2024												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
	BHP													
1.	Chemical Alcacide (ml)	1500	1500	1400	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1100	1100	1200	15200
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	21	37	34	31	32	32	34	37	37	32	31	33	391
3.	Kassa Masuk (roll)	54	54	38	45	54	58	57	57	63	40	32	40	592
4.	Kassa Keluar (pouches)	1899	2130	1983	2003	2036	2322	2253	2148	2496	1598	1950	2240	25058
5.	BHP Pouces (roll)	5.5	5	5	5	5	5.5	4	4	4	6,5	6	7	62,5
6.	Indikator Adhesive (roll)	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	15
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	19,5
	Alat yang disetor													
8.	IKO	391	367	367	365	387	391	382	369	371	351	366	365	4472
9.	IRJA	101	87	75	72	65	65	101	110	97	104	110	96	1083
10.	IRNA 5C	7	7	4	3	2	1	2	1	4	7	6	1	45
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	3	3	2	3	4	3	2	3	5	6	3	4	41
12.	IRNA 3C ANAK	2	2	0	3	3	4	4	1	1	0	1	1	22
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	8	8	4	3	4	7	7	9	11	9	10	11	91
14.	IRNA 2C VIP	4	4	3	3	3	1	1	4	4	2	2	1	32
15.	IRNA ICU	10	10	11	12	12	2	2	1	6	6	7	8	87
16.	IGD	126	126	149	156	163	176	189	99	98	101	112	115	1610
17.	MATERNITAS	203	203	179	243	256	269	282	188	175	147	151	156	2452
18.	NEONATOLOGI	108	108	112	139	124	135	135	98	88	71	68	78	1264
	Jumlah	963	925	906	1002	1023	1054	1107	883	860	804	836	836	11199

3.3.1.6.2 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD selama Tahun 2024



3.3.1.6.3 Grafik Jumlah Produktivitas CSSD selama Tahun 2024



Analisis :

1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, pengeluaran BHP paling banyak adalah Bulan September 2024, hal ini tidak sebanding dengan jumlah alat yang disetor unit ke CSSD karena pada Bulan September 2024 produktivitas kassa repack meningkat.
2. Jumlah pengeluaran BHP paling sedikit adalah Bulan September 2024, hal ini sebanding dengan menurunnya penyeteran alat unit pada bulan tersebut, sehingga produktivitas ikut menurun.
3. Jumlah alat yang disterilasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat selama Tahun 2024 yaitu sejumlah 4.472 set, diikuti dari Unit Maternitas 2.452 set dan IGD 1.610 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
4. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.
5. Terjadi peningkatan produktifitas kinerja dalam pembuatan kasa steril, hal ini disebabkan adanya pemenuhan petugas dan pemenuhan permintaan stok Gudang Farmasi.

- Rencana Tindak Lanjut :
1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.

2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.

3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.

4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

3.3.1.6.4 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Selama Tahun 2024

NO	HAL	BULAN TAHUN 2024												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
BHP														
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	17
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	15
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1,5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	14,5
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	26	24	23	20	18	21	21	18	18	16	18	19	242
6.	Pemutih Bayclean (liter)	19	17	16	17	14	15	15	14	13	10	11	12	173
7.	Softener (liter)	0	20,7	21,7	19	21	22	22	19	18	18	18	15	214,4
8.	Liquid matic (liter)	0	8	8	8	8	9	9	8	9	8	9	9	93
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	18	20	16	20	18	21	21	16	17	18	17	19	221
Total		67,5	93,7	88,7	88	85	93	93	81	80	74	80	78	1001,9
LINEN														
1.	VVIP	1	0	0	2	1	1	2	1	1	1	2	2	14
2.	VIP	1	3	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	26
3.	KELAS 1	81	117	88	80	92	101	110	80	81	87	80	76	1073
4.	KELAS 2	507	486	346	380	440	456	470	445	380	401	355	309	4975
5.	KELAS 3	1461	1451	1500	1400	1230	1358	1400	1238	1209	1224	1194	1257	15922
6.	MATER 1	33	30	20	22	10	15	17	26	13	17	15	16	234
7.	MATER 2	245	312	224	235	245	268	345	303	276	255	242	222	3172
8.	MATER 3	669	654	765	709	780	785	787	761	799	770	710	725	8914
9.	ICU	205	212	176	190	200	140	78	67	76	50	40	41	1475
10.	IKO	2230	2021	2434	2225	2450	2560	2600	2575	2501	2350	2005	2035	27986
11.	IRJA	27	34	28	30	20	20	19	17	15	16	12	15	253
12.	IGD	75	65	75	70	76	50	80	55	57	68	48	52	771
13.	LABORATORIUM	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
14.	RADIOLOGI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	35
15.	DAPUR/GIZI	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	32
16.	CSSD	5	4	4	3	3	4	5	5	5	5	4	3	50
Total		5550	5401	5671	5357	5559	5770	5924	5583	5423	5254	4716	4764	64972

3.3.1.6.5 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Per Unit Selama Tahun 2024



3.3.1.6.6 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Selama Tahun 2024



Analisa :

1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pencucian linen fluktuatif sebanding dengan jumlah pasien dan penggunaan di unit, jika tidak sebanding dengan penggunaan bhp hal ini disebabkan oleh linen kotor yang memerlukan pencucian ulang karena noda terlalu pekat.
2. Pencatatan penimbangan linen menggunakan timbangan beras masih manual, resiko angka tidak terbaca dengan baik, sehingga jumlah yang dihasilkan kurang valid.
3. Berat linen setiap tahun nya paling berat adalah IKO dan Kelas 3, hal ini disebabkan karena jumlah pasien yang banyak dan tindakan operasi yang meningkat. Salah satu penyebab lainnya adalah ditemukan benda asing ketika pencucian sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada mesin cuci.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
2. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
3. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
4. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
5. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

3.3.1.7 Unit Kamar Jenazah

Tidak ada proses pemulasaraan jenazah di RS Prima Husada Malang

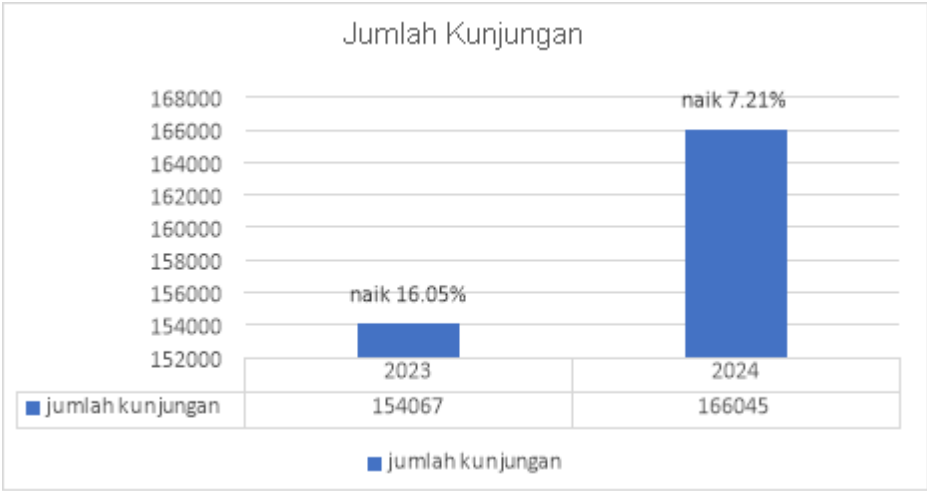
3.3.2 Pelayanan

3.3.2.1 IRJA

3.3.2.1.1 Tabel Kunjungan Pasien IRJA Tahun 2023-2024

NAMA UNIT	2023	2024
IGD	7486	8518
Klinik Anak	14896	13934
Klinik anak sakura	0	26
Klinik Bedah	9900	9753
Klinik Bedah Plastik	469	346
Klinik bedah saraf	0	132
Klinik Fisioterapi	14202	13948
Klinik Gigi Spesialis	233	110
Klinik gigi ortodonti	0	114
Klinik gigi pedodontis	0	825
Klinik gigi Periodonti	0	402
Klinik Gizi	1	4
Klinik Ibu dan Anak	136	208
Klinik Jantung	10584	13986
Klinik Jiwa	2891	3783
Klinik Kandungan	13443	13716
Klinik kandungan sakura	0	74
Klinik Kulit & Kelamin	4950	4879
Klinik Mata	13200	13810
Klinik Orthopedi	6325	6727
Klinik Paru	5601	5675
Klinik Penyakit Dalam	26135	30822
Klinik penyakit dalam sakura	0	5
Klinik penyakit dalam sub EMD	0	7
Klinik Syaraf	15451	16454
Klinik THT	3546	2786
Klinik Urologi	4305	4458
Klinik Umum	313	543
Unit Pinere	0	0
TOTAL	154067	166045

3.3.2.1.2 Grafik Kunjungan Pasien IRJA Tahun 2023-2024



Analisa :

Jumlah kunjungan masing masing tahun 2023-2024 mengalami peningkatan kunjungan 7.21% ,sebanyak 11978 pasien. Secara umum, kunjungan instalasi rawat jalan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan pelayanan Kedokteran gigi anak, Bedah Saraf dan Periodonti yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Selain itu juga terdapat pelayanan Poliklinik Sakura, Poli vaksin, dan poli MCU. Tingginya rujukan dari FKTP juga merupakan pemicu kenaikan jumlah kunjungan rawat jalan.

Rencana Tindak Lanjut :

Pertahankan dan tingkatkan jumlah kunjungan koordinasi dengan humas dan marketing

PDSA Kinerja Produktivitas IRJA

Problem	Kunjungan Poli Sakura baru launching bulan Juni 2024
Step	Mendata dan menganalisa jumlah pasien Sakura dalam sebulan
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab kunjungan rawat jalan poli Sakura yang belum maksimal Harapan : Pasien umum poli rawat jalan beralih ke poli Sakura Tindakan : a. Mensosialisasikan poli Sakura melalui media sosmed RSPHM b. Koordinasi dengan FKTP, asisten poli dan DPJP, dan grup komunitas terkait poli sakura
Do	Cara Staf melakukan promosi poli sakura
Study	Cara Staf mempromosikan poli sakura apakah sudah sesuai dengan tarif dan SPO yang ditentukan
Action	Pada kunjungan bulan Agustus dan September, poli sakura mengalami kenaikan, karena ada diskon 50%, dari harga Rp 280.000, menjadi Rp. 175.000. dan total satu tahun sebanyak 105 pasien, 0.05% dari total kunjungan rawat jalan dalam setahun. Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025 diharapkan kunjungan poli sakura naik lebih banyak dari tahun 2024

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan rawat jalan
Step	Open recrutmen dokter spesialis
Plan	Rencana : Membuka open rekrutmen dr gigi anak,penyakit dalam,dokter umum,dr bedah saraf Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan periode tahun 2025 Tindakan : a. Koordinasi dengan ketua dokter gigi spesialis di pasuruan b. Koordinasi dengan dokter urologi serta THT di PHM untuk praktek di PHS c. Koordinasi dengan para DPJP untuk membantu mencari rekanan dokter gigi spesialis, dokter urologi, dan THT d. Membuka lowongan pekerjaan yang disebarakan di sosial media
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Membuat plotingan jadwal dokter gigi spesialis ,membuka layanan baru setelah mendapatkan dokter rekrutmen
Study	Apa yang anda pelajari ?

	Menyiapkan sloting jadwal dokter, melihat kunjungan setelah di buka layanan baru
Action	Apa yang anda pelajari ? - Koordinasi dengan dpjp dengan kabit pelayanan - Melihat kendala di lapangan - Bekerjasama dengan marketing untuk sosialisasi dokter layanan baru

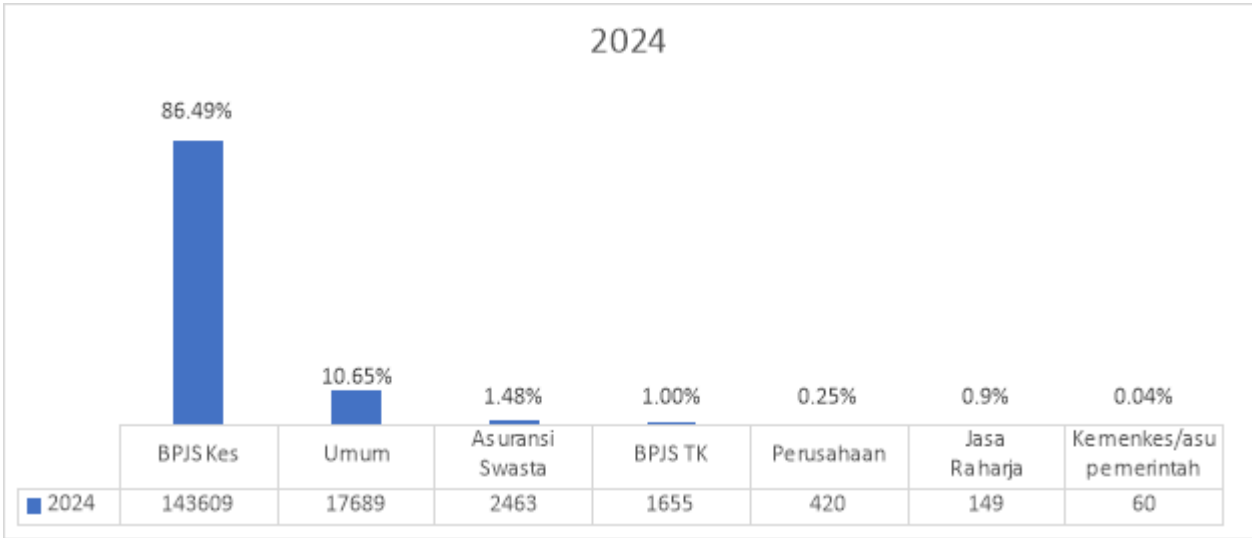
3.3.2.1.3 Rawat Jalan Per Cara Bayar Bulan Januari-Desember 2024

CARA BAYAR	BULAN												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Umum	1508	1102	1282	1320	1540	1435	1400	1593	1536	1601	1584	1788	17689
BPJS Kes	13220	12100	12340	11499	11611	11121	12601	12182	11587	11723	11866	11759	143609
BPJS TK	107	95	131	113	147	128	150	144	138	162	162	178	1655
Kemenkes/asu pemerintah	0	0	4	0	2	4	16	17	7	5	2	3	60
Jasa Raharja	6	8	16	17	10	22	6	24	15	14	4	7	149
Asuransi Swasta	183	191	200	170	264	226	231	179	184	227	197	211	2463
Perusahaan	35	35	35	35	49	22	39	23	28	39	43	37	420
Total	15059	13531	14008	13154	13623	12958	14443	14162	13495	13771	13858	13983	166045

Analisa :

- Pada tabel diatas tampak bahwa kunjungan pasien BPJS IRJA fluktuatif dan yang paling tinggi kunjungan di bulan januari 2024 yaitu 15059 kemudian terjadi penurunan ke bulan selanjutnya
- Pasien JKK paling tinggi di bulan november 2024 yaitu 67 pasien
- Pasien BPJS paling tinggi di bulan januari 2024 yaitu 13220 pasien
- Pasien UMUM paling tinggi di bulan di bulan desember yaitu 1788 pasien
- Pasien Asuransi lain paling tinggi di bulan mei 2024 yaitu 264
- Pasien Jasa raharja paling tinggi di bulan agustus yaitu 24 pasien
- Total pasien dalam 1 tahun sebesar 19.095 naik 24% dari tahun 2023

3.3.2.1.4 Grafik Rawat Jalan Per Cara Bayar Bulan Januari – Desember 2024



Analisa :

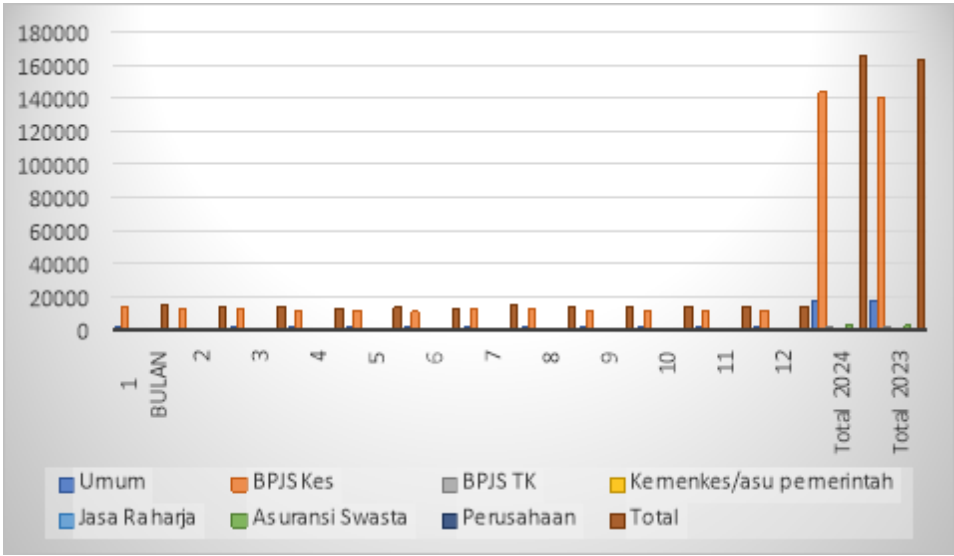
Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa cara bayar yang paling tinggi : 86.49% pasien menggunakan cara bayar bpjs, 10.65% pasien menggunakan cara bayar umum, 1.48% pasien menggunakan cara bayar asuransi swasta, 1.00% pasien menggunakan cara bayar bpjs tk, 0.25% pasien menggunakan cara bayar perusahaan, 0.9% pasien menggunakan cara bayar

jasa raharja, dan paling rendah 0.04% pasien menggunakan cara bayar asuransi pemerintah (asabri/taspen/bkkbn)

Rencana tindaklanjut :

- 1. Tingkatkan kunjungan pasien umum dengan meningkatkan kunjungan MCU dan vaksin
- 2. Koordinasi dengan humas marketing untuk menambah dan memperbarui PKS dengan perusahaan maupun asuransi
- 3. Bekerjasama dengan FKTP untuk menjaring pasien yang berkenan menggunakan kontrasepsi pemerintah (BKKBN) karena kunjungan masih sangat sedikit.
- 4. Koordinasi humas dengan JR, Polisi dan Perusahaan untuk meningkatkan kunjungan pasien JR dan JKK

3.3.2.1.5 Grafik Rawat Jalan Per Cara Bayar Tahun 2023 – 2024



3.3.2.1.6 Tabel 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Tahun 2024

NO	KODE	DIAGNOSA	TAHUN 2024
1	E11	DM Type 2 / Noninsulin-dependent diabetes mellitus	8153
2	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	5067
3	M54.5	LBP (Low Back Pain)	3359
4	I69.3	Sequelae of cerebral infarction	2779
5	I25	Chronic ischemic heart disease	2548
6	M17	Gonarthrosis [arthrosis of knee]	2502
7	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	2463
8	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	2098
9	N40	BPH / Hyperplasia of prostate	2076
10	K30	Dyspepsia (1130)	2071

Analisa :

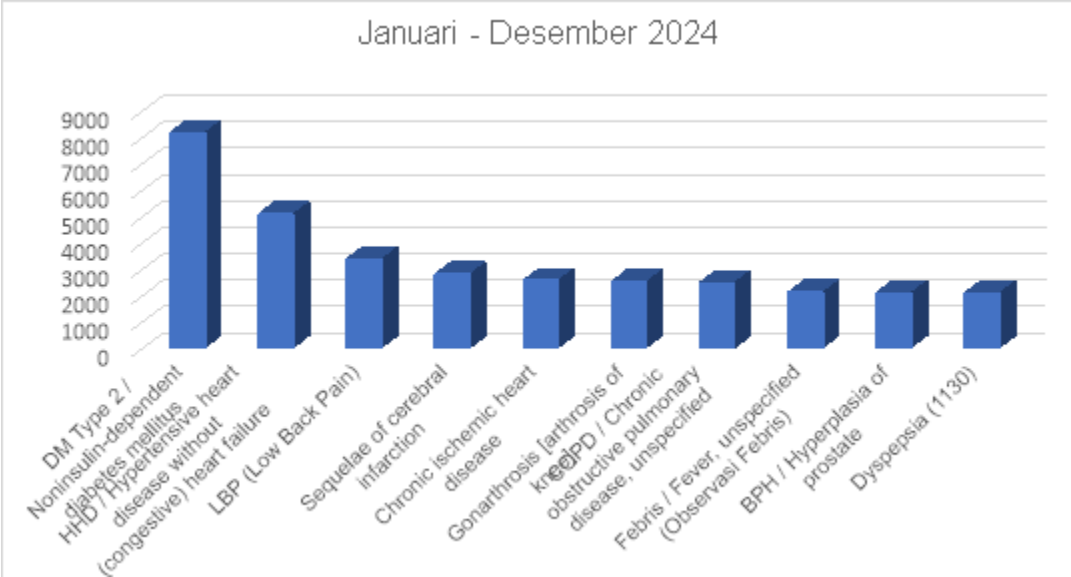
Dari 10 besar penyakit rawat jalan, penyakit terbanyak di IRJA adalah DM Type 2. Diagnosa tersebut paling banyak dari Poli Penyakit dalam. Jumlah pasien DM menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 di nilai (10647) dan di 2024 turun (8153) dikarenakan diagnosa tersebut juga masuk 9 diagnosa PRB yang wajib dikembalikan ke FKTP, dan pada bulan oktober 2024, PRB RSPHM tercapai. Sehingga terlihat adanya penurunan jumlah kunjungan pasien DM dari tahun lalu.

Rencana Tindak Lanjut :

Meskipun jumlah pasien DM menurun dari tahun sebelumnya, RSPHM tetap berupaya mengurangi penyakit DM dengan program promotive dan perventif seperti Senam diabetes melitus nanti bisa di

agendakan di acara senam geriatri, program pemeriksaan gula darah secara berkala berkerjasama degan FKTP MS (untuk event tertentu) dan menyediakan leaflet yang bisa diakses dengan mudah melalui barcode.

3.3.2.1.7 Grafik 10 Diagnosa Rawat Jalan Terbesar Januari – Desember 2024



Analisa :

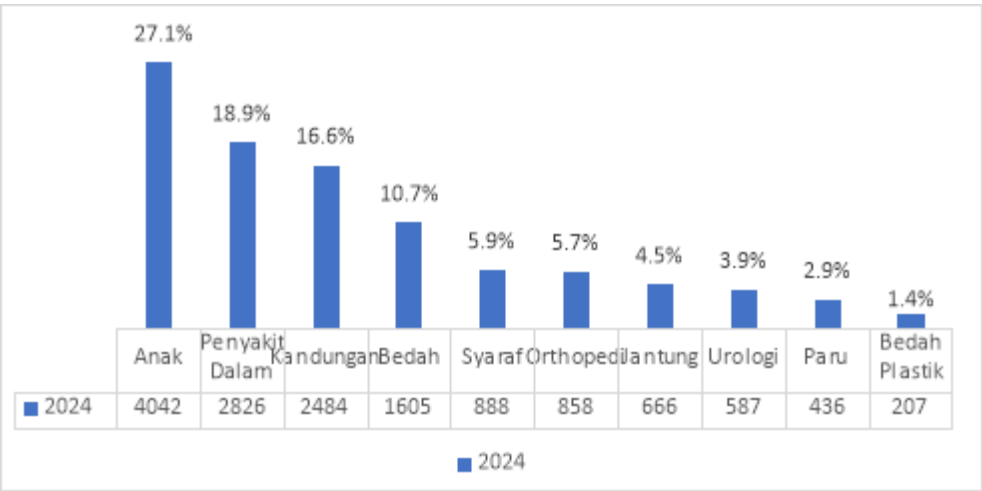
- 1. DM type 2 merupakan kunjungan paling tinggi di tahun 2024
- 2. HHD kunjungan sangat tinggi di rawat jalan

3.3.2.2 IRNA

3.3.2.2.1 Tabel Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap sesuai dengan Jenis Pelayanan Tahun 2023-2024

JENIS PELAYANAN	2023	2024
Anak	3302	4042
Anastesi	0	5
Bedah	1514	1605
Bedah Plastik	222	207
Bedah syaraf	0	83
Jantung	357	666
Jiwa	1	1
Kandungan	2440	2484
Kulit & Kelamin	62	25
Mata	168	147
Orthopedi	644	858
Paru	584	436
Penyakit Dalam	1793	2826
Spesialis Gigi	1	26
Syaraf	821	888
THT	85	29
Urologi	610	587
Umum	17	19
TOTAL	12621	14934

3.3.2.2.2. Grafik Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap sesuai dengan Jenis Pelayanan Tahun 2023 -2024



Analisa :
Kunjungan paling banyak di kunjungan pasien IRNA adalah pelayanan Anak mencapai 27.1% dari total kunjungan 14934 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien anak maupun dewasa, koordinasi dengan Humas – marketing untuk mempromosikan pelayanan IGD yang cepat dan tanggap, koordinasi dengan FKTP Mutiara sehat jika ada pasien rujukan rawat inap dari MS bisa dikawal dengan baik.

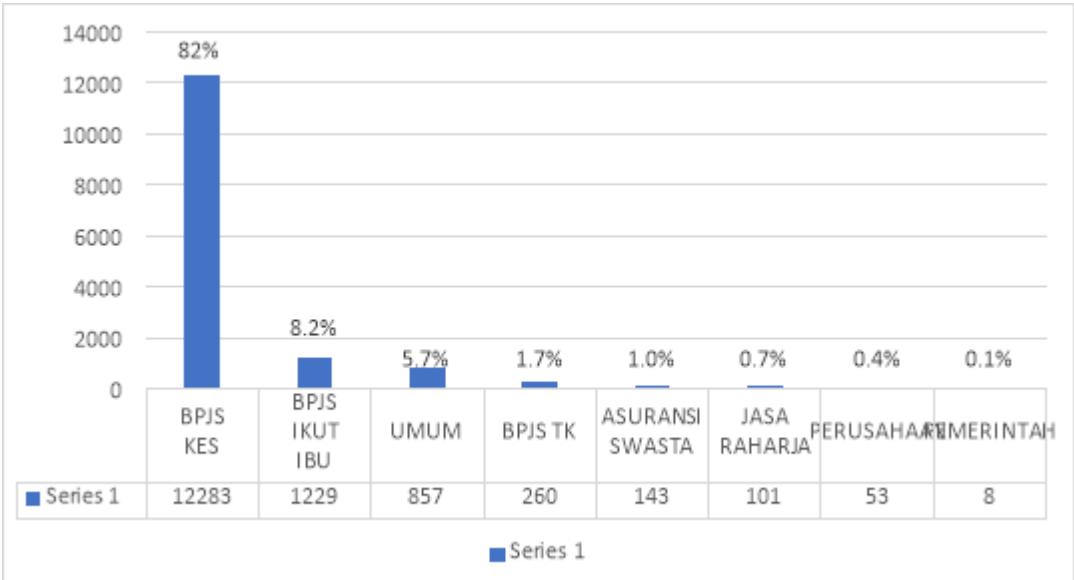
PDSA Kinerja Produktivitas IRNA	
Problem	Kunjungan Pelayanan Bedah Plastik Sedikit
Step	Mendata dan menganalisa jumlah pasien bedah plastic yang rawat inap dalam sebulan
Plan	Rencana : - Mengetahui penyebab kunjungan pasien bedah plastik yang belum maksimal - Hanya ada 1 DPJP bedah plastic yang memback up pelayanan bedah plastik Harapan : Kunjungan pasien rawat inap bedah plastik meningkat di tahun 2025 Tindakan : a. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk mengupdate pelayanan bedah plastik khususnya untuk pasien JKK dan asuransi b. Koordinasi dengan FKTP baik puskesmas maupun klinik, jika ada kasus trauma di wajah/kepala, ekstremitas sampai hand , luka bakar, boleh dirujuk ke PHM
Do	Koordinasi dengan humas untuk melakukan promosi kunjungan baik sosmed maupun door to door ke perusahaan
Study	Koordinasi apakah materi yang disampaikan bisa diterima perusahaan atau FKTP

Action	Refresh kembali pada dokter IGD terkait diagnosa yang masuk di pelayanan bedah plastik dan bedah saraf, mengingat bedah saraf sudah bisa melayani BPJS Kesehatan per Juni 2024. Pelayanan bedah plastik menurun 15 pasien dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini tidak terlalu signifikan, karena tahun 2023 belum ada bedah saraf, sedangkan april tahun 2024 sudah ada pelayanan bedah saraf dengan kompetensi yang hampir sama yaitu di area kepala dan wajah. Rencana tindaklanjut : Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025 diharapkan kunjungan pasien rawat inap bedah plastik meningkat dari tahun 2024
--------	--

3.3.2.2.3 Tabel Rawat Inap Per Cara Bayar Bulan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	KEME NKES	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUT IBU	PEMERINTAH LAINYA (TASPEN)	TOTAL
1	VVIP	39	82	1	0	0	21	4	0	0	147
2	VIP	49	171	3	0	1	47	9	0	0	280
3	Kelas I	56	1949	0	0	11	51	20	0	1	2088
4	Kelas II	135	3532	227	0	23	12	5	0	1	3935
5	Kelas III	449	4814	15	0	62	3	10	0	5	5358
6	ICU	14	216	2	0	4	0	3	0	0	239
7	Maternitas	57	1227	0	0	0	0	1	0	0	1285
8	Neonatologi	45	123	0	0	0	9	1	1229	1	1408
9	NICU	3	33	0	0	0	0	0	0	0	36
10	Isolasi	9	77	12	0	0	0	0	0	0	98
11	ICU T -	1	58	0	0	0	0	0	0	0	59
12	PICU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		857	12283	260	0	101	143	53	1229	8	14.934

3.3.2.2.4 Grafik Rawat Inap Per Cara Bayar tahun 2024



Analisa :
Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa cara bayar yang paling tinggi 82% pasien menggunakan cara bayar bpjs, 8.2% pasien menggunakan cara bayar bpjs ikut ibu,5.7% pasien menggunakan cara bayar Umum,1.7% pasien menggunakan cara bayar Bpjs TK, 1.0% pasien menggunakan cara bayar asuransi swasta, 0.7% pasien menggunakan cara bayar jasa raharja,

0.4% pasien menggunakan cara bayar perusahaan, 0.1% pasien menggunakan cara bayar pemerintah.

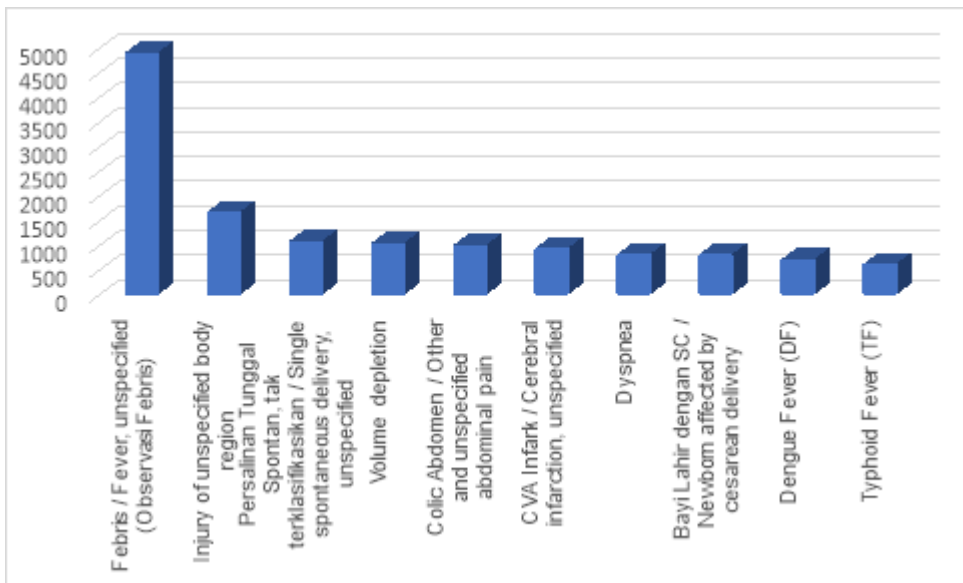
Rencana tindaklanjut :

1. Tingkatkan kunjungan pasien umum di IGD dan rawat inap
2. Koordinasi dengan humas marketing untuk menambah dan memperbarui PKS dengan perusahaan maupun asuransi
3. Bekerjasama dengan FKTP untuk menjaring pasien yang berkenan menggunakan kontrasepsi pemerintah (BKKBN) karena kunjungan masih sangat sedikit.
4. Koordinasi humas dengan JR, Polisi dan Perusahaan untuk meningkatkan kunjungan pasien JR dan JKK

3.3.2.2.5 Tabel Jumlah Penyakit Rawat Inap 10 Terbesar tahun 2024

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	4872
2	T14	Injury of unspecified body region	1640
3	O80.9	Persalinan Tunggal Spontan, tak terklasifikasikan / Single spontaneous delivery, unspecified	1055
4	E86	Volume depletion	1012
5	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	973
6	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	913
7	R06.0	Dyspnea	788
8	P03.4	Bayi Lahir dengan SC / Newborn affected by cesarean delivery	784
9	A90	Dengue Fever (DF)	682
10	A01.0	Typhoid Fever (TF)	590

3.3.2.2.6 Grafik Jumlah Penyakit 10 Terbesar Tahun 2024



Analisa :
Jumlah penyakit terbesar di rawat inap sama adalah Febris/Fever (Observasi Febris). Penyakit tersebut juga terbanyak di tahun 2023.

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk diagnosa Observasi febris bukan diagnosa utama, diagnosa tersebut masuk dari IGD, untuk selanjutnya ditegakkan menjadi diagnosa lain diantaranya Typoid Fever, Dengue Fever dan lainnya. Diagnosa tersebut dapat dilayani di faskes satu. Salah satu upaya di tahun 2025 adalah meminimalisir pendingan pasien BPJS Kesehatan karena diagnosa non spesialisik dan menghindari case yang menyebabkan fraud. Dengan adanya pembaharuan PPK di IGD, diharapkan dokter IGD dapat melakukan skrining dan pengkajian lebih mendalam terhadap pasien yang datang, dan dapat memberikan KIE yang jelas terkait kriteria kegawatdaruratan yang dapat dilayani di IGD.

3.3.2.2.6 Tabel Jumlah TT Rawat Inap

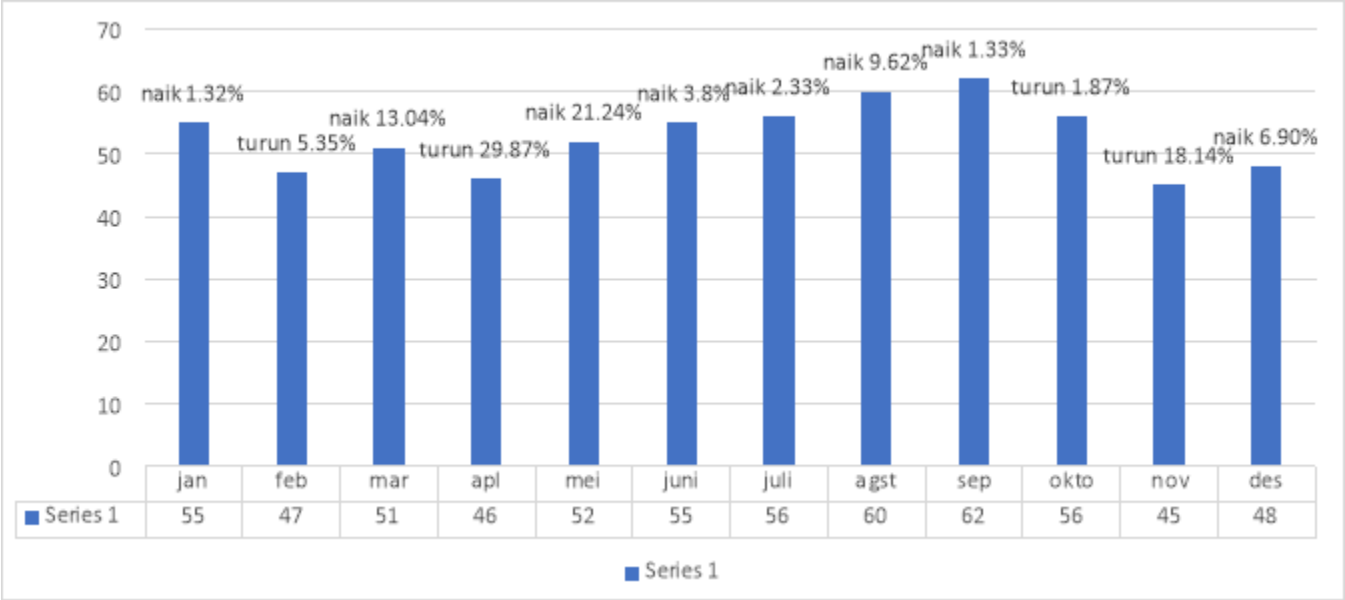
NO	RUANG PERAWATAN	KELAS PERAWATAN	JUMLAH TT
1	IRNA	VVIP	3
		VIP	3
		Kelas 1	18
		Kelas 2	24
		Kelas 3	48
Total :			: 96
2	ICU	-	7
	HCU	-	2
	NICU	-	2
	PICU	-	1
	IsoalasiTekanan Negative	-	7
	Isolasi Immunocompromise	-	5
Total			: 24
3	Non TT :		
	BOX BAYI	-	14
	BED PARTUS	-	6
Total			: 20
			120

3.3.2.2.7 Tabel Perbandingan BOR tahun 2023 dan 2024

BULAN	PERBANDINGAN TAHUN 2023 - 2024				
	JUMLAH PASIEN	BOR 2023	JUMLAH PASIEN	BOR 2024	KETERANGAN
JAN	984	55%	1148	57%	Naik 14.29%
FEB	934	47%	1206	66%	Naik 22.55%
MAR	1074	51%	1341	64%	Naik 19.91%
APRL	827	46%	1297	63%	Naik 36.24%
MEI	1050	52%	1332	62%	Naik 21.17%

JUNI	1046	55%	1237	59%	Naik 15.44%
JULI	1071	56%	1240	67%	Naik 13.63%
AGST	1185	60%	1192	62%	Naik 0.59%
SEP	1201	62%	1235	68%	Naik 2.75%
OKT	1179	56%	1213	64%	Naik 2.80%
NOP	998	45%	1228	70%	Naik 18.73%
DES	1072	48%	1262	71%	Naik 15.06%

3.3.2.2.8 Grafik Perbandingan BOR Tahun 2023 dan 2024



Analisa :

Pada grafik diatas tampak bahwa pencapaian BOR pada tahun 2024 naik turun,rata rata BOR tahun 2024 adalah 70%. BOR rumah sakit mengalami penurunan yang cukup rendah pada bulan januari 57%. Akan tetapi 3 bulan terakhir mengalami peningkatan pada bulan oktober (64%), nopember (70%) dan desember (71%),. Rata rata BOR di tahun 2024 adalah (70%).

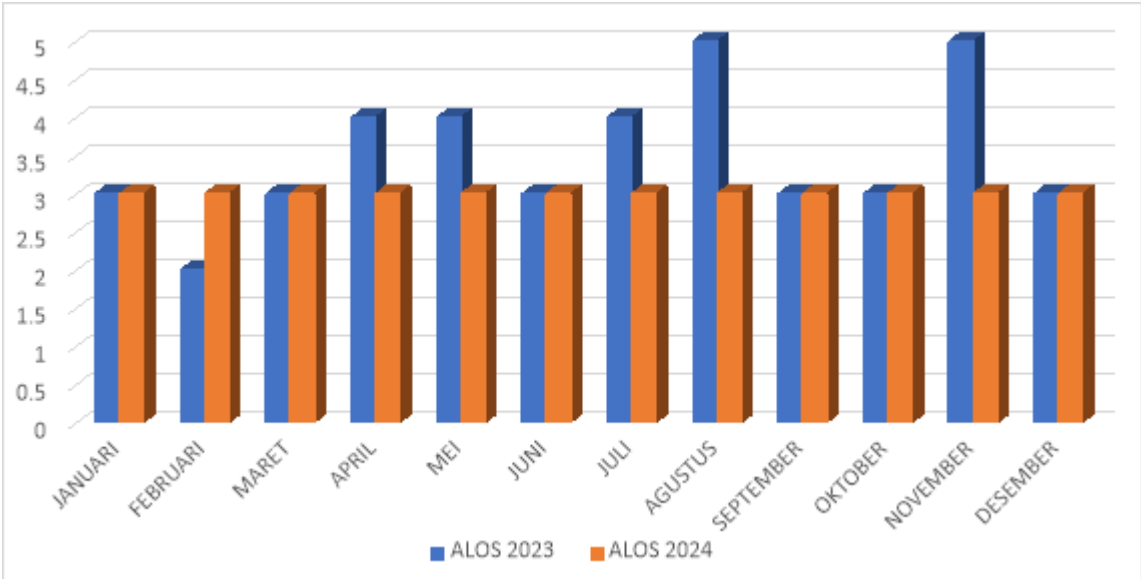
Terjadi penurunan BOR yang paling rendah di bulan januari (57%) hal ini di sebabkan penurunan jumlah kunjungan pasien di awal tahun, dikarenakan salah satunya adalah penyesuaian kebijakan sistem proporsi sehingga unit IGD dan DPJP sangat selektif dalam menerima pasien yang masuk agar tidak masuk proporsi.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Sosialisasi pada DPJP dalam rapat komite medik maupun diskusi per SMF untuk penjelasan sistem proporsi
 2. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk promosi ke FKTP dan perusahaan untuk meningkatkan kunjungan ke IGD

3.3.2.2.9 Tabel Perbandingan ALOS Tahun 2023 dan 2024

NO	JENIS PELAYANAN	ALOS 2023	ALOS 2024
1	JANUARI	3	3
2	FEBRUARI	2	3
3	MARET	3	3
4	APRIL	4	3
5	MEI	4	3
6	JUNI	3	3
7	JULI	4	3
8	AGUSTUS	5	3
9	SEPTEMBER	3	3
10	OKTOBER	3	3
11	NOVEMBER	5	3
12	DESEMBER	3	3
Total rata rata 1 tahun		3	3

3.3.2.2.10 Grafik Perbandingan ALOS Tahun 2023 dan 2024



Analisa :

Rata rata lama rawat seorang pasien pada periode tahunan (ALOS) tahun 2024 adalah 3 hari dan perbandingan untuk tahun 2023 juga sama rata rata alos 3 hari. Untuk tahun 2023 lebih bervariasi untuk tiap bulannya, sedangkan untuk tahun 2024 rata-rata per bulan sudah sesuai 3 hari, DPJP cenderung patuh dengan adanya kebijakan proporsi, sehingga lebih hati-hati dalam efisiensi lama rawat dan penggunaan terapi pasien

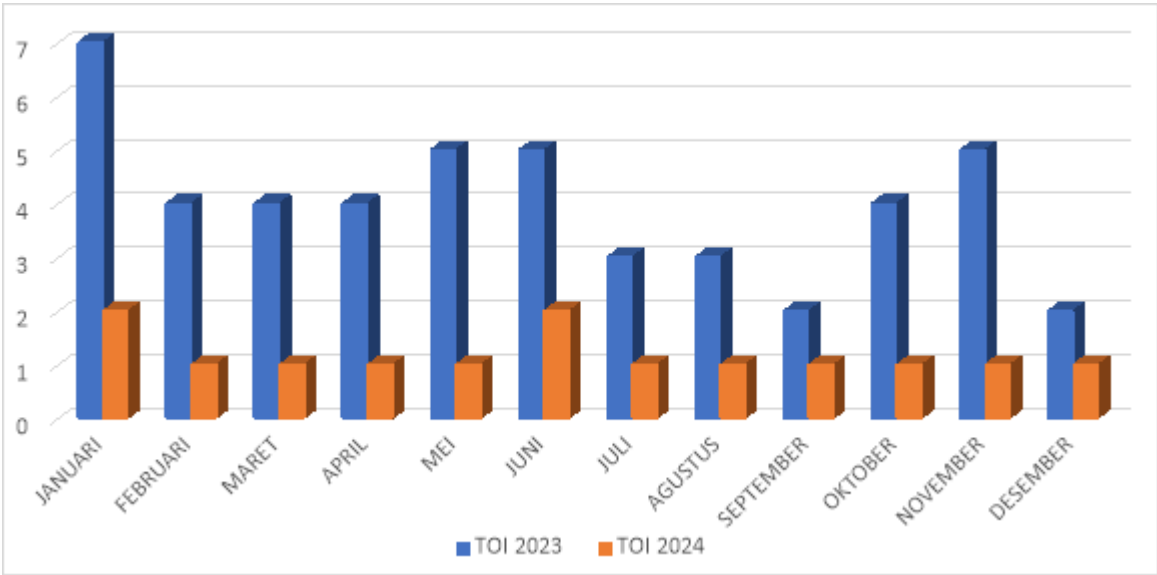
Rencana Tindak Lanjut :

Sudah sesuai standart sehingga perlu dipertahankan pada tahun 2025

3.3.2.2.11 Tabel Perbandingan TOI tahun 2023 dan 2024

NO	JENIS PELAYANAN	TOI 2023	TOI 2024
1	JANUARI	7	2
2	FEBRUARI	4	1
3	MARET	4	1
4	APRIL	4	1
5	MEI	5	1
6	JUNI	5	2
7	JULI	3	1
8	AGUSTUS	3	1
9	SEPTEMBER	2	1
10	OKTOBER	4	1
11	NOVEMBER	5	1
12	DESEMBER	2	1
Total rata rata 1 tahun		3	1

3.3.2.2.12 Grafik Perbandingan TOI tahun 2023 dan 2024



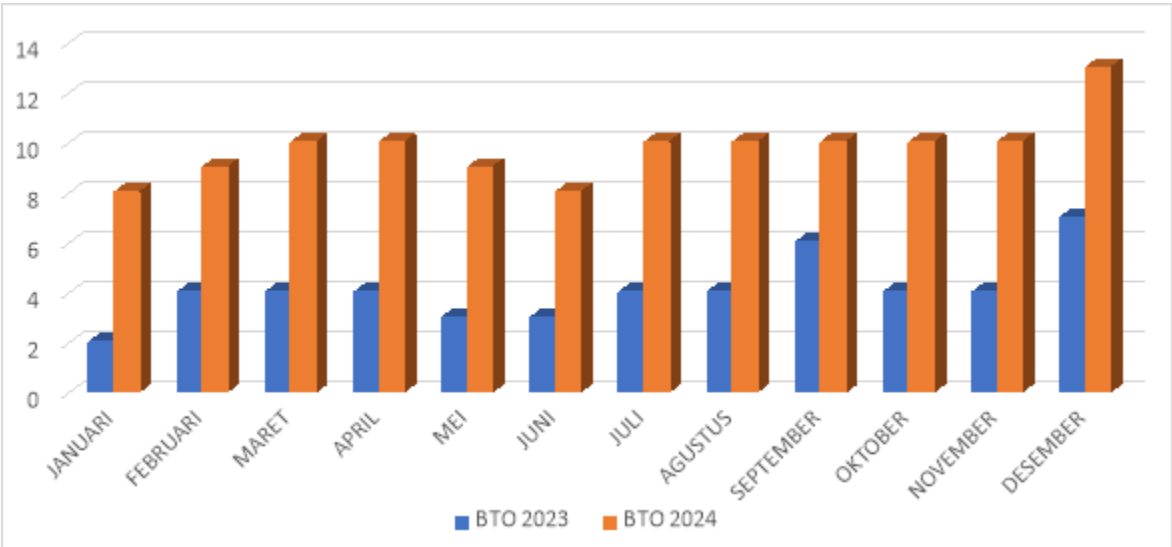
Analisa :
Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari,dari rata rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati pada periode tahunan (TOI) tahun 2024 adalah 1 hari sudah sesuai dengan standart depkes 1-3 hari dan untuk 2023 TOI (3 hari). Tidak ada masalah dalam hal ini dikarenakan 2024 sudah sesuai standar.

Rencana Tindak Lanjut :
Sudah sesuai standart sehingga perlu di pertahankan di tahun 2025

3.3.2.2.13 Tabel Perbandingan BTO Tahun 2023 dan 2024

NO	JENIS PELAYANAN	BTO 2023	BTO 2024
1	JANUARI	2	8
2	FEBRUARI	4	9
3	MARET	4	10
4	APRIL	4	10
5	MEI	3	9
6	JUNI	3	8
7	JULI	4	10
8	AGUSTUS	4	10
9	SEPTEMBER	6	10
10	OKTOBER	4	10
11	NOVEMBER	4	10
12	DESEMBER	7	13
Total pemakaian dalam 1 tahun		49	83

3.3.2.2.14 Grafik Perbandingan TOI Tahun 2023 dan 2024



Analisa:
Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali, tabel di atas setelah di analisa untuk BTO tahun 2024 rata rata tempat tidur di pakai 123 kali ,sudah sesuai dengan standard , dan di 2023 BTO (49 kali). Tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan standard.

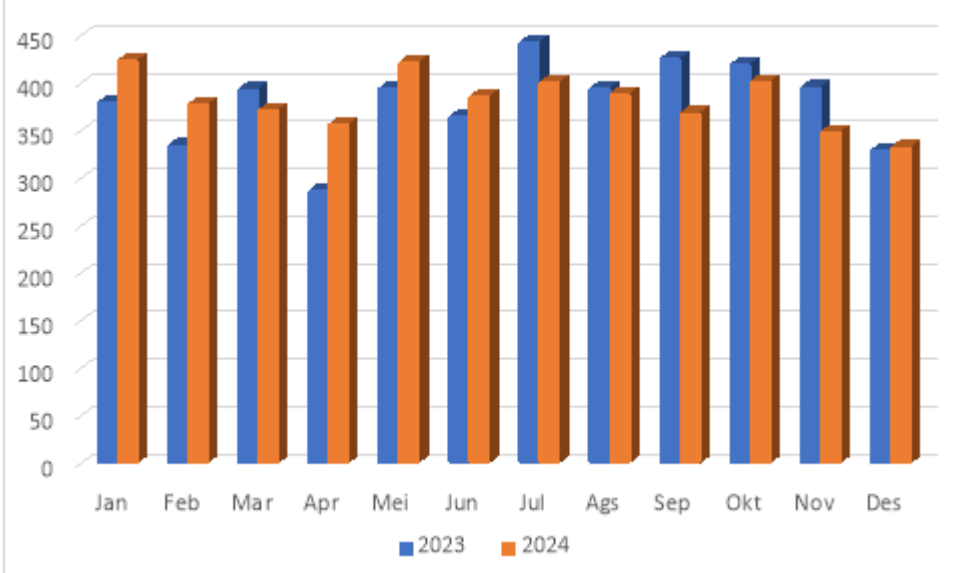
Rencana Tindak Lanjut :
Sudah sesuai standart sehingga perlu di pertahankan.

3.3.2.3 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.3.2.3.1 Tabel Jumlah Pasien Operasi di IKO Tahun 2023-2024

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1.	Khusus	62	40	66	62	56	73	53	61	62	59	68	56	714
2.	Besar	289	281	244	255	293	256	301	276	259	279	226	252	3353
3.	Sedang	5	7	1	1	0	4	2	4	4	4	0	0	23
4.	Kecil	66	48	59	37	71	51	43	46	42	58	53	23	783
Jumlah Tahun 2024		422	376	370	355	420	384	399	387	367	400	347	331	4873
Jumlah tahun 2023		378	333	392	285	393	363	441	393	424	418	394	328	4542

3.3.2.3.2 Grafik Jumlah Pasien Operasi di IKO Tahun 2023-2024



Analisa :
Pelayanan kamar operasi ditahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 4542 menjadi 4873 atau meningkat sebanyak 29.55%. Hasil ini didukung oleh adanya Dokter Spesialis tambahan sehingga peningkatan masing-masing dokter spesialis semakin besar dan memberikan kontribusi terhadap jumlah pelayanan dikamar operasi. Analisa lainnya adalah dengan banyak jenis tindakan operasi yang bisa dilayani, kelengkapan alat operasi serta penambahan kebutuhan SDM baik kualitas dan kuantitas.

Rencana Tindak Lanjut :
Mempertahankan dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan perbaikan layanan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2025

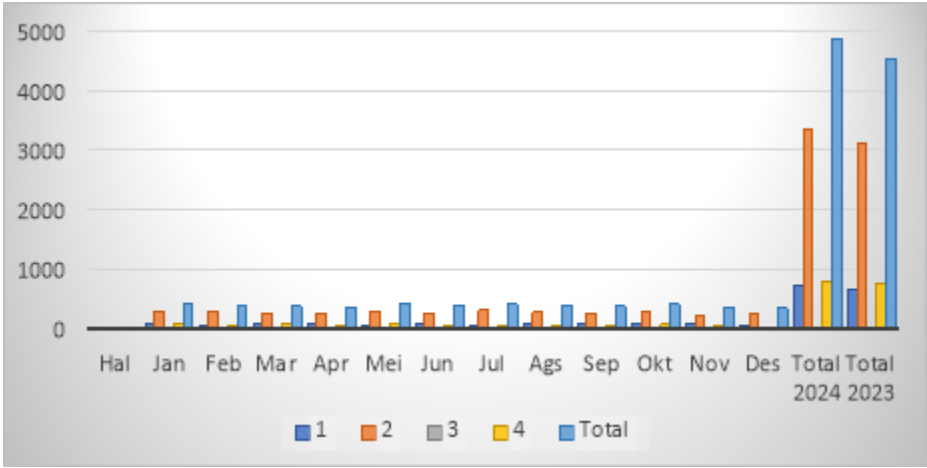
PDSA Kinerja Produktivitas IKO

Problem	Kunjungan Pelayanan IKO bulan Desember turun
Step	Mendata dan menganalisa jumlah pasien operasi dalam sebulan
Plan	Rencana : - Mengetahui penyebab kunjungan pasien operasi bulan desember - Pasien operasi terdiri dari operasi besar, sedang dan kecil. Operasi kecil diantaranya adalah op phaco mata yang turun signifikan karena adanya Batasan/kuota BPJS Kesehatan yang sudah habis untuk tahun 2024, sedangkan pasien phaco 100% adalah pasien bpjs kesehatan Harapan : Kunjungan pasien operasi meningkat di tahun 2025 Tindakan : 1. Meningkatkan kunjungan IGD, poli dan rawat inap 2. Kerjasama dengan FKTP, PSC, Klinik dan Bidan untuk pasien trauma maupun PONEK bisa dikirim ke RSPHM
Do	Koordinasi dengan humas untuk melakukan promosi branding kecepatan pelayanan IGD dan pelayanan poli yang lengkap, agar kasus operatif juga naik
Study	- Koordinasi apakah materi promosi branding kecepatan pelayanan IGD dan pelayanan poli yang lengkap bisa disosialisasikan di sosmed, komunitas, maupun perujuk - Membuat video pelayanan IKO dengan branding kecepatan pelayanan saat operasi - Koordinasi pembagian kuota phaco tahun 2025 mengacu pada operasi phaco 2024
Action	- Mensosialisasikan pembagian kuota phaco di awal tahun pada dokter mata, agar bisa dikalkulasikan tindakan phaco tidak turun di satu bulan saja, karena ada target per bulan dan akan di evaluasi tiap 3 bulannya - Video pelayanan unit IKO dan IGD sudah dibuat - Video pelayanan phaco sudah ada dari tahun sebelumnya, perlu di review kembali di tahun 2025 Rencana tindaklanjut : Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025 diharapkan kunjungan pasien rawat inap bedah plastik meningkat dari tahun 2024

3.3.2.3.3 Tabel Kunjungan Ruang IKO Menurut Cara Bayar Pasien Tahun 2023 – 2024

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL 2024	TOTAL 2023
1.	Khusus	62	40	66	62	56	73	53	61	62	59	68	56	714	658
2.	Besar	289	281	244	255	293	256	301	276	259	279	226	252	3353	3101
3.	Sedang	5	7	1	1	0	4	2	4	4	4	0	0	23	23
4.	Kecil	66	48	59	37	71	51	43	46	42	58	53	23	783	760
Total		422	376	370	355	420	384	399	387	367	400	347	331	4873	4542

3.3.2.3.4 Grafik Kunjungan Ruang IKO Menurut Cara Bayar Pasien Tahun 2023 – 2024



Analisis :
Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2024 didapatkan bahwa pelayanan kamar operasi ditahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 4542 menjadi 4873 atau meningkat sebanyak 29.55%. Hasil ini didukung oleh adanya Dokter Spesialis tambahan sehingga peningkatan masing-masing dokter spesialis semakin besar dan memberikan kontribusi terhadap jumlah pelayanan dikamar operasi. Analisa lainnya adalah dengan banyak jenis tindakan operasi yang bisa dilayani, kelengkapan alat operasi serta penambahan kebutuhan SDM baik kualitas dan kuantitas. Analisa terakhir adalah adanya peningkatan jumlah pelayanan pasien BPJS, BPJS ketenaga kerjaan serta pasien jasa raharja yang sudah bekerjasama dengan RS dan kepercayaan masyarakat akan kualitas dan kuantitas pelayanan dikamar operasi yang sangat bagus dan terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
Rencana tindak lanjut ditahun 2025 adalah dengan mempertahankan bahkan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan dibeberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2025 serta melakukan pembenahan terkait pembagian jam operasional operasi masing-masing DPJP. Serta tetap terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, SDM dan Humas Marketing RS serta program RS yang ada untuk terus melakukan supervisi berjenjang.

3.3.2.3.5 Tabel 10 Besar Tindakan Operatif Tahun 2024

NO.	DESKRIPSI	JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH	
1.	Bedah Umum:														
	Debridement Necrotomy	34	36	30	42	40	28	55	26	31	23	22	26	393	
	Excisi	39	25	15	28	33	25	41	38	33	30	24	27	358	
	Herniotomy	12	18	7	9	19	13	12	3	11	12	8	13	137	
	Laparatomy	10	4	9	5	6	9	10	10	4	10	7	6	90	
	Appendectomy	4	10	3	3	6	3	5	7	9	7	8	5	70	
	Biopsi	7	7	3	3	2	4	6	6	6	10	5	8	67	
	Hemoroidectomy	1	3	3	5	4	5	5	2	2	4	6	1	41	
	Cholesistectomy	3	2	1	0	5	4	3	1	4	2	0	5	30	
	Limfadenectomy	2	2	4	2	3	0	0	2	2	4	5	1	27	
	Repair	1	2	2	1	3	2	1	4	1	2	2	1	22	
2	Obgin														

	SC	77	73	72	67	74	75	78	84	60	77	54	44	835	
	Laparatomy	3	3	2	1	5	0	2	1	3	3	4	3	30	
	Histerectomy	1	3	3	4	2	2	1	2	1	2	1	3	25	
	Salpingooovorectomy	2	1	1	0	2	0	3	1	1	1	1	1	14	
	Kistectomy	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	8	
	Oovorectomy	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	6	
	Excisi	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4	
	SVH	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	4	
	Marsupialisasi	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4	
	Salphingektomy	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
3	Orthopedi														
	Orif	18	28	26	21	25	29	16	18	22	26	16	15	260	
	Remove Implant	23	9	16	13	9	23	10	15	14	16	10	16	174	
	Repair	11	12	12	17	8	11	10	7	16	14	12	13	143	
	Close Reduction	7	7	8	11	3	6	3	10	7	11	13	9	95	
	Debridement Repair	4	0	0	5	3	4	6	6	2	5	7	7	49	
	Release	1	1	0	3	1	3	2	1	1	3	1	2	19	
	Excisi	2	2	2	0	0	1	0	0	0	2	1	1	11	
	Partial Ostectomy	0	1	1	0	1	0	2	1	2	0	0	0	8	
	Squestectomy	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	6	
	Hemiarthoplasty	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	
4	Urologi														
	TURP	26	8	12	12	12	12	10	13	5	14	13	17	154	
	URS	10	6	11	11	12	10	5	10	10	12	20	6	123	
	URS + Aff Sten	2	6	15	6	9	8	5	2	4	3	6	7	73	
	ESWL	9	6	11	4	6	7	3	1	2	2	3	1	55	
	Vesicolithotripsi	1	5	5	2	2	5	4	5	2	0	3	2	36	
	Internal Uretrotomi	0	1	1	1	0	3	4	2	6	2	1	1	22	
	Varicocelectomy	1	2	2	2	1	2	3	1	2	1	0	1	18	
	Rekontruksi Penis	0	1	1	0	0	3	0	0	2	0	3	1	11	
	Meatotomy	0	0	0	0	3	0	2	1	1	1	1	1	10	
	Sitoscopy	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	
5	Bedah Plastik														
	Repair	6	4	4	6	11	9	6	8	8	6	8	14	90	
	Debridement	3	9	9	1	6	1	7	5	4	6	4	1	56	
	Rekontruksi+Platting	1	2	2	2	3	3	0	1	0	0	0	2	16	
	Excisi	4	0	0	1	4	0	1	1	3	0	0	0	14	
	Remove Achbar	0	1	1	1	3	0	0	2	2	1	2	0	13	
	Rekontruksi	1	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	0	8	
	Skin Graft	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	5	
	Flap	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
6	Mata														
	Phaco	57	41	49	34	61	39	30	35	46	42	44	10	488	
	Excisi	7	6	2	4	7	5	5	6	3	4	5	3	57	
	Extirpasi+Graft	1	1	1	1	2	1	5	9	3	8	3	8	43	
	Iridectomy	4	7	2	0	0	3	2	3	0	4	0	0	25	
	Explore Debridement	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	
7	THT														

	Tonsilectomy	2	2	2	3	1	0	3	1	0	2	3	0	19	
	Excisi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
8	Kulit dan Kelamin														
	Excisi	5	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	
	Enukleasi	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	
9	Bedah Syaraf														
	Excisional Debridement	-	-	-	-	0	0	1	3	1	2	2	1	10	
	Debridement	-	-	-	-	3	0	0	0	3	0	0	0	6	
	VP Shunt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	2	3	
	Evakuasi+Dekompresi	-	-	-	-	0	0	0	0	2	0	0	1	3	
	Craniotomy+evakuasi ICH+EVD	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	2	3	
	Repair	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	Craniotomy	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
	EVD	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Cranioplasty	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Burrhole	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

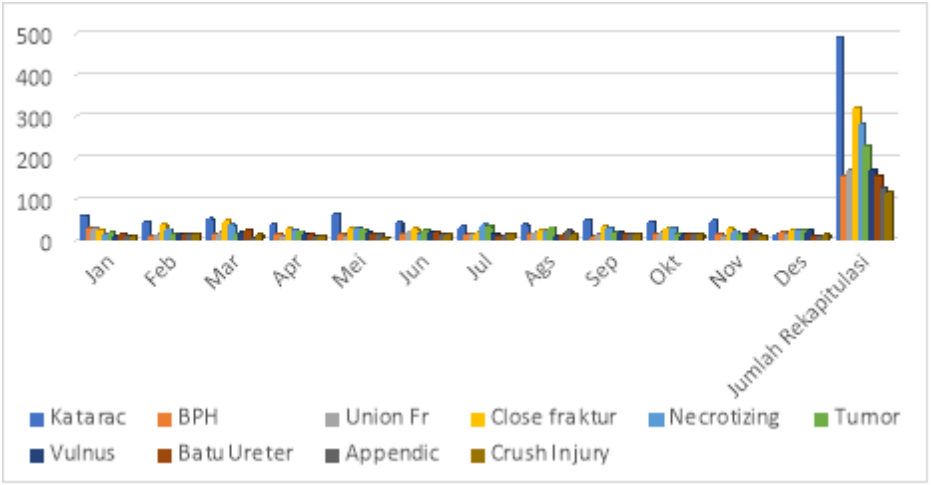
Analisa :
 Analisa 10 besar tindakan operasi tahun 2024 untuk tindakan operasi mata di batasi oleh bpjs sehingga tahun 2024 operasi mata mengalami penurunan,tindakan Excisi juga dibatasi oleh peraturan bpjs yang terbaru sehingga excisi yang tidak membahayakan pasien bisa dilkaukan di poli

Rencana Tindak Lanjut :
 Tetap mempertahankan kunjungan operasi yang naik akan tetapi sesuai dengan peraturan bpjs sehingga kunjungan tetap naik dan peraturan bpjs di patuhi oleh dpjp yang melakukan tindakan,target untuk tahun 2025

3.3.2.3.6 Tabel 10 Besar Diagnosa Operasi 2024

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH REKAPITULASI	KET
1.	Katarac	57	41	49	34	61	39	30	35	46	42	44	10	488	
2.	BPH	26	8	12	12	12	12	10	13	5	14	13	17	154	
3.	Union Fr	25	10	16	8	8	19	12	16	13	16	9	14	166	
4.	Close fraktur	23	34	44	26	27	25	15	21	31	25	25	21	317	
5.	Necrotizing	10	24	34	23	28	13	34	19	27	26	19	21	278	
6.	Tumor	17	14	11	19	24	22	30	29	15	13	12	21	227	
7.	Vulnus	9	10	18	14	16	17	14	8	16	11	14	20	167	
8.	Batu Ureter	12	11	21	11	12	15	9	10	14	12	20	7	154	
9.	Appendic	8	12	3	5	11	11	10	20	13	12	12	8	125	
10.	Crush Injury	7	11	11	7	4	10	12	10	12	10	8	10	112	

3.3.2.3.7 Grafik 10 Besar Diagnosa Operasi 2024



- Analisa :**
- 1. Jumlah operasi paling tinggi di rumah sakit prima husada malang yaitu oleh dr mata operasi katarak sebesar 488 pasien
 - 2. Jumlah operasi terbesar kedua dari dr othopedi sebesar 317 pasien
 - 3. Jumlah operasi pasien bedah dengan diagnose tumor sebesar 227 pasien

3.3.2.3.8 Tabel Utilitas / Penggunaan Kamar Operasi 2024

NO	JAM KEGIATAN OPERASI	JUMLAH PASIEN												RATA-RATA (3 KAMAR OPERASI)
		JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	05.00-06.00	33	20	10	13	18	20	12	11	11	8	3	13	57
2	06.00-07.00	65	52	55	56	69	51	55	58	54	55	45	49	221
3	07.00-08.00	35	37	40	41	43	49	49	50	49	40	37	43	171
4	08.00-09.00	21	23	32	29	40	31	28	41	47	44	39	34	136
5	09.00-10.00	16	14	26	19	17	23	15	15	18	27	13	18	74
6	10.00-11.00	12	13	10	15	29	12	18	11	13	17	11	10	57
7	11.00-12.00	13	7	5	13	6	10	8	7	4	6	7	6	31
8	12.00-13.00	13	12	14	8	13	13	3	4	6	12	8	7	38
9	13.00-14.00	18	20	25	16	20	17	7	15	19	21	22	22	74
10	14.00-15.00	12	8	12	12	15	12	2	11	10	9	21	15	46
11	15.00-16.00	6	6	17	16	11	14	8	10	7	9	12	20	45
12	16.00-17.00	30	20	21	31	20	27	29	43	27	20	19	18	102
13	17.00-18.00	17	12	13	17	13	13	23	15	17	22	12	9	61
14	18.00-19.00	22	9	4	7	13	14	5	12	8	8	7	3	37
15	19.00-20.00	25	32	6	6	11	9	20	20	10	18	17	17	64
16	20.00-21.00	9	19	7	13	5	9	7	10	8	8	11	9	38
17	21.00-05.00	4	16	13	5	6	4	6	6	11	8	5	7	30

3.3.2.3.9 Tabel Tindakan Anestesi 2024

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH REKAPITULASI	KET
Tindakan Anestesi di Kamar Operasi															
2.	GA	133	138	132	135	147	143	149	140	139	146	127	143	1672	
3.	Regional	218	182	177	182	202	186	205	198	182	195	174	165	2266	
4.	Lokal	71	55	66	38	71	55	44	49	46	62	54	23	634	
Tindakan Lokal Anestesi di Luar Kamar Operasi															
1.	Rawat Inap	6	6	7	5	7	11	13	8	10	18	6	16	113	
2.	Rawat Jalan	160		203	197	198	217	208	171	174	125	116	160	1929	
3.	IGD	0	17	17	-	-	17	-	-	23	12	38	-	124	
4.	Maternitas	46	39	42	45	50	42	43	41	47	56	51	44	546	
5.	ICU	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
6.	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tindakan Sedasi di Luar Kamar Operasi															
1.	Rawat Inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Rawat Jalan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	IGD	0	13	13	-	-	4	-	-	9	24	9	-	72	
4.	Maternitas	25	27	20	26	25	27	27	26	32	28	22	19	304	
5.	ICU	0	0	0	0	0	2	3	6	3	5	4	2	25	
6.	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

Analisa :
Hasil analisis tindakan Anestesi yang dilakukan di RS Prima Husada Malang baik yang dilakukan di dalam Kamar Operasi maupun di luar kamar operasi adalah:
Untuk di dalam kamar operasi tindakan dengan regional anestesi lebih sering dilakukan dibanding dengan general anestesi. Hal ini sesuai dengan tindakan yang paling sering di lakukan di kamar operasi yaitu SC dimana pada pasien-pasien SC dilakukan pembiusan dengan Regional Anestesi.
Untuk pelaksanaan tindakan Lokal anestesi yang dilakukan di luar kamar operasi dengan dilakukannya supervisi ke luar kamar operasi sehingga data dilaporkan serta tindakan yang dilakukan juga terpantau. Untuk tindakan local anestesi di luar kamar operasi kebanyakan dilakukan di rawat jalan dan maternitas, sedangkan untuk sedasi kebanyakan dilakukan di ruang maternitas.

Rencana Tindak Lanjut :
Tetap melakukan supervise terutama untuk tindakan anestesi yang dilakukan di luar kamar operasi, sehingga bila ada yang tidak sesuai agar bisa segera diluruskan

PDSA Kinerja Produktivitas IKO periode Tahun 2024

Problem	Penurunan jumlah pasien operasi pada akhir tahun
Step	Melakukan telusur penyebab terjadinya penurunan pasien operasi
Plan	Rencana : Menambah sarana dan instrumen untuk diversifikasi tindakan operasi Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan pasien operasi periode tahun 2024 Tindakan : a. Koordinasi dengan DPJP bedah terkait diversifikasi tindakan dan penambahan sarana serta instrument di kamar operasi

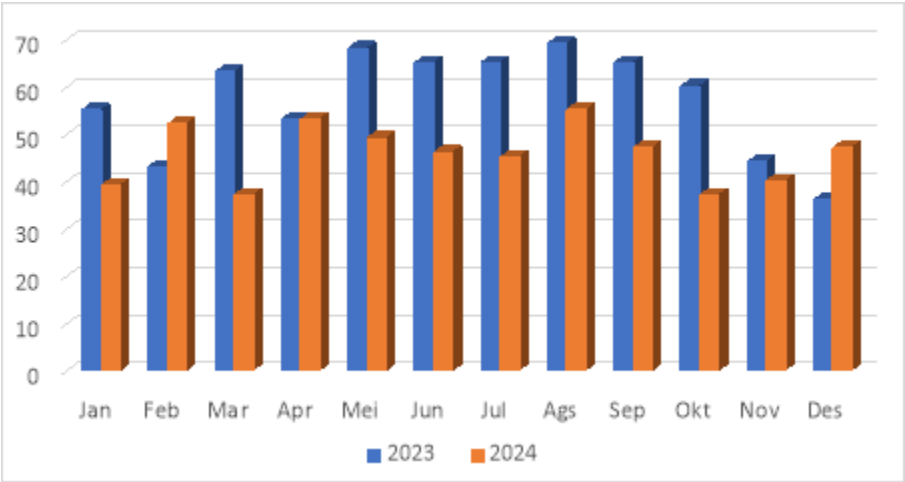
	b. Koordinasi dengan SDM untuk open recrutmen dokter gigi spesialis c. Koordinasi dengan humas dan marketing terkait promosi pengembangan pelayanan di kamar operasi d. Koordinasi dengan PKRS terkait pengembangan kamar operasi yang disampaikan di sosmed
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Cara meningkatkan kunjungan pasien IKO periode tahun 2025 Meningkatkan kunjungan di IGD terutama pasien asuransi,JR ,BPJS TK
Study	Apa yang anda pelajari ? . Cara meningkatkan kunjungan pasien IKO . Cara penambahan diversifikasi tindakan IKO . Menambah dokter spesialis yang menunjang operasi di IKO
Action	Apa yang anda pelajari ? - Diversifikasi tindakan dan penambahan sarana serta instrument di kamar operasi - Open recrutmen dokter gigi spesialis - Penyebaran terkait pengembagan IKO melalui sosmed Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi jumlah pasien operasi periode tahun 2024

3.3.2.4 Intensive Care Unit (ICU)

3.3.2.4.1 Tabel Jumlah pasien di ICU Tahun 2023-2024

THN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
2023	55	43	63	53	68	65	65	69	65	60	44	36	686
2024	39	52	37	53	49	46	45	55	47	37	40	47	547

3.3.2.4.2 Grafik Jumlah Pasien di ICU Tahun 2023-2024



Analisa :
 Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2024 didapatkan bahwa pelayanan rawat inap ditahun ini kondisi stabil . Karena pasien yang di rawat di ICU berjalan sesuai kriteria Keluar dan Masuk ICU, dan sesuai dengan pedoman pelayanan di Unit ICU. dan untuk pasien BPJS pasien yang di rawat di ruang ICU sesuai dengan tingkat Tipe RS tipe C.

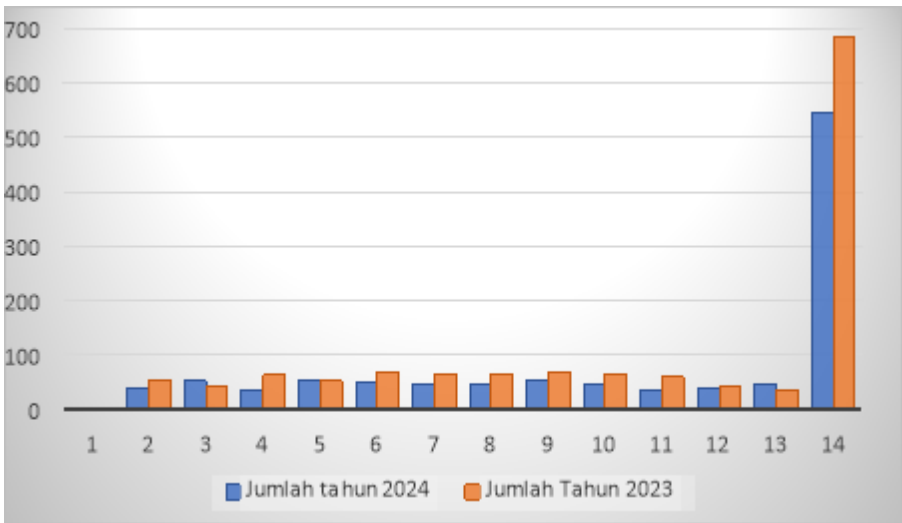
Rencana Tindak Lanjut :
 Mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan di beberapa yang kurang agar mampu

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2025 serta melakukan pembenahan terkait penambahan fasilitas sarana dan prasarana di Ruang ICU

3.3.2.4.3 Tabel Kunjungan Rawat Inap ICU Menurut Cara Bayar

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH REKAPITULASI	KET
1.	BPJS	34	48	35	51	46	45	41	52	43	34	37	45	511	
2.	UMUM	5	3	2	1	2	0	3	3	0	1	2	2	24	
3.	ASSURANSI	0	1	0	1	1	1	1	0	4	2	1	0	12	
4.	Pindahan	5	6	5	13	7	3	6	4	2	7	1	8	67	
5.	Di pindahkan	24	37	26	45	45	38	29	44	38	21	32	34	413	
6.	PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
7.	Rujuk	7	8	4	7	3	8	4	6	5	3	4	4	63	
8.	Meninggal	7	6	7	9	3	4	9	4	4	13	3	9	78	
Jumlah tahun 2024		39	52	37	53	49	46	45	55	47	37	40	47	547	
Jumlah Tahun 2023		55	43	63	53	68	65	65	69	65	60	44	36	686	

3.3.2.4.4 Grafik Kunjungan Rawat Inap ICU Menurut Cara Bayar



Analisa :
Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2024 didapatkan bahwa pelayanan rawat inap di ICU tahun 2024 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2023 . Karena ada beberapa kendala terkait proporsi untuk DPJP sehingga DPJP mengadviskan pasien di rawat inap biasa, dan sesuai dengan pedoman pelayanan di Unit ICU.

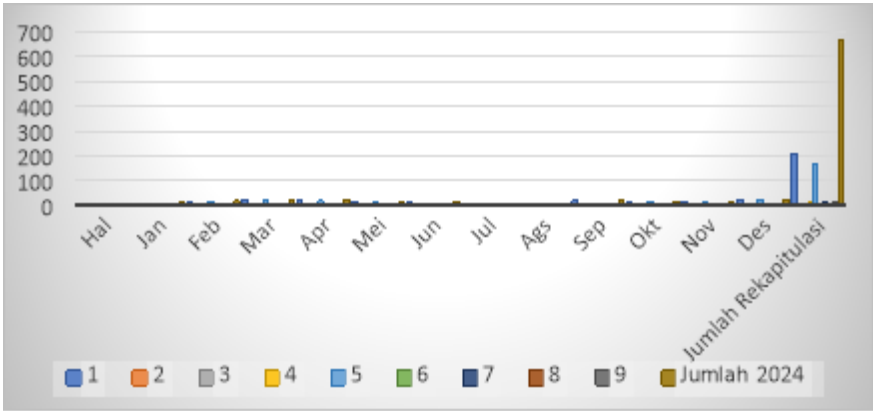
Rencana Tindak Lanjut :
Rencana tindak lanjut ditahun 2025 adalah dengan mempertahankan bahkan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan di beberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2025 serta melakukan pembenahan terkait penambahan fasilitas sarana dan prasarana di Ruang ICU. Serta tetap terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, SDM dan Humas Marketing RS serta program RS yang ada untuk terus melakukan supervisi berjenjang.

3.3.2.5 High Care Unit (HCU)

3.3.2.5.1 Kunjungan Rawat Inap HCU Menurut Cara Bayar 2024

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH REKAPITULASI	KET
1.	BPJS	11	18	25	24	18	16	7	9	21	19	17	26	211	
2.	UMUM	1	1	1	3	1	0	0	0	1	0	2	1	11	
3.	ASSURANSI	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
4.	Pindahan	4	3	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	12	
5.	Di pindahkan	11	14	21	20	15	11	6	6	8	18	17	25	172	
6.	PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Rujuk	1	0	4	0	1	1	1	1	3	0	0	0	12	
8.	Meninggal	1	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	11	
9.	KRS	0	0	0	5	3	3	0	0	0	0	1	2	14	
Jumlah 2024		12	20	26	27	19	16	7	9	22	19	19	27	668	
Jumlah 2023															

3.3.2.5.2 Grafik Kunjungan Rawat Inap HCU Menurut Cara Bayar 2024



Analisa :
Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2024 didapatkan bahwa pelayanan rawat inap ditahun ini kondisi belumi stabil . Karena HCU buka tahun 2024,pasien yang di rawat di HCU berjalan sesuai kriteria Keluar dan Masuk HCU, dan sesuai dengan pedoman pelayanan di Unit HCU. dan untuk pasien BPJS pasien yang di rawat di ruang HCU sesuai dengan tingkat Tipe RS tipe C

Rencana Tindak Lanjut :
Rencana tindak lanjut ditahun 2025 adalah dengan mempertahankan bahkan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan dibeberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2025 serta melakukan pembenahan terkait penambahan fasilitas sarana dan prasarana di Ruang HCU. Serta tetap terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, SDM dan Humas Marketing RS serta program RS yang ada untuk terus melakukan supervisi berjenjang.

3.3.2.6 Maternitas

NO	BULAN	KEGIATAN	JUMLAH YANG DIPANTAU/ DIOBERVASI	HASIL TEMUAN	AKAR MASALAH	RTL	PIC	KET
1	Januari	Pengecekan rekam medis skrining untuk resiko nutrisi sebagai bagian dari pengajian awal	15	Dari 15 rekam medis saat di cek di semua ruangan kelengkapan pengisian resiko nutrisi : Irna 2c menemukan perawat yang belum mengisi,oleh perawat yolan tidak mengisi ICU menemukan perawat yang belum terisi oleh perawat dwinta 4a menemukan perawat yang tidak mengisi perawat Maternitas menemukan bidan yang tidak mengisi atas nama elok,faiza 7a menemukan perawat yang tidak mengisi rekam medis atas nama cintya IKO dalam 1 bulan hanya 2x bongkaran	Ketidakpahaman tujuan pengisian	1.Menegur secara langsung perawat yang bersangkutan 2.Memberi tugas jika terulang kembali dalam bentuk edukasi ke pasien dan menghafal sop yang ada di rumah sakit yang berhubungan dengan akreditasi		Supervisi kembali untuk melihat kelengkapan rekam medis
2	Februari	Pengkajian awal keperawatan	8	1. IGD: menemukan ketidaklengkapan dalam pengisian rekam medis	Kurang teliti saat mengerjakan rekam medis	Menegur dan evaluasi		Supervisi kembali untuk melihat

		menghasilkan diagnosis keperawatan untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan, intervensi atau pemantauan pasien yang spesifik		terutama perawat baru yang orientasi 2. 3C : menemukan perawat lantai 3c yang pengisiannya tidak lengkap perawat dio, laras 3. 3A : menemukan perawat lantai 3a yang pengisiannya tidak lengkap oleh perawat sahri dan putra 4. 4A: menemukan perawat lantai 4a yang pengisiannya tidak lengkap oleh perawat iqbal, fifi 5. 5C : menemukan kekurangannya di penulisan diagnosa oleh perawat made 6. 6A : menemukan kekurangannya di penulisan diagnosa oleh perawat resti 7. 7A : menemukan kekurangannya di penulisan diagnosa oleh perawat inggar				kelengkapan rekam medis
		Penilaian OPPE juga meliputi peran tenaga medis dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja		1. IGD: 1 perawat tidak aktif dalam bekerja dan malas-malasan 2. 3C : 1 perawat orientasi yang belum paham alur dan rekam medis 3. 3A: 4 perawat 2 adaptasi dengan baik 2 belum bisa dalam adaptasi 4. Maternitas : 1 bidan orientasi beradaptasi dengan baik dan	Kurangnya bimbingan dan supervisi karu	Menegur karu dan memberikan pr untuk kepala ruangan supervisi setiap saat		

				5.1 staf perawat ,kurang paham alur dan tidak bisa adaptasi				
		Papan dinas		1.Papan dinas yang belum di tulis sesuai dengan jadwal hanya di lantai 8a	Kurang paham penggunaan paham dinas	Menegur karu dan memberikan pr untuk kepala ruangan supervisi setiap saat		
3	Maret	Penilaian tenaga kesehatan baru telah diberikan orientasi umum dan orientasi khusus sesuai	10	1. IGD: perawat jalu,risa seing malas-malasan dalam bekerja,kurang peka terhadap pasien 2. 2c: 1 perawat atas nama nurfy masih belum bisa di lepas sendiri 3. 3A :perawat nata masih kurang peka dalam pekerjaan	Kurangnya bimbingan dan supervisi karu	Konfirmasi ke petugas		
		Pengisian kartu stok	15	1. IKO Pengisian kartu stok belum sesuai tanggal	Kurangnya bimbingan dan supervisi karu			
		Penulisan ERM di rawat jalan	5	Dokter dpjp yang masih belum ttd di erm	Dr spesialis kurang paham dalam penyelesaian rekam medis	1. Asisten mengingatkan ke dokter untuk kelengkapan erm		
4	April	Proses yang diterapkan sesuai dengan ukuran rumah sakit,kompleksitas layanan,ketersedian staf terlatih,sumber	25	1.IGD :dari 25 perawat IGD yang mempunya acls hanya 4 orang yang lain sertifikat sudah tidak mati semua	SDM saat melakukan open rekrutmen sertifikat pelatihan di wajibkan harus	Memberikan surat edaran untuk mewajibkan semua medis mempunyai pelatihan sesuai		

		daya teknis,dan sumber daya lainnya		2.Irna :semua unit mengikuti pelatihan internal 3.Irja:semua unit mengikuti pelatihan eksternal	ada dan wajib hidup	dengan ketentuan unit		
		PPJA memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu pasien	12	1.IGD: 5 perawat IGD pada saat di temui di igd selalu memperknalkan diri ke semua pasien yang di temui 2.Irna: dari 8 perawat yang di temui saat supervisi 2 perawat tidak 5 s, 3.Irja :dari 4 perawat yang ditemui perawat irja sangat sopan dan santun	Kurangnya pahamiannya tujuannya dalam komunikasi yang baik	Menegur staf dan konfirmasi untuk memeberikan edukasi secara lengkap dan jelas		
		Bukti kelengkapan dan pengurutan sesuai dengan assembling	20	Pengurutan assembling rekam medis di rawat inap sudah sesuai tetapi masih ada perawat yang masih kurang bisa assembling dengan baik	Kurang teliti dalam penyusunan rekam medis	Menegur staf yang bersangkutan dan memberikan tugas untuk menyetorkan rekam medis ke verif		
		Terlaksananya pengkajian dan manajemen nyeri ke pasien dan di dokumentasikan di rekam medis	25	Pengkajian nyeri sudah dilakukan yang belum patuh ada di irna 3a	Belum dikerjakan sesuai dengan sop di karenakan crowdit	Menegur staf yang bersangkutan dan memberikan tugas untuk menyetorkan rekam medis ke verif		
		Terlaksana pemberian edukasi tentang konsekuensi dan menolak atau tidak melanjutkan tindakan	10	10 direkam medis pada saat di cek dan di supervise langsung semuanya edukasi dilakukan pada	Kurang pahamiannya perawat pelaksana pengisian	Mensosialisasi Kembali kepada semua staf jika ada pasien baru harus dijelaskan diawal pada saat masuk		

				saat krs ini harus di rubah system yang salah sperti ini	edukasi yang benar			
5	Mei	Staf memiliki kuku pendek dan bersih bebas dari ekstensi kuku atau kutek	16	Ara : Kuku Panjang	Kurang disiplin dalam menjaga kuku pendek	Menegur staf untuk selalu menjaga kuku pendek		
		Cek pengisian dan kelengkapan dokumen rekam medis lembar perlembar sesuai ketentuan	40	1. Asembling tidak berurutan oleh perawat wawa 2. Pengisian pengajian awal rawat inap oleh perawat nurfy 3. Perawat anis skrining resiko nutrisi tidak terisi 4. Perawat fifi tidak lengkap di pengkajian nyeri 5. Perawat putra di pengisian jam 6. Perawat dwinta tidak lengkap diawal medis kurang lengkap di bagian edukasi 7. Bidan mita tidak mengisi rekam medis berupa skrining resiko nutrisi	Kurang teliti dalam mengerjakan rekam medis	Menegur staf dan konfirmasi untuk melengkapi rekam medis		
		Keramahan perawat dalam merawat pasien	7	1. Perawat wawa di complain pasien dengan bernada tinggi	Edukasi yang kurang bagus	Menegur dengan baik perawat wawa dan membuat pelatihan komunikasi efektif dengan dr aslicah		

		Pengisian kartu stok di IKO yang belum konsisten di letakan keranjang	15	1. Semua perawat iko belum patuh dalam penulisan dan meletakkan kartu stok di keranjang	Penulisan kartu stok kurang efektif	Membuat rapat antara karu IKO dan farmasi membuat Keputusan Solusi		
		Asisten perawat rawat jalan tidak menyampaikan ke cso jika dokter tidak praktek	15	Perawat yuni salah dalam komunikasi ke pasien saat dokter praktek perawat menyampaikan tidak praktek, sehingga pasien dan dokter complain hal ini	Komunikasi yang salah antara dpjp dan perawat	Menegur staf		
6	Juni	Cek pengisian dan kelengkapan dokumen rekam medis lembar perlembar sesuai ketentuan	55	1. Perawat Yolanda ,laras ,ningrum tidak lengkap dalam penulisan rekam medis di pengkajian awal keperawatan tepatnya di berat badan dan tinggi badan 2. Perawat arlia dan adi tidak menulis skrining nutrisi 3. Perawat adi tidak lengkap skrining nyeri	Kurangnya teliti dalam menulis di rekam medis	Menegur staf		
		Penginputan visite dokter jaga IGD	12	1. Di temukan 2x inputan seharusnya 1 inputan	Kurangnya teliti dalam penginputan di simrs	Kolaborasi dengan karu lebih ketat dalam supervise karu		
		Return obat belum sesuai dengan SPO	15	Menemukan kurang patuhnya dalam return obat sesuai dengan pasien	Kurang disiplin dalam pemakaian obat dan jumlah return	Setiap memulangkan pasien kepala unit harus supervise Kembali yang dilakukan oleh perawat pelaksana		

7	Juli	Penampilan Staf	6	Aneta :Tidak Memakai Id Card Ketinggalan Dirumah	Kurang disiplin dengan tatib	Menegur staf		
		Penggunaan coolbox	6	wahyu : membawa methilergometrin tidak memakai coolbox	Kurang disiplin dengan peraturan yg sudah berlaku	Menegur staf		
		Cek penggunaan seragam dan aksesoris sesuai dengan tata tertib RS	18	Ara : Kuku Panjang Fifi:tidak memakai nametag Ulfa: tidak memakai nametag Sahri:tidak memakai nametag	Kurang disiplin dengan tatip	Menegur staf untuk memotong kuku sesegera mungkin.		
		Cek input tindakan di SIMRS	6	1. Wahyu dan elok: tindakan persalinan yg seharusnya diinput partus dokter, di input partus bidan, pasien asuransi vip 2. ara : input tindakan kuret dokter anastesi tidak di cantumkan 3. Penginputan dokter spesialis di input padahal jika pasien operasi sudah termasuk paket jika visite tidak perlu di input kembali	Kurang disiplin dalam menginputan di simrs Mengecek Kembali jika akan menginput visite dokter	1. Menegur staf dan membetulkan inputan di simrs 2. Menegur staf dan membetulkan inputan di simrs		
		Cek pengisian dan kelengkapan dokumen rekam medis lembar perlembar sesuai ketentuan	12	1.Perawat rudi dan mikail,perawat wawa,	Kurang teliti dalam mengerjakan rekam medis	Menegur staf yang bersangkutan dan diberikan tugas untuk mengawasi teman dinasny		

8	Agustus	Fasilitas rumah sakit	12	Cempaka 1 bel tidak nyala Dahlia 1 bel tidak nyala Lampu sorot tindakan lepas	Nurscall rusak, lampu sorot lepas	Lapor ke IPSRS dan sudah bisa dipakai lagi (ganti batreai) 12		
		Cek pengisian dan kelengkapan dokumen rekam medis lembar perlembar sesuai ketentuan	56	1.Perawat fahad,rini,rudi,nurfi dari 16 perawat yang saya temui yang kurang lengkap dalam pengisian rekam medis	Kurang teliti dalam mengerjakan rekam medis	Menegur staf yang bersangkutan dan diberikan tugas untuk mengawasi teman dinasny		
9	September	Pembuangan dan pemilahan sampah infeksius, benda tajam, dan sampah non infeksius sesuai tempat sampah	6	Plastik bekas infus dibuang di sampah infeksius	Kurang disiplin dalam pemilahan sampah	Menegur staf		
		Lain- Lain	11	1. Elok : tidak full up ke kasir tentang DP pasien BPJS bermasalah, operan dari IGD sudah DP tetapi ternyata belum DP 2. Mita : Botol minum selesai dinas tidak dikembalikan ke lemari 3. Rida : lemari ATK berantakan 4. Di PIPP tanggal 4 dan tanggal 5 tidak ada Quisioner masuk. Maternitas tanggal 4 ada pasien KRS 4 dan tanggal 5 ada 3 pasien KRS.	Kurang disiplin dalam pekerjaan di setiap shif	1. Menginfokan ke pasien untuk DP 2. Mengingatkan staf untuk selalu rapi di setiap dinas 3. Mengingatkan staf untuk membereskan lemari ATK 4. Setelah mengarahkan pasien mengisi quisioner, di cek Kembali apakah benar sudah mengisi apa belum. 5. Menginfokan ke pasien untuk		

				5. Barang- barang pasien tertinggal saat KRS 6. Buku KIA pasien tertinggal tidak diserahkan ke pasien saat KRS (3 pasien) 7. Aneta : Kabel monitor pasien setelah kuretage tidak ditata dengan rapi 8. Mita : Ada beberapa alat exp belum di steril ulang ke cssd 9. Tria,elok,fifi: Ceklis alat emergency tidak diisi 10. Tria, elok,fifi : ceklis troli emergency tidak diisi 11. Selesai memakai lemari B3 tidak dikunci Kembali. 12. Etorvel punya pasien tidak diserahkan saat KRS (kranjang pasien tertutup keranjang Rawat luka) 13. Rida : methilergometrin injeksi ada di coolbox sejak semalam belum dikembalikan ke farmasi 14. Handskond ginekologi sudah ada yang terbuka, ambil baru lagi, tidak memakai yg ada dulu 15. CSSD salah memberikan Gunting benang bukan punya maternitas 16. Ara : tidak rapi dengan barang2 pribadi dan tidak di taruh di lemari staf 17. Aneta : saat menyiapkan obat anastesi, di bak		- mengambil barang tertinggal saat kontrol poli 6. Menghubungi pasien untuk mengambil buku kia saat kontrol poli 7. Menegur staf untuk merapikan alat yang selesai dipakai 8. Menginfokan ke PJ alat untuk mensteril ulang ke sccd 9. Menegur staf untuk melengkapi 10. Menegur staf untuk melengkapi 11. Menegur staf untuk mengunci 12. Menghubungi pasien untuk mengambil 13. Menegur staf untuk membuang dan lebih disiplin lagi 14. Menegur staf 15. Konfirmasi ke cssd, alat sudah sesuai 16. Menegur staf untuk memasukkan	
--	--	--	--	---	--	--	--

				instrument menggenang cairan WI. 18. Ara dan Aneta : paket kuret yang seharusnya diinput selesai tindakan, sudah diinput sebelum tindakan Aneta : penempelan hasil laboratorium tidak sesuai ketentuan		barang pribadi ke lemari staf 17. Menegur staf untuk lebih rapi 18. Menegur staf untuk menginput sesuai prosedur Menegur staf untuk penempelan sesuai ketentuan		
9	September	Cek kesiapan lingkungan kerja/ fasilitas pendukung (AC, wastafel, dll)	-	1. gagang pintu kamar mandi cempaka 1-4 rusak 2. ac ginekologi tidak dingin , ac ginekologi ada suara keras, nyembur air dan mengeluarkan es 3. kloset ruang dahlia 1-4 tersumbat (di kloset ada plastik pembalut,)	Sarana prasarana perlu pembenahan	1. sudah di tindak lanjut 2. ac ginekologi tidak ada tindak lanjut 3. koordinasi dengan tim umum		
		Cek penggunaan seragam dan aksesoris sesuai dengan tata tertib RS	16	1. Aneta Tidak Memakai Id Card 2. Faid,elsa,sagita tidak memakai id card 3.	Kurang disiplin	Menegur staf untuk disiplin penggunaan troli emergency		
		Bongkaran	4	Dalam 1 bulan masih belum patuh bongkaran dilakukan 4x,pada saat di supervise bongkaran dilakukan 3x	Kurang disiplin dalam melakukan bongkaran di IKO	Menegur staf		
		ERM IGD dan Rawat jalan	12	Penulisan ERM IGD kurang lengkap dalam pengisiannya terutama bagian dokter, bagian perawat adanya ketidak sesuaian kondisi ttv	Kurang disiplin dan patuh penulisan sesuai dengan kondisi pasienn	Menegur staf		

				dan gcs pada pasien sama ERM yang di tulis				
10	Oktober	Penempatan kondisi pasien tidak sesuai	13	Dari 13 pasien yang saya supervise terutama bagian di IGD 1 pasien yang tidak sesuai dengan kondisi pasien, pasien yang seharusnya di tempatkan ke ICU ,DPJP meminta tetap di ruangan biasa	Proporsi DPJP	Kolaborasi dengan kapid pelayanan untuk bertemu mencari solusi		
		Cek kesiapan alat observasi pasien (TTV, Monitor, Syringpump, Infuspump, dll)	-	1. oksigen transport jarumnya tidak bisa naik (maternitas) 2. usg tidak bisa menyala 3. termometer rusak 4. Bed pasien tidak bisa di putar (6A) 5. Menemukan beberapa computer yang belum dimatikan setelah praktek (Irja)		1. lapor IPSRS dan sudah bisa 2. lapor ipsrs dan sudah di kasih UPS lapor ipsrs dan sudah di ganti yang baru		
		Cek penggunaan seragam dan aksesoris sesuai dengan tata tertib RS	16	1. perawat IGD 2 orang tidak memakai nametag 2. Perawat lantai 8a 2 orang tidak memakai nametag	SDM yang tidak paham tata tertib peraturan rumah sakit	Menegur staf yang bersangkutan		

				3. Banyaknya seragam yang tidak sama yang diberikan sdm sehingga saat dilihat tidak elok di pandang				
		Masalah E-Casemix	45	1. Menemukan beberapa kendala saat E-casemix keluhan pasien yang tidak sesuai dengan diagnose dokter	Kurang telitinya dokter dpjp dalam penulisan diagnose dan pengisian rekam medis	Berkoordinasi dengan kabid pelayanan menemui dokter dpjp untuk pengisian rekam medis		
		Kepatuhan Dalam return obat		1. Menemukan oabat-obatan yang di IKO belum terreturn dengan baik dan masih di simpan di dalam IKO	Kurang disiplin terhadap return obat	Menegur karu setiap hari supervisi		
11	November	Cek input tindakan di SIMRS	6	Wahyu salah input resep paket partus di billing, harusnya ada centang nya	Kurang disiplin dalam penginputan di simrs	Menegur staf		
		Cek kesiapan alat observasi pasien (TTV, Monitor, Syringpump, Infuspump, dll)	-	1. Part tabung oksigen tanspor lepas 2. Print usg tidak bisa	Part tabung lepas tidak ada yang tahu	Lapor ipsrs		
		Cek kesiapan lingkungan kerja/ fasilitas pendukung (AC, wastafel, dll)	-	1. AC ruang ginekologi tidakdingin 2. Lampu ruang bougenfil redup 3. Remote ruang bougenfil sudah di ganti baterai tidak bisa digunakan 4. Atap ruang tindakan 1 bocor		Lapor ipsrs		

				5. Dispenser air tidak panas 6. Closet dahlia 5-7 tidak keluar air				
		Masalah etiket pasien tidak sama dengan nama pasien	2	Menemukan SEP yang di input oleh pendaftaran tidak sama dengan nama pasien (4a)	Kurang teliti dalam menginput pasien baru	Berkoordinasi dengan kabit penunjang untuk memperbaiki system yang belum baik		
		Cek penggunaan seragam dan aksesoris sesuai dengan tata tertib RS	15	Menemukan 6 orang yang belum pakai nametag	Kurang disiplin kepatuhan perawat dalam memakai nametag	Menegur staf dan edukasi pasien		
		Pengisian survey rumah sakit dan bpjs	5	Dalam pengisian survey ada beberapa dendala anantara laian 1.pasien tidak mempunyai data di hpnya 2.Hp ketinggalan 3.Tidak paham mengisinya	Tidak pahamnya pasien dalam pengisian survey	Berkoordinasi dengan karu unit untuk patuh dalam pengisian survey		
12	Desember	Kepatuhan return obat	8	Dari 8 unit di temukan 5 unit yang tidak patuh return obat	SDM yang kurang patuh dalam return obat	Berkoordinasi dengan kabit penunjang untuk dilakukan sidak		
		Transfer pasien	2	Menemukan bebrapa kali pasien yang di transfer dari IGD ke unit selalu lama ada bebrapa kendalla	Irna yang masih mempersulit IGD menaikan pasien	1.Koordinasi dengan IGD jika ada yang mempersulit		

				1.irna masih ada beberapa alasan jika pasien akan di naikan 2.pada saat crowdit perawat masih melakukan banyak tindakan		catat nama dan di serahkan kabit keperawatan		
		Penginputan pasien di v-claim rehab medik		Program dari bpjs semua pasien yang masuk di rehab medik di tulis di v-claim	Program baru	1.Koordinasi dengan kabit pelayanan untuk penginputan		
		Penginputan obat di IGD		Menemukan beberapa pasien yang belum di input oleh IGD	Kurang teliti dalam penginputan obat	1.Kerjasama dengan bagian farmasi jika belum di input akan segera di follow up dan segera di input		
		Salah transfer pasien		Menemukan 1 kasus dalam transfer pasien dari IGD,yang seharusnya masuk ICU tetapi di tempatkan di rawat inap biasa	Komunikasi yang kurang efektif	Teguran lisan		

3.3.3 Umum
3.3.3.1 Humas – Marketing

NO	RENCANA PROGRAM	TARGET	RINCIAN KEGIATAN	HASIL KINERJA
1	MCU		1. Kunjungan ke Perusahaan rekanan, menawarkan program MCU karyawan 2. Mamanfaatkan bulan pendaftaran siswa baru / mahasiswa baru, promosi MCU kepada Institusi pendidikan	MCU belum memenuhi target, harga MCU lebih mahal dari vendor lain, sehingga banyak pihak kedua yang mundur dan memilih vendor dengan penawaran harga lebih murah
2	Baby Spa	-	1. Bayi baru lahir gratis baby spa selama 2 kali 2. Baby spa ke 3 berbayar	Belum terlaksana
3	Digital Marketing	-	1. Mengupload jenis pelayanan di monitor lift 2. Membuat promosi di Sosmed	Sudah terlaksana setiap bulan

3.3.3.2 PKS – IKS
3.3.3.2.1 Tabel Pencapaian Kinerja PKS – IKS Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH IKS BARU	TARGET IKS BARU PER BULAN	PROSENTASE TERPENUHI (%)
1	Januari	4	5	80
2	Februari	3	5	60
3	Maret	4	5	80
4	April	1	5	20
5	Mei	1	5	20
6	Juni	0	5	0
7	Juli	4	5	80
8	Agustus	2	5	40
9	September	2	5	40
10	Oktober	5	5	100
11	November	5	5	100
12	Desember	3	5	60
Prosentase terpenuhi dalam satu tahun			56,66 %	



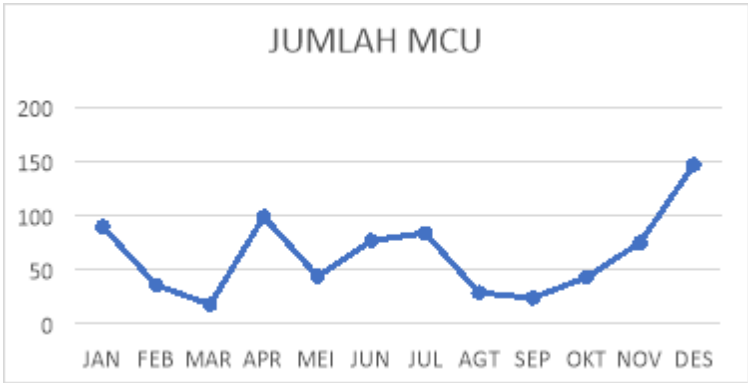
- Evaluasi :
- 1. Target PKS – IKS baru dalam satu tahun hanya memenuhi sebesar 56,66%
 - 2. Draft yang dikirim ke perusahaan masih dalam tahap review.
 - 3. Follow up ke perusahaan sudah dilakukan, tapi belum ada feedback.

3.3.2.6.2 Medical Check Up

3.3.2.6.2.1 Tabel Pencapaian Hasil Kinerja MCU Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH MCU
1	Januari	90
2	Februari	36
3	Maret	18
4	April	99
5	Mei	44
6	Juni	77
7	Juli	84
8	Agustus	29
9	September	24
10	Oktober	43
11	November	75
12	Desember	147

3.3.2.6.3 Grafk Pencapaian Hasil Kinerja MCU Tahun 2024



Analisis :
Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien MCU rata – rata 63 orang perhari, tidak mencapai target yang diinginkan yaitu 100 orang per hari. Penawaran MCU ke berbagai perusahaan dan instansi sudah dilakukan, tetapi kita kalah bersaing terkait harga.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Melakukan promosi program MCU ke perusahaan dan media sosial.
 - 2. Menjalin kerjasama dengan perusahaan maupun komunitas

- Melakukan kunjungan ke perusahaan dengan mempromosikan layanan rumah sakit
- Mereview tarif/ biaya pemeriksaan

3.3.2.6.3 Digital Marketing

BULAN	FOLLOWER			UNFOLLOW		
	INSTAGRAM	YOUTUBE	TIKTOK	INSTAGRAM	YOUTUBE	TIKTOK
Januari	13877	140	-	265	0	-
Februari	14076	140	-	22	0	-
Maret	14353	152	-	22	0	-
April	14692	158	-	18	0	-
Mei	15034	250	-	29	0	-
Juni	15181	251	-	31	0	-
Juli	15493	255	-	13	0	-
Agustus	15716	260	-	8	0	-
September	15931	264	65	30	0	-
Oktober	16218	265	121	23	0	0
November	16510	273	143	15	0	0
Desember	16818	281	164	19	0	0

Analisis :

- Digital marketing untuk mengelola Youtube belum ada masih menjadi satu di PT.
- Follower Instagram meningkat karena tim PKRS aktif melakukan upload dan promosi di media sosial.
- Akun baru Tiktok RSPH membantu dalam digital marketing

Rencana Tindak Lanjut :

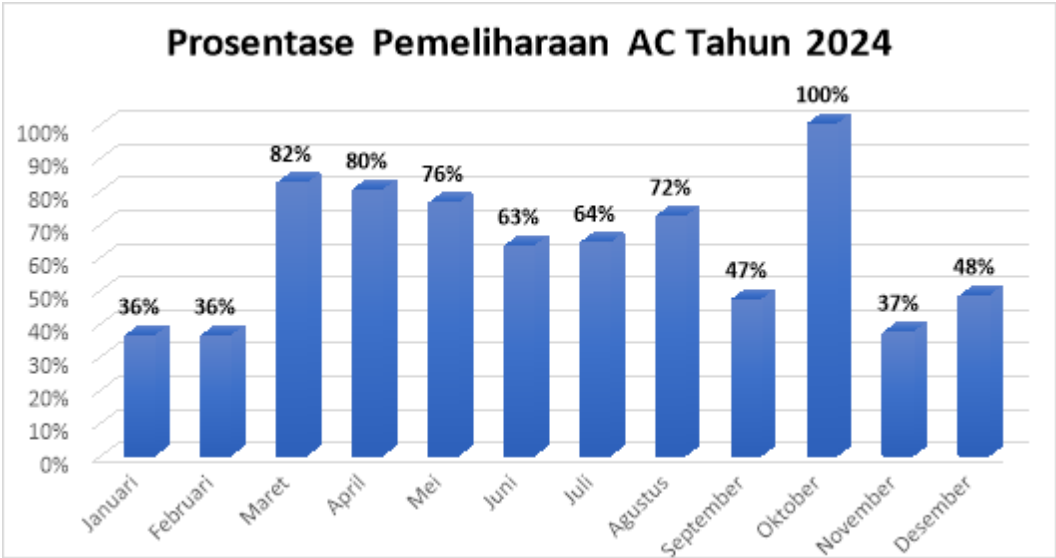
Membuat tim untuk pengelolaan digital marketing

3.3.3.2 IPSRS
3.3.3.2.1 Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	TARGET	CAPAIAN TOTAL	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	95 unit	35 unit	36%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
2	Februari	95 unit	35 unit	36%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
3	Maret	95 unit	78 unit	82%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
4	April	95 unit	76 unit	80%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC

					(System monitoring pemeliharaan AC)
5	Mei	95 unit	73 unit	76%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
6	Juni	95 unit	60 unit	63%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
7	Juli	95 unit	61 unit	64%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
8	Agustus	95 unit	69 unit	72%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
9	September	95 unit	45 unit	47%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
10	Oktober	95 unit	124 unit	100%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
11	November	95 unit	36 unit	37%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)
12	Desember	95 unit	46 unit	48%	Sesuai jadwal pemeliharaan AC (System monitoring pemeliharaan AC)

3.3.3.2.2.1 Prosentase Pemeliharaan AC Tahun 2024



Analisa :
Secara Umum di tahun ini ada peningkatan karena adanya system reminder yang dimiliki unit IPSRS terkait maintenance AC. Namun pada bulan November dan desember terjadi penurunan terindikasi adanya gangguan pada system tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :
Perbaiki sistem dan reminder target maintenance.

3.3.3.2.2 Perbaikan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH PERBAIKAN AC	% DARI TOTAL JUMLAH AC / 187 UNIT
1	Januari	41 unit (by pelaporan)	21%
2	Februari	48 unit (by pelaporan)	25%
3	Maret	31 unit (by pelaporan)	16%
4	April	17 unit (by pelaporan)	10%
5	Mei	31 unit (by pelaporan)	16%
6	Juni	15 unit (by pelaporan)	10%
7	Juli	19 unit (by pelaporan)	10%
8	Agustus	11 unit (by pelaporan)	10%
9	September	8 unit (by pelaporan)	10%
10	Oktober	5 unit (by pelaporan)	10%
11	November	20 unit (by pelaporan)	10%
12	Desember	29 unit (by pelaporan)	15%

3.3.3.2.1 Grafik Prosentase Perbaikan AC Tahun 2024



Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi untuk tahun 2025

3.3.3.2.2 Pemeliharaan Genset

- a. Utilitas : Genset
- b. Jumlah : 1 unit (Hartec 350 KVA)
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 4/bulan
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	De S
Nilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3.3.2.2 Grafik Presentase Pemeliharaan APAR Tahun 2024



Analisa :
Terpelihara sesuai jadwal

Rencana Tindaj Lanjut :
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.2 Pemeliharaan Panel Listrik

- a. Utilitas

b. Jumlah

c. Frekuensi Pemeliharaan

d. Target pemeliharaan
- : Panel Listrik

: 4 Gedung
 - Panel LV = 50 unit
 - Panel SDP = 5 unit
 - Panel ATS = 3 unit

: 4x/bulan

: 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN											
4 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

3.3.3.2.2.1Grafik Prosentase Pemeliharaan Panel Tahun 2024



Analisa :

Terpelihara sesuai jadwal

Rencan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.6 Pemeliharaan APAR

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN											
1 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.3.2.6.1 Grafik Prosentase Pemeliharaan APAR 2024



Analisa :
Terpelihara sesuai jadwal

Rencana Tindak Lanjut :
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.6 Pemeliharaan Hydrant

- a. Utilitas : Hidrant
- b. Jumlah : 16 unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 1x/bulan
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN											
1 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.3.2.6.1 Grafik Prosentase Pemeliharaan Hydrant Tahun 2024



Analisa :
Terpelihara sesuai jadwal

Rencana Tindak Lanjut :
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.6 Pemeliharaan IPAL

- a. Utilitas : IPAL
- b. Jumlah : 1 unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 1/bulan (Pemeliharaan Kebersihan/Pengurasan Kolam Monitoring Outlet dan Inlet)
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
1 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.3.2.6.1 Grafik Prosentase Pemeliharaan IPAL Tahun 2024



Analisa :
Terpelihara sesuai jadwal

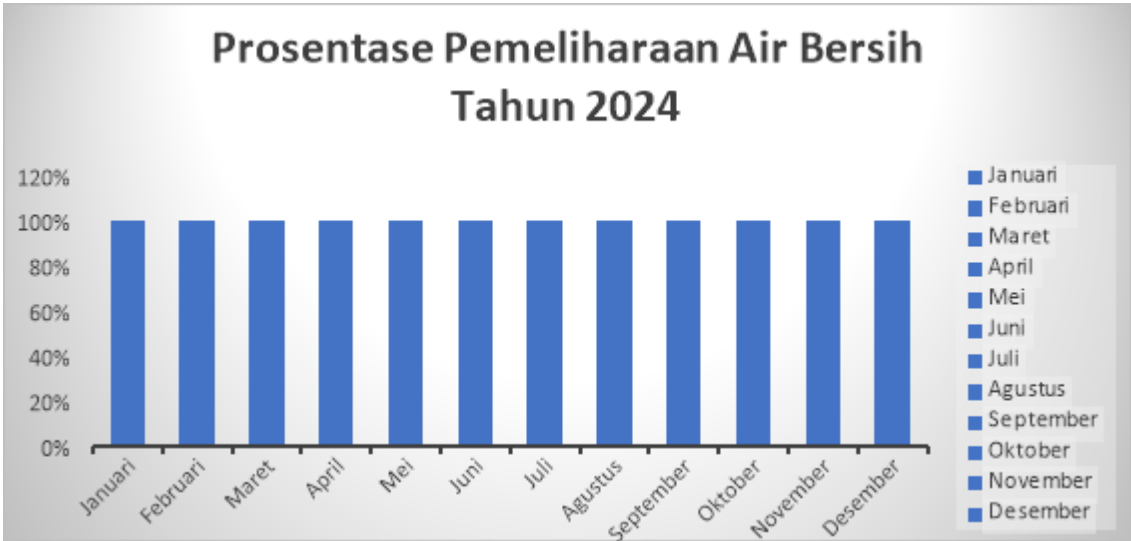
Rencana Tindak Lanjut :
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.6 Pemeliharaan Air Bersih

- a. Utilitas : Air Bersih Torn Air Bersih
- b. Jumlah : 12 unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 4/bulan
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
4 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.3.2.6.1 Grafik Prosentase Pemeliharaan Air Bersih Tahun 2024



Analisa :
Terpelihara sesuai jadwal

RTL :
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.6 Pemeliharaan Ac Cassette

- a. Utilitas : AC Cassette
- b. Jumlah : 27 unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 2 bulan/sekali oleh vendor CV. Berkah Jaya AC
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
1 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%

3.3.3.2.6.1 Grafik Angka Pemeliharaan AC Casette Tahun 2024



Analisa :
Terpelihara sesuai jadwal

RTL :
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.10.2 Pemeliharaan Lift (Vendor)

- a. Utilitas : Lift

- b. Jumlah : 5 unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 1/bulan
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
1 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.3.2.10.2.1 Grafik Prosentase Pemeliharaan Lift Tahun 2024



Analisa :
 Terpelihara sesuai jadwal

Rencana Tindak Lanjut :
 Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.7Pemeliharaan Tabung Oksigen dan Liquid Oksigen

- a. Utilitas : O2 dan Likuid
- b. Jumlah : 2 unit (Tabung Oksigen O2 dan Likuid O2)
- c. Frekuensi Pemeliharaan : Setiap Hari
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
30 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	De s
Nilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3.3.2.7Pemeliharaan Air Minum

- a. Utilitas : Air Minum
- b. Jumlah : 1 unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 4/bulan
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3.3.2.12.1 Grafik Prosentase Pemeliharaan Air Minum 2024



3.3.3.2.7Pemantauan Pengawasan Vektor dan Rodent

- a. Utilitas : Pemantauan pengawasan vektor dan rodent dengan PT. Rentokil Malang
- b. Jumlah : 10 Unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 2 x / Bulan
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
2 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.3.2.13.1 Grafik Prosentase Pengawasan Vektor dan Rodent Tahun 2024



Analisa :
 Terpelihara sesuai jadwal

Rencan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.7Pemeliharaan Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan 2

- a. Utilitas : Filter Air Bersih Poli Gigi
- b. Jumlah : 2 unit
- c. Frekuensi Pemeliharaan : 4/bulan
- d. Target pemeliharaan : 100%

TARGET PER BULAN	HASIL CAPAIAN / 100%											
4 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	D
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1

3.3.3.2.14.1 Grafik Prosentase Pemeliharaan Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan 2



3.3.3.2.7 Tabel Jumlah Laporan Keluhan Sarana Prasarana

BULAN	LAPORAN BY SIMIPSRs	LAPORAN MANUAL	TOTAL LAPORAN
JANUARI	47	40	87
FEBRUARI	29	45	74
MARET	17	56	73
APRIL	10	73	83
MEI	9	38	47
JUNI	8	55	63
JULI	0	47	47
AGUSTUS	0	70	70
SEPTEMBER	2	94	96
OKTOBER	0	101	101

NOVEMBER	0	139	139
DESEMBER	1	106	107

3.3.3.2.7Grafik Total Jumlah Laporan Kelauhan IPSRS Tahun 2024



Analisa :

Dalam grafik ini terlihat adanya peningkatan keluhan dikarenakan proses pencatatan admnistrasi laporan mulai membaik.sehingga setiap keluhan yang masuk mulai lebih tercatat. Hal ini tidak ditemukan pada tahun 2023 dan masih beradaptasi pada tahun 2024 di 4 Bulan Pertama. Di 4 bulan terakhir terjadi koreksi pada instrument yang digunakan sehingga lebih rapi.

Rencana Tindak Lanjut :

Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3.2.7 ATEM

3.3.3.2.7.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis Berdasarkan Ruangan

KET	TARGET	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Capaian Maintenance Ruangan	90%	93,94	90,91	79.41	70.59	88.24	82.85	45,71%	94,73%	97.43%	92.30%

TOTAL ALAT (MAINTENANCE)	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Oktober	267	187	70.03%
November	268	194	72.38%
Desember	268	207	77.23%

Analisa :

Pada capaian pemeliharaan alat medis target ruangan 90% tercapai. Pada bulan September angka 45.71% merupakan angka maintenance Atem RS sebelum dan setelah perugas kalibrasi datang, namun pada bulan tersebut alat tetap di maintenance dengan agenda kalibrasi oleh vendor sehingga tetap terjaga pada bulan tersebut. Tiga bulan terakhir terdapat metode pencatatan baru yang lebih baik sehingga dapat dimonitor untuk capaian per alat.

Rencana Tindak Lanjut :

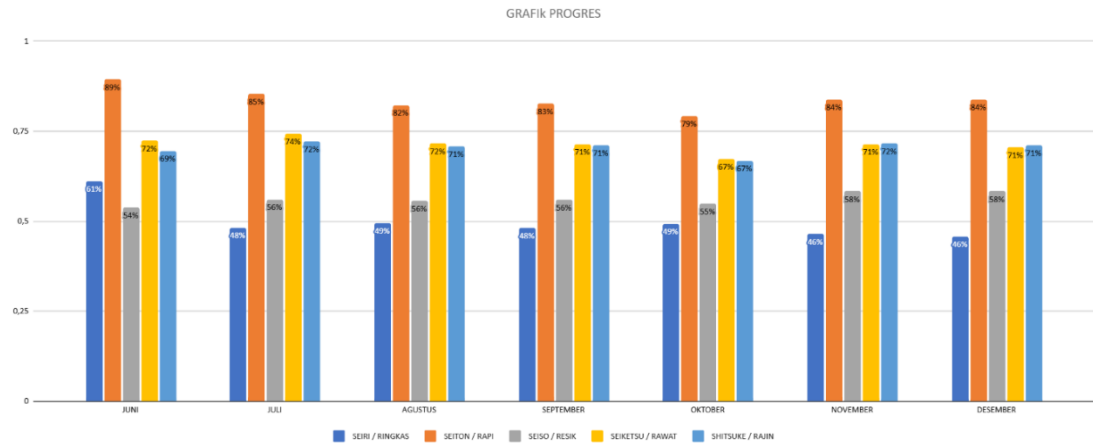
Mempertahankan kinerja dengan tetap monitoring dan evaluasi

3.3.3 Cleaning Service

3.3.3.3.1 Tabel Progres Kinerja Produktivitas

JENIS	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
SEIRI / RINGKAS	61%	48 %	49,38%	48%	49,3%	46%	45,81%
SEITON / RAPI	89%	85 %	82,21%	83%	79,2%	84%	83,78%
SEISO / RESIK	54%	56 %	55,67%	56%	54,8%	58%	58,26%
SEIKETS U / RAWAT	72%	74 %	71,51%	71%	67,2%	71%	70,51%
SHITSUK E / RAJIN	69%	72 %	70,74%	71%	66,9%	72%	71,03%

3.3.3.3.2 Grafik Progres Kinerja Produktivitas



SEIRI / RINGKAS	DESKRIPSI
Penempatan Alat Kebersihan di Janitor	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Janitor. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Janitor, peralatan kebersihan ditempatkan ppada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Penempatan alat kebersihan di Trolley	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Trolley. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Trolley, peralatan kebersihan ditempatkan pada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Kondisi bak pembersih / kereta peras	Kondisi bahan pembersih yang ada di bak pembersih / ketreta peras tidak kotor. Maksimal 2x penggantian. Jika sebelum 2x sudah kotor amaka harus diganti. Pel harus dalam kondisi bersih
SEITON / RAPI	
Kerapian baju petugas CS	CS menggunakan baju sesuai seragam dengan rapi dan bersih
Penggunaan ID card	CS Menggunakan id card sesuai aturan
Penanganan sampah Medis dan Non Medis	

Penempatan sampah medis dan nonmedis	tempat sampah diberi kantong plastik sesuai warna dan fungsinya. Sampah medis dan nonmedis tidak boleh tercampur.
Penempatan plastik	Tempat sampah dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh, tidak kotor, tidak ada sampah berceceran
SEISO / RESIK	
Lantai	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih, dan sudut lantai harus bebas noda.
Langit – Langit / Plafon	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kaca Luar – Dalam	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, bebas noda, dan mengkilap.
Jendela / Tralis	Jendela / tralis bersih, tidak berdebu, dan tidak bernoda.
Tirai (vertical blind, gordyn)	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan rapi.
Lampu	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Saklar & stopkontak	Tidak berdebu, tidak bernoda, dan tidak basah.
Sarana pemadam kebakaran	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan tidak digunakan untuk menyimpan barang.
Objek Berbahan Stainless	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak berminyak, dan tidak ada lawa – lawa.
Dinding	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Wastafel dan eye wash	Pembuangan mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, kering, kaca cermin bersih, bening, tidak berdebu, tidak bernoda, kran tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Kamar Mandi	Kebersihan dan bau
Ruangan	Tidak bau amis, pesing, dan anyir.
Plafon/langit-langit	Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kasa nyamuk	Bersih, tidak bernoda, tidak ada lawa – lawa, dan tidak berdebu.
Dinding Keramik	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, dan nat dinding bersih.
Closed	Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada percakan air disekelilingnya, dan tidak bau.
Kran	Tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Pintu	Bersih, tidak ada noda, dan mengkilap.
Urinoir	Bersih, tidak ada noda, tidak bau, dan tidak berkarat.
Bak Mandi	Tidak menguning karena lumut, tidak kotor, dan tidak ada jentik.
Ember dan Gayung	Bersih dan tidak berlumut.
Lantai	Bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak bau, dan sudut lantai harus bebas noda.
Keset	Tidak berdebu, tidak basah, tidak bau, dan tidak ada sampah.
Tempat Sampah	Dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh (terisi kurang dari 2/3 bagian), tidak kotor, dan tidak ada sampah berceceran
Tangga	Bersih dan bebas sawang

Railing	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan bila diusap tidak membekas.
Lantai (anak tangga & Bordes)	Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, dan tidak bau.
Dinding	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan tidak ada bercak.
Plafon	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Lift	Lantai dan dinding tidak berdebu, tidak bernoda, mengkilat, harum, dan sudut lantai harus bebas noda.
Dek Level	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa / sampah / daun kering.
Pagar	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Spoel hock/Dapur	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Pembersihan Tempat Sampah / Trolly	Pembersihan tempat sampah / trolly dilakukan secara rutin, kondisi tidak berdebu, dan ada jadwal pembersihannya juga.
SEIKETSU / RAWAT	
Poles lantai di ruangan	Sudah dilakukan dan/atau dijadwalkan poles lantai, baik basah dan atau kering maksimal 1x/bulan
Pemakaian APD	APD masker, sepatu, sarung tangan
Penandaan alat kebersihan	Hijau strip 1 (-) : kantor, Hijau strip 2 (=) : dapur, Biru (selasar), kuning (r. perawatan/pelayanan, merah : kamar mandi
Kebersihan Diri Petugas	Pakaian bersih, Badan bersih, Tidak berbau tidak sedap
SHITSUKE / RAJIN	
Kompetensi CS Memperagakan Cuci tangan dengan benar	Dapat mempraktekan lengkap sesuai SOP cuci tangan
Kompetensi CS dalam menanggapi response keluhan	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup
Kompetensi CS dalam mengikuti arahan kordinator	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup

Analisa :
Tahun ini Unit CS memiliki dan telah menerapkan metode supervise baru yang dapat diukur. Sejak pertengahan tahun sudah mulai adanya perbaikan dari pelaporan dan supervisi

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.3.3.4 Gudang

N O	UNIT ASAL	JAN	FEB	MAR	APRIL	M EI	JU NI	JU LI	AGU ST	SE P	O KT	NO V	DE S	JUML AH
1	IGD	4	1	2	2	4	1	4	2	1	2	1	2	26
2	MATERNITAS	2	2	3	3	2	2	4	1	2	2	2	1	26
3	IKO	3	2	0	0	2	2	2	1	1	0	1	2	16
4	IRNA 2A	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3

5	IRNA 2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	IRNA 2C	3	2	3	3	3	1	2	1	2	1	0	1	22
7	ICU	1	3	2	2	1	0	3	0	1	1	1	1	16
8	IRNA 3A	0	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	11
9	IRNA 3C DEWASA	3	2	1	1	0	2	3	2	2	1	2	1	20
10	IRNA 4C+4A	3	3	2	2	2	3	6	1	4	3	0	3	33
11	IRNA 5C	3	2	2	2	2	1	4	2	1	1	0	1	20
12	MS PTP, LAWANG, K ARLOS	10	8	8	8	11	8	11	11	11	12	7	11	116
13	KASIR	4	5	3	3	5	4	4	4	4	3	2	4	45
14	DAPUR	9	6	7	7	8	6	9	8	8	6	6	8	88
15	POLI	10	13	7	7	2	6	9	6	5	8	4	3	80
16	CLEANING SERVICE	8	5	7	7	5	6	5	4	5	5	4	6	166
17	IPSRs	4	6	5	5	7	4	5	4	5	4	3	6	58
18	GUDANG FARMASI	4	2	3	3	5	4	3	4	2	3	5	3	43
19	RUMAH DPM	2	2	3	3	5	2	2	1	2	3	3	3	31
20	SEKRETARIA T PT	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	42
21	SEKRETARIA T RS	1	3	4	4	5	4	5	6	3	4	3	3	45
22	CSSD	3	1	2	2	3	2	2	3	1	1	3	2	25
23	GIZI	3	4	3	3	4	1	3	2	1	2	2	2	30
24	REKAM MEDIS	2	3	4	4	6	3	4	4	3	4	4	3	38
25	PENDAFTAR AN	5	2	4	4	6	3	5	3	3	3	3	3	44
26	DEPO FARMASI	9	9	8	8	12	7	6	6	5	5	5	4	84
27	SECURITY	1	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	7
28	LABORATORI UM	5	4	4	4	6	3	3	4	6	3	3	4	49
29	RADIOLOGI	4	2	2	2	4	1	2	3	3	3	1	1	28
30	FISIOTERAPI	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
31	IRNA 3C ANAK	3	3	4	4	4	5	4	3	2	2	1	2	37
32	NS NICU	3	2	2	2	5	4	4	2	2	1	2	2	31
33	LAUNDRY	0	0	2	2	2	2	0	2	1	2	0	0	13
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	2	0	0	2	0	2	2	0	0	1	1	11
35	DRIVER	1	3	0	0	0	1	2	1	3	1	1	2	15
36	SIMRS	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
37	ASURANSI CENTER	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	3	3	50
38	DPW	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Analisis:
Pengeluaran Gudang umum dalam 1 tahun jumlah yg paling banyak adalah unit cleaning service

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.3.3.4 Security

NO.	PENGUKURAN MUTU	STANDAR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Angka kejadian kehilangan barang 0%	0%	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
2.	Angka kejadian berpotensi barang hilang 0%	0%	0	1	0	0	0	0	1	3	5	1	2	4
3	Angka kejadian kekerasan 0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Angka kejadian merokok di area rumah sakit 0%	0%	0	0	16	8	6	2	8	2	1	12	9	7

BULAN	KEHILANGAN BARANG	BARANG BERPOTENSI HILANG	KEKERASAN	MEROKOK DI AREA RUMAH SAKIT
Januari	-	Menemukan barang berupa 2 unit hp milik pengunjung yang tertinggal di rumah sakit , sudah diambil pemiliknya	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	16 Pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
April	Kunci kendaraan motor pasien tertinggal di pendaftaran poli	hp pengunjung tertinggal di depan IGD dan sudah diambil pemiliknya		8 Pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
Mei	-	1. Telah ditemukan dompet warna hijau di gedung poli	-	6 Pengunjung yang merokok sudah di beri

		anak dan sudah di ambil pemiliknya 2. Ditemukan kunci mobil ada dompet dan hiasan rambut , sudah diambil pemiliknya 3. Ditemukan kontak mobil terkondisikan di pos igd & sudah diambil oleh pemilik 4. Ditemukan hp merek Samsung di masjid shaf Perempuan terkondisikan di pos igd & sudah di ambil pemiliknya		edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
Juni	1ditemukan kontak motor terjatuh di sekitar depan area igd diamankan di pos security igd (box)	1. Telah ditemukan tas pengunjung di area parkir depan igd telah diamankan di pos igd & telah di kondisikan oleh pemilik 2. Ditemukan jam tangan di area kamar mandi samping iko telah diamankan di pos security & telah dikondisikan oleh pemilik	-	Pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
Juli	Telah ditemukan dompet pasien di area pendaftaran poli , berisi uang sejumlah 105rb & kartu atm 3 pcs (2 mandiri , 1 bca) , diamankan di pos security IGD (kotak ATK)		-	Pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
Agustus	-	1. Ditemukan hp di meja pendaftaran , diamankan di	-	Pengunjung yang merokok sudah di beri

		pos igd & sudah di ambil pemilik 2. Ditemukan jam tangan oleh pak ustadz di tempat wudhu area masjid diamankan di pos igd & sudah di ambil pemilik 3. Telah ditemukan kontak motor terjatuh di depan poli paru , diamankan di pos igd & sudah diambil pemilik		edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
September	-	1. Ditemukan dompet berisi identitas pasien warna hitam di bawa tulisan pos dpm & sudah diambil pemilik 2. Ditemukan kunci mobil di loket kasir terkondisikan di pos igd & sudah diambil pemilik 3. Telah ditemukan stnk & bpjs milik pasien terkondisikan di pos igd & sudah diambil pemilik 4. Telah ditemukan hp milik pasien di area pos poli terkondisikan di pos igd & sudah diambil pemilik 5. Telah di temukan dompet di depan kasir atas nama Firda Ratna Safitri dompet di pos IGD & sudah diambil pemilik	-	Pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
Oktober	Helm karyawan hilang di area parkir masjid (	Telah ditemukan dompet terjatuh di depan meja	-	Pengunjung yang merokok

	perawat nicu) atas nama rizda , sudah dilakukan Pemasangan cctv serta meningkatkan pengawasan di seluruh area rumah sakit	cs0 , tanpa identitas berisi uang sejumlah 1.020.000 diamankan di pos IGD & Telah diambil oleh pemilik dengan menunjukkan bukti identitas dan keterangan pemilik		sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
November	-	1. Telah ditemukan kontak mobil merek Daihatsu di meja pendaftaran central terkondisikan di pos security IGD & sudah diambil pemilik 2. Telah ditemukan hp milik pasien di pendaftaran central terkondisikan di pos security poli & sudah diambil pemilik	-	Pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok
Desember	-	1. Ditemukan hp milik pasien tertinggal di loket pendaftaran poli (loket 2) diamankan di CSO & sudah diambil pemilik 2. Telah ditemukan sejumlah uang diarea tempat wudhu perempuan diamankan di pos igd & sudah diambil pemilik 3. Telah ditemukan dompet milik pengunjung di depan ruang tunggu iko didalam terdapat identitas & sejumlah uang 165.500 diamankan di pos igd & sudah diambil pemilik	-	Pengunjung yang merokok sudah di beri edukasi dan pengarahan terkait larangan area dilarang merokok

		4. Telah ditemukan hp milik keluarga pasien di kursi tunggu irna 3A diamankan di pos igd & sudah diambil pemilik		
--	--	--	--	--

Analisis :
 Sistem pemantauan memiliki instrument baru yang lebih tertata. Indikator ditambah angka kejadian berpotensi barang hilang 0% membuat tidak ambgu dengan indicator barang hilang. CCTV menjadi alat bantu utama untuk mendeteksi / mentelusur kejadian di rumah sakit.

3.3.3.6 Asuransi Center
 3.3.3.6.1 Rekanan Kunjungan dan Penyakit
 3.3.3.6.1.1 Tabel Kunjungan Pasien Asuransi

NO	JAMINAN	2023			2024			%
		RJ	RI	TOTAL	RJ	RI	TOTAL	
1	Umum	17.910	779	18.689	18.176	854	19.030	2%
2	BPJS Kesehatan	130.874	10.309	141.183	142.646	12.322	154.968	10%
3	BPJS TK	1.759	202	1.961	1.671	267	1.938	-1%
4	Jasa Raharja	101	76	177	149	109	258	46%
5	Asuransi Swasta	2.139	95	2.234	2.463	145	2.608	17%
6	Perusahaan	318	28	346	420	53	473	37%

3.3.3.6.1.1 Tabel 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Pasien BPJS Kesehatan
 Periode 2024

NO	KODE ICD 10	DESKRIPSI	JUMLAH	TARIF RS	TARIF INACBG'S	SELISIH
1	Z50.1	Other physical therapy	13,354	2.160.443.212	1.815.420.100	- 345.023.112
2	Z09.8^E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	8,707	1.969.334.010	1.728.453.000	- 240.881.010
3	Z09.8^I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	5,23	934.526.586	1.056.698.300	122.171.714
4	Z09.8^I51.9	Heart disease, unspecified	3,516	660.086.311	706.032.600	45.946.289
5	Z09.8^I25.1	Atherosclerotic heart disease	3,179	629.872.074	647.862.600	17.990.526
6	Z35.9	Supervision of high-risk pregnancy, unspecified	3,146	481.050.212	527.716.500	46.666.288

7	Z09.8^M17.0	Primary gonarthrosis, bilateral	3,051	1.109.515.161	1.084.408.100	- 25.107.061
8	Z09.8^J44.9	Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	2,699	518.450.689	682.688.400	164.237.711
9	Z09.8^I69.3	Sequelae of cerebral infarction	2,687	421.366.500	533.117.100	111.750.600
10	Z09.0	Follow-up examination after surgery for other conditions	2,404	478.594.297	536.497.500	57.903.203

3.3.3.6.1.2 Tabel 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan
Periode 2024

NO	KODE ICD 10	DESKRIPSI	JUMLAH	TARIF RS	TARIF INACBG'S	SELISIH
1	A01.0	Typhoid fever	1,739	4.764.734.110	5.023.472.100	258.737.990
2	A90	Dengue fever [classical dengue]	639	1.683.569.549	1.533.313.700	- 150.255.849
3	J18.9	Pneumonia, unspecified	390	1.282.661.098	1.732.130.300	449.469.202
4	O63.0	Prolonged first stage of labour	374	1.850.217.695	1.202.791.900	- 647.425.795
5	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	355	1.849.852.727	2.059.368.800	209.516.073
6	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	229	872.708.198	1.140.912.200	268.204.002
7	E14.9	Unspecified diabetes mellitus without complications	218	787.119.824	1.065.804.700	278.684.876
8	K21.9	Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis	200	550.785.770	792.467.800	241.682.030
9	A49.9	Bacterial infection, unspecified	195	497.754.506	517.796.500	20.041.994
10	O34.2	Maternal care due to uterine scar from previous surgery	189	1.668.989.748	1.112.554.700	- 556.435.048

3.3.3.6.1.1 Tabel 10 Tindakan Operatif Terbanyak dengan Biaya Tertinggi

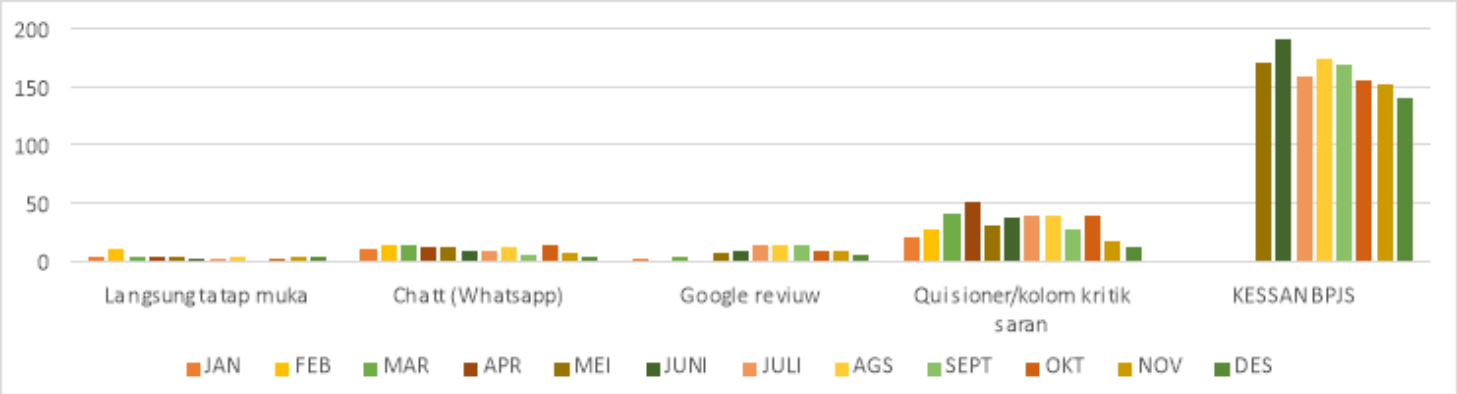
NO	KODE ICD 10	DESKRIPSI	JUMLAH	TARIF RS	TARIF INACBG'S	SELISIH
1	73.59	Other manually assisted delivery	420	1.747.688.058	1.070.347.000	- 677.341.058
2	86.22	Excisional debridement of wound, infection, or burn	298	2.851.475.213	1.264.262.600	- 1.587.212.613
3	74.4	Cesarean section of other specified type	272	2.079.115.928	1.596.490.300	- 482.625.628
4	74.1	Low cervical cesarean section	238	1.800.266.949	1.388.887.300	- 411.379.649
5	56.0	Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis	171	2.074.291.590	1.326.006.400	- 748.285.190
6	74.0	Classical cesarean section	136	1.004.587.075	793.316.100	- 211.270.975
7	60.11	Closed [percutaneous] [needle] biopsy of prostate	134	1.805.143.917	1.047.287.000	- 757.856.917
8	85.12	Open biopsy of breast	132	1.285.457.097	784.300.700	- 501.156.397
9	66.39	Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes	111	1.422.014.874	646.932.800	- 775.082.074
10	53.00	Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	108	1.015.239.635	591.390.400	- 423.849.235

3.3.3.PIPP

3.3.3.6.2 Tabel Jenis Pasien Komplain Tahun 2024

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	Langsung	4	10	3	4	3	1	1	4	0	1	3	4	38
2.	Tidak Langsung :													
	Chatt (Whatsapp)	10	13	13	11	11	8	9	11	5	13	6	4	114
	Google reviuw	1	0	3	0	6	9	13	14	13	8	8	5	80
	Quisioner/kolom kritik saran	21	27	41	51	31	37	38	38	27	38	17	12	194
	KESSAN BPJS	0	0	0	0	170	190	158	173	168	155	152	140	1306

3.3.3.6.3 Grafik Jenis Pasien Komplain Tahun 2024



Analisa :

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pasien complain tertinggi pertama yaitu di dapat dari Quisioner sebanyak 194 komplain, jenis pasien complain tertinggi kedua yaitu dari chatt wa yaitu 114 komplain di tahun 2024

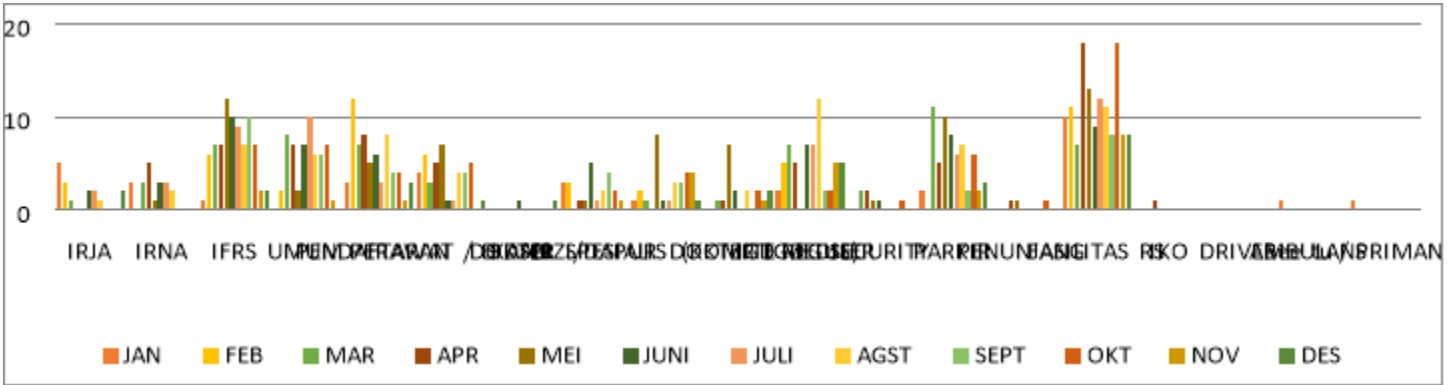
Rencana Tindak Lanjut

Penyampaian complain berdasarkan jenis pasien ini bekerjasama dengan unit terkait seperti IRNA, marketing dan IRJA agar menyaring pasien untuk memberikan masukan kepada rumah Sakit

3.3.3.6.4 Tabel Laporan Komplain Pasien

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	IRJA	5	3	1	0	0	2	2	1	0	0	0	2	16
2.	IRNA	3	0	3	5	1	3	3	2	0	0	0	0	20
3.	IFRS	1	6	7	7	12	10	9	7	10	7	2	2	80
4.	UMUM	0	2	8	7	2	7	10	6	6	7	1	0	56
5.	PENDAFTARAN	3	12	7	8	5	6	3	8	4	4	1	3	64
6.	PERAWAT / BIDAN	4	6	3	5	7	1	1	4	4	5	0	1	41
7.	KASIR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
8.	GIZI/DAPUR	3	3	0	1	1	5	1	2	4	2	1	0	23
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	1	2	1	0	8	1	1	3	3	4	4	1	29
10.	DOKTER IGD	0	0	1	1	7	2	0	2	0	2	1	2	18
11.	IGD REGULER	2	5	7	5	0	7	7	12	2	2	5	5	59
12.	SECURITY	0	0	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	7
13.	PARKIR	2	0	11	5	10	8	6	7	2	6	2	3	62
14.	PENUNJANG	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
15.	FASILITAS RS	10	11	7	18	13	9	12	11	8	18	8	8	133
16.	IKO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17.	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	AMBULANS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19.	Bee tu / PRIMANTARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3.3.3.7.4 Grafik Jumlah Komplain Pasien Terhadap Unit Tahun 2024



Analisa :
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Komplain Pasien terhadap Unit tahun 2024 tertinggi yaitu fasilitas RS sebanyak 133 kasus, di ikuti bagian farmasi sebanyak 80 kasus, bagian pendaftaran sebanyak 64 kasus, bagian parkir sebanyak 62 kasus, bagian IGD sebanyak 59 kasus

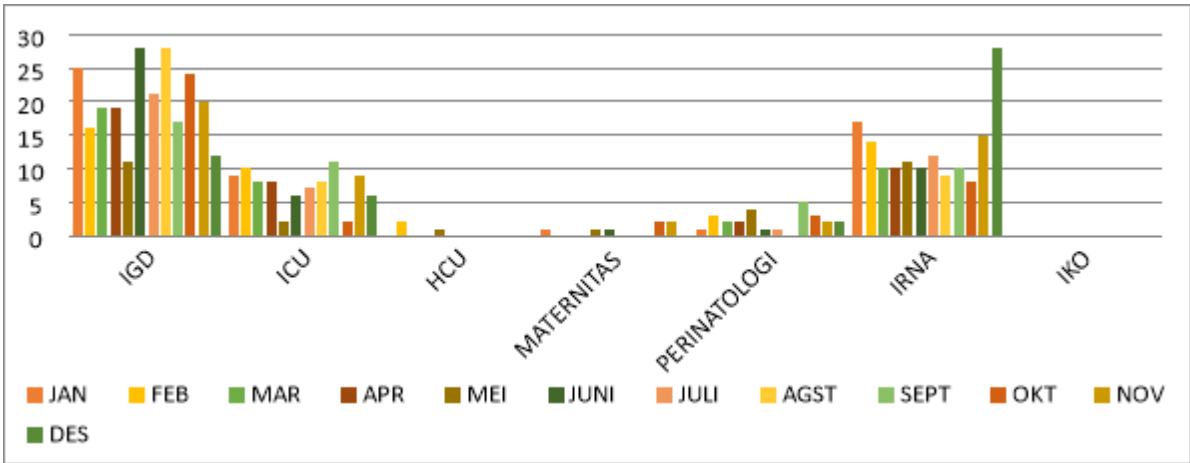
Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan Kabid umum terkait ketentuan parkir pasien rawat inap dengan kebijakan khusus, sehingga keluarga pasien cukup membayar 1 kali bayar saja.

3.3.3.6.5 Tabel Laporan Pasien Rujuk

NO	UNIT PERUJUK	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	IGD	25	16	19	19	11	28	21	28	17	24	20	12	240
2.	ICU	9	10	8	8	2	6	7	8	11	2	9	6	86
3.	HCU	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
4.	MATERNITAS	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	7
5.	PERINATOLOGI	1	3	2	2	4	1	1	0	5	3	2	2	26
6.	IRNA	17	14	10	10	11	10	12	9	10	8	15	28	154
7.	IKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3.3.6.6 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Tahun 2024



Analisa :

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pasien rujuk eksternal tahun 2024 palling banyak yaitu IGD sebanyak 240 pasien yang dirujuk, dan terbanyak kedua yaitu dari IRNA sebanyak 154 pasien yang dirujuk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan dimana di RS Prima Husada Malang belum bisa melakukan perawatan tersebut.

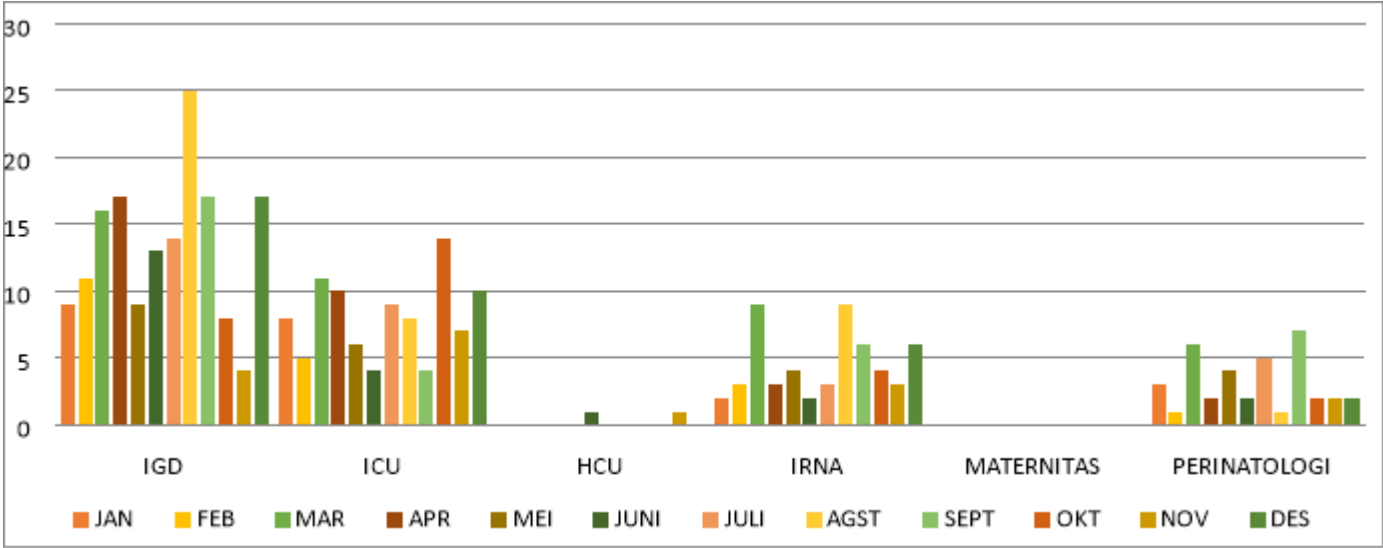
Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan Kabid pelayanan terkait tambahan layanan Rumah Sakit, sehingga pasien bisa dilakukan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Mlang, seperti Unit HD, PICU.

3.3.3.6.7 Tabel Laporan Pasien Meninggal

NO	JUMLAH PASIEN MENINGGAL	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	IGD	9	11	16	17	9	13	14	25	17	8	4	17	160
2.	ICU	8	5	11	10	6	4	9	8	4	14	7	10	96
3.	HCU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
4.	IRNA	2	3	9	3	4	2	3	9	6	4	3	6	54
5.	MATERNITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	PERINATOLOGI	3	1	6	2	4	2	5	1	7	2	2	2	37

3.3.3.6.8 Grafik Jumlah Pasien Meninggal Tahun 2024



Analisa :

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pasien meninggal tahun 2024 palling banyak yaitu IGD sebanyak 160 pasien, dan terbanyak kedua yaitu dari ICU sebanyak 96 pasien yang dirujuk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan dimana di RS Prima Husada Malang belum bisa melakukan perawatan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan Kabid pelayanan terkait tambahan layanan Rumah Sakit, sehingga pasien bisa dilakukan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Mlang, seperti Unit HD, PICU.

3.3.3.7 IT-SIMRS

BULAN	KEJADIAN DOWNTIME
JANUARY	3
FEBRUARY	5
MARCH	2
APRIL	1
MAY	3
JUNE	5
JULY	8
AUGUST	4
SEPTEMBER	7
OCTOBER	5
NOVEMBER	3
DECEMBER	8
TOTAL	54

DOWNTIME TERENCANA	1
DOWNTIME TIDAK TERENCANA	53

Analisa :
Kejadian downtime tidak terencana mayoritas berasal dari server BPJS. Kejadian downtime terencana dilakukan saat pergantian server baru.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.3.3.8 Keuangan

3.3.3.8.1 Tabel Pendapatan Tahun 2024 (Tarif RS)

No	Jaminan	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	MAY 2024	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	DECEMBER 2024	YTD 2024
1	Umum	675.552.400	601.132.841	798.711.044	651.768.029	875.195.852	787.407.884	960.323.585	950.059.428	697.575.329	710.628.285	718.414.315	961.275.516	9.388.444.307
2	BPKS Kes	8.017.884.809	8.042.049.635	8.215.376.080	7.506.058.382	8.717.005.300	7.526.450.601	7.595.665.169	7.547.774.708	7.914.588.980	8.138.200.408	8.066.888.654	8.002.466.652	96.490.489.329
	Obat Kronis	526.543.739	509.960.649	475.687.757	482.893.426	499.716.708	492.645.221	516.207.012	502.008.195	486.080.417	543.684.139	504.141.291	500.481.307	6.050.049.861
	Lupis(Ambulance)	7.810.000	8.923.750	6.557.500	4.350.000	6.823.750	6.945.000	9.136.250	7.910.000	8.411.250	6.222.500	5.738.750	4.710.000	85.538.750
	Lupis(Akses)	12.485.000	3.795.000	3.678.750	3.630.000	3.464.593	8.470.000	6.764.861	6.160.000	8.907.211	8.690.000	5.775.000	3.465.000	75.283.815
3	BPKS TK	455.734.749	377.992.816	529.157.693	643.955.887	454.736.552	505.124.335	513.841.299	599.648.225	617.037.266	565.965.394	749.270.304	543.078.789	6.565.543.408
4	Jasa Raharja	107.447.815	152.615.193	237.339.659	242.106.626	70.977.605	329.483.302	82.661.384	238.087.616	134.252.968	194.439.771	68.059.969	148.825.332	2.004.297.238
5	Kemenkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Asuransi Swasta	212.264.905	178.335.021	216.265.088	134.652.348	232.843.338	230.637.919	240.331.495	233.036.486	174.348.092	239.247.730	178.911.645	172.048.904	2.442.922.972
7	Perusahaan	25.430.335	67.202.145	44.086.093	56.538.692	48.555.566	28.476.220	30.531.766	14.255.327	111.598.614	115.547.031	21.616.685	48.064.613	612.345.069
	Penunjang Perusahaan	8.688.250	88.552.600	10.450.300	13.526.246	9.063.339	15.059.550	8.873.300	6.528.450	21.104.400	4.662.750	8.919.350	12.148.350	207.776.985
	Total	10.950.842.603	10.030.559.850	10.547.307.963	10.139.479.567	10.918.382.461	10.330.742.431	10.364.316.121	10.105.468.536	10.382.7045.27	10.527.388.998	10.331.735.963	10.394.444.362	123.822.591.754
1	Obat-obatan					6.598.303				48.857.014			68.225.366	123.650.623
2	Laboratorium													-
3	Radiologi Umum	2.661.000	5.557.000	3.926.500	4.885.000	13.032.500	3.913.000	9.021.500	6.742.000	10.489.000	5.849.000	7.100.000	9.185.000	82.361.500
4	IRO													-
5	MCU	129.600.500	5.426.000	14.821.500	864.000		10.390.000	79.944.000	-	144.000	4.214.000	31.412.000	43.961.500	320.717.500
6	Ambulance	-	1.562.100	450.000	1.400.000	975.000	225.000	225.000	300.000	813.700	825.550	1.760.704	622.500	9.169.554
7	Home Care											257.500		257.500
8	Parkir	84.381.000	84.843.000	89.701.000	89.755.000	100.274.000	89.209.000	92.262.000	90.271.000	87.197.000	88.478.500	87.823.000	89.858.000	1.074.052.500
9	Pelayanan	2.240.500	80.500	300.000	177.350	2.880.000	1.667.850	875.000	300.000		300.000	300.000	-	9.121.200
10	Primartara	-	1.056.700	3.125.060	4.577.500	7.568.000	7.302.200	8.559.100	10.562.500	11.262.400	11.001.900	11.895.600	10.118.000	87.028.960
11	ATM		36.999.999	3.956.050	853.794	854.721	825.266	935.859	47.251.480	1.971.383	2.317.427	2.172.378	98.128.257	
12	Lain-Lain	254.800	621.100	238.400	259.250	382.850	333.450	669.900	383.450	1.249.100	1.242.900	233.850	312.012	6.181.162
	Total	219.337.800	136.146.399	112.562.460	105.874.250	132.524.447	113.895.221	192.381.766	109.494.809	207.263.694	114.150.733	142.842.581	224.404.696	1.810.678.856
	Grand Total	10.219.379.803	10.166.706.249	10.659.870.423	10.245.353.837	11.050.906.850	10.444.637.652	10.556.717.887	10.214.963.345	10.389.968.221	10.641.538.741	10.474.578.544	10.618.849.058	125.733.270.610

Analisa :
Pada tahun 2024, pendapatan perbulan cenderung stabil pada angka yang hampir sama yaitu rata-rata Rp. 10.477.772.550. Grafik omzet lebih stabil dan cenderung mendatar. Stabilitas ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah menemukan pola operasional yang lebih konsisten baik dari segi sistem maupun pengelolaan SDM. Hal ini yang seringkali diinginkan dalam jangka panjang karena akan memudahkan perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan pengendalian biaya. Pendapatan yang konsisten dan dapat diprediksi membantu dalam perencanaan strategis, alokasi anggaran, dan pengembangan bisnis yang lebih terarah.

Rencana Tindak Lanjut :
Mempertahankan kinerja operasional dengan tetap monitoring dan evaluasi

CARA BAYAR	PENDAPATAN	PROPORSI
Umum	9.388.444.307	7%
BPJS Kes	96.490.489.329	77%
BPJS Obat Kronis	6.050.049.861	5%
BPJS Lupis	160.822.565	0%
BPJS TK	6.565.543.408	5%
Jasa Raharja	2.004.297.238	2%
Kemenkes	-	0%
Asuransi Swasta	2.442.922.972	2%
Perusahaan	820.022.074	1%
Radiologi Umum	82.361.500	0%
MCU	320.717.500	0%
Ambulance	9.169.554	0%
Parkir	1.074.052.500	1%
PRIMANTARA	87.028.960	0%
Lain - Lain	237.348.842	0%
TOTAL	125.733.270.610	100%

Analisa :
77% pendapatan bersumber dari BPJS Kesehatan dan 7 % Umum.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitroing dan evaluasi

3.3.3.8.2 Kinerja Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					
									0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	
		a	b	(a-b-c= d)	e	f	(e-f-g=h)	d+h						
PERIODE DESEMBER 2024 :														
1	Asuransi	222.051.899	135.922.907	83.659.535	142.783.969	21.932.274	119.944.933	203.604.469	177.641.309	709.648	21.900.904	1.614.426	1.738.181	2
2	Penusahaan	210.885.044	112.293.086	98.198.417	184.440.547	15.350.000	169.090.547	267.288.964	191.709.391	15.748.222	34.155.194	2.063.692	23.612.465	2
3	Mandiri Inhealth	103.587.639	45.968.985	56.648.234	26.958.918	-	26.958.918	83.607.153	83.235.113	-	-	-	372.039	1
4	Jasa Raharja	106.777.477	106.797.126	920.917	119.996.273	-	119.996.273	120.917.190	119.996.273	920.917	-	-	-	1
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.442.773.264	1.239.847.050	202.926.667	542.812.928	-	542.812.928	745.739.595	741.531.234	-	497.635	513.240	3.197.502	1

- Keterangan :
- 1. Cutt OF Piutang per 31 Desember 2024 Rp 1.421.157.387,-
 - 2. Piutang Asuransi dan Perusahaan sudah bersurat :
 - a. Mandiri Inhealth rencana pembayaran Januari 2025
 - b. PT Karya Bina Sentausa rencana pelunasan Januari 2025

3.3.3.8.2.1 Tabel Daftar Pembayaran Piutang Asuransi Non BPJS Desember 2024

Asuransi	157.855.181
Perusahaan	127.643.086
Mandiri Inhealth	45.968.985
Jasa Raharja	106.797.126
BPJS Ketenagakerjaan	1.238.236.300
Total Penerimaan 109	1.676.500.678

NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND	NILAI PENDING
1	JULI 24	RJ	12.689	12.689	2	-	0,0%	0
		RI	1.002	993	-	9	1%	69.125.600
2	AGT 24	RJ	12.175	12.169	7	6	0%	3.472.200
		RI	950	942	-	8	1%	46.355.500
3	SEPT 24	RJ	11.573	11.447		126	1%	36.302.300
		RI	1.011	922		89	9%	46.089.600
4	OKT 24	RJ	11.710	11.379	3	331	3%	76.986.800
		RI	997	929		68	7%	276.904.000
5	NOV 24	RJ	11.855	11.214	3	641	5%	152.539.100
		RI	1.030	925		105	10%	376.338.700
								1.084.113.800

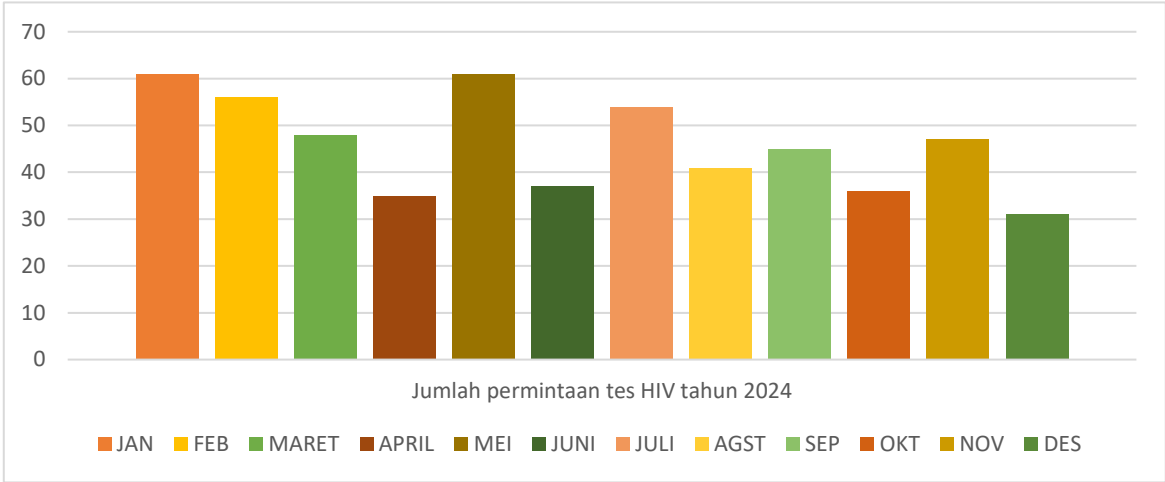
REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN								
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK	
PELAYANAN 2023								-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336			-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000			-
5	FPK OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876			-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000			-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000			-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000			-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000			-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636			-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500			-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704			-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860			-
PELAYANAN 2024								-
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000			-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000			-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814			-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779			-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743			-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000			-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000			-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702			-
	FPK PEND REGULER FEBRUARI	373.212.100	10.06.2024	19.06.2024	373.212.100			-
	FPK PEND II FEB 2024	58.112.500	09.07.2024	17.07.2024	58.112.500			-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200		-
	FPK AMBULANCE MARET 24	5.280.000	14.06.2024	10.06.2024	5.280.000			-
	FPK ALKES MARET 24	3.465.000	14.06.2024	10.06.2024	3.465.000			-
	FPK OR MARET 24	471.764.386	15.07.2024	22.07.2024	471.764.386			-
	FPK PEND MARET 2024	383.291.100	09.07.2024	17.07.2024	309.918.000	73.373.100		-
	FPK PEND MARET 2 2024	90.791.600	20.08.2024	29.08.2024	90.791.600			-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500		-
	FPK OBAT KRONIS APRIL 2024	477.096.910	26.07.2024	05.08.2024	477.096.910			-
	FPK AMBULANCE APRIL 24	3.270.000	14.06.2024	10.06.2024	3.270.000			-
	FPK ALKES APRIL 24	3.630.000	14.06.2024	10.06.2024	3.630.000			-
	FPK Pending April 2024	289.580.800	07.08.2024	19.08.2024	289.580.800			-
	FPK Pending II April 2024	125.899.300	10.09.2024	18.09.2024	125.899.300			-
	FPK Pending III April 2024	4.353.500	10.10.2024	21.10.2024	4.353.500			-
	FPK Obat Pend April 2024	5.989.571	06.09.2024	17.09.2024	5.989.571			-
5	FPK MEI 2024	7.537.333.400	23.06.2024	01.07.2024	7.493.109.800	44.223.600		-
	FPK OBAT KRONIS MEI 2024	487.109.484	26.07.2024	12.08.2024	487.109.484			-
	FPK Alkes Mei 2024	3.465.000	24.07.2024	07.08.2024	3.465.000			-
	FPK Ambulance Mei 2024	5.145.000	24.07.2024	07.08.2024	5.145.000			-
	FPK Obat Pend Mei 2024	10.593.498	06.09.2024	17.09.2024	10.593.498			-
	FPK PEND MEI 2024	334.480.400	23.09.2024	30.09.2024	296.561.200	37.919.200		-
	FPK PEND II MEI 2024	67.517.700	05.11.2024	13.11.2024	67.517.700			-
6	FPK JUNI 2024	6.959.035.980	24.07.2024	31.07.2024	6.868.943.180	90.092.800		-
	FPK Alkes Juni 2024	8.470.000	24.07.2024	07.08.2024	8.470.000			-
	FPK Ambulance Juni 2024	6.945.000	24.07.2024	07.08.2024	6.945.000			-
	FPK Obat Kronis Juni 2024	468.625.741	15.09.2024	23.09.2024	468.625.741			-
	FPK Pending I Juni 2024	406.675.400	15.11.2024	25.11.2024	406.675.400			-
	FPK Pending Obat Kronis Juni 2024	10.909.672	15.11.2024	25.11.2024	9.479.776	1.429.896		-
	FPK Pending II Juni 2024	95.247.300	12.12.2024	23.12.2024	95.247.300			-
7	FPK JULI 2024	7.160.148.298	20.08.2024	29.08.2024	7.122.971.498	37.176.800		-
	FPK Alkes Juli 2024	6.655.000	25.09.2024	09.10.2024	6.655.000			-
	FPK Ambulance Juli 2024	8.085.000	25.09.2024	09.10.2024	8.085.000			-
	FPK Obat Kronis Juli 2024	486.756.047	24.10.2024	04.11.2024	490.002.657	8.753.390		-
	FPK Pending Juli 2024	291.190.700	12.12.2024	24.12.2024	291.190.700			-
8	FPK Reguler Agustus 2024	6.671.460.900	25.09.2024	02.10.2024	6.662.482.200	8.978.700		-
	FPK Alkes Agustus 2024	6.160.000	25.09.2024	09.10.2024	6.160.000			-
	FPK Ambulance Agustus 2024	6.510.000	25.09.2024	09.10.2024	6.510.000			-
	FPK OR Agustus 2024	486.971.257	04.12.2024	16.12.2024	486.971.257			-
	FPK Pending Agustus 2024	315.773.900	12.12.2024	20.12.2024	315.773.900			-
9	FPK Reguler Ri September 2024	4.225.116.643	22.10.2024	28.10.2024	4.219.384.343	5.732.300		-
	FPK Reguler RJ September 2024	2.700.053.100	31.10.2024	13.11.2024	2.692.209.100	7.844.000		-
	FPK Ambulance September 2024	4.500.000	04.12.2024	27.12.2024	4.500.000			-
	FPK Alkes September 2024	8.855.000	04.12.2024	27.12.2024	8.855.000			-
10	FPK Reguler Oktober 2024	7.115.971.438	21.11.2024	28.11.2024	7.115.971.438			-
	FPK Ambulance Oktober 2024	4.575.000	04.12.2024	27.12.2024	4.575.000			-
	FPK Alkes Oktober 2024	8.690.000	04.12.2024	27.12.2024	8.690.000			-
11	FPK Reguler November 2024	6.816.237.444	23.12.2024	30.12.2024	6.816.237.444			-
	FPK Ambulance November 2024	8.415.000	24.12.2024				8.415.000	-
	FPK ALKES November 2024	5.775.000	24.12.2024				5.775.000	-
12	Belum FPK Desember 2024 (Pengajuan)	7.340.311.100					7.340.311.100	-
		101.119.895.534			93.364.837.648	400.556.786	7.354.501.100	-

3.3.4 Program Nasional (PROGNAS)
3.3.4.1 HIV

Jumlah permintaan Tes HIV

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Permintaan Test HIV	61	56	48	35	61	37	54	41	45	36	47	31	552

Grafik
Jumlah Permintaan Test Hiv Di Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2024



Analisa :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada tahun 2024 sebanyak 552 pemeriksaan, hal ini dikarenakan terdapat sedikit pasien dengan diagnose suspek HIV dan sudah berjalannya pemeriksaan PMTCT di poli kandungan dan PONEK IGD.

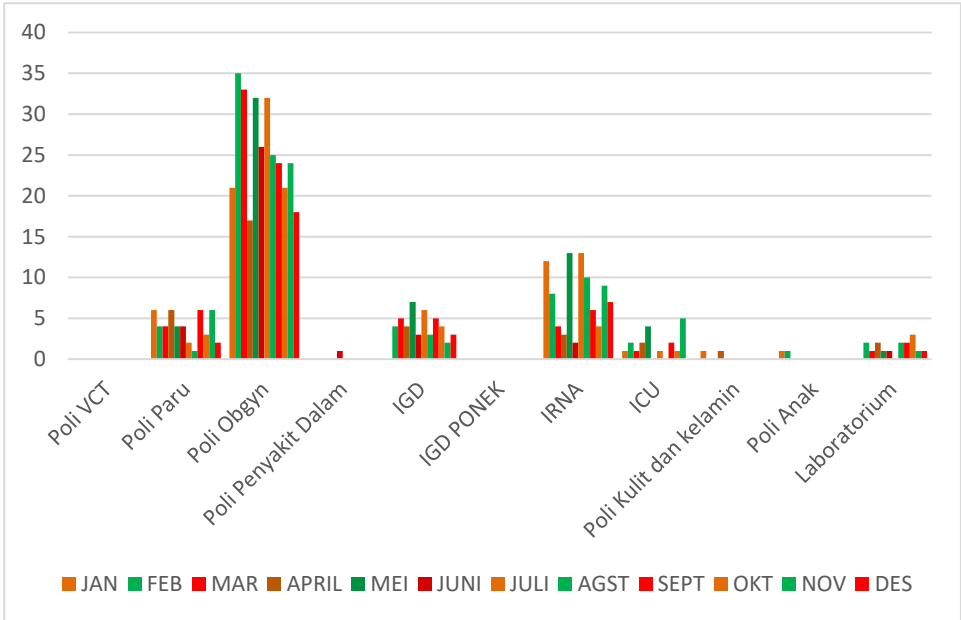
Rencana Tindak Lanjut
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.3.2 Asal Permintaan Tes Hiv

No	URAIAN	Ja n	Fe b	Ma r	Apri l	Me i	Jun i	Jul i	Ags t	Sep t	Ok t	No v	De s	Σ
1	Poli VCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poli Paru	6	4	4	6	4	4	2	1	6	3	6	2	48
3	Poli Obgyn	21	35	33	17	32	26	32	25	24	21	24	18	308
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	IGD	0	4	5	4	7	3	6	3	5	4	2	3	46
6	IGD PONEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA	12	8	4	3	13	2	13	10	6	4	9	7	91
8	ICU	1	2	1	2	4	0	1	0	2	1	5	0	19
9	Poli Kulit dan kelamin	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

10	Poli Anak	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	Laboratorium	0	2	1	2	1	1	0	2	2	3	1	1	16

Grafik
Jumlah Asal Permintaan Test HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2024



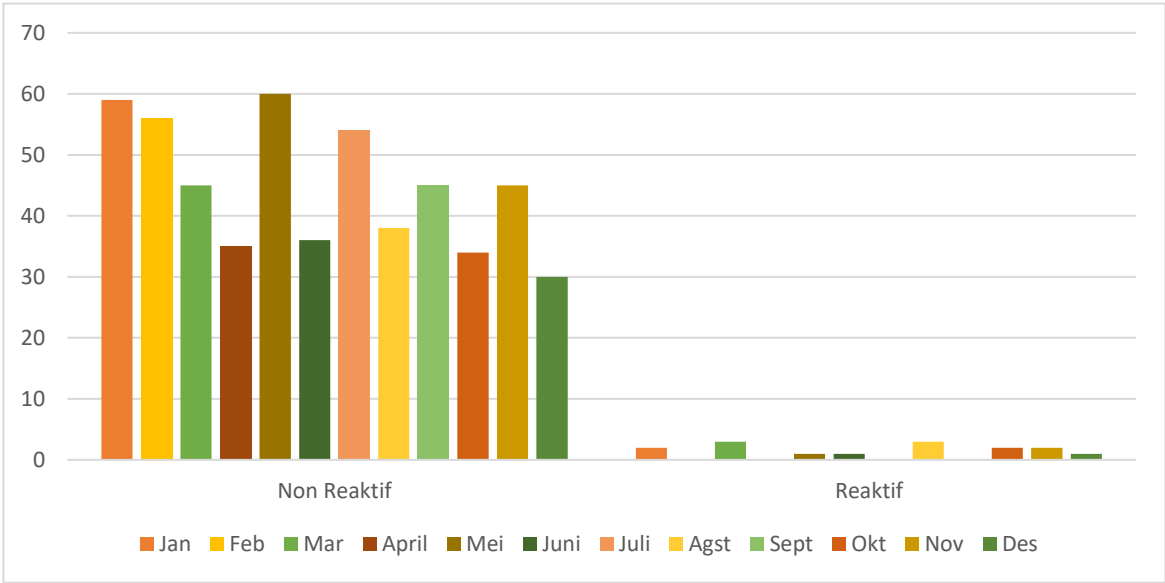
Analisis
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan pada tahun 2024 masih tinggi dibandingkan dengan unit lain yaitu 308 permintaan tes. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut
 Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.3.3 STATUS HIV

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Non Reaktif	59	56	45	35	60	36	54	38	45	34	45	30	537
2	Reaktif	2	0	3	0	1	1	0	3	0	2	2	1	15

Grafik
Status HIV DI Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024

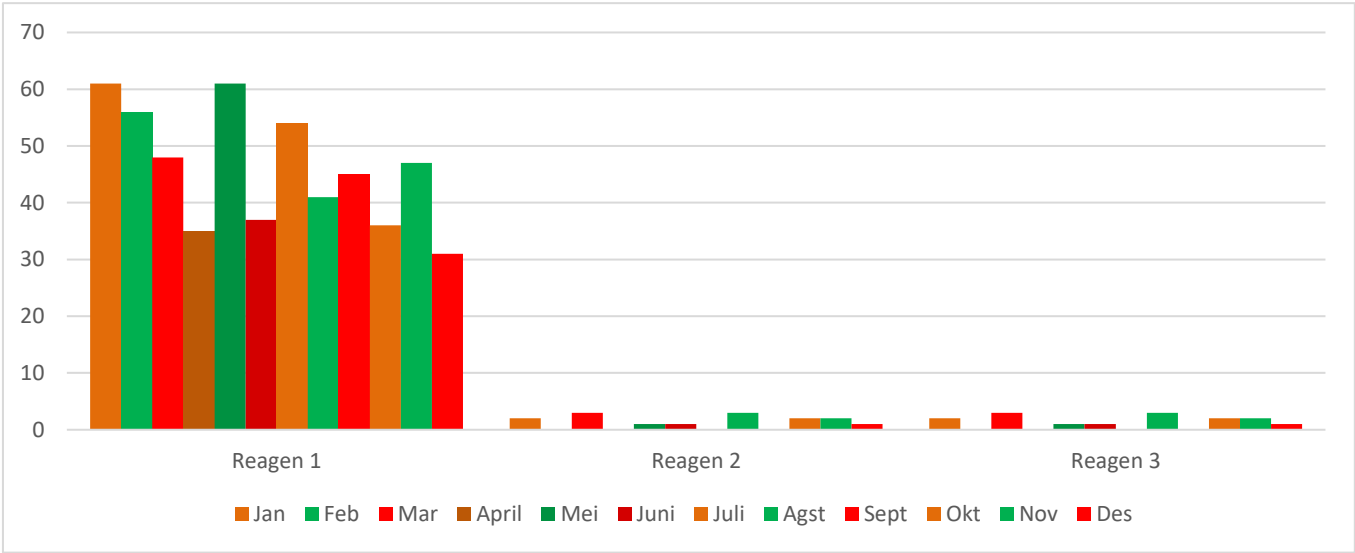


Analisis Status HIV
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa status HIV dengan status non reaktif pada tahun 2024 terdapat 537 orang pasien dan status reaktif pada tahun 2024 yaitu 15 orang pasien.

Rencana Tindak Lanjut
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.3.4 Jumlah Pemakaian Reagen														
No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Reagen 1	61	56	48	35	61	37	54	41	45	36	47	31	552
2	Reagen 2	2	0	3	0	1	1	0	3	0	2	2	1	15
3	Reagen 3	2	0	3	0	1	1	0	3	0	2	2	1	15

Grafik 4
Jumlah Pemakaian Reagen Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024



Analisis jumlah pemakaian reagen

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada tahun 2024 sampai dengan reagen 3, dikarenakan terdapat 15 pasien dengan hasil HIV Reaktif.

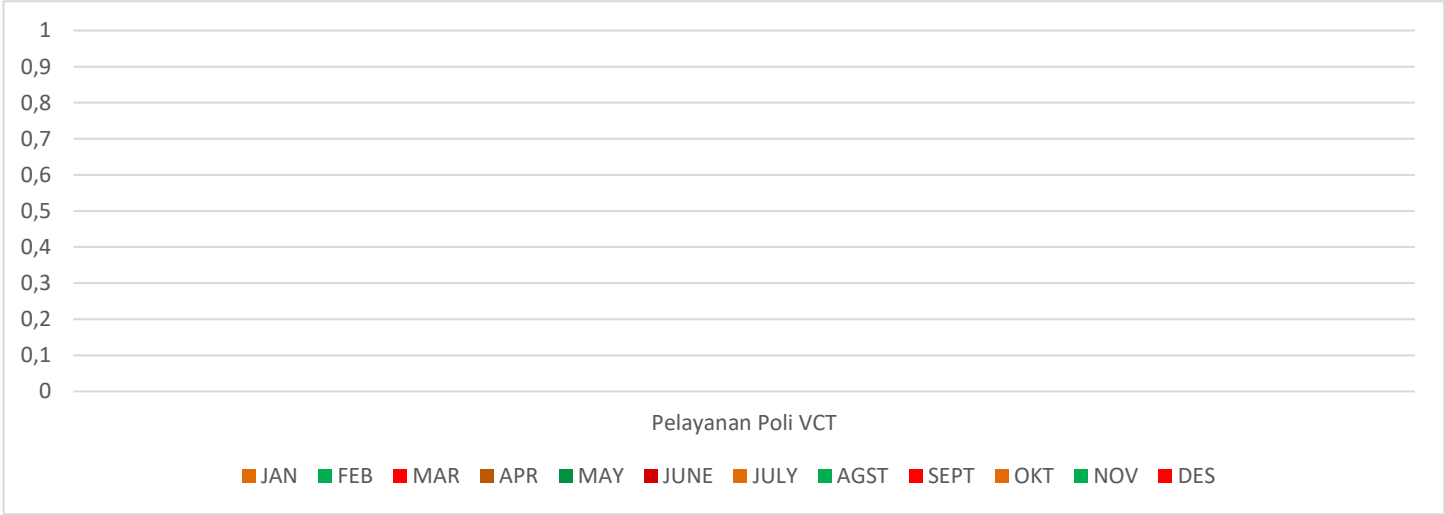
Rencana Tindak Lanjut

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3. Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.3.5 Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik
Pelayanan POLI VCT Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

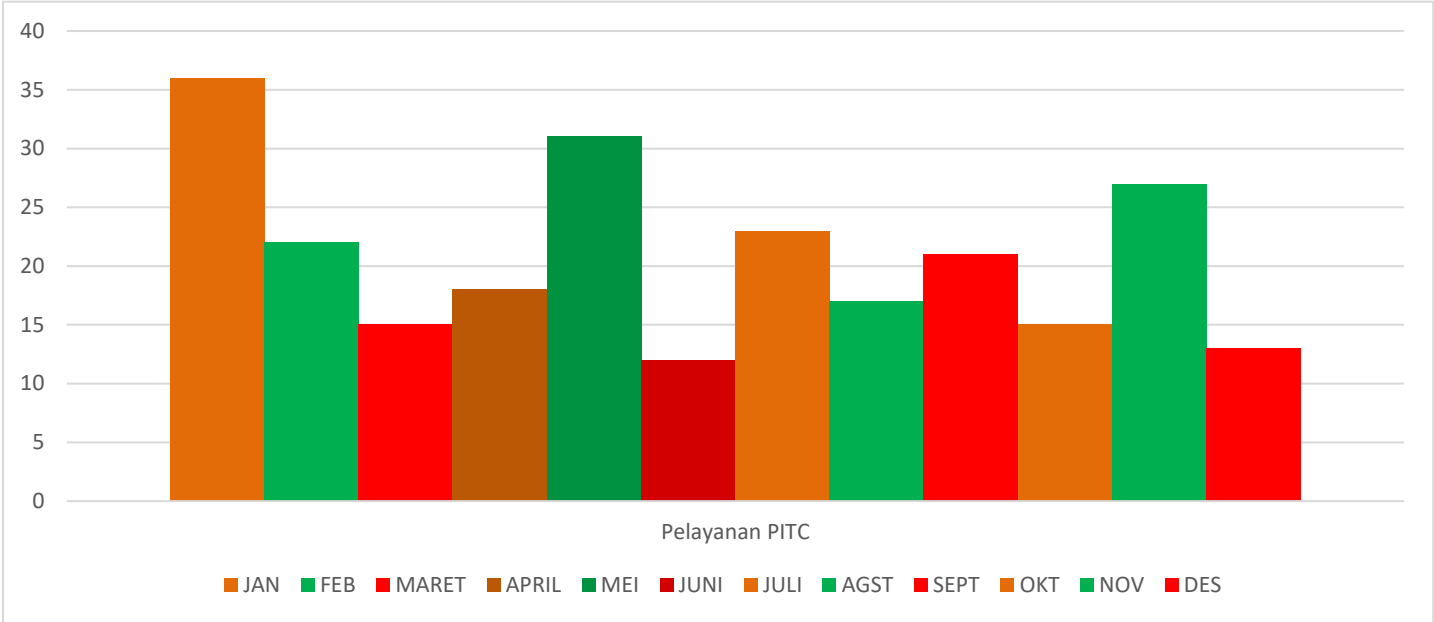
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

c Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan PITC	36	22	15	18	31	12	23	17	21	15	27	13	250

Grafik
Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024



Analisis pelayanan PITC

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada tahun 2024 sebanyak 250 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

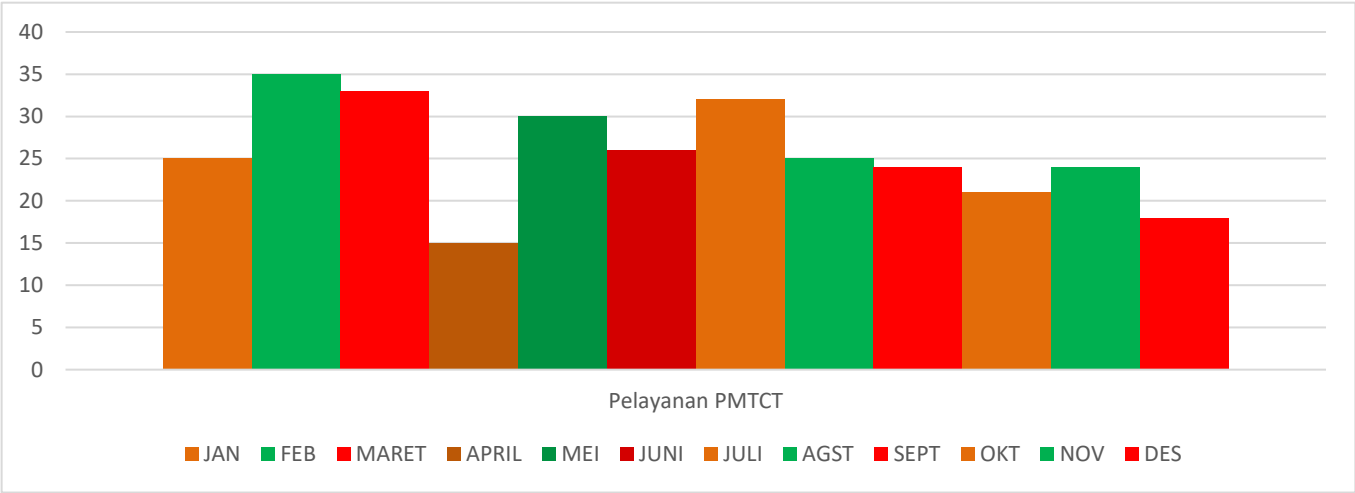
Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tenytang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.3.7 Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan PMTCT	25	35	33	15	30	26	32	25	24	21	24	18	308

Grafik
Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024



Analisis pelayanan PMTCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada tahun 2024 sebnayak 308 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

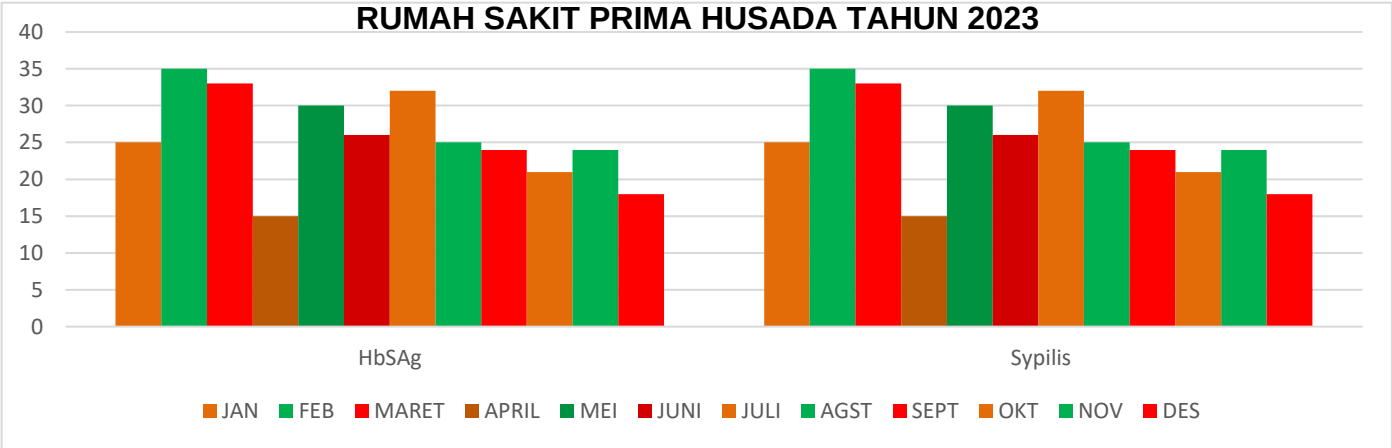
Rencana Tindak Lanjut

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.3.8 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pemeriksaan HbSAg	25	35	33	15	30	26	32	25	24	21	24	18	308
2	Pemeriksaan Sypilis	25	35	33	15	30	26	32	25	24	21	24	18	308

GRAFIK 8
PELAYANAN PEMERIKSAAN TRIPLE ELIMINASI PADA IBU HAMIL DI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2023



Analisis Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu hamil

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada tahun 2022 sebanyak 308 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

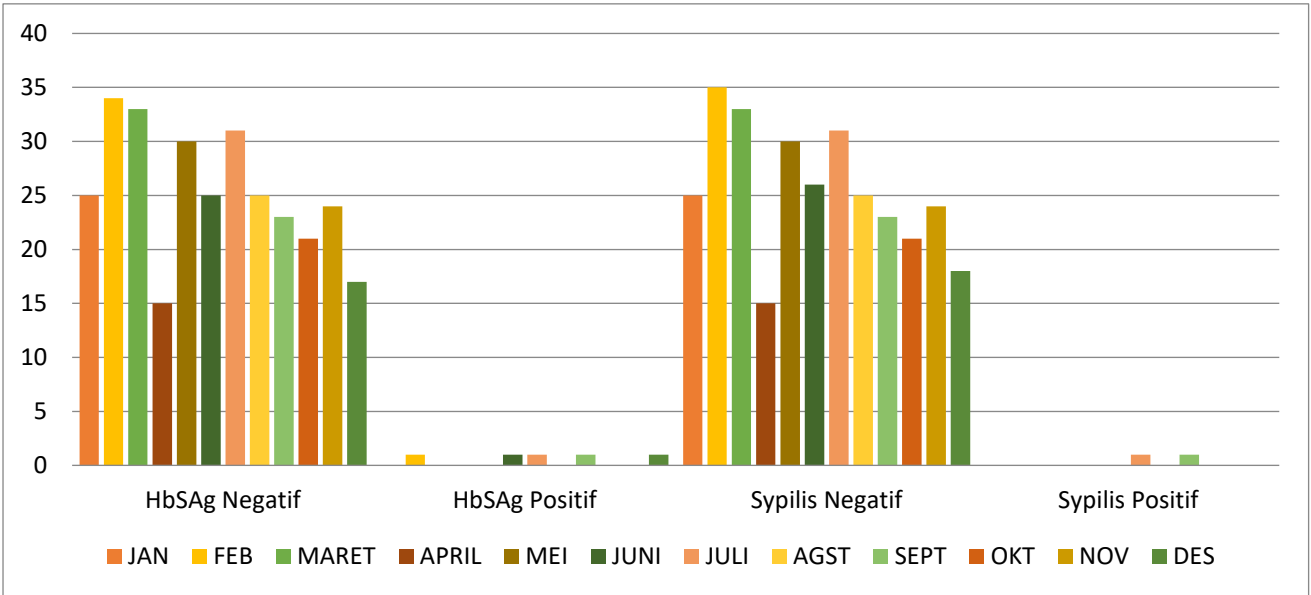
Rencana Tindak lanjut

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.3.9 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	HbSAg													
	Negatif	25	34	33	15	30	25	31	25	23	21	24	17	303
	Positif	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	5
2	Sypilis													
	Negatif	25	35	33	15	30	26	31	25	23	21	24	18	306
	Positif	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2

Grafik
Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2022



Analisis Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada ibu Hamil

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa ditemukan 5 kasus pasien dengan HbSAg positif sepanjang tahun 2024. Sedangkan pada kasus syphilis tditemukan 2 kasus positif. Hal ini dikarenakan pasien menerapkan pola hidup sehat saat kehamilan.

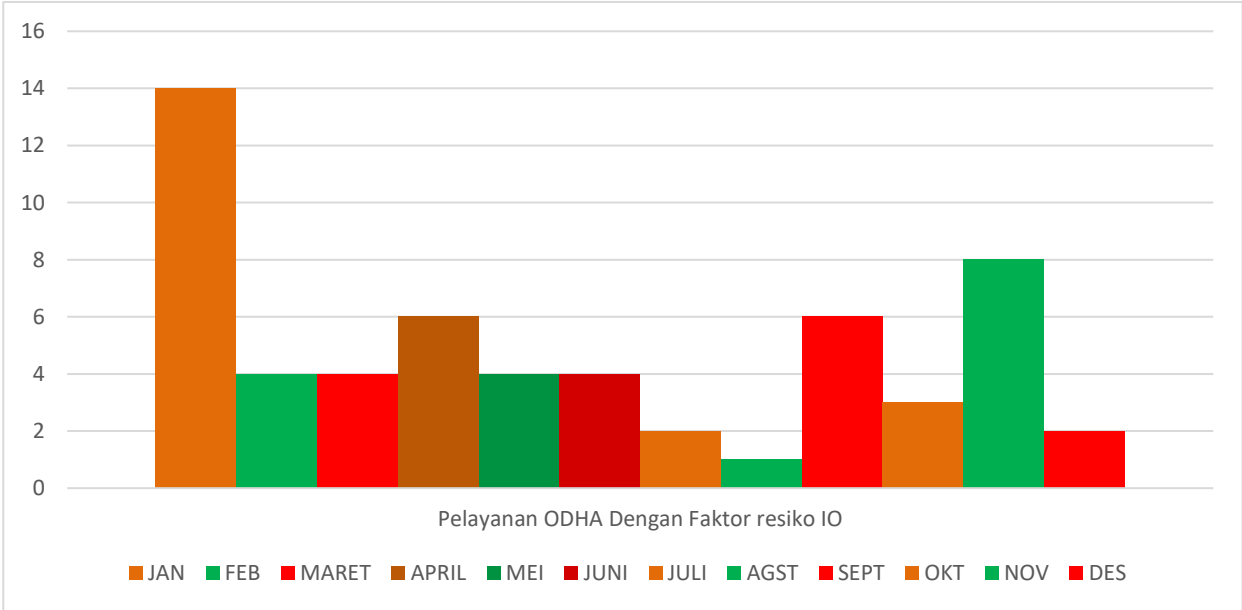
Rencana Tindak Lanjut

- Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- Pada pasien Sypilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.3.10 Pelayanan ODHA Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	14	4	4	6	4	4	2	1	6	3	8	2	58

Grafik
Pelayanan Odha Dg Faktor Resiko Io Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024



Analisis pelayanan Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada malang selama tahun 2024 sebanyak 58 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

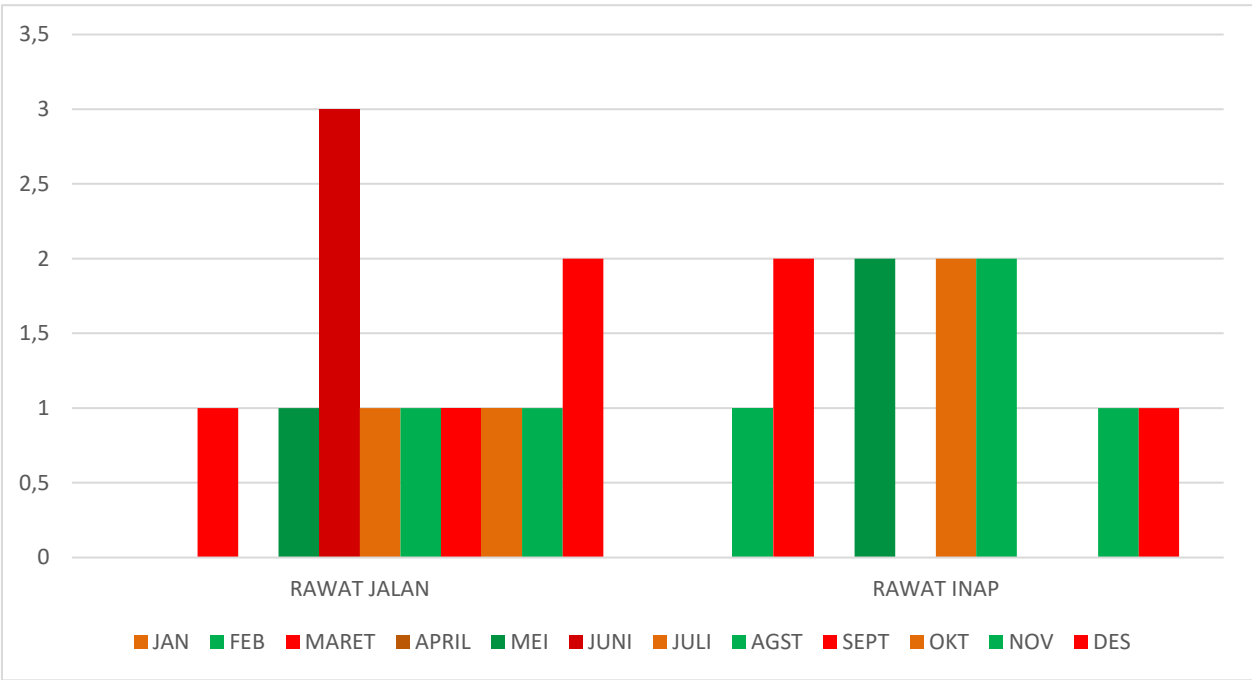
Rencana Tindak Lanjut

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.3.11 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Σ
1	Rawat Jalan	0	0	1	0	1	3	1	1	1	1	1	2	12
2	Rawat Inap	0	1	2	0	2	0	2	2	0	0	1	1	11

Grafik
Pelayanan Rujukan Pasien DENGAN HIV/AIDS Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024



Analisis Pelayanan rujukan pasien dengan HIV/AIDS

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada tahun 2024 terdapat 23 pasien yang dilakukan rujuk eksternal. Hal ini dikarenakan tidak ada pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut

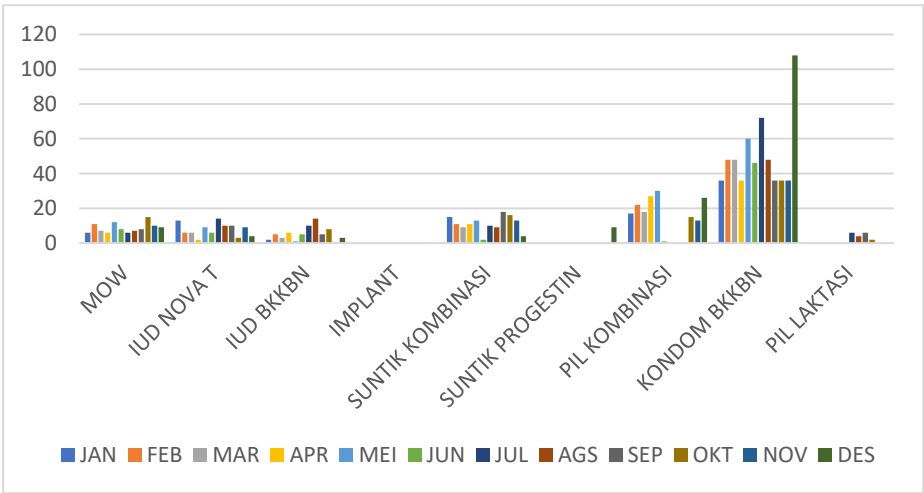
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang

3.3.4.2 PKBRS

3.3.4.2.1 Tabel Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	MOW	6	11	7	6	12	8	6	7	8	15	10	9
2	IUD Nova T	13	6	6	2	9	6	14	10	10	3	9	4
3	IUD BKKBN	2	5	3	6	1	5	10	14	5	8	0	3
4	IMPLANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SUNTIK KOMBINASI	15	11	9	11	13	2	10	9	18	16	13	4
6	SUNTIK PROGESTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7	PIL KOMBINASI	17	22	18	27	30	1	0	0	0	15	13	26
8	KONDOM BKKBN	36	48	48	36	60	46	72	48	36	36	36	108
9	PIL LAKTASI	0	0	0	0	0	0	6	4	6	2	0	0

3.3.4.2.2 Grafik Angka Capaian Pelayanan Kb Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Januari (6) meningkat pada bulan Februari (11) menurun pada Maret (7)
- 2. Peserta IUD Nova T pada Januari (13) dan pada bulan Februari (6) Maret (6) Peserta IUD BKKBN, pada Januari (2) dan meningkat pada bulan february (5) menurun Maret (3)
- 3. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Januari (15) Februari (11) menurun maret (9)
- 4. Peserta KB pil pada Januari (17) Februari (22) menurun Maret (18)
- 5. Peserta KB Kondom pada bulan Januari (36) Februari (48) maret (48)

6. Peserta MOW pada bulan April (6) Mei (12) Juni (8)
7. Peserta IUD Nova T pada bulan April (2)Mei meningkat(9) menurun Juni (6)
8. Peserta IUD BKKBN, pada bulan April (6) Mei menurun (1) meningkat Juni (5)
9. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan April (11) Mei meningkat(13) menurun Juni (2)
10. Peserta KB pil kombinasi pada April (27) Mei meningkat (30) menurun Juni (1) karena stok kosong Gudang bkkbn.
11. Peserta KB Kondom pada bulan April (36) Mei meningkat (60) menurun Juni (46)
12. Peserta MOW pada bulan Juli (6) Agustus naik (7) September naik (8)
13. Peserta IUD Nova T pada bulan Juli (14) Agustus (10) September (10)
14. Peserta IUD BKKBN, pada bulan Juli (10) meningkat agustus (14) menurun September (5)
15. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Juli (10) Agustus (9) meningkat September (18)
16. Peserta KB pil kombinasi karena stok kosong Gudang bkkbn Juli (0) Agustus (0) September (2),Pil KB laktasi Juli (6) Agustus (4) September (6)
17. Peserta KB Kondom pada bulan Juli (72) Agustus (48) September (36)
18. Peserta MOW pada bulan Oktober naik (15) November turun (10) Desember turun (7)
19. Peserta IUD Nova T pada bulan Oktober (3) November naik (9) Desember turun (4)
20. Peserta IUD BKKBN Oktober (8) menurun November (0) Desember naik (3)
21. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Oktober (16) menurun November (13) Desember turun (4)
22. Peserta KB suntik progestin Desember (9)
23. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Oktober meningkat (15) November menurun (13) Desember naik (26),Pil KB laktasi September (6) Oktober menurun (2) November dimusnahkan karena ED
24. Peserta KB Kondom pada bulan Oktober (48) November menurun (36) Desember meningkat(108)

Analisis:

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

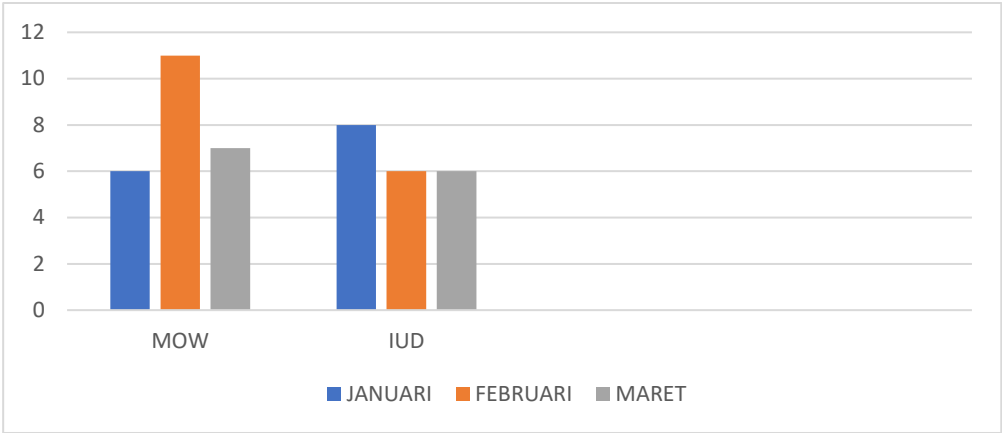
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

3.3.4.2.3 Tabel Angka Capaian Pelayanan KB Pasca persalinan dan Pasca Keguguran

NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	MOW	6	11	7	6	12	8	6	7	8	15	10	9
2	IUD	8	6	7	6	4	8	10	13	7	7	1	4

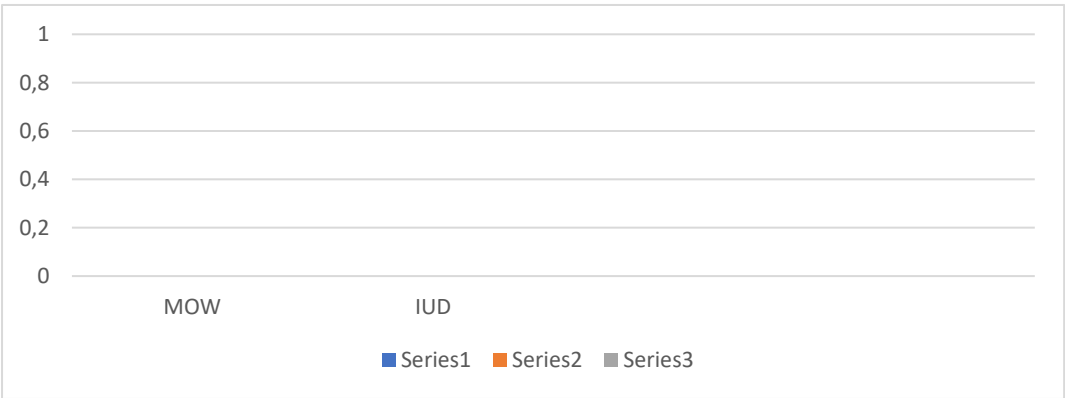
3.3.4.2.4 Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



3.3.4.2.5 Tabel Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	MOW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3.4.2.6 Grafik Capaian Pelayanan KB Pasca Keguguran



Analisa :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

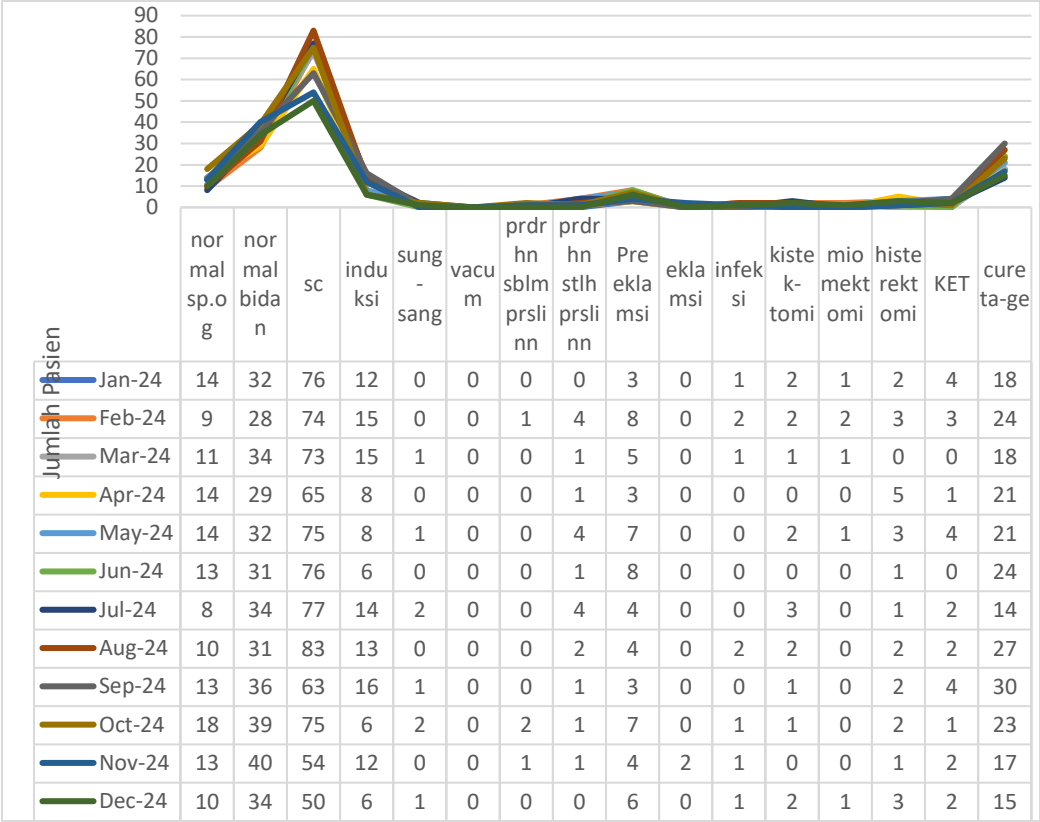
- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluha

3.3.4.3 PONEK

3.3.4.3.1 Kinerja Produktivitas Pelayanan Maternal 2024

No	Jenis Pelayanan		Jumlah Pasien												Σ 2024	Rata2	Σ 2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1		Persalinan															
	1. Persalinan Normal Sp. OG		14	9	11	14	14	13	8	10	13	18	13	10	147	12	131
	2. Persalinan Normal Bidan		32	28	34	29	32	31	34	31	36	39	40	34	400	33	404
	3. SectioCaesaria		76	74	73	65	75	76	77	82	63	75	54	50	840	70	826
2																	
	1. Induksi / Drip		12	15	15	8	8	6	14	13	16	6	12	6	79	6	138
	2. Sungsang		0	0	1	0	1	0	2	0	1	2	0	1	8	1	2
	3. Vacum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3																	
	A. Perdarahan sebelum Persalinan		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	0	5
	B.Perdarahan setelah Persalinan		0	4	1	1	4	1	4	2	1	1	1	0	20	2	12
	C. Pre Eklamsi		3	8	5	3	7	8	4	4	3	7	4	6	62	5	73
	D. Eklamsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5
	E. Infeksi		1	2	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1	9	1	13
4																	
	a. Curretage		18	24	18	21	21	24	14	27	30	23	17	15	252	21	235
	b. Kistektomi		2	2	1	0	2	0	3	2	1	1	0	2	16	1	9
	c. Miomektomi		1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4
	d. Histerectomy		2	2	0	5	3	1	1	2	2	2	1	3	24	2	37
	e. KET		4	3	0	1	4	0	2	2	4	1	2	2	25	2	23

3.3.4.3.1.1 Grafik Pelayanan Maternal 2024



Analisa :

- 1. Pelayanan Sectio Caesaria yang tertinggi pada bulan Agustus yaitu 83 pasien disebabkan disebabkan banyak kasus yang tidak bisa dilayani dengan persalinan normal dan terendah di bulan Desember yaitu 50 pasien disebabkan banyak kasus inpartu dengan resiko rendah sehingga bisa dilayani dengan Tindakan persalinan normal
- 2. Pelayanan Persalinan normal tertinggi di bulan November yaitu 40 pasien, disebabkan banyak kasus yang bisa dilayani dengan resiko rendah dan persalinan paling rendah di bulan Februari yaitu 28 pasien disebabkan banyak kasus resiko tinggi yang harus dilakukan Tindakan SC
- 3. Tidak semua pasien dilayani dengan observasi induksi/drip, hanya kasus-kasus tertentu yang dilakukan tindakan tersebut, tindakan ini dilakukan disebabkan ada kasus-kasus tertentu seperti his kurang adekuat.
- 4. Penyulit persalinan dan diagnosa patologis hanya ada beberapa kasus selama tahun 2024
- 5. Tindakan curettage tertinggi pada bulan September yaitu 30 pasien, dan terendah pada bulan juli yaitu 14 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahayapada kehamilan.
- 4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.3.4.4 STUNTING DAN WASTING

3.3.4.4.1 Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

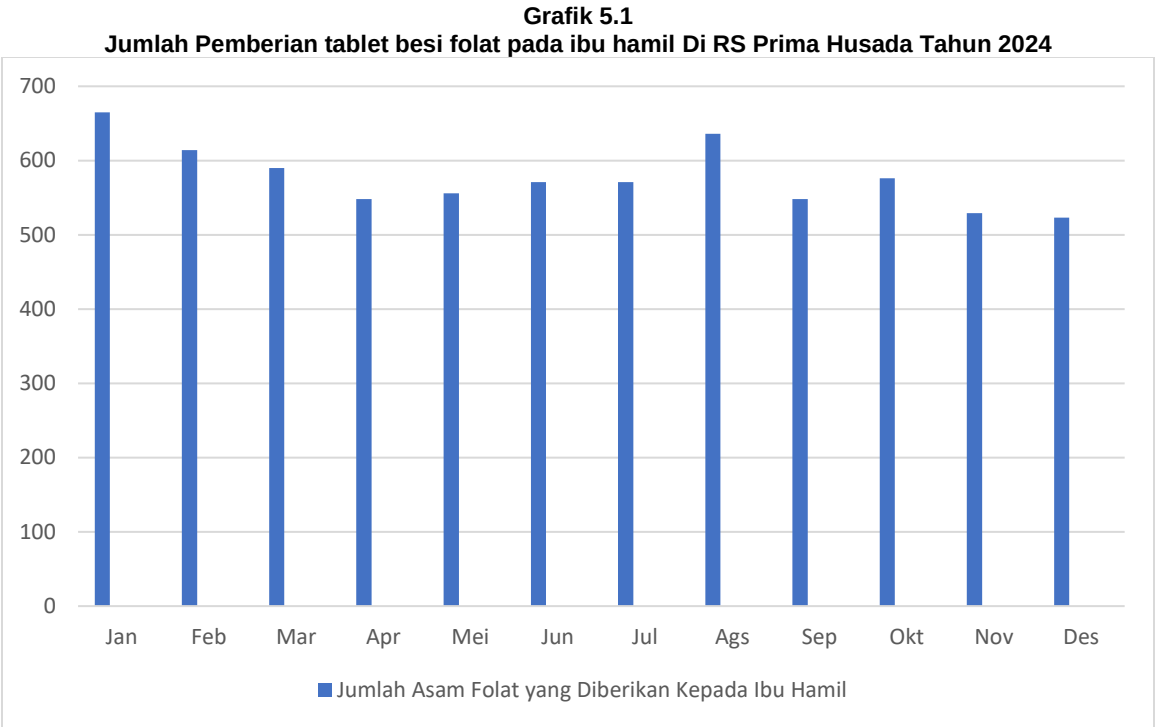
	tinggi badan anak														
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa intervensi yang diberikan dengan bekerjasama dengan puskesmas karena ketersediannya hanya ada di puskesmas seperti pemberian bubuk taburia dan vitamin A. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pada bulan Maret karena terdapat 1 balita stunting dan wasting yang berasal dari puskesmas Ardimulyo. Sehingga Ahli Gizi Puskesmas Ardimulyo melakukan koordinasi dengan Ahli gizi RSPHM untuk pemberian PKMK, Bubuk Taburia, dan mineral mix terhadap pasien tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.3.3.4.2 Pemberian Tablet Besi Folat bagi ibu hamil
3.3.4.4.2.1 Tabel Distribusi Tablet besi folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	665	614	590	548	556	571	571	636	548	576	529	523



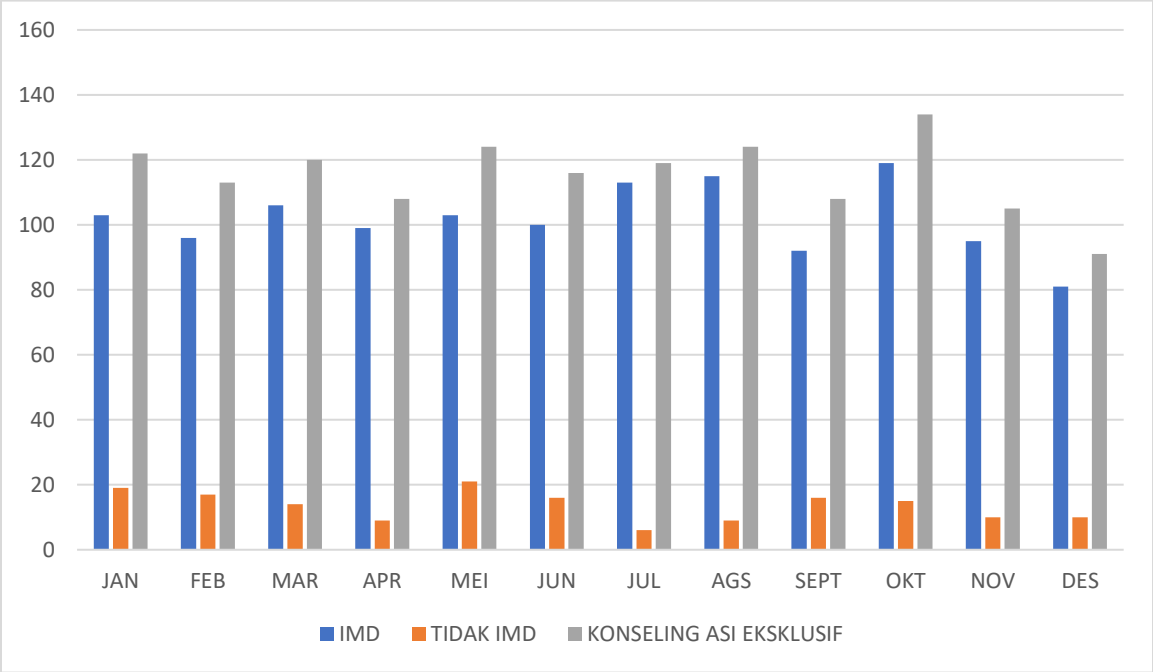
Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah asam folat yang diberikan kepada ibu hamil mengalami naik turun pada tahun 2024 bergantung kepada jumlah kunjungan ibu hamil.

- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.3.3.4.4.3 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
3.3.3.4.4.3.1 Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

No	Uraian	Jumlah Pasien											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	IMD	103	96	106	99	103	100	113	115	92	119	95	81
2	Tidak IMD	19	17	14	9	21	16	6	9	16	15	10	10
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	122	113	120	108	124	116	119	124	108	134	105	91

3.3.3.4.4.3.2 Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Tahun 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada mengalami kenaikan pada bulan Oktober yaitu 119 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Januari 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan lainnya, yaitu 19 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Oktober 2024.

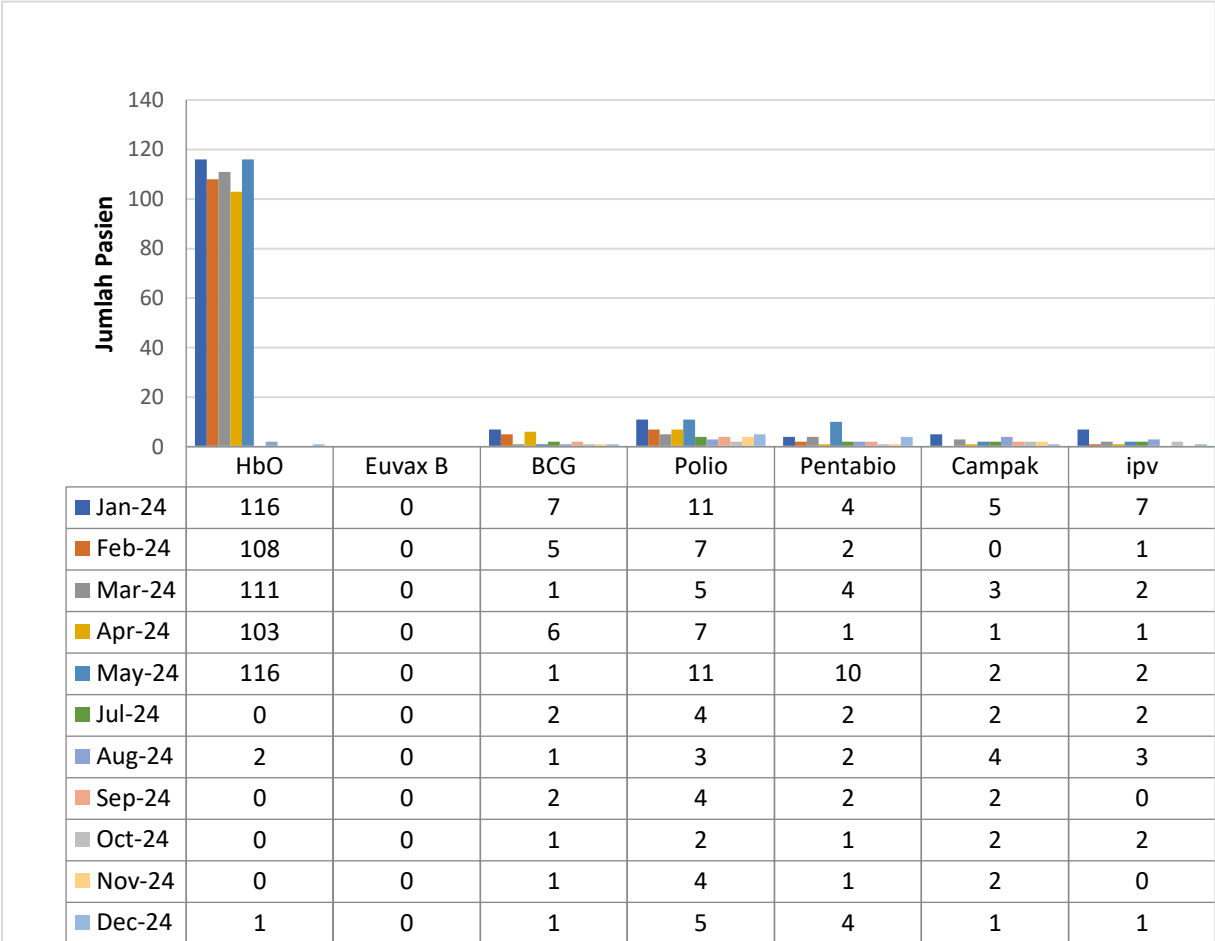
Rencana Tindak Lanjut:

Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.3.3.4.4.4Jumlah Balita yang mendapat imunisasi
3.3.3.4.4.4.1 Tabel Jumlah Balita yang mendapat imunisasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	HbO	116	108	111	103	116	71	0	2	0	0	1	1
2	Euvax B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BCG	7	5	1	6	1	3	2	1	2	1	1	1
3	Polio	71	67	65	67	71	66	4	3	4	2	4	5
4	Pentabio	64	62	64	61	70	63	2	2	2	1	1	4
5	Campak	5	0	3	1	2	0	2	4	2	2	2	1
6	IPV	7	1	2	1	2	1	2	3	0	2	0	1

3.3.3.4.4.2 Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2024

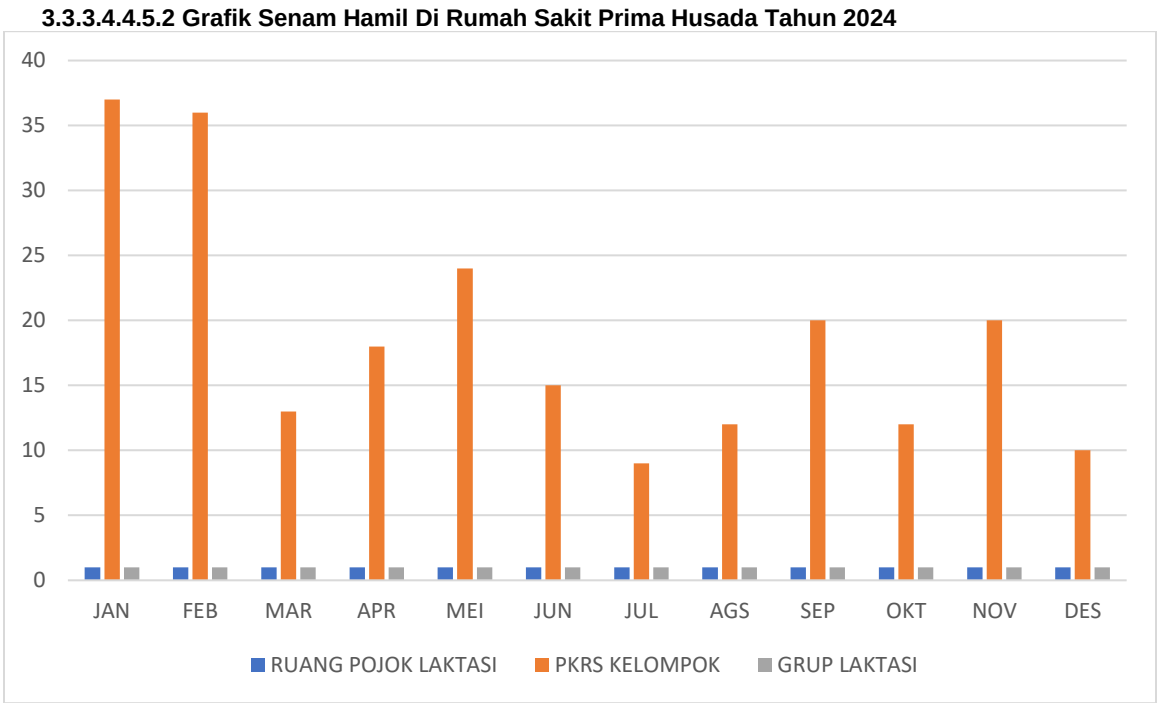


Analisis:
Tren kunjungan pasien untuk melakukan imunisasi pada anak mengalami penurunan pada 6 bulan terakhir. Hal ini disebabkan karena beberapa vaksin terbatas ketersediannya dan ketersediannya hanya ada di puskesmas seperti vaksin HB0 dan rotavirus.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Penanggungjawab Imunisasi melakukan komunikasi dengan pihak Puskesmas Singosari untuk penyediaan vaksin HB0 dan rotavirus di RS Prima Husada Malang. Akan tetapi dari pihak puskesmas masih belum bisa menyediakan di rumah sakit swasta karena jumlah vaksin rotavirus yang terbatas.

3.3.3.4.4.5 .Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
3.3.3.4.4.5.1 Tabel Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Kegiatan Penerapan Rumah sakit sayang ibu dan bayi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Edukasi Senam Hamil	37	36	13	18	24	15	9	12	20	12	20	10
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



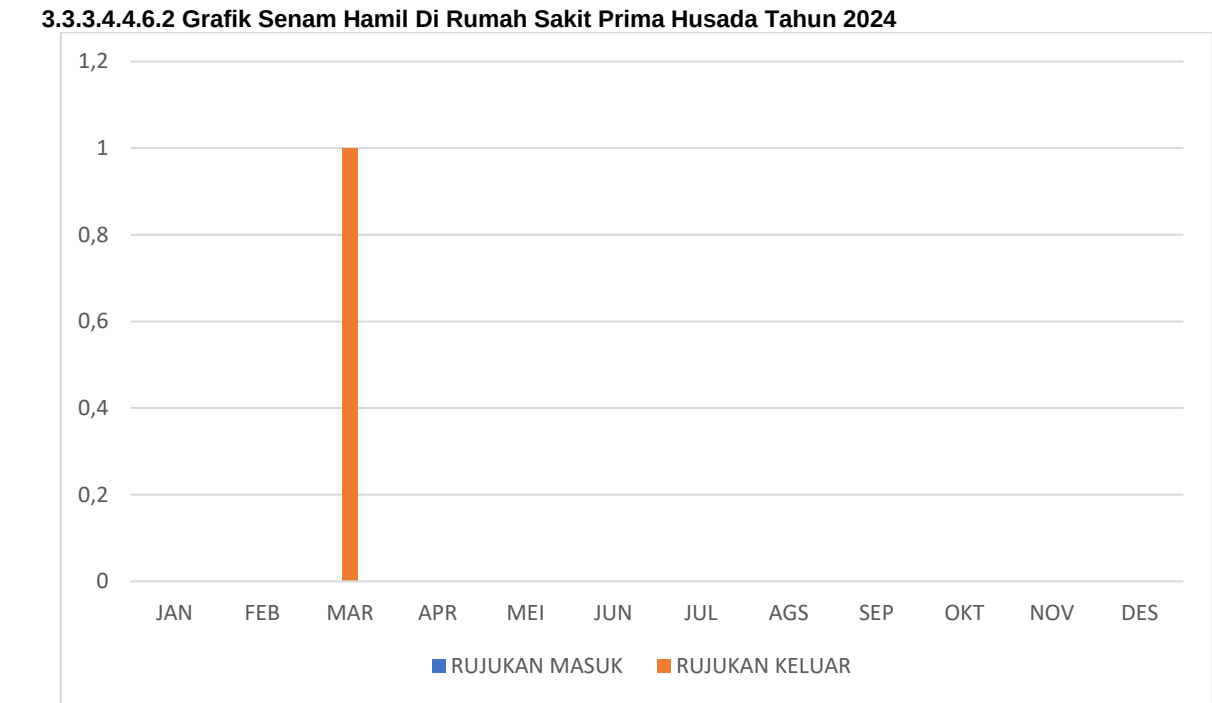
- Analisis :**
1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.

Rencana Tindak Lanjut :
Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.

3.3.3.4.4.6 Pelayanan jejaring rujukan kasus stunting dan wasting

3.3.3.4.4.6.1 Tabel Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

No	Rujukan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rujukan Masuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rujukan keluar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Analisis :
Terdapat 1 pasien dengan kondisi stunting yang dirujuk keluar yaitu ke RS Saiful Anwar dengan diagnose Stunting + Autism.

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangir pasien stunting dan wasting.

3.3.3.4.4.7 Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan

3.3.3.4.4.7.1 Tabel Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pasien Stunting	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0
Pasien Wasting	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0

3.3.3.4.4.7.2 Grafik Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan



Analisa :
Terdapat balita terindikasi stunting dan wasting di RS Prima Husada Malang pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Oktober, dan November. Hal tersebut dikarenakan pola makan balita terbilang kurang karena hanya 1-2 kali sehari, pasien juga jarang megkonsumsi makanan tinggi protein dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

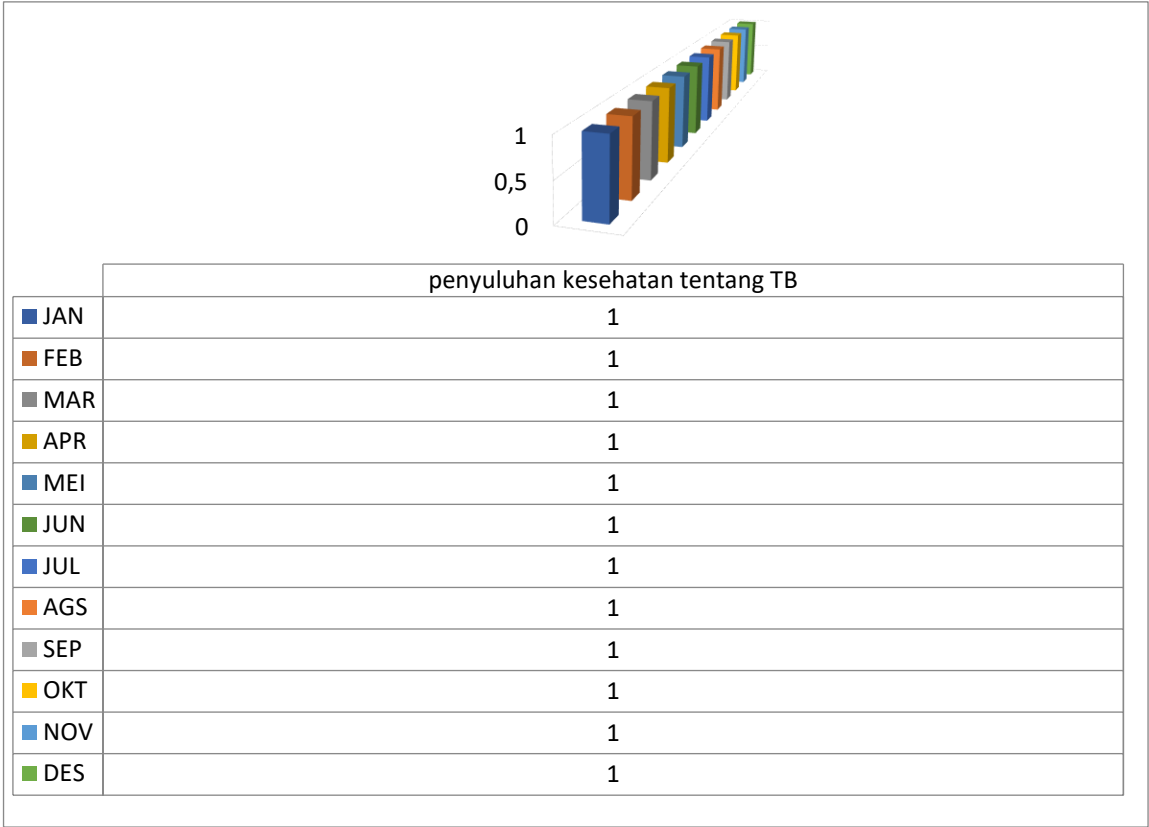
Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

3.3.4.5 TB DOT'S

3.3.4.5.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3.3.4.5.1 Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Di RS Prima Husada



Evaluasi :

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut

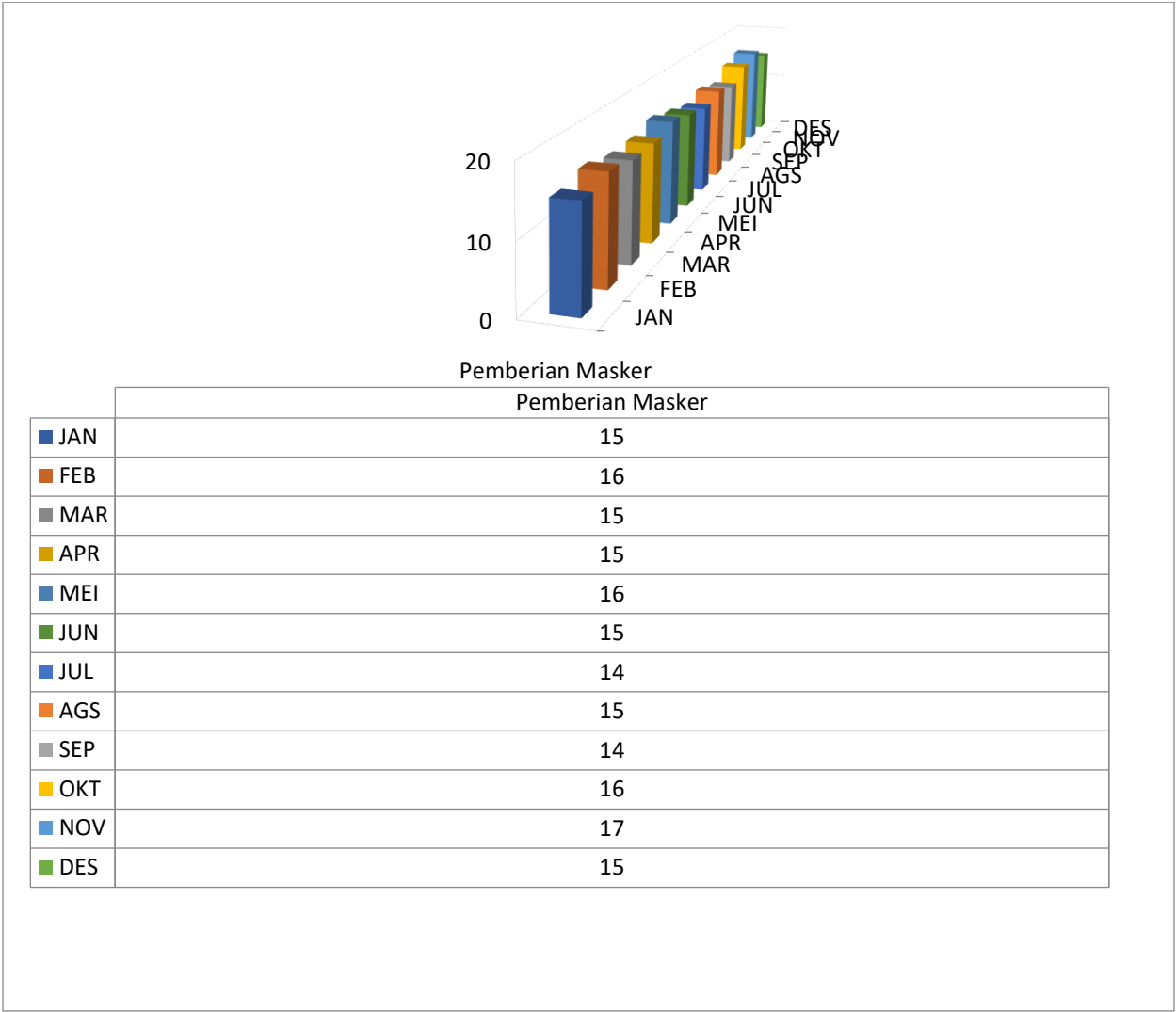
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.3.4.5.2 Skrining Pasien

No	Jenis Skrining	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemberian Masker	15	16	15	15	16	15	14	15	14	16	17	15

Grafik 2

3.3.3.4.5.2.1 Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Januari 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 2) Pada bulan Februari 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 3) Pada bulan Maret 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 4) Pada bulan APRIL 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 5) Pada bulan MEI 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 6) Pada bulan JUNI 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 7) Pada bulan JULI 2024 terdapat 14 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 8) Pada bulan AGUSTUS 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 9) Pada bulan SEPTEMBER 2024 terdapat 14 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 10) Pada bulan OKTOBER 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 11) Pada bulan NOVEMBER 2024 terdapat 17 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

12) Pada bulan DESAMBER 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standar

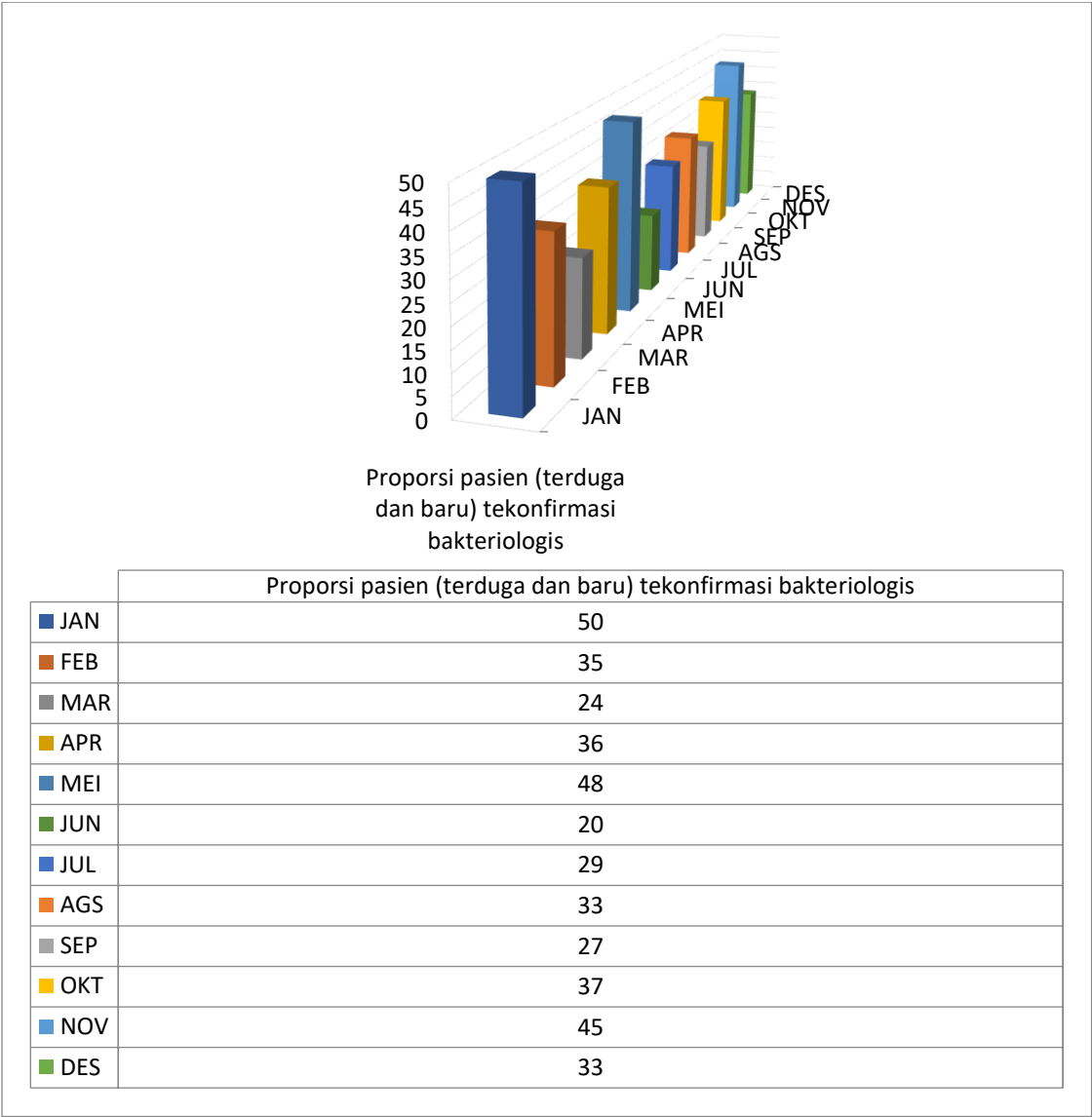
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2) Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.3.3.4.5.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

No	Jenis Skrining	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	50	35	24	36	48	20	29	33	27	37	45	33

3.3.3.4.5.4 Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Di RS Prima Husada B



Evaluasi :

- 1) Pada bulan januari 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 50
- 2) Pada bulan februari 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 35
- 3) Pada bulan maret 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 24
- 4) Pada bulan APRIL 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36
- 5) Pada bulan MEI 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 48
- 6) Pada bulan JUNI 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 20
- 7) Pada bulan JULI 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 29
- 8) Pada bulan AGUSTUS 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 33
- 9) Pada bulan AGUSTUS 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 27
- 10) Pada bulan OKTOBER 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 37
- 11) Pada bulan NOVEMBER 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 45
- 12) Pada bulan DESEMBER 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 33

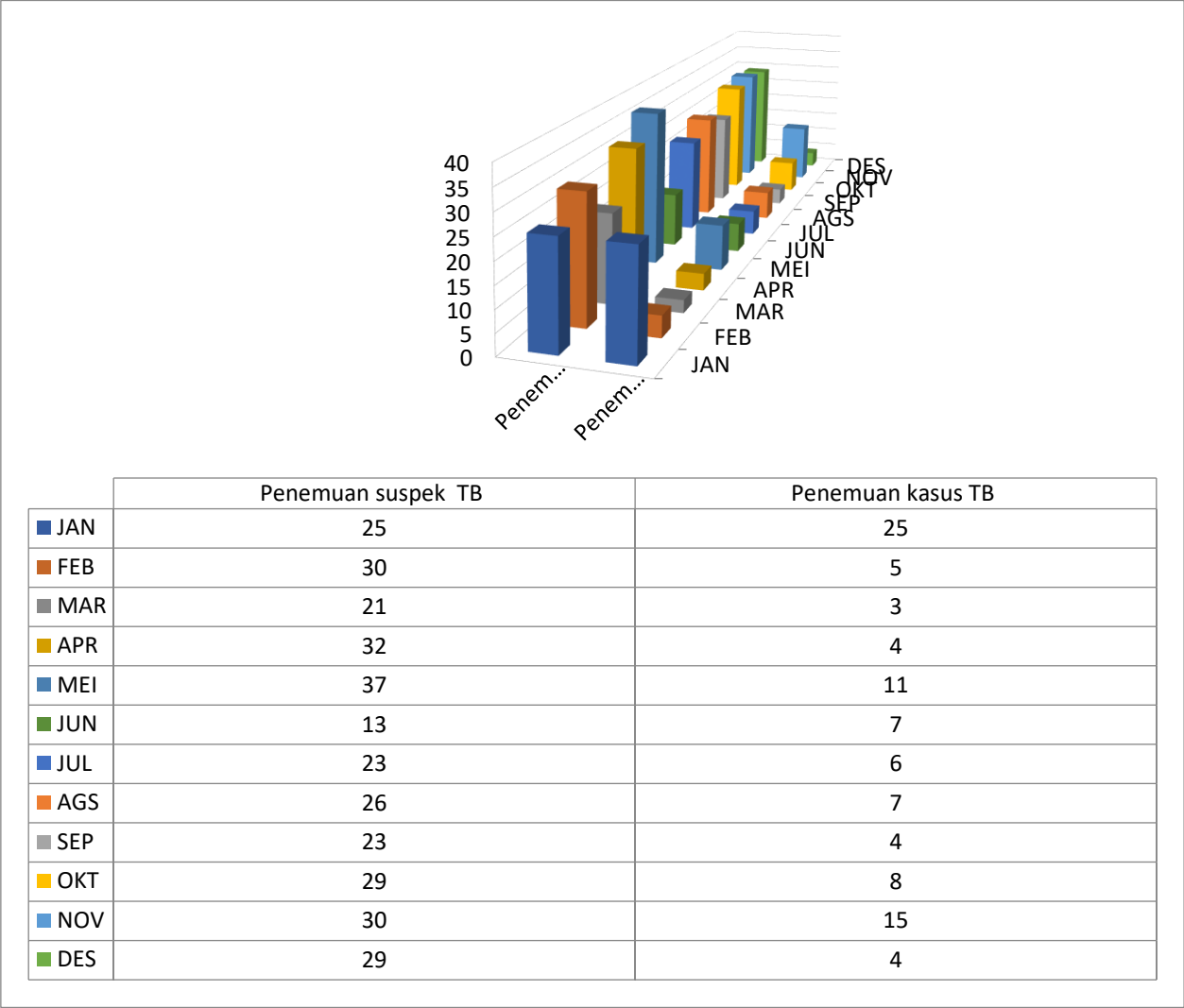
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.3.3.4.6 Penemuan Kasus TB

No	Jenis Skrining	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penemuan suspek TB	25	30	21	32	37	13	23	26	23	29	30	29
2	Penemuan kasus TB	25	5	3	4	11	7	6	7	4	8	15	4

3.3.3.4.6.1 Grafik Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi

- 1) Pada bulan januari 2024 terdapat 25 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 25 pasien
- 2) Pada bulan februari 2024 terdapat 30 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 5 pasien
- 3) Pada bulan maret 2024 terdapat 21 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 3 pasien
- 4) Pada bulan APRIL 2024 terdapat 32 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien
- 5) Pada bulan MEI 2024 terdapat 37 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 11 pasien
- 6) Pada bulan JUNI 2024 terdapat 13 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 7 pasien
- 7) Pada bulan JULI 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien
- 8) Pada bulan AGUSTUS 2024 terdapat 26 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 7 pasien
- 9) Pada bulan SEPTEMBER 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien
- 10) Pada bulan OKTOBER 2024 terdapat 29 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 8 pasien
- 11) Pada bulan NOVEMBER 2024 terdapat 30 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 15 pasien

12) Pada bulan DESEMBER 2024 terdapat 29 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien

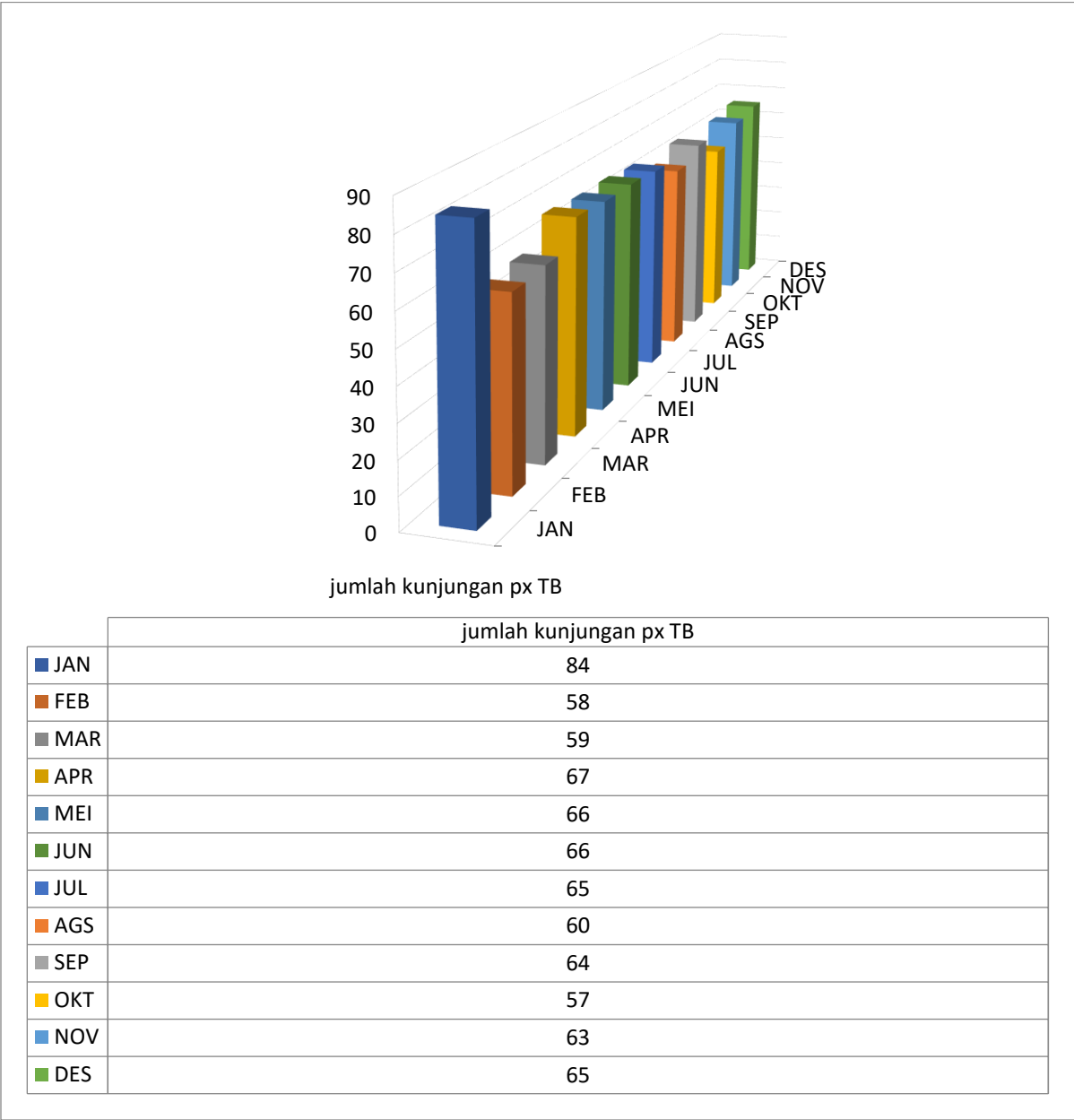
Rencana Dan Tindak Lanjut

- 1) Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning

3.3.3.4.4.8 Jumlah Kunjungan pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasien TB kunjungan keseluruhan	84	58	59	67	66	66	65	60	64	57	63	65

3.3.3.4.9 Grafik 5Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



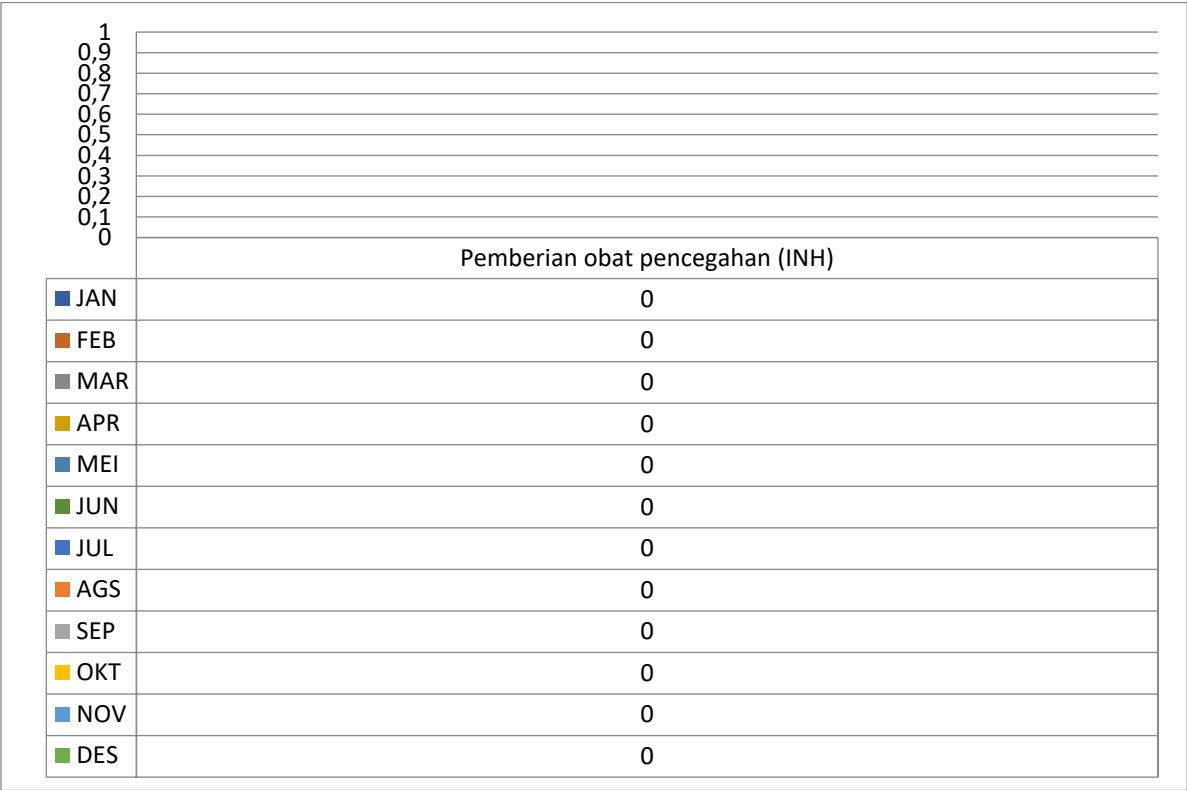
Evaluasi :
Setiap bulannya terus meningkatkan jumlah kunjungan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.3.3.4.5 Pemberian Obat Pencegahan

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3.3.4.5.1 Grafik Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima Husada



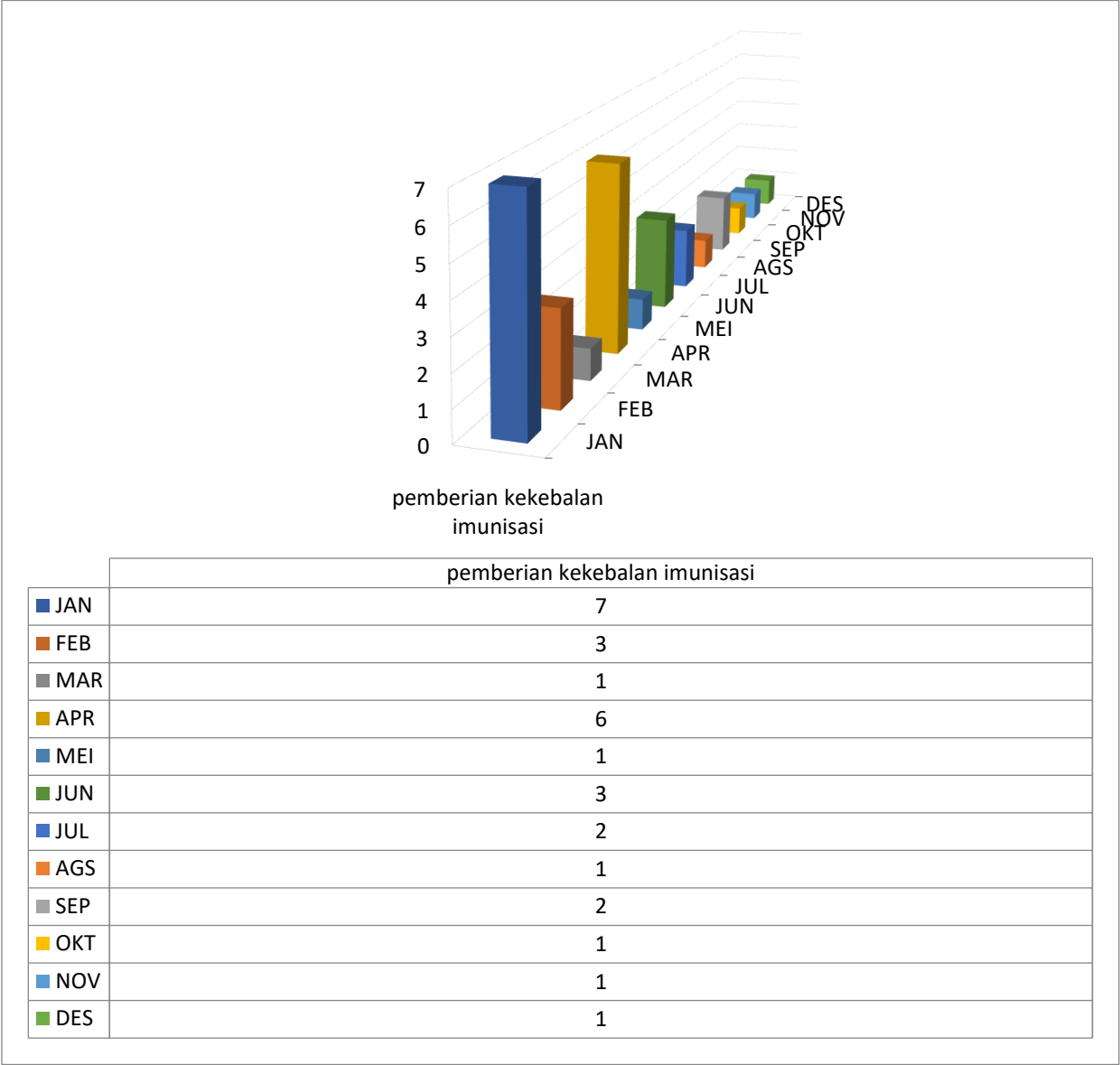
Evaluasi :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- 1) Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
 - 2) Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.3.3.4.4.6 Pemberia Imunisasi BCG

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemberian imunisasi BCG	7	3	1	6	1	3	2	1	2	1	1	1

3.3.3.4.4.6.1 Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 7 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
- 2) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari
- 3) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Maret
- 4) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 6 pasien yang diimunisasi pada bulan APRIL
- 5) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan MEI
- 6) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan JUNI
- 7) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan JULI
- 8) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan AGUSTUS
- 9) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan SEPTEMBER
- 10) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan OKTOBER

- 11) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan NOVEMBER
- 12) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan DESEMBER

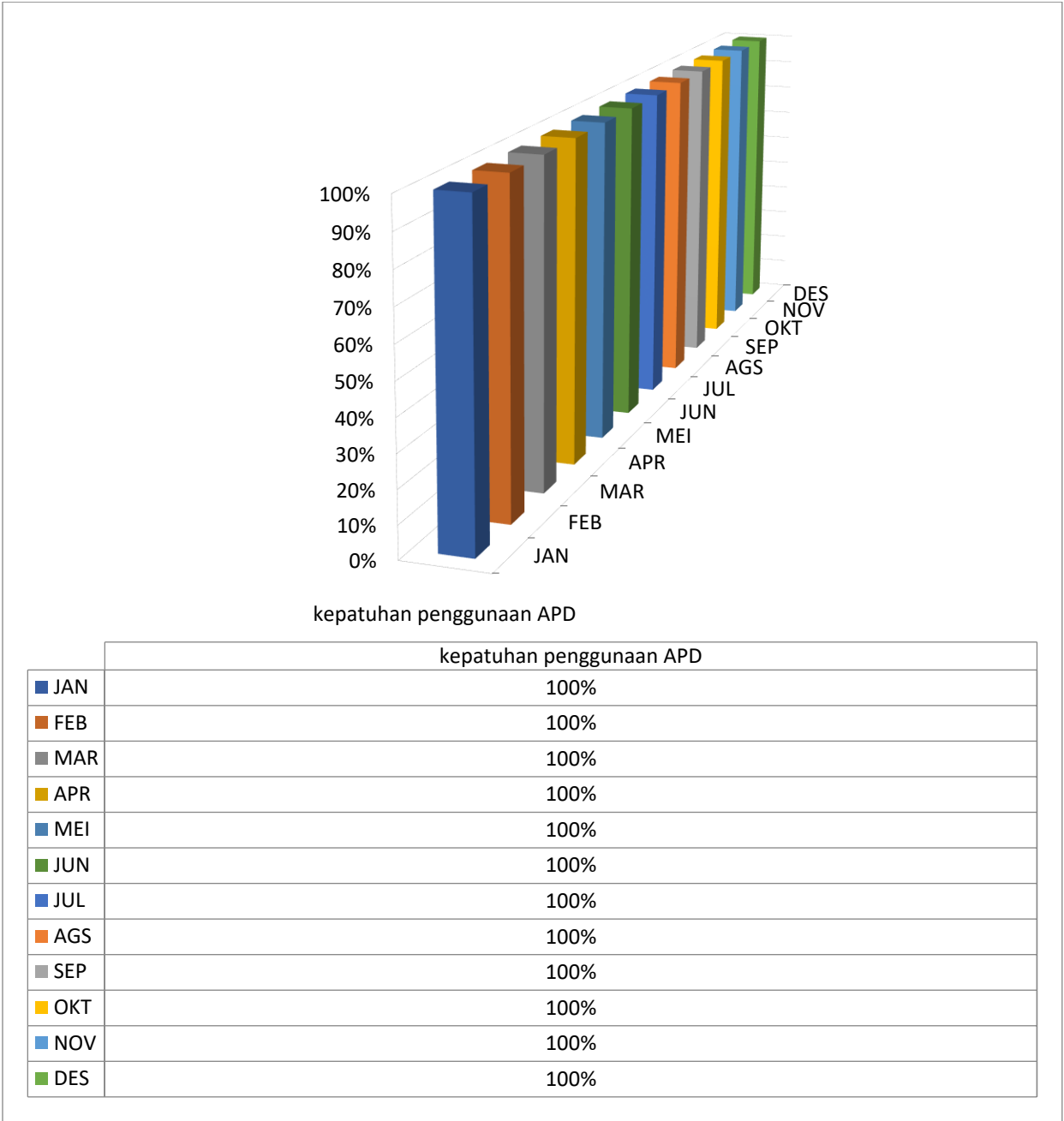
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2) Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya.

3.3.3.4.Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.3.4.1 Grafik
Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada Bulan



Evaluasi :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

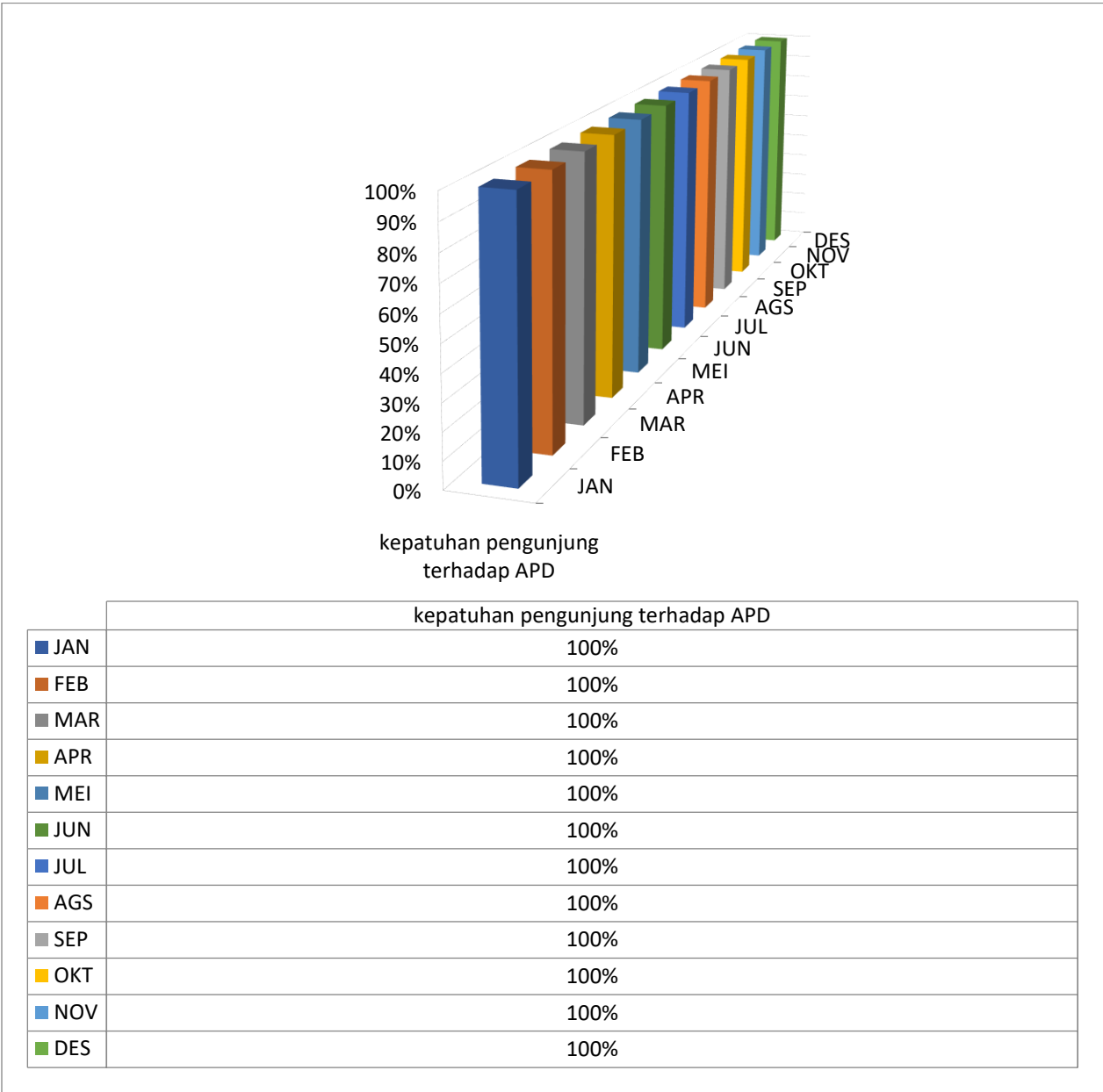
Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.3.3.4.5 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 9

Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

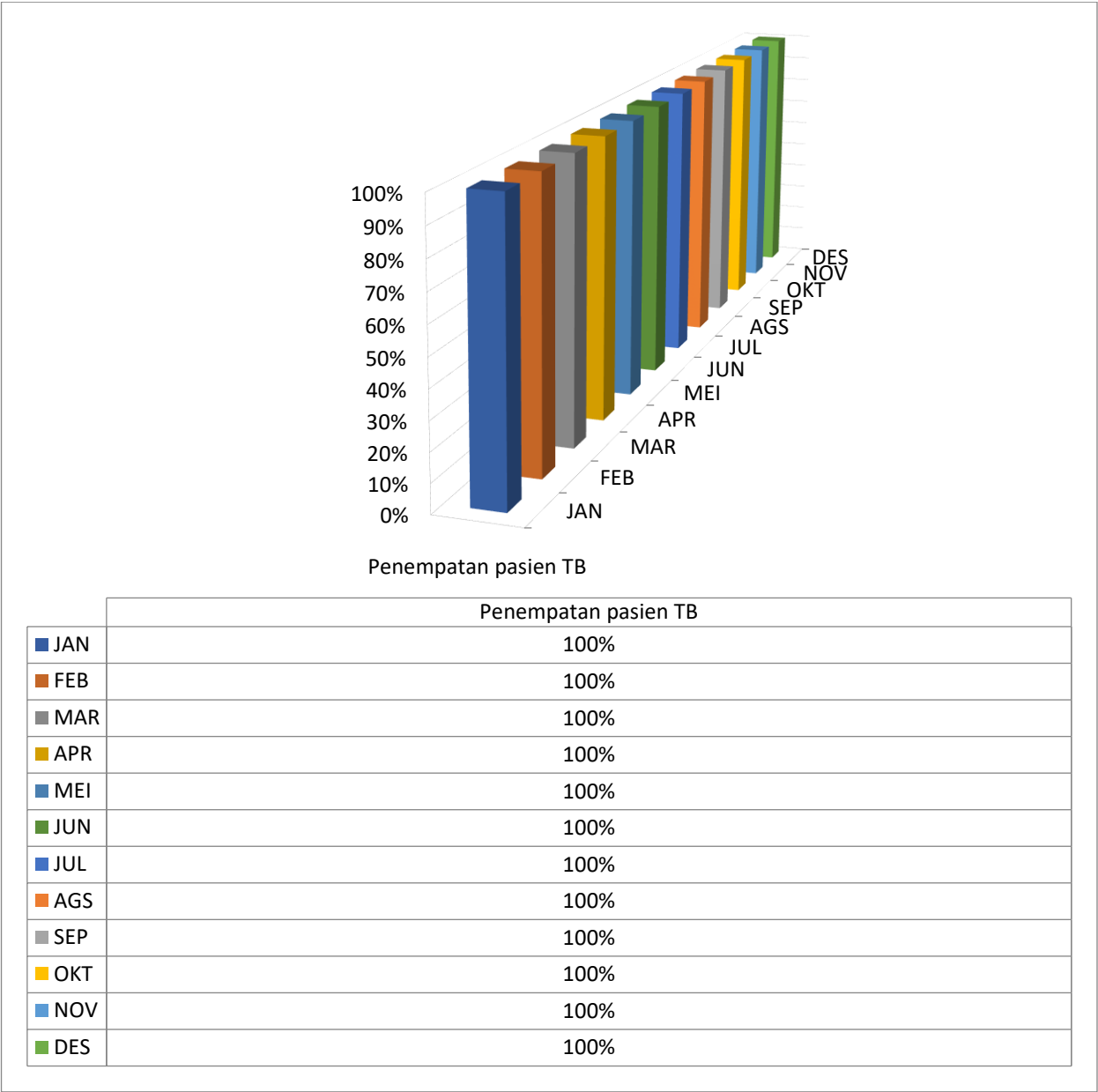
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.3.3.4.6 Penempatan Pasien TB

NO	Kegiatan	Jumlah kegiatan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 10
Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.
- 2) Dari bulan ke bulan mengalami stabilitas yang baik dalam penempatan pasien TB di ruang isolasi.

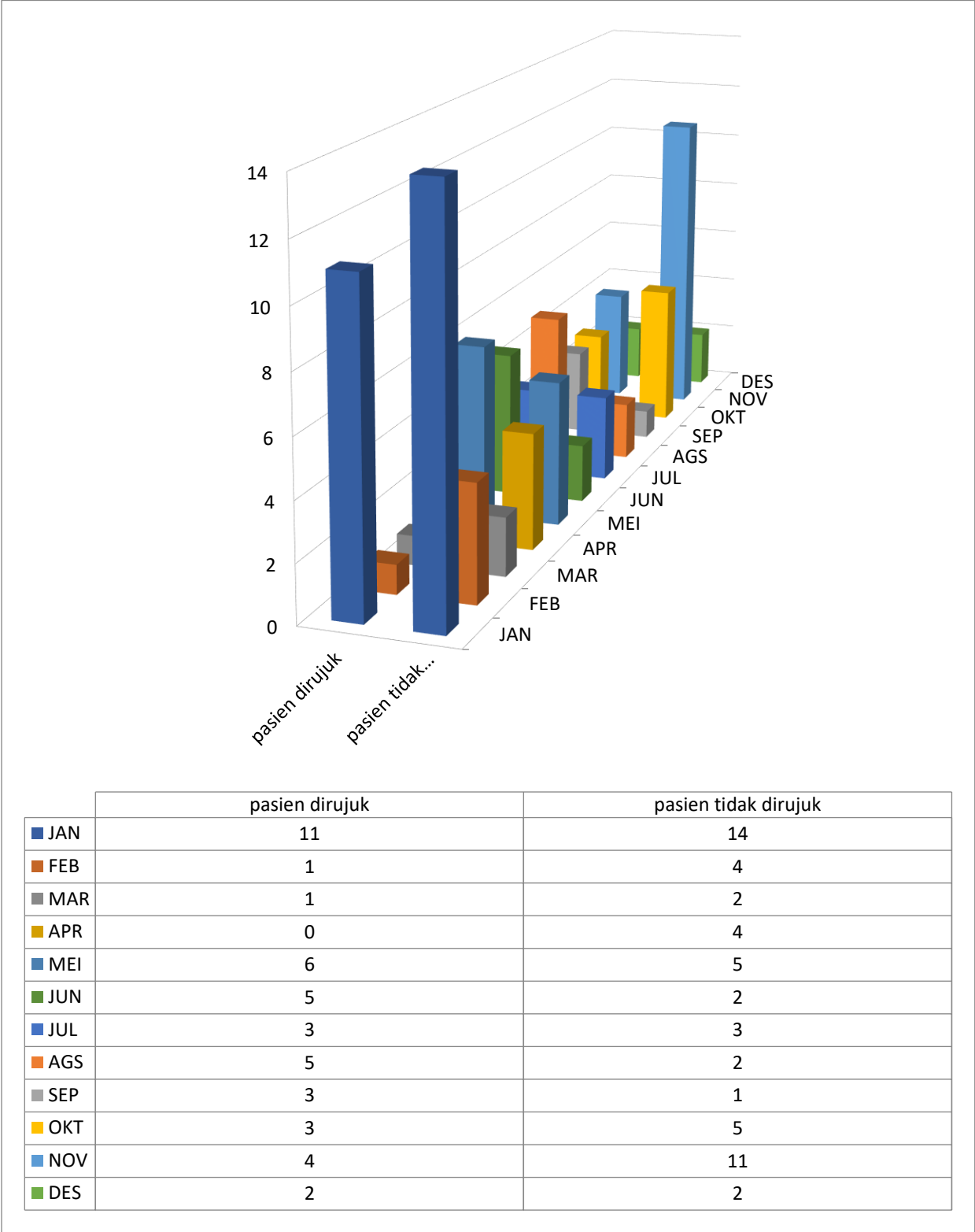
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan penempatan dengan benar

3.3.3.4.7 Pasien TB yang dirujuk

NO	Jenis Skrining	Jumlah kegiatan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pasien TB yang dirujuk	11	1	1	0	6	5	3	5	3	3	4	2
2	Pasien TB yang tidak dirujuk	14	4	2	4	5	2	3	2	1	5	11	2

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Januari 2024 terdapat 11 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 2) Pada bulan Februari 2024 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 3) Pada bulan Maret 2024 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 4) Pada bulan APRIL 2024 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

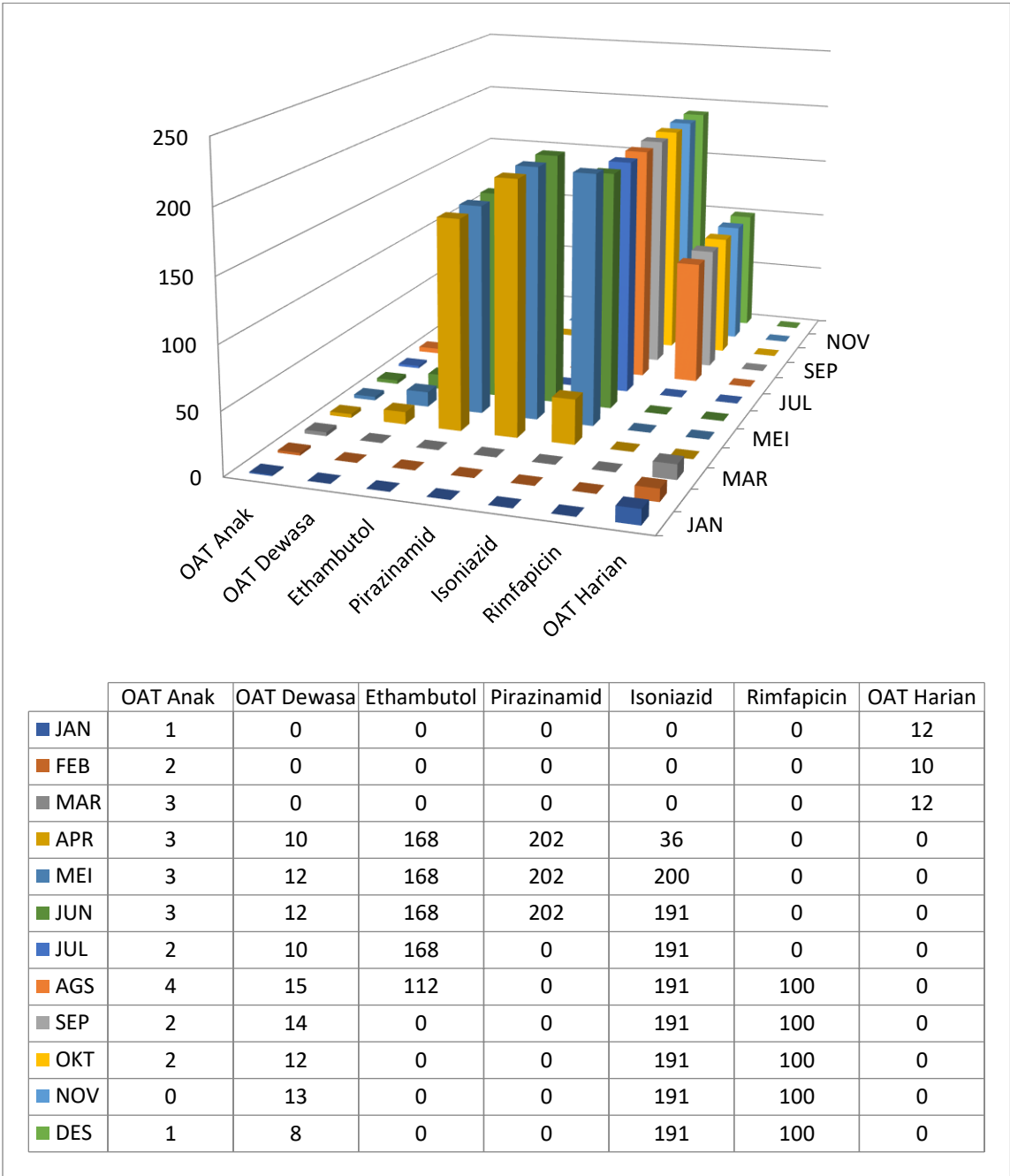
- 5) Pada bulan MEI 2024 terdapat 6 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 6) Pada bulan JUNI 2024 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 7) Pada bulan JULI 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 8) Pada bulan AGUSTUS 2024 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
- 9) Pada bulan SEPTEMBER 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
- 10) Pada bulan OKTOBER 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 11) Pada bulan NOVEMBER 2024 terdapat 4 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 12) Pada bulan DESEMBER 2024 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.3.3.4.8 Stok OAT

NO	Kegiatan	Jumlah kegiatan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	OAT Anak	1	2	3	3	3	3	2	4	2	2	0	1
2	OAT Dewasa	0	0	0	10	12	12	10	15	14	12	13	8
3	Ethambutol	0	0	0	168	168	168	168	112	0	0	0	0
4	Pirazinamid	0	0	0	202	202	202	0	0	0	0	0	0
5	Isoniazid	0	0	0	36	200	191	191	191	191	191	191	191
6	Rimfapicin	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
7	OAT Harian	12	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

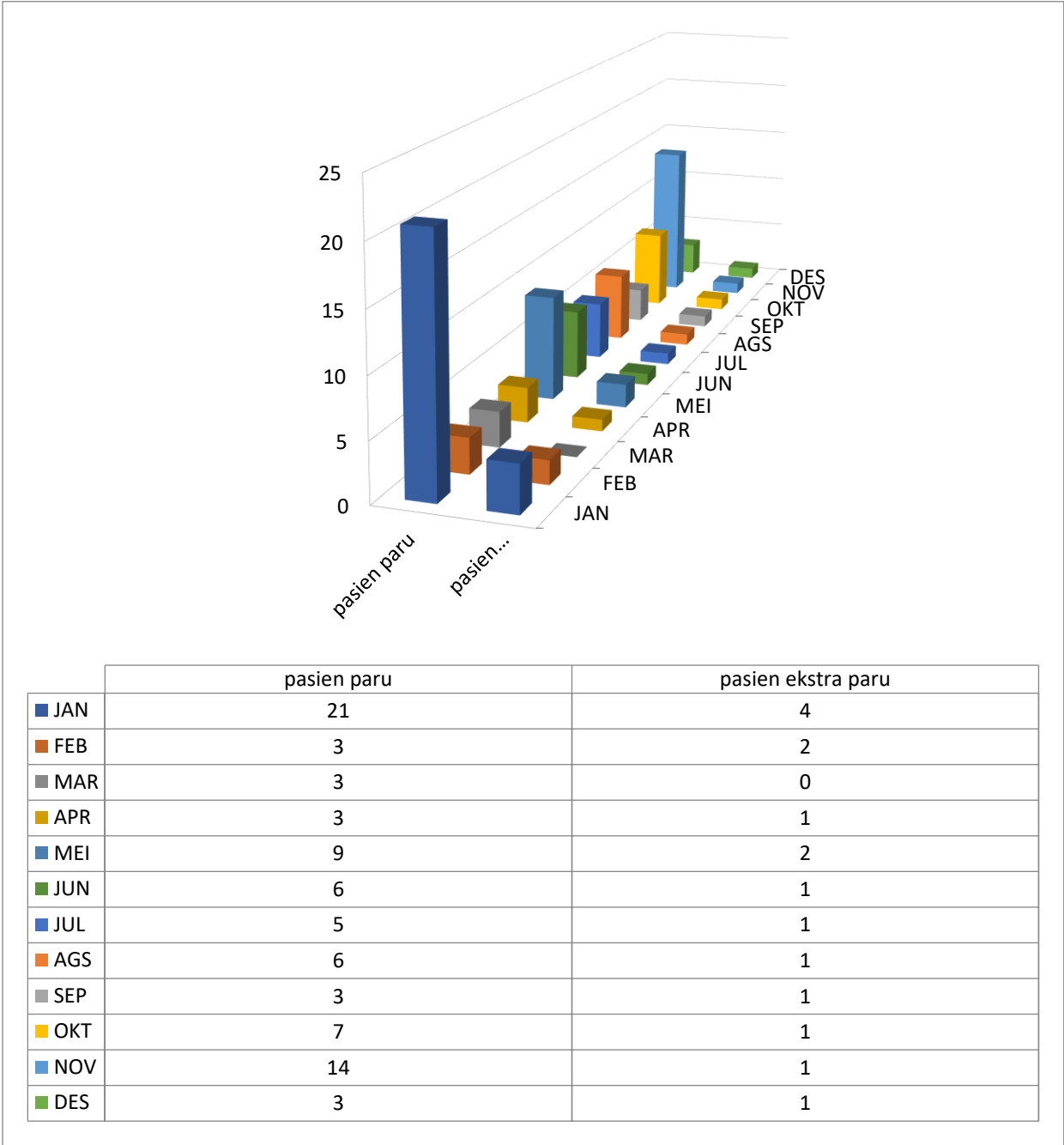
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal

3.3.3.4.9 Pasien paru dan ekstra paru

NO	Kegiatan	Jumlah kegiatan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pasien paru	21	3	3	3	9	6	5	6	3	7	14	3
2	Pasien Ekstra paru	4	2	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Grafik Pasien paru dan Ekstra paru Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan januari 2024 terdapat 4 pasien ekstra paru
- 2) Pada bulan februari 2024 terdapat 2 pasien ekstra paru
- 3) Pada bulan maret 2024 terdapat 0 pasien ekstra paru
- 4) Pada bulan APRIL 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
- 5) Pada bulan MEI 2024 terdapat 2 pasien ekstra paru
- 6) Pada bulan JUNI 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
- 7) Pada bulan JULI 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
- 8) Pada bulan AGUSTUS 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

- 9) Pada bulan SEPTEMBER 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
10) Pada bulan OKTOBER 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
11) Pada bulan NOVEMBER 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
12) Pada bulan DESEMBER 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

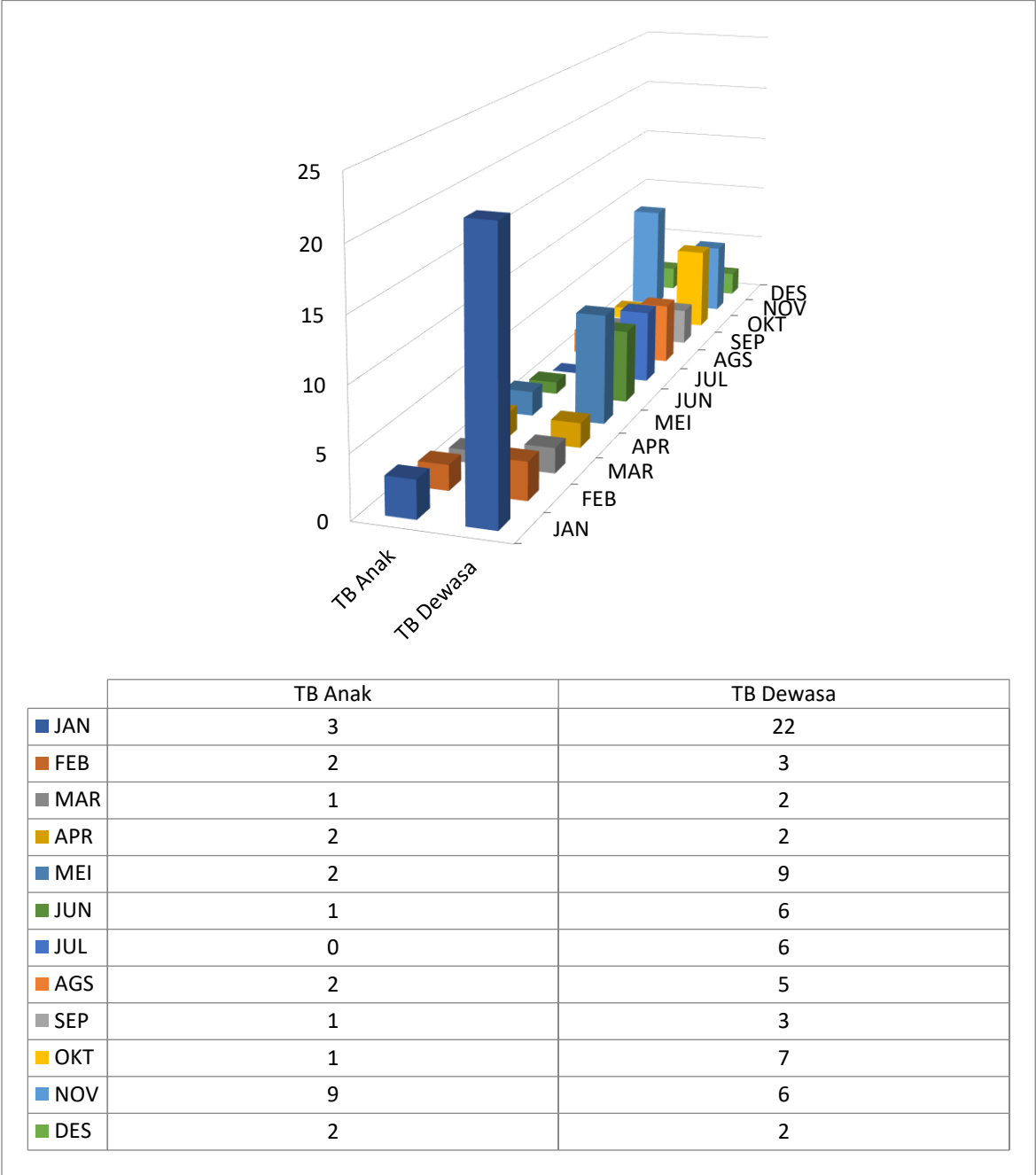
Rencana dan Tindak Lanjut :

Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.3.3.4.10 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	Kegiatan	Jumlah kegiatan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pasien Anak	3	2	1	2	2	1	0	2	1	1	9	2
2	Pasien Dewasa	22	3	2	2	9	6	6	5	3	7	6	2

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Januari terdapat 3 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 22 pasien
- 2) Pada bulan Februari terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 3 pasien
- 3) Pada bulan Maret terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien
- 4) Pada bulan APRIL terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien
- 5) Pada bulan MEI terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 3 pasien
- 6) Pada bulan JUNI terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 1 pasien
- 7) Pada bulan JULI terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 6 pasien
- 8) Pada bulan AGUSTUS terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien

- 9) Pada bulan SEPTEMBER terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien
- 10) Pada bulan OKTOBER terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 7 pasien
- 11) Pada bulan NOVEMBER terdapat 9 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 6 pasien
- 12) Pada bulan DESEMBER terdapat 9 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien

3.3.3.4.11 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. A	V		
		Ny. S	V		
		Ny. A	V		
		Tn. S	V		
		Tn. S	V		
		Tn. H	V		
		Ny. W	V		
		Tn. A	V		
		Ny. K	V		
		Ny. D	V		
		Tn. S	V		
		Tn. A	V		
2	dr. Yunita , Sp. P	Tn. A	V		
		Tn. M	V		
3.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn.. E	V		
		Ny. S	V		
		Ny. A	V		
		Tn. M	V		
		Tn. A	V		
		Tn. F	V		

- 1) Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

3.4 Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3
3.4.1 Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA ALAT MEDIS	MERK ALAT / TYPE	SERIAL NUMBER	JUMLAH	PELETAKAN	EXP KALIBRASI
1	Anesthesi Unit	Mindray / Wato EX-35	KG-93003671	1	IKO	Laik Pakai
2	Anesthesi Unit	Aeonmed/Aeon74400A	AEONMED7400AEYYYY067	1	IKO	Laik Pakai
3	Anesthesi Unit	Mindray Wato Ex-35	KG83002147	1	IKO	Laik Pakai
4	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-9B055504	1	IKO	Laik Pakai
5	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-9B055454	1	IKO	Laik Pakai
6	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-9B055488	1	IKO	Laik Pakai
7	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-85024963	1	IKO	Laik Pakai
8	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-9B055359	1	IKO	Laik Pakai
9	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-9B055507	1	IKO	Laik Pakai
10	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-91038052	1	IKO	Laik Pakai
11	Patient Monitor	Mindray Umec 10	KN-24137506	1	IKO	Laik Pakai
12	Suction Pump	Onemed / 7A-23B	00097	1	IKO	Laik Pakai
13	Suction Pump	GEA Medical / YX930D	B2.21.271	1	IKO	Laik Pakai
14	Suction Pump	Onemed / 7A-23B	00029	1	IKO	Laik Pakai
15	Suction Pump	SMAF / DY-1A	11141-028	1	IKO	Laik Pakai
16	Suction Pump	GEA Medical / YX930D	B2.21.245	1	IKO	Laik Pakai
17	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Injectomat Agilia	018290/2295337	1	IKO	Laik Pakai
18	Lampu Operasi	Panalex	3.8205000075084E13	1	IKO	Laik Pakai
19	Lampu Operasi	Panalex / Panalex 3	220718-011664	1	IKO	Laik Pakai
20	Lampu Operasi	Panalex / PX-401	G0088	1	IKO	Laik Pakai
21	Lampu Operasi	Onemed / OKLED800	JMIAH00003	1	IKO	Laik Pakai
22	Lampu Operasi	Mindray / HyLED200	40-85000337	1	IKO	Laik Pakai

23	Lampu Operasi	Panalex / Panalex 3	220718-011664	1	IKO	Laik Pakai
24	Defibrilator	Perlong / PT-9000D	H16420	1	IKO	Laik Pakai
25	Infant Radiant Warmer	Onemed / HKN-90	9.1025517E7	1	IKO	Laik Pakai
26	ESU	Meditom / DT-400P	DT4AKJ005	1	IKO	Laik Pakai
27	ESU	Meditom / DT-400P	DE40PEGAE009	1	IKO	Laik Pakai
28	ESU	Zerone / Doctanz 400	A03CKAN0219	1	IKO	Laik Pakai
29	ESU	Zerone / Doctanz 400	A03BTAT0409	1	IKO	Laik Pakai
30	Phaco System	Laureate / Alcon	1801965901 X	1	IKO	Laik Pakai
31	Digital Endoscopy System	Endo / EC-1	EC1IP21220516	1	IKO	Laik Pakai
32	Blood Infusion Warmer	ANIMEC / AM-2S	-	1	IKO	Laik Pakai
33	Operating Microscope	Takagi / OM-9	2002458.0	1	IKO	Laik Pakai
34	Baby Scale	Onemed / OD 230	-	1	IKO	Laik Pakai
35	Patient Monitor	Mindray / Umec 10	KN-9B055358	1	IGD	Laik Pakai
36	Patient Monitor	Mindray / Umec 10	KN-9B055387	1	IGD	Laik Pakai
37	Patient Monitor	Mindray / Umec 10	KN-85024967	1	IGD	Laik Pakai
38	Patient Monitor	Mindray / Umec 10	KN-9B055344	1	IGD	Laik Pakai
39	Patient Monitor	Mindray / Umec 10	KN-9B055394	1	IGD	Laik Pakai
40	Patient Monitor	Yonker / E12	2.1081910030126E13	1	IGD (Ambulance)	Laik Pakai
41	Defibrilator	Mindray / BenerHeart D3	EL – 5C023721	1	IGD	Laik Pakai
42	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP	2.5176779E7	1	IGD	Laik Pakai
43	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP	2.5385391E7	1	IGD	Laik Pakai
44	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP	2.520998E7	1	IGD	Laik Pakai
45	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Injectomat Agilia	2.5385389E7	1	IGD	Laik Pakai
46	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Injectomat Agilia	2.2265202E7	1	IGD	Laik Pakai
47	NST	WR-MD003	1108801.0	1	IGD (Ponek)	Laik Pakai
48	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-0C025598	1	IGD	Laik Pakai
49	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-91016799	1	IGD	Laik Pakai

50	Infant Radiant Warmer	BNT / BNT-2000	BNT20002E15146	1	IGD (Ponek)	Laik Pakai
51	Infuse Pump	Terumo / TE-112	1.303000117E9	1	IGD	Laik Pakai
52	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK 30409612	1	IGD	Laik Pakai
53	Baby Scale	Onemed / OD231B	-	1	IGD (Ponek)	Laik Pakai
54	Tensimeter Digital	Onemed / TensiOne 1A	B2105008421	1	IGD	Laik Pakai
55	Tensimeter Digital	Onemed / TensiOne 1A	-	1	IGD	Laik Pakai
56	Pulse Oxymetri	Bionet / Oxy9wave	O2T1000064	1	IGD	Laik Pakai
55	Suction Pump	Onemed / 7E-B	0003B	1	IGD	Laik Pakai
56	Suction Pump	Onemed / 7E-G	4.0	1	IGD	Laik Pakai
57	Suction Pump	GEA / YX930D	B22.21.222	1	IGD	Laik Pakai
58	Nebulizer	Omron / NE-C28	20230700270LF	1	IGD	Laik Pakai
59	Autoclave	All American	I0006777	1	CSSD	Laik Pakai
60	Dry Sterilization	Memmert	B.717.0326	1	CSSD	Laik Pakai
61	Patient Monitor	Philips Intelliviu MP5	SNDE656B5757	1	Radiologi	Laik Pakai
62	CT-Scan	Philips/Ingenuity CT	45801407831	1	Radiologi	Laik Pakai
63	D-AR	GEMSS/EVA	123107051153	1	Radiologi	Laik Pakai
64	X-Ray Mobile	Ecotron/Ultra30HF	1907D01	1	Radiologi	Laik Pakai
65	Injector Contrast	MedRad Stellant	60764873206763	1	Radiologi	Laik Pakai
66	USG	GE / Versana Essential	6023069WX0	1	Radiologi	Laik Pakai
67	ESWL	HK / ESWL-V	4379.0	1	ESWL	Laik Pakai
68	USG	Landwind / -	CU30CYA2LR19110127	1	ESWL	Laik Pakai
69	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-85024965	1	ICU	Laik Pakai
70	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-85024962	1	ICU	Laik Pakai
71	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-9B055424	1	ICU	Laik Pakai
72	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-85024968	1	ICU	Laik Pakai
73	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-9B055435	1	ICU	Laik Pakai
74	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-85024961	1	ICU	Laik Pakai

75	Patient Monitor	Yonker / E12	2.02104061004054E14	1	ICU	Laik Pakai
76	Patient Monitor	Yonker / E12	2.02104061004091E14	1	ICU	Laik Pakai
77	Patient Monitor	Yonker / E12	2.02104061004034E14	1	ICU	Laik Pakai
78	Patient Monitor	Yonker / E12	2.02104061004073E14	1	ICU	Laik Pakai
79	Ventilator	Mindray / SV300	GB-07025351	1	ICU	Laik Pakai
80	Ventilator	Mindray / SV300	GB-07025371	1	ICU	Laik Pakai
81	Ventilator	Vyaire / LTV 2200	L93842	1	ICU	Laik Pakai
82	Ventilator	Vyaire / LTV 2200	L95231	1	ICU	Laik Pakai
83	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-38037722	1	ICU	Laik Pakai
84	HFNC	Yuwell / YH-830	YH830A*V20440212	1	ICU	Laik Pakai
85	HFNC	Yuwell / YH-830	YHB830A*V20440114	1	ICU	Laik Pakai
86	HFNC	Yuwell / YH-830	YH830A*V20440459	1	ICU	Laik Pakai
87	Nebulizer	Omron / NE-C29	201605002333UF	1	ICU	Laik Pakai
88	Syringe Pump	Med Captain / MP-30	3.0181208215E10	1	ICU	Laik Pakai
89	Syringe Pump	Med Captain / MP-30	3.0181208233E10	1	ICU	Laik Pakai
90	Syringe Pump	Med Captain / MP-30	3.0181208222E10	1	ICU	Laik Pakai
91	Syringe Pump	Med Captain / MP-30	3.0181208228E10	1	ICU	Laik Pakai
92	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Injectomat Agilia	2.3107443E7	1	ICU	Laik Pakai
93	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP TIVA	2.5209981E7	1	ICU	Laik Pakai
94	Syringe Pump	Fresenius Kabi / SP7s	8.1053567E7	1	ICU	Laik Pakai
95	Infuse Pump	Fresenius Kabi / Infusia VP7	1.400086E7	1	ICU	Laik Pakai
96	Infuse Pump	Fresenius Kabi / Infusia VP7	1.4000862E7	1	ICU	Laik Pakai
97	Infuse Pump	Fresenius Kabi / Infusia VP7	1.4000858E7	1	ICU	Laik Pakai
98	Infuse Pump	Infusion / -	7.0201107E7	1	ICU	Laik Pakai
99	Defibrillator	Mindray / BeneHeart D3	EZ-2A099981	1	ICU	Laik Pakai
100	Fetal Doppler	Lotus / -	-	1	ICU	Laik Pakai
101	USG	Mindray / DC-32	9Q-83000084	1	ICU	Laik Pakai

102	Patient Monitor	Mindray / uMec 10	KN-9B055452	1	HCU	Laik Pakai
103	Patient Monitor	Mindray / uMec 10	KN-9B055495	1	HCU	Laik Pakai
104	Patient Monitor	Mindray / uMec 10	KN-9B055448	1	HCU	Laik Pakai
105	Patient Monitor	Mindray / uMec 10	KN-9B055379	1	HCU	Laik Pakai
106	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP	2.5385345E7	1	HCU	Laik Pakai
107	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Infusia SP7s	8.1053566E7	1	HCU	Laik Pakai
108	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Infusia SP7	1.4000192E7	1	HCU	Laik Pakai
109	Infuse Pump	Fresenius Kabi / Infusia VP7s	8.1054923E7	1	HCU	Laik Pakai
110	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-33035560	1	HCU	Laik Pakai
111	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-3B205219	1	IRNA 2A	Laik Pakai
112	Syringe Pump	Onemed / Fresenius Kabi	25748158	1	IRNA 2A	Laik Pakai
113	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-41038735	1	IRNA 2A	Laik Pakai
114	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20221208635UF	1	IRNA 2A	Laik Pakai
115	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-24138433	1	IRNA 3A	Laik Pakai
116	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20221120885UF	1	IRNA 3A	Laik Pakai
117	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK - 41038722	1	IRNA 3A	Laik Pakai
118	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-9B055415	1	IRNA 4A	Laik Pakai
119	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-28151783	1	IRNA 4A	Laik Pakai
120	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP	2.5385375E7	1	IRNA 4A	Laik Pakai
121	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP	2.5385378E7	1	IRNA 4A	Laik Pakai
122	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Infusia SP7s	8.108432E7	1	IRNA 4A	Laik Pakai
123	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-1A0292151	1	IRNA 4A	Laik Pakai
124	Nebulizer	OMRON / NE-C28	202211208822UF	1	IRNA 4A	Laik Pakai
125	USG	Zoncare / Zoncare-150	K61CW51050003	1	IRNA 4A	Laik Pakai
126	Patient Monitor	YKDMED / YKD-1000Plus	ORD1905685	1	IRNA 6A	Laik Pakai
128	Syringe Pump	Fresenius Kabi / SP7s	8.1084316E7	1	IRNA 6A	Laik Pakai
129	ECG	Zoncare / ZQ-1212	K61CW81040001	1	IRNA 6A	Laik Pakai

130	Nebulizer	OMRON / C28	20180806147UF	1	IRNA 6A	Laik Pakai
131	Patient Monitor	YKDMED / YKD-1000Plus	ORD2012030	1	IRNA 7A	Laik Pakai
132	Patient Monitor	YKDMED / YKD-1000Plus	ORD2012036	1	IRNA 7A	Laik Pakai
133	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Infusia SP7s	8.1084318E7	1	IRNA 7A	Laik Pakai
134	Infuse Pump	Mindray / BeneFusion VP3	SK-30409621	1	IRNA 7A	Laik Pakai
135	Infuse Pump	Mindray / BeneFusion VP3	SK-30409636	1	IRNA 7A	Laik Pakai
136	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-0C025594	1	IRNA 7A	Laik Pakai
137	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20221120881UF	1	IRNA 7A	Laik Pakai
138	Nebulizer	Onemed / 408 Air	N4080823162	1	IRNA 8A	Laik Pakai
139	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-41038702	1	IRNA 8A	Laik Pakai
140	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-91016803	1	IRNA 2C	Laik Pakai
141	Nebulizer	OMRON/ NE-C28	20190200326UF	1	IRNA 2C	Laik Pakai
142	Nebulizer	Onemed / 408 Air	N4080823163	1	IRNA 2C	Laik Pakai
143	Patient Monitor	Yonker / E12	2.1081910030114E13	1	IRNA 3C	Laik Pakai
144	Infuse Pump	Fresenius Kabi / VP7s	8.1054938E7	1	IRNA 3C	Laik Pakai
145	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Infusia SP7s	8.1084317E7	1	IRNA 3C	Laik Pakai
146	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Infusia SP7s	8.1100133E7	1	IRNA 3C	Laik Pakai
147	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20220816205UF	1	IRNA 3C	Laik Pakai
148	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20180815763UF	1	IRNA 3C	Laik Pakai
149	Patient Monitor	Yonker / E12	2.02104061004021E14	1	Maternitas	Laik Pakai
150	Patient Monitor	Mindray / uMec10	KN-85024969	1	Maternitas	Laik Pakai
151	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20220703139UF	1	Maternitas	Laik Pakai
152	Fetal Doppler	Vcomin / FD-200B	F200B018044245	1	Maternitas	Laik Pakai
153	Fetal Doppler	Lotus / -	-	1	Maternitas	Laik Pakai
154	Baby Scale	Onemed / OD-230	-	1	Maternitas	Laik Pakai
155	Suction Pump	GEA / DY-1A	15YE3.196	1	Maternitas	Laik Pakai
156	USG	GE / Logic 100 Pro	55469WS1	1	Maternitas	Laik Pakai

157	Fetal Doppler	Serenity / SR-D6	LGT2023080710	1	Maternitas	Laik Pakai
158	CPAP	Stephan/Easy +	S0111501110	1	Perinatology	Laik Pakai
159	CPAP	Stephan/Easy +	SO111301077	1	Perinatology	Laik Pakai
160	CPAP	Stephan/Easy +	SO111501105	1	Perinatology	Laik Pakai
161	CPAP	Blender / AD Series (Pigeon)	16077I005	1	Perinatology	Laik Pakai
162	CPAP	Blender / AD Series (Pigeon)	1507I042	1	Perinatology	Laik Pakai
163	CPAP	Blender / AD-10	84.2162037037037	1	Perinatology	Laik Pakai
164	Infant Incubator	GEA / YP-100	01BZZD01029	1	Perinatology	Laik Pakai
165	Infant Incubator	GEA / YP-100	01AHZB02006	1	Perinatology	Laik Pakai
166	Infant Incubator	GEA / YP-100	01BAKG07019	1	Perinatology	Laik Pakai
167	Infant Incubator	GEA / YP-100	1.150502014E9	1	Perinatology	Laik Pakai
168	Infant Incubator	GEA / YP-100	01AIAB07044	1	Perinatology	Laik Pakai
169	Infant Incubator	GEA / YP-100	1.1709030238E10	1	Perinatology	Laik Pakai
170	Infant Incubator Transport	Poli Medical / Poly 021-TC	021TC-22-0002	1	Perinatology	Laik Pakai
171	Baby Scale	Onemed / OD 230	-	1	Perinatology	Laik Pakai
172	Phototeraphy	Onemed / QLC-2	PT-001	1	Perinatology	Laik Pakai
173	Phototeraphy	Philips / EG-2000N	P001	1	Perinatology	Laik Pakai
174	Phototeraphy	Bistos / BT-400	EAG60101	1	Perinatology	Laik Pakai
175	Patient Monitor	YKDMed / YKD-1000Plus	ORD1905572	1	Perinatology	Laik Pakai
176	Ventilator	Mindray / SynoVent E5	EE-23006435	1	Perinatology	Laik Pakai
177	Pulse Oxymetri	Bionet / Oxy9wave	02T1000066	1	Perinatology	Laik Pakai
178	Pulse Oxymetri	Bionet / Oxy9wave	ENAA0111	1	Perinatology	Laik Pakai
179	Pulse Oxymetri	Bionet / Oxy9wave	02T1200020	1	Perinatology	Laik Pakai
180	Infant Radiant Warmer	GEA / HKN-90	21AIAB02005	1	Perinatology	Laik Pakai
181	Infant Radiant Warmer	GEA / HKN-90	V3/150801128	1	Perinatology	Laik Pakai
182	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20220702192UF	1	Perinatology	Laik Pakai
183	Infuse Pump	-	7.0201109E7	1	Perinatology	Laik Pakai

184	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK30410076	1	Perinatology	Laik Pakai
185	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK30801318	1	Perinatology	Laik Pakai
186	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK30801327	1	Perinatology	Laik Pakai
187	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK30500066	1	Perinatology	Laik Pakai
188	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK30801510	1	Perinatology	Laik Pakai
189	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK30409638	1	Perinatology	Laik Pakai
190	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK30409627	1	Perinatology	Laik Pakai
191	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK31005368	1	Perinatology	Laik Pakai
192	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK31005371	1	Perinatology	Laik Pakai
193	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK31005393	1	Perinatology	Laik Pakai
194	LAF	Wina / WR-3045	1.0	1	LAF	Laik Pakai
195	Patient Monitor	Mindray / uMec 10	KN-9B055402	1	IRNA 5C	Laik Pakai
196	Patient Monitor	Mindray / uMec 10	KN-9B055406	1	IRNA 5C	Laik Pakai
197	Patient Monitor	Mindray / uMec 10	KN-9B055399	1	IRNA 5C	Laik Pakai
198	Nebulizer	OMRON / NE-C28	20221120886UF	1	IRNA 5C	Laik Pakai
199	Infuse Pump	Fresenius Kabi / VP7s	8.1054922E7	1	IRNA 5C	Laik Pakai
200	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-03021939	1	IRNA 5C	Laik Pakai
201	Spirometri	Contec / SP-100	2312E200016	1	IRNA 5C	Laik Pakai
202	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Infusia SP7s	8.1053568E7	1	IRNA 5C	Laik Pakai
203	Syringe Pump	Fresenius Kabi / Agilia SP TIVA	25385353	1	IRNA 5C	Laik Pakai
204	Blood Infusion Warmer	Animec / AM-301	2020D0051	1	IRNA 5C	Laik Pakai
205	Tensimeter Digital	Onemed / TensiOne 1A	B2402001774	1	Poli Eksekutif	Laik Pakai
206	Tensimeter Digital	Onemed / TensiOne 1A	B240200778	1	Poli Eksekutif	Laik Pakai
207	Tensimeter Digital	Onemed / TensiOne 1A	B240200767	1	Poli Eksekutif	Laik Pakai
208	Baby Scale	Indomed / -	-	1	Poli Eksekutif	Laik Pakai
209	Sphygmomanometer	Onemed / Tensi Mobile	2.1122288E7	1	Poli Jantung	Laik Pakai
210	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-65008263	1	Poli Jantung	Laik Pakai

211	Treadmill + Stress ECG	Quinton / TM55	1.16520545367E11	1	Poli Jantung	Laik Pakai
212	USG Echo	Mindray / Consona N6 Exp	LY4-39000040	1	Poli Jantung	Laik Pakai
213	Nebulizer	OMRON / NE-C29	20110802740UF	1	Poli Paru	Laik Pakai
214	Spirometri	MIR / Spirolab	A23-OJ.11305	1	Poli Paru	Laik Pakai
215	USG	GE / Logiq V5	6044600WX0	1	Poli Syaraf	Laik Pakai
216	Baby Scale	LAICA / BF2051	PPO-9040801	1	Poli Anak	Laik Pakai
217	Baby Scale	Onemed / OD231B	-	1	Poli Anak	Laik Pakai
218	USG	GE / Versana Balance	6051753WXO	1	Poli Obgyn	Laik Pakai
219	USG	Mindray / DC-30	9P-81002625	1	Poli Obgyn	Laik Pakai
220	Tensimeter Digital	Onemed / TensiOne 1A	B2110020985	1	Poli Obgyn	Laik Pakai
221	Tensimeter Digital	Onemed / TensiOne 1A	B2111002063	1	Poli IPD	Laik Pakai
222	USG	Chison / Q9	1607008.0	1	Poli IPD	Laik Pakai
223	USG	Mindray / Z60	HG5-3A000301	1	Poli Urologi	Laik Pakai
224	Digital Uroflowmetry	Digiflow / ST2	1.8020021E7	1	Poli Urologi	Laik Pakai
225	Mikroskop	Yeosn / CCQ-400	-	1	Poli Mata	Laik Pakai
226	NCT	Takagi / SNT-700	2056662.0	1	Poli Mata	Laik Pakai
227	Auto Refractro Keratometer	Topcon / KR-800	4765679.0	1	Poli Mata	Laik Pakai
228	Biometri	Axis Nano / BF	1703.0	1	Poli Mata	Laik Pakai
229	Slit Lamp	H.SLM / SLM-3ER	1.6111404E7	1	Poli Mata	Laik Pakai
230	USG	GE / Versana Balance	605182WXO	1	Poli Orthopedi	Laik Pakai
231	Dental Unit	INTEGRAL / KS-317	201614	1	Poli Gigi	Laik Pakai
232	Ultrasonic Scalling	Woodpecker / UDS-K	S1910923CC KT	1	Poli Gigi	Laik Pakai
233	Tensimeter Digital	Yuwell / YE660B	B2109010879	1	Poli Gigi	Laik Pakai
234	ENT Treatment	ENT Treatment Unit / PK-3201	32012401076	1	Poli THT	Laik Pakai
235	Audiometer	Maico / MA28	MA9099967	1	Poli THT	Laik Pakai
235	Suction Pump Apparatus	Onemed / 7A-23B	PT 221203017	1	Poli THT	Laik Pakai
237	ESU	ConMed / Hyfrecator2000	1.6410193E7	1	Poli Kulit	Laik Pakai

238	Tensimeter Digital	Yuwell / YE660B	B2109010877	1	Poli Jiwa	Laik Pakai
239	US,ES, Laser	BTL / BTL4000	2575B12614	1	RehabMedik	Laik Pakai
240	US,ES, Laser	BTL / BTL4000	2575B12976	1	RehabMedik	Laik Pakai
241	SWD	Zimmer / Thermo Pro	2120008016	1	RehabMedik	Laik Pakai
242	Traction	Galaxy 3 Section / DJ03133	1473-2019	1	RehabMedik	Laik Pakai
243	TDP	Corona / CQ-89	84.08888888888889	1	RehabMedik	Laik Pakai
244	Centrifuge	Wina / 507.0	5.0704022691E10	1	Laboratorium	Laik Pakai
245	Centrifuge	Wina / 502.0	2.0	1	Laboratorium	Laik Pakai
246	Centrifuge	Wina / 505.0	5.05121446E8	1	Laboratorium	Laik Pakai
247	Mikroskop	Olympus / CX23	9D86675201904	1	Laboratorium	Laik Pakai
248	Mikroskop	Olympus / CX23	2G82372	1	Laboratorium	Laik Pakai
249	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK-64008098	1	Laboratorium	Laik Pakai
250	Micro pipet	Eppendorf	P3336669	1	Laboratorium	Laik Pakai
251	Micro pipet	DLAB / 100/1000uL	YL318AK0083357	1	Laboratorium	Laik Pakai
251	Micro pipet	Boeco / 5uL	CS68107	1	Laboratorium	Laik Pakai
253	Micro pipet	Eppendorf	464475	1	Laboratorium	Laik Pakai
254	Micro pipet	Eppendorf	-	1	Laboratorium	Laik Pakai
255	Micro pipet	Eppendorf / 100/1000uL	YL20CAK0032219	1	Laboratorium	Laik Pakai
256	Micro pipet	ENDO / 50uL	0F28816	1	Laboratorium	Laik Pakai
257	Syringe Pump	Fresenius KABI / Agilia SP TIVA	25748172	1	PICU	Laik Pakai
258	Syringe Pump	Fresenius KABI / Agilia SP TIVA	25748174	1	PICU	Laik Pakai
259	Syringe Pump	Fresenius KABI / Agilia SP TIVA	25748175	1	PICU	Laik Pakai
260	Syringe Pump	Fresenius KABI / Agilia SP TIVA	25748173	1	PICU	Laik Pakai
261	Ventilator	Mindray / SV-350	GA-3A020822	1	PICU	Laik Pakai
262	Ventilator	Mindray / SV-350	GA-330200062	1	PICU	Laik Pakai
263	Pasien Monitor	Mindray / Umec-10	KN-42214247	1	PICU	Laik Pakai
264	Pasien Monitor	Mindray / Umec-10	KN-42214377	1	PICU	Laik Pakai

265	Pasien Monitor	Mindray / Umec-10	KN-42214344	1	PICU	Laik Pakai
266	Pasien Monitor	Mindray / Umec-10	KN-42214357	1	PICU	Laik Pakai
267	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK 31005378	1	PICU	Laik Pakai
268	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK 31005394	1	PICU	Laik Pakai
269	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK 31005383	1	PICU	Laik Pakai
270	Infuse Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK 30409619	1	PICU	Laik Pakai
271	ECG	Mindray / BeneHeart R3	FK - 41038723	1	PICU	Laik Pakai
272	Suction Pump	GEA / YX930D	B22.23.261	1	PICU	Laik Pakai
273	Funduscopy	Nexy / Next Sight	UEFX7Q2	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
274	Monitor NIBP & SpO2	Amone / -	V026A006494	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
275	Patient Monitor	Mindray / Umec-10	KN-42214362	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
276	Patient Monitor	Mindray / Umec-10	KN-42214376	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
277	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30801514	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
278	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30801509	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
279	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30801513	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
280	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30801516	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
281	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30801313	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
282	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30801506	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
283	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30500072	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
284	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30500069	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
285	Syringe Pump	Mindray / Benefusion SP3	SK-30500076	1	Gudang Alkes	Laik Pakai
286	Infusion Pump	Mindray / Benefusion VP3	SK-31005370	1	Gudang Alkes	Laik Pakai

3.4.2 Gedung dan Bangunan

NO	LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)
1.	5.411 m ²	Luas bangunan sebesar 6.924 m ² 1. Gedung DPM 2. Gedung A 8 Lantai 3. Gedung B 5 Lantai 4. Gedung C 5 Lantai 5. Gedung IRJA Sentral 6. Gedung IRJA Blok 1 7. Gedung Lama (Gudang Umum, Gudang Farmasi, Parkiran Motor Karyawan, Laundry) 8. Gedung Blok 3 (IPSRS dan Cleaning Service) 9. Parkiran Mobil Umum 10. Pakiran Motor Umum 11. Masjid

NO	NAMA UNIT	NAMA GEDUNG	LANTAI	NAMA RUANGAN	PANJANG (M)	LEBAR (M)
1	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. ANALISA	4.3	3.9
2	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. SAMPEL	2.8	2.9
3	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. PENCUCIAN	3.4	3.2
4	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. PENDAFTARAN	9.6	2.7
5	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. TUNGGU PENDAFTARAN	3.69	9.79
6		Blok 1	1	R. TRAKSI	3.74	1.3
7		Blok 1	1	R. LAKTASI	3.74	1.3
8	REKAM MEDIS	Blok 1	1	REKAM MEDIS LT 1	6.54	7.6
9	REKAM MEDIS	Blok 1	1	REKAM MEDIS LT 2	14.63	9.11
10	REHAB MEDIK	Blok 1	1	REHAB MEDIK	4.79	4.09
11	REHAB MEDIK	Blok 1	1	R. TERAPI WICARA	2.8	3.33
12	REKAM MEDIS	Blok 1	1	REKAM MEDIS 2	6.89	14.78
13		Blok 1	1	IGD LAMA + MATERNITAS	18.5	28.38
14		Blok 1	1	CS	2.6	2.33
15		Blok 1	1	R. PERIKSA KANDUNGAN	4.3	5.5
16		Blok 1	1	R. BEDAH	8.44	4.22
17		Blok 1	1	R. PERIKSA ANAK	2.8	3.76
18		Blok 1	1	R. BEDAH PLASTIK	3.33	3.7
19		Blok 1	1	FISIOTERAPI 1	3	3.22
20		Blok 1	1	R. SAMPEL SWAB	2.1	3.4

21	IRJA	Blok 2	1	R. TUNGGU	14.87	2.79
22	IRJA	Blok 2	1	POLI GIGI	3.96	3.08
23	IRJA	Blok 2	1	POLI PARU	8.04	3.03
24	IRJA	Blok 2	1	POLI PARU TINDAKAN	3.6	1.53
25	IRJA	Blok 2	1	POLI JiWA	2.83	3.8
26	IRJA	Blok 2	1	POLI BEDAH 1	2.8	3.7
27	IRJA	Blok 2	1	POLI BEDAH 2	3.02	3.06
28	IRJA	Blok 3	1	R. TUNGGU 1	12.4	2.79
29	IRJA	Blok 3	1	POLI MATA	8.67	3.4
30	IRJA	Blok 3	1	POLI UROLOGI	3.79	3.36
31	IRJA	Blok 3	1	POLI THT	3.79	2.85
32	IRJA	Blok 3	1	POLI KULIT	2.83	2.83
33	IRJA	Blok 3	1	POLI PENYAKIT DALAM 1	3.7	2.8
34	IRJA	Blok 3	1	R. GIZI	2.76	2.89
35	IRJA	Blok 3	1	R. UROFLOMETRI	1.92	2.1
36	IRJA	Blok 3	1	R. TUNGGU 2	11.6	4.8
37	IRJA	Blok 3	1	POLI PENYAKIT DALAM 2	6.87	4.3
38	IT	Blok 3	1	R. IT	7.41	2.74
39	LAUNDRY		1	R. LAUNDRY & JENAZAH	6.84	15.78
40	PINERE		1	PINERE	9.69	15.4
41	IGD	A	1	R. TINDAKAN	13.832	5.22
42	IGD	A	1	R. TRIAGE	3.63	5.22
43	IGD	A	1	R. PENAPISAN	3.45	3.47
44	IGD	A	1	R. DEKONTAMINAS I	2.5	1.7
45	IGD	A	1	R. ISOLASI	3.19	2.1
46	IGD	A	1	R. PONEK	5.26	4.79
47	IGD	A	1	R. KONSELING	1.97	2.1
48	IGD	A	1	R. TINDAKAN BEDAH	2.49	2.02
49	IGD	A	1	R. TRANSIT	2.29	1.863
50	IGD	A	1	R. JENAZAH	2.29	2.33
51	IGD	A	1	R. DOKTER	4.41	2.1
52	IGD	A	1	R. KOMITE	4	2.2
53	IGD	A	1	R. STUNTING	4.2	2.3
54	EX MATERNITAS	A	2	NS MATERNITAS 2A (GD BARU)	5.7	2.7
55	EX MATERNITAS	A	2	R. 1	7.6	5.8
56	EX MATERNITAS	A	2	R. 2	7.6	5.8
57	EX MATERNITAS	A	2	R. 3	7.6	5.8
58	EX MATERNITAS	A	2	JANITOR	1.4	1.4

59	EX MATERNITAS	A	2	TOILET	3.2	3.2
60	EX MATERNITAS	A	2	DEPAN TANGGA DARURAT	5.8	4.8
61	EX MATERNITAS	A	2	LORONG LT 2 GD A	23.3	3.5
62	IRNA	A	3	NS 3A	5.7	2.7
63	IRNA	A	3	R. 1	7.6	5.8
64	IRNA	A	3	R. 2	7.6	5.8
65	IRNA	A	3	R. 3	7.6	5.8
66	IRNA	A	3	JANITOR	1.4	1.4
67	IRNA	A	3	TOILET	3.2	3.2
68	IRNA	A	3	DEPAN TANGGA DARURAT	5.8	4.8
69	IRNA	A	3	LORONG LT 3 GD A	23.3	3.5
70	IRNA	A	4	NS 4A	5.7	2.7
71	IRNA	A	4	R. 1	7.8	5.8
72	IRNA	A	4	R. 2	7.8	5.8
73	IRNA	A	4	R. 3	7.8	5.8
74	IRNA	A	4	JANITOR	1.4	1.4
75	IRNA	A	4	TOILET	3.2	3.2
76	IRNA	A	4	DEPAN TANGGA DARURAT	5.8	4.8
77	IRNA	A	4	LORONG LT 4 GD A	23.3	3.5
78	HALL	A	5	TOILET 1	3	2.6
79	HALL	A	5	HALL SAKURA	17.8	11.3
80	HALL	A	5	DEPAN HALL	5.8	7.9
81	HALL	A	5	JANITOR	1.4	1.4
82	HALL	A	5	TOILET 2	3.2	3.2
83	IRNA	A	6	NS 6A	5.4	2.4
84	IRNA	A	6	LORONG LT 6 GD A	23.3	3.5
85	IRNA	A	6	R. 1	7.6	5.9
86	IRNA	A	6	R. 2	7.6	5.9
87	IRNA	A	6	R. 3	7.6	5.9
88	IRNA	A	6	JANITOR	1.4	1.4
89	IRNA	A	6	TOILET	3.2	3.2
90	IRNA	A	6	DEPAN TANGGA DARURAT	6.3	5.7
91	IRNA	A	7	NS 7A	5.4	2.4
92	IRNA	A	7	LORONG LT 7 GD A	23.3	3.5
93	IRNA	A	7	R. 1	7.6	5.9
94	IRNA	A	7	R. 2	7.6	5.9
95	IRNA	A	7	R. 3	7.6	5.9
96	IRNA	A	7	JANITOR	1.4	1.4
97	IRNA	A	7	TOILET	3.2	3.2
98	IRNA	A	7	DEPAN TANGGA DARURAT	6.3	5.7
99	IRNA	A	8	NS 8A	5.4	2.4

100	IRNA	A	8	LORONG LT 8 GD A	23.3	3.5
101	IRNA	A	8	R. 1	7.6	5.9
102	IRNA	A	8	R. 2	7.6	5.9
103	IRNA	A	8	R. 3	7.6	5.9
104	IRNA	A	8	JANITOR	1.4	1.4
105	IRNA	A	8	TOILET	3.2	3.2
106	IRNA	A	8	DEPAN TANGGA DARURAT	6.3	5.7
107	FARMASI	B	1	DEPO FARMASI	4.7	2.22
108	FARMASI	B	1	PERACIKAN FARMASI	7.5	6.5
109	FARMASI	B	1	R. TUNGGU FARMASI	7.74	11.5
110	INSTALASI GIZI	B	1	INSTALASI GIZI	12.9	8.57
111	INSTALASI GIZI	B	1	GIZI TROLI MAKANAN	5.35	2.5
112	CSSD	B	1	R. BERSIH	4.1	4.01
113	CSSD	B	1	R. KOTOR	5.5	3.5
114	RUANG MANAJEMEN	B	2	RUANG MANAJEMEN 2B	17.24	8.04
115	PT DPM	B	2	RUANG PT DPM	18.22	16.03
116	IRNA	B	2	NS IRNA 2A	3.46	3.09
117	IRNA	B	2	VIOLA 6	4.65	3.68
118	IRNA	B	2	VIOLA 5	4.95	3.68
119	IRNA	B	2	VIOLA 4	4.95	3.68
120	IRNA	B	2	VIOLA 1-3	16.4	3.17
121	IRNA	B	2	ANGGREK 1	4.65	3.12
122	IRNA	B	2	ANGGREK 2	4.95	3.12
123	IRNA	B	2	PANTRY 2A	2.57	1.5
124	IRNA	B	2	JANITOR 2A	3.02	1.2
125	IRNA	B	2	SELASAR LT 2	21.6	3.67
126	IRNA	B	2	SELASAR LT 2 ICU	12.3	2.58
127	IRNA	B	3	LORONG 3B	16.8	1.6
128	IRNA	B	3	DAHLIA 3.11- 3.15	6.1	5.85
129	PENCAMPURAN OBAT	B	3	R. PENCAMPURAN OBAT	5.6	2.3
130	ESWL	B	3	R. ESWL + OPERATOR	6.8	6.2
131	IRNA	B	4	CEMPAKA 4.21- 4.24	6.1	5.8
132	IRNA	B	4	CEMPAKA 4.11- 4.14	6.1	6.8
133	IRNA	B	4	LORONG LT 4 GD B	17.1	1.5
134	IRNA	B	4	GUDANG ALKES	5.6	2.6
135	HALL	B	5	BELAKANG HALL SAKURA	5.8	4.8
136	HALL	B	5	LORONG HALL CEMARA	20.5	1.5
137	HALL	B	5	HALL CEMARA	13	6.5

138	HALL	B	5	TOILET HALL CEMARA	5.6	2.2
139	RADIOLOGI	C	1	USG RADIOLOGI	4.76	2.5
140	RADIOLOGI	C	1	RONTGENT	4.87	3.69
141	RADIOLOGI	C	1	CT SCAN	6.23	6.68
142	RADIOLOGI	C	1	CT SCAN OPERATOR	5.97	1.69
143	IKO	C	1	IKO PREMED	4.68	3.63
144	IKO	C	1	IKO 1	4.75	4.43
145	IKO	C	1	IKO 2	4.25	5.1
146	IKO	C	1	IKO 3	3.47	5.9
147	IKO	C	1	IKO 4	3.8	5.9
148	IKO	C	1	R. ALAT IKO	2.7	4.9
149	IKO	C	1	R. BEDAH MINOR	4.6	2.86
150	IKO	C	1	RECOVERY ROOM	6.5	3.37
151	IRNA	C	2	NS 2C	3.81	3.54
152	IRNA	C	2	DAHLIA 2.41 - 2.46	7.84	7.01
153	IRNA	C	2	NS ICU	6	3.85
154	IRNA	C	2	ICU TINDAKAN	11.76	6
155	IRNA	C	2	HCU	9.7	3.7
156	IRNA	C	3	NS 3C	5.98	1.9
157	IRNA	C	3	SELASAR CEMPAKA	19.6	2.71
158	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.61 & 3.62	6.09	3.86
159	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.91 & 3.92	5.98	3.88
160	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.81 & 3.82	5.9	3.88
161	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.71 & 3.72	5.9	3.88
162	IRNA	C	3	BOUGENVILE 3.11 & 3.12	6.94	3.8
163	IRNA	C	3	BOUGENVILE 3.21 & 3.22	6.94	3.8
164	IRNA	C	3	BOUGENVILE 3.31 & 3.32	6.94	3.8
165	IRNA	C	3	RUANG KOMITE KEPERAWATAN	3.67	2.7
166	IRNA	C	3	JANITOR	3.67	3.9
167	IRNA	C	3	NS 3A	2.7	3.6
168	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.31	3.99	3.3
169	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.41	3.99	3.3
170	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.21	5.6	3.2
171	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.11	5.6	3.2
172	IRNA	C	3	DAHLIA 3.1	5.3	3.1
173	IRNA	C	3	DAHLIA 3.2	5.5	3.1
174	IRNA	C	3	DAHLIA 3.3	5.5	3.1
175	IRNA	C	3	SELASAR 4C	19.52	2.5
176	IRNA	C	4	NS 4	4.09	1.99

177	IRNA	C	4	DAHLIA 4.31	5.8	5.8
178	IRNA	C	4	DAHLIA 4.1	5.8	5.8
179	IRNA	C	4	BOUGENVILLE 4.2	5.8	5.8
180	IRNA	C	4	NICU	2.8	6.8
181	IRNA	C	4	PERINATOLOGI	6.9	3.7
182	IRNA	C	4	JANITOR	6.9	4.7
183	IRNA	C	4	TINDAKAN MATERNITAS	18.6	12.4
184	IRNA	C	5	BOUGENVILLE 5.31	5.8	3.7
185	IRNA	C	5	BOUGENVILLE 5.1	5.8	3.7
186	IRNA	C	5	BOUGENVILLE 5.2	5.8	3.7
187	IRNA	C	5	ISOLASI 5.1	5.8	3.7
188	IRNA	C	5	ISOLASI 5.2	6.8	3.7
189	IRNA	C	5	DAHLIA 5.1	6.8	7.8
190	IRNA	C	5	NS	7.69	2.8
191	IRNA	C	5	JANITOR	5.6	3.68
192	FARMASI	DPM	1	GUDANG FARMASI	9.36	5.02
193	FARMASI	DPM	1	GUDANG VAKSIN & INJECT	2.3	1.65
194	FARMASI	DPM	1	GUDANG B3	1.87	1.62
195	GUDANG UMUM	DPM	1	GUDANG UMUM	9.34	2.22
196	IPSRS	DPM	1	IPSRS	9.39	3.03
197	GUDANG DPM	DPM	1	GUDANG DPM	8.26	2.08
198	RUANG TUNGGU	DPM	1	RUANG TUNGGU	15.76	9.12
199	IRJA	DPM	1	POLI PENYAKIT DALAM	4.14	2.93
200	IRJA	DPM	1	POLI JANTUNG	9.03	2.89
201	IRJA	DPM	1	POLI JANTUNG (VAKSIN)	3.91	3.91
202	IRJA	DPM	1	EKS FARMASI	8.16	4.63
203	IRJA	DPM	1	POLI SYARAF	5.03	3.14
204	REKAM MEDIS	DPM	1	GUDANG RM	4.99	1.69
205	REKAM MEDIS	DPM	1	REKAM MEDIS	16.95	5.95

3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3.4.3.1 Tabel Jumlah Angka Kecelakaan Kerja Tahun 2024

BULAN	ANGKA KECELAKAAN KERJA	KETERANGAN
Januari	1	Form Kecelakaan Kerja a) Nama Lengkap : Ns. Hana Hamimah, S.Kep b) Unit : IRJA c) Umur : 32 Tahun d) Hari / Tgl kejadian : Rabu, 31/01/2024

BULAN	ANGKA KECELAKAAN KERJA	KETERANGAN
		e) Jam Kejadian : 13.55 WIB f) Lokasi Kejadian : Depan Sebrang POM Bensin Banjararum g) Kronologi Kejadian : Jatuh dari motor saat berangkat kerja terpeleset karna hujan lebat h) Luka yg Diderita : Vulnus Abrasi Pedis + Sprain Ankle i) Jenis Luka : Sedang j) Penanganan Kecelakaan : IGD k) Tindak Lanjut Setelah Penanganan : Perawatan Luka l) Waktu Lama Perawatan : 3 Minggu m) Penjamin : JKK
Februari	2	1. Tanggal 1 Februari 2024, petugas IPSRS an Salma Gita Pramesti AMd.TEM, terjatuh diserempet motor saat hendak akan berangkat kerja, luka pada kpala, tangan dan kaki penanganan di IGD. 2. Tanggal, 25 Februari 2024, petugas gizi an Chandrawati Mustikasari, AMd. Gz saat akan duduk di kursi bakso tidak tepat sehingga jatuh pantat kanan terlebih dahulu luka di pantan dan nyeri, penanganan ke poli orthopedi.
Maret	1	Tanggal 23 Maret 2024 petugas an Della Ardisca bagian keuangan PT. DPM hendak saat pulang kerja, saat menaiki motor melintasi palang parkir terburu – buru dan tidak hati – hati saat melihat portal, sehingga kepala (pakai helm) terkena portal saat mau turun, sehingga petugas jatuh, petugas mengalami luka sedang dan dibawa ke IGD
April	-	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja
Mei	-	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja
Juni	-	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja
Juli	-	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja
Agustus	-	1 kejadian kecelakaan kerja Petugas cs IGD tertusuk jarum di tangan jari tengah sebelah kiri, pada tanggal 13 Agustus 2024, tertusuk di bagian bed pasien
September	1	1 kejadian kecelakaan kerja petugas perawat IGD tertusuk jarum pada ibu jari tangan kiri, pada tanggal 03 September 2024
Oktober	-	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja
November	-	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja
Desember	2	1. Tanggal 06 Desember 2024 petugas IRNA 2C, terkena jarum suntik saat menggoyangkan safety box dan terkean jarum, tindakan penangan dilakukan bilas dan penanganan pertama. 2. Tanggal 26 Desember 2024 petugas dapur, jatuh dari kursi (kursi rusak), mengalami sakit di bokong dilakukan penanganan pertama di IGD.

BULAN	ANGKA KECELAKAAN KERJA	KETERANGAN

3.4.3.2 Grafik Angka Kecelakaan Kerja Tahun 2024



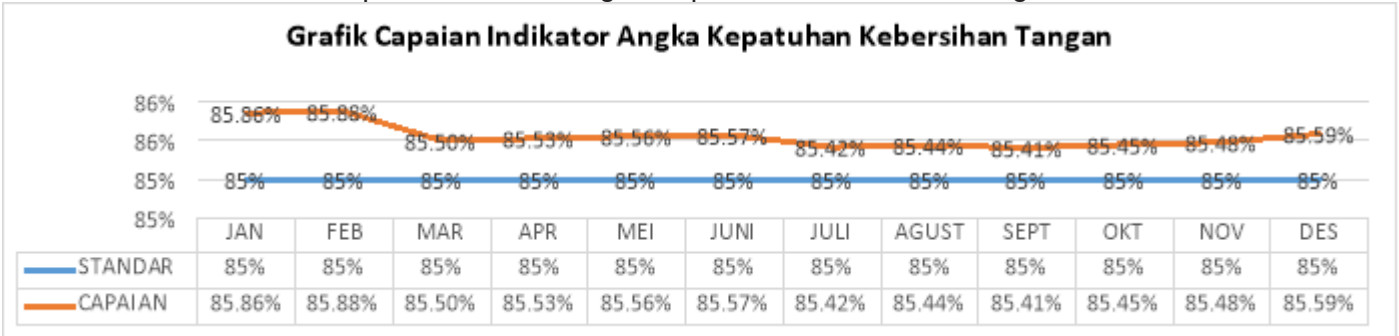
- Keterangan :**
- a) Jumlah total kecelakaan kerja di tahun 2024 yaitu : 7 kejadian
 - b) Terbanyak adalah terjadi 2 kejadian di bulan Februari dan Desember.

3.5 Kinerja Produktifitas Komite Mutu
3.5.1 Mutu Nasional

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%	85,44%	85,41%	85,45%	85,48%	85,59%	85,55%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04%	93,15%	93,3%	93,52%	93,73%	93,8%	93,92%	93,24%	92,15%	92,21%	92,77%	92,94%	93,14%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%	99,95%	99,93%	99,96%	99,99%	99,98%	99,99%	99,87%	98,29%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2%	91,7%	95,74%	52,7%	63,8%	72,8%	80,97%	85,74%	88,65%	82,77%	74,14%	80,22%	80,37%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19%	79,08%	79,28%	78,06%	76,32%	78,47%	78,3%	79,04%	77,89%	74,83%	79,77%	75,31%	77,71%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,46%	97,5%	98,9%	99,69%	100%	100%	100%	97,91%	98,22%	99,2%	98,94%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8%	71,62%	67,56%	66,7%	100%	92,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,51%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%	96,51%	98,64%	98,72%	95,94%	95,92%	99,68%	97,84%	97,85%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,42%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%	100%	100%	99,38%	99,81%	99,7%	99,91%	99,82%	99,13%

3.5.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

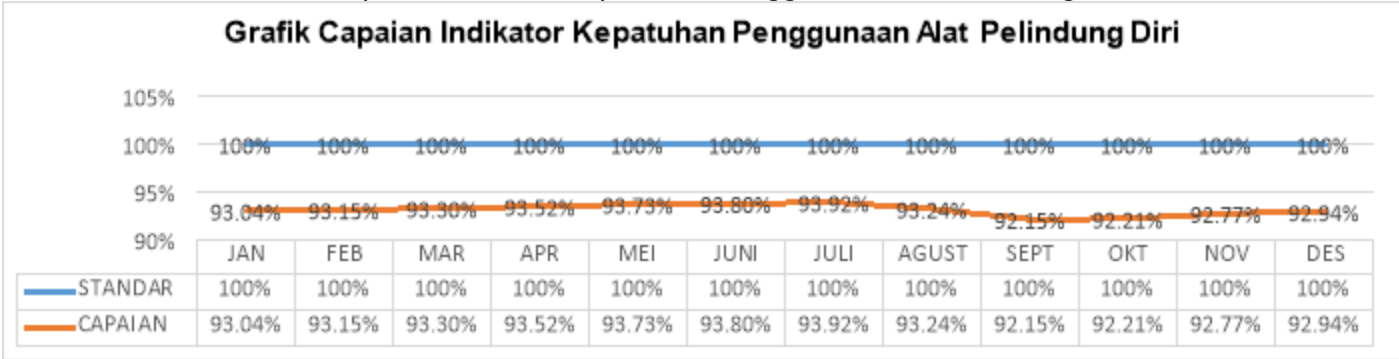
Gambar 3.5.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu diatas 85%, hal ini berkat kedisiplinan seluruh karyawan serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan kebersihan tangan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 3.5.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



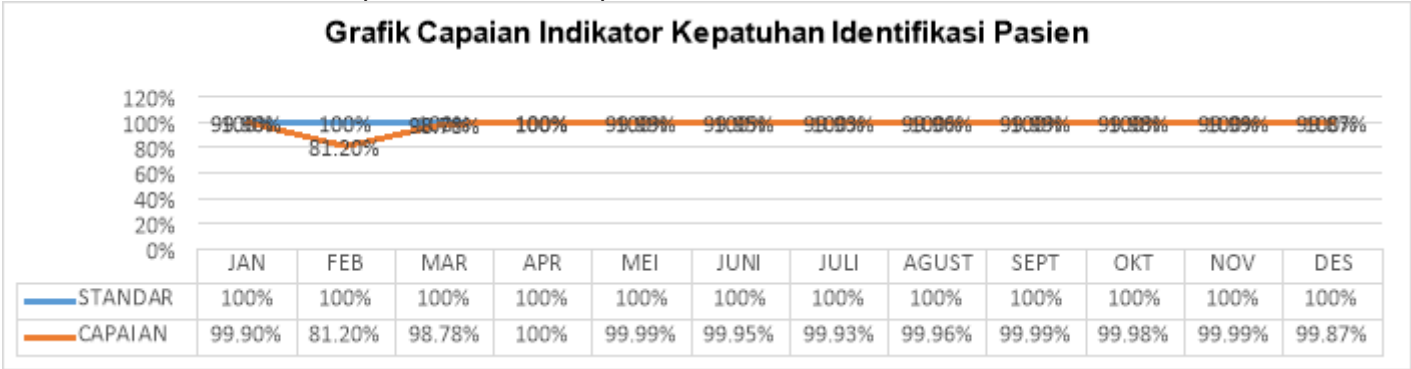
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	- Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.

	- Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, diketahui rata rata capaian setiap bulan adalah 93,14%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	- Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	- Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. - Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. - Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu Tahun

3.5.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3.5.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

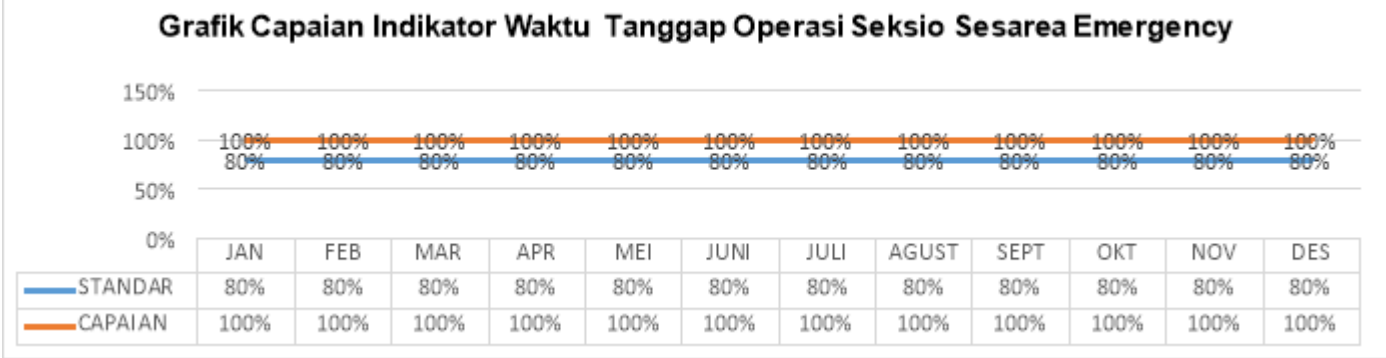


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan rata rata capaian setiap bulan sebesar 98,29%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu tahun

3.5.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

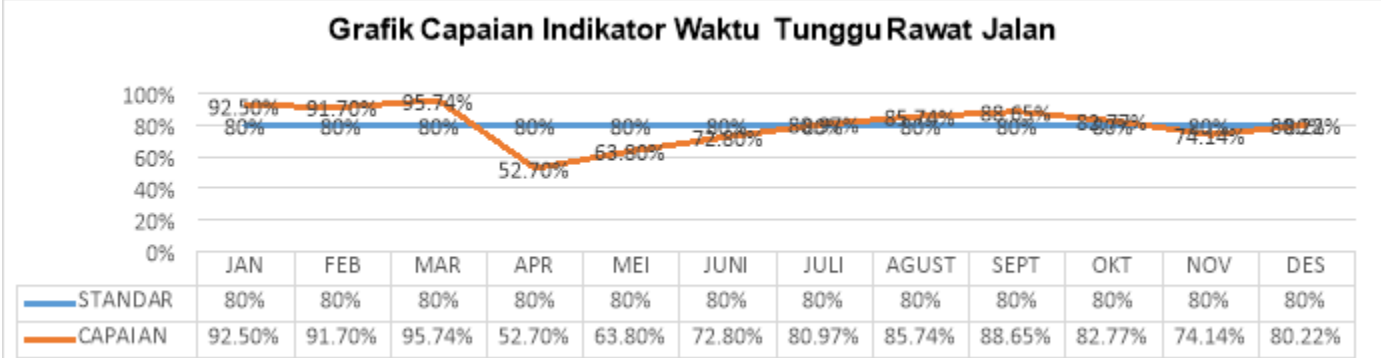
Gambar 3.5.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 3.5.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 belum mencapai standrart dengan rata-rata 80,37%, hasil tersebut sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	- Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	- Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan kapid pelayanan	Manajemen RS	- Satu bulan

Rekap Data Dokter Terlambat Januari 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Rudi Priyo,Sp.Og	18	6	12	66,67%	2	4	33,33%
2	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	9	5	4	44,44%	0	5	0,00%
3	dr. Eko N, Sp. KFR	22	16	6	27,27%	8	8	50,00%

4	dr. Rinadhi Reza, Sp.PD-KEMD	4	3	1	25,00%	1	2	33,33%
5	dr. Nimim, SpTHT-KL	38	32	7	18,42%	5	27	15,63%
6	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	13	11	2	15,38%	2	9	18,18%
7	dr Rossy Zaki,Sp B	18	16	2	11,11%	15	1	93,75%
8	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	28	25	3	10,71%	1	24	4,00%
9	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	27	23	2	7,41%	17	6	73,91%
10	dr. Miryanti, Sp.JP	26	25	1	3,85%	15	10	60,00%
11	dr Heriyatmo SpPD	26	26	1	3,85%	7	19	26,92%
12	dr. Dewi Maharani, Sp. S	26	25	1	3,85%	1	24	4,00%
13	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	30	29	1	3,33%	8	21	27,59%
14	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	52	51	1	1,92%	0	51	0,00%
15	dr. Nurhadi Sp.M	50	50	0	0,00%	47	3	94,00%
16	dr. Andy, Sp. P	22	22	0	0,00%	19	3	86,36%
17	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	22	22	0	0,00%	13	9	59,09%
18	drg. ega lucida Sp.Perio	9	9	0	0,00%	4	5	44,44%
19	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	30	30	0	0,00%	7	23	23,33%
20	dr Humaira Rahma, SpOG	40	40	0	0,00%	6	34	15,00%
21	dr Aida Musyarofah SpOG	22	22	0	0,00%	3	19	13,64%
22	dr. Catur Elvi, Sp.P	8	8	0	0,00%	1	7	12,50%
23	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	13	13	0	0,00%	2	11	9,00%
24	dr Pradana Nurhadi Sp.U	13	13	0	0,00%	1	12	7,69%
25	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	18	18	0	0,00%	1	17	5,56%
26	dr Anton Setiadi SpB	48	48	0	0,00%	1	47	2,08%
27	dr. Catur Ari Setianto, Sp. S (K)	9	9	0	0,00%	0	9	0,00%

28	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE	5	5	0	0,00%	0	5	0,00%
29	dr Arianto Prabowo SpOT	10	10	0	0,00%	0	10	0,00%
30	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	26	26	0	0,00%	0	26	0,00%
31	dr. Fiona Paramita Sp.A	22	22	0	0,00%	0	22	0,00%
32	dr Iwan, SpB	12	12	0	0,00%	0	12	0,00%
33	dr. Edi Wibowo, SpU	13	13	0	0,00%	0	13	0,00%
34	dr. Didit Roesono, SpKJ	14	14	0	0,00%	0	14	0,00%
35	dr. Andi Abdillah, SpB	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
		751	707	44		187	520	

Rekap Data Dokter Terlambat Februari 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Nurhadi Sp.M	45	35	5	11,11%	34	1	97,14%
2	dr Rossy Zaki,Sp B	14	14	0	0,00%	13	1	92,86%
3	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	22	22	2	9,09%	18	1	81,82%
4	dr. Andy, Sp. P	20	16	4	20,00%	12	4	75,00%
5	dr. Miryanti, Sp.JP	22	20	2	9,09%	15	5	75,00%
6	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	19	18	1	5,26%	13	5	72,22%
7	dr Heriyatmo SpPD	22	21	1	4,55%	14	7	66,67%
8	drg. ega lucida Sp.Perio	9	8	1	11,11%	4	4	50,00%
9	dr. Meyrna, Sp.THBKL	12	9	2	16,67%	4	5	44,44%
10	dr. Rinadhi Reza, Sp.PD-KEMD	4	3	1	25,00%	1	2	33,33%
11	dr Humaira Rahma, SpOG	35	31	4	11,43%	8	23	25,81%

12	dr. Catur Elvi, Sp.P	9	8	1	11,11%	2	6	25,00%
13	dr Pradana Nurhadi Sp.U	12	12	0	0,00%	3	9	25,00%
14	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	26	25	1	3,85%	6	19	24,00%
15	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	11	11	0	0,00%	2	9	18,18%
16	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	26	24	2	7,69%	4	15	16,67%
17	dr Aida Musyarofah SpOG	19	19	0	0,00%	3	16	15,79%
18	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	8	7	1	12,50%	1	6	14,29%
19	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	26	24	2	7,69%	3	23	12,50%
20	dr. Edi Wibowo, SpU	12	10	2	16,67%	1	9	10,00%
21	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	14	14	0	0,00%	2	12	9,00%
22	dr Iwan, SpB	12	12		0,00%	1	11	8,33%
23	dr. Eko N, Sp. KFR	50	50	0	0,00%	4	46	8,00%
24	drg. Bhakti Sp.Ortho	17	17	0	0,00%	1	16	5,88%
25	dr Anton Setiadi SpB	41	41	0	0,00%	2	39	4,88%
26	dr. Nimim, SpTHBKL	31	23	8	25,81%	1	22	4,35%
27	dr. Rudi Priyo,Sp.Og	17	3	14	82,35%	0	3	0,00%
28	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	21	15	4	19,05%	0	15	0,00%
29	dr. Dewi Maharani, Sp. S	25	23	2	8,00%	0	23	0,00%
30	dr. Fiona Paramita Sp.A	21	20	1	4,76%	0	20	0,00%
31	dr. Andi Abdillah, SpB	7	6	1	14,29%	0	6	0,00%
32	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE	4	4	0	0,00%	0	4	0,00%
33	dr Arianto Prabowo SpOT	7	7	0	0,00%	0	7	0,00%
34	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	22	22	0	0,00%	0	22	0,00%
35	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	53	53	0	0,00%	0	53	0,00%
36	dr. Didit Roesono, SpKJ	12	12	0	0,00%	0	12	0,00%

		727	659	62		138	480	
--	--	-----	-----	----	--	-----	-----	--

Rekap Data Dokter Terlambat Maret 2024

Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
dr. Meyrna, Sp.THBKL	12	9	3	25,00%	8	1	88,89%
dr Titok Hariyanto, Sp.,M	24	23	1	4,17%	19	4	82,61%
dr. Miryanti, Sp.JP	24	24	0	0,00%	16	8	66,67%
dr Rossy Zaki,Sp B	15	15	0	0,00%	8	7	53,33%
dr. Rinadhi Reza, Sp.PD-KEMD	4	2	2	50,00%	1	1	50,00%
dr. Rudi Priyo,Sp.Og	6	2	4	66,67%	1	1	50,00%
dr. Andy, Sp. P	19	16	3	15,79%	7	9	43,75%
dr. Nimim, SpTHTBKL	35	33	2	5,71%	14	17	42,42%
dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	19	19	0	0,00%	7	12	36,84%
dr. Nurhadi Sp.M	43	43	0	0,00%	15	28	34,88%
dr Iwan, SpB	11	11	0	0,00%	3	8	27,27%
dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	27	27	0	0,00%	7	20	25,93%
drg. ega lucida Sp.Perio	8	8	0	0,00%	2	6	25,00%
dr Humaira Rahma, SpOG	33	31	2	6,06%	7	24	22,58%
dr Heriyatmo SpPD	24	19	5	20,83%	4	15	21,05%
dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	29	29	0	0,00%	6	23	20,69%
dr. Catur Elvi, Sp.P	7	7	0	0,00%	1	7	14,29%
dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	23	23	0	0,00%	3	20	13,04%
dr. Eko N, Sp. KFR	48	48	0	0,00%	5	43	10,42%
Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	12	12	0	0,00%	2	10	9,00%
dr Pradana Nurhadi Sp.U	12	12	0	0,00%	1	11	8,33%

dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	12	12	0	0,00%	1	11	8,33%
dr Anton Setiadi SpB	43	43	0	0,00%	3	40	6,98%
drg. Bhakti Sp.Ortho	16	16	0	0,00%	1	15	6,25%
dr Aida Musyarofah SpOG	19	18	1	5,26%	1	17	5,56%
dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	7	7	0	0,00%	0	7	0,00%
dr. Edi Wibowo, SpU	12	12	0	0,00%	0	12	0,00%
dr. Dewi Maharani, Sp. S	26	25	1	3,85%	0	25	0,00%
dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE	4	2	2	50,00%	0	2	0,00%
dr Arianto Prabowo SpOT	7	7	0	0,00%	0	7	0,00%
dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	23	23		0,00%	0	0	0,00%
dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	47	47	0	0,00%	0	47	0,00%
dr. Fiona Paramita Sp.A	19	19	0	0,00%	0	19	0,00%
dr Akhmad Syahrir, Sp. N	22	22	0	0,00%	0	22	0,00%
dr. Didit Roesono, SpKJ	12	12		0,00%	0	12	0,00%
dr. Andi Abdillah, SpB	7	6	1	14,29%	0	6	0,00%
	711	684	27		135	516	

Rekap Data Dokter Terlambat April 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Rossy Zaki,Sp B	16	15	1	6,25%	11	4	73,33%
2	drg. ega lucida Sp.Perio	9	7	2	22,22%	5	2	71,43%
3	dr. Andy, Sp. P	20	18	2	10,00%	12	6	66,67%
4	dr. Miryanti, Sp.JP	24	16	8	33,33%	10	6	62,50%
5	dr. Eko N, Sp. KFR	48	47	1	2,08%	23	25	48,94%
6	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	20	19	1	5,00%	9	10	47,37%
7	drg. Bhakti Sp.Ortho	48	12	5	10,42%	5	7	41,67%

8	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	30	26	4	13,33%	9	17	34,62%
9	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	24	21	3	12,50%	7	14	33,33%
10	dr. Nurhadi Sp.M	44	37	4	9,09%	10	27	27,03%
11	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	4	4	0	0,00%	1	3	25,00%
12	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	27	21	6	22,22%	5	16	23,81%
13	dr Iwan, SpB	12	10	2	16,67%	2	8	20,00%
14	dr. Meyrna, Sp.THBKL	13	11	2	15,38%	2	9	18,18%
15	dr. Nimim, SpTHTBKL	33	23	10	30,30%	4	19	17,39%
16	dr Arianto Prabowo SpOT	9	6	2	22,22%	1	11	16,67%
17	dr. Catur Elvi, Sp.P	8	7	1	12,50%	1	6	14,29%
18	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	25	24	1	4,00%	3	21	12,50%
19	dr Humaira Rahma, SpOG	36	29	7	19,44%	3	26	10,34%
20	dr Pradana Nurhadi Sp.U	13	10	3	23,08%	1	9	10,00%
21	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	13	10	3	23,08%	1	9	10,00%
22	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	12	12	0	0,00%	3	9	9,00%
23	dr Aida Musyarofah SpOG	20	19	1	5,00%	1	18	5,26%
24	dr Heriyatmo SpPD	24	20	4	16,67%	1	19	5,00%
28	dr. Rudi Priyo,Sp.Og	15	1	14	93,33%	0	1	0,00%
29	dr. Dewi Maharani, Sp. S	22	16	6	27,27%	0	16	0,00%
26	dr. Edi Wibowo, SpU	13	10	3	23,08%	0	10	0,00%
30	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	24	20	4	16,67%		20	0,00%
34	dr. Didit Roesono, SpKJ	13	11	2	15,38%	0	11	0,00%
33	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	21	18	3	14,29%	0	18	0,00%
31	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	47	41	6	12,77%	0	41	0,00%
32	dr. Fiona Paramita Sp.A	20	18	2	10,00%	0	18	0,00%

27	dr Anton Setiadi SpB	44	43	1	2,27%	0	43	0,00%
25	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	7	7	0	0,00%	0	7	0,00%
35	dr. Andi Abdillah, SpB	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
		766	617	144		119	490	

Rekap Data Dokter Terlambat Mei 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Rossy Zaki,Sp B	15	15	0	0,00%	12	3	80,00%
2	drg. ega lucida Sp.Perio	9	7	2	22,22%	2	5	28,57%
3	dr. Andy, Sp. P	20	17	3	15,00%	7	10	41,18%
4	dr. Miryanti, Sp.JP	24	19	5	20,83%	16	3	84,21%
5	dr. Eko N, Sp. KFR	46	46	2	4,35%	28	18	60,87%
6	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	20	20	0	0,00%	19	1	95,00%
7	drg. Bhakti Sp.Ortho	15	15	0	0,00%	4	11	26,67%
8	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	28	27	1	3,57%	18	9	66,67%
9	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	24	23	1	4,17%	4	19	17,39%
10	dr. Nurhadi Sp.M	44	42	2	4,55%	6	36	14,29%
11	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	4	3	1	25,00%	0	3	0,00%
12	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	28	26	2	7,14%	6	20	23,08%
13	dr Iwan, SpB	12	10	2	16,67%	4	6	40,00%
14	dr. Meyrna, Sp.THBKL	12	9	3	25,00%	3	6	33,33%
15	dr. Nimim, SpTHTBKL	36	25	11	30,56%	4	21	16,00%
16	dr Arianto Prabowo SpOT	8	5	3	37,50%	0	5	0,00%
17	dr. Catur Elvi, Sp.P	7	6	1	14,29%	0	6	0,00%
18	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	28	24	4	14,29%	3	21	12,50%
19	dr Humaira Rahma, SpOG	36	36	0	0,00%	6	30	16,67%

20	dr Pradana Nurhadi Sp.U	12	12	0	0,00%	1	11	8,33%
21	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	12	8	4	33,33%	1	7	12,50%
22	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	11	9	0	0,00%	3	9	9,00%
23	dr Aida Musyarofah SpOG	20	16	4	20,00%	0	16	0,00%
24	dr Heriyatmo SpPD	24	24	0	0,00%	0	24	0,00%
25	dr. Rudi Priyo,Sp.Og	16	1	15	93,75%	0	1	0,00%
26	dr. Dewi Maharani, Sp. S	20	16	4	20,00%	0	16	0,00%
27	dr. Edi Wibowo, SpU	13	12	1	7,69%	0	12	0,00%
28	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	24	22	2	8,33%	0	22	0,00%
29	dr. Didit Roesono, SpKJ	38	13	0	0,00%	1	12	7,69%
30	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	20	18	2	10,00%	1	17	5,56%
31	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	48	48	0	0,00%	0	48	0,00%
32	dr. Fiona Paramita Sp.A	20	19	1	5,00%	0	19	0,00%
33	dr Anton Setiadi SpB	44	43	1	2,27%	0	43	0,00%
34	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	7	7	0	0,00%	0	7	0,00%
35	dr. Andi Abdillah, SpB	7	5	2	28,57%	0	5	0,00%
36	dr. Diah Puspita Rifasanti,Sp.M	15	13	2	13,33%	0	13	0,00%
37	dr. Fahimma, Sp. N	8	8	0	0,00%	7	1	87,50%
		775	669	81		144	513	

Rekap Data Dokter Terlambat Juni 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	11	11	0	0,00%	10	1	90,91%
2	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	19	18	1	5,26%	14	4	77,78%

3	dr. Rossy Zaki,Sp B	14	13	1	7,14%	10	3	76,92%
4	dr. Fahimma, Sp. N	8	8	0	0,00%	6	2	75,00%
5	dr. Miryanti, Sp.JP	23	20	3	13,04%	13	7	65,00%
6	drg. Bhakti Sp.Ortho	14	14	0	0,00%	9	5	64,29%
7	drg. ega lucida Sp.Perio	12	11	1	8,33%	7	5	63,64%
8	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	28	27	1	3,57%	17	10	62,96%
9	dr. Eko N, Sp. KFR	22	44	0	0,00%	26	18	59,09%
10	dr. Meyrna, Sp.THBKL	11	10	1	9,09%	5	5	50,00%
11	dr. Diah Puspita Rifasanti,Sp.M	15	12	3	20,00%	5	7	41,67%
12	dr Iwan, SpB	10	10	0	0,00%	4	6	40,00%
13	dr. Nurhadi Sp.M	42	40	2	4,76%	13	27	32,50%
14	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	27	25	2	7,41%	7	18	28,00%
15	dr. Andy, Sp. P	19	18	1	5,26%	5	13	27,78%
16	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	23	20	3	13,04%	5	15	25,00%
17	dr. Nimim, SpTHTBKL	31	20	11	35,48%	4	16	20,00%
18	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	11	11	0	0,00%	2	9	18,18%
19	dr Heriyatmo SpPD	23	22	1	4,35%	3	19	13,64%
20	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	11	8	3	27,27%	1	7	12,50%
21	dr Pradana Nurhadi Sp.U	12	11	1	8,33%	1	11	9,09%
22	dr Aida Musyarofah SpOG	19	15	4	21,05%	1	14	6,67%
23	dr Humaira Rahma, SpOG	34	34	0	0,00%	2	32	5,88%
24	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	26	21	5	19,23%	1	20	4,76%
25	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	4	2	2	50,00%	0	2	0,00%
26	dr Arianto Prabowo SpOT	8	7	0	0,00%	0	8	0,00%
27	dr. Catur Elvi, Sp.P	7	7	0	0,00%	0	7	0,00%
28	dr. Dewi Maharani, Sp. S	19	17	2	10,53%	0	17	0,00%

29	dr. Edi Wibowo, SpU	11	11	0	0,00%	0	11	0,00%
30	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	22	22	0	0,00%	0	22	0,00%
31	dr. Didit Roesono, SpKJ	33	33	0	0,00%	0	33	0,00%
32	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	21	19	2	9,52%	0	19	0,00%
33	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	49	42	5	10,20%	0	42	0,00%
34	dr. Fiona Paramita Sp.A	19	19	0	0,00%	0	19	0,00%
35	dr Anton Setiadi SpB	40	38	2	5,00%	0	38	0,00%
36	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	8	7	1	12,50%	0	7	0,00%
37	dr. Andi Abdillah, SpB	6	5	1	16,67%	0	6	0,00%
38	drg. Ajeng Sp.KGA	20	10	10	50,00%	0	10	0,00%
		732	682	69		161	514	

Rekap Data Dokter Terlambat Juli 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Miryanti, Sp.JP	27	25	2	7,41%	24	1	96,00%
2	dr. Rossy Zaki,Sp B	19	19	0	0,00%	16	3	84,21%
3	dr. Fahimma, Sp. N	9	9	0	0,00%	6	3	66,67%
4	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	31	30	1	3,23%	16	14	53,33%
5	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	23	20	3	13,04%	9	11	45,00%
6	dr. Fachriy Balafif, SpBS	9	9	0	0,00%	4	5	44,44%
7	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	14	10	4	28,57%	4	6	40,00%
8	drg. ega lucida Sp.Perio	12	10	2	16,67%	4	6	40,00%
9	dr. Nurhadi Sp.M	50	49	1	2,00%	19	30	38,78%
10	dr. Andy, Sp. P	23	21	2	8,70%	7	14	33,33%
11	dr. Meyrna, Sp.THBKL	13	12	1	7,69%	4	8	33,33%
12	drg. Bhakti Sp.Ortho	18	18	0	0,00%	6	12	33,33%

13	dr. Diah Puspita Rifasanti,Sp.M	17	16	1	5,88%	5	11	31,25%
14	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	32	28	4	12,50%	7	21	25,00%
15	dr. Nimim, SpTHBKL	41	33	8	19,51%	8	25	24,24%
16	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	13	13	0	0,00%	3	10	23,08%
17	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	27	27	0	0,00%	6	21	22,22%
18	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	32	29	3	9,38%	6	23	20,69%
19	dr Iwan, SpB	13	13	0	0,00%	2	11	15,38%
20	dr. Huda Sp.KJ	75	75	1	1,33%	11	13	14,67%
21	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	14	8	6	42,86%	1	7	12,50%
22	dr. Andi Abdillah, SpB	9	8	1	11,11%	1	7	12,50%
23	dr Arianto Prabowo SpOT	10	10	0	0,00%	1	9	10,00%
24	dr Pradana Nurhadi Sp.U	13	12	1	7,69%	1	12	8,33%
25	dr. Eko N, Sp. KFR	54	54	0	0,00%	3	51	5,56%
26	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	21	19	2	9,52%	1	18	5,26%
27	dr Aida Musyarofah SpOG	23	23	0	0,00%	1	22	4,35%
28	dr. Catur Elvi, Sp.P	9	8	1	11,11%	0	8	0,00%
29	drg. Ajeng Sp.KGA	10	9	1	10,00%	0	10	0,00%
30	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	53	49	4	7,55%	0	49	0,00%
31	dr. Dewi Maharani, Sp. S	23	22	1	4,35%	0	22	0,00%
32	dr Heriyatmo SpPD	27	26	1	3,70%	0	26	0,00%
33	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	9	9	0	0,00%	0	9	0,00%
34	dr. Adya Sp.DV	54	54	0	0,00%	0	54	0,00%
35	dr Humaira Rahma, SpOG	42	42	0	0,00%	0	42	0,00%
36	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	5	5	0	0,00%	0	5	0,00%
37	dr. Edi Wibowo, SpU	14	14	0	0,00%	0	14	0,00%
38	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	27	27	0	0,00%	0	27	0,00%

39	dr. Didit Roesono, SpKJ	42	42	0	0,00%	0	42	0,00%
40	dr. Fiona Paramita Sp.A	23	23	0	0,00%	0	23	0,00%
41	dr Anton Setiadi SpB	49	49	0	0,00%	0	49	0,00%
		1029	976	51		152	753	

Rekap Data Dokter Terlambat Agustus 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Rossy Zaki,Sp B	17	14	3	17,65%	13	1	92,86%
2	dr. Miryanti, Sp.JP	26	25	1	3,85%	23	2	92,00%
3	dr. Fahimma, Sp. N	8	6	2	25,00%	5	1	83,33%
4	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	13	10	3	23,08%	7	3	70,00%
5	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	23	18	5	21,74%	11	7	61,11%
6	dr. Nurhadi Sp.M	45	42	3	6,67%	25	17	59,52%
7	drg. ega lucida Sp.Perio	13	11	2	15,38%	6	5	54,55%
8	dr Iwan, SpB	14	14	0	0,00%	6	8	42,86%
9	dr. Fachriy Balafif, SpBS	9	7	2	22,22%	3	4	42,86%
10	dr. Meyrna, Sp.THBKL	14	14	0	0,00%	5	9	35,71%
11	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	14	14	0	0,00%	5	9	35,71%
12	dr. Andy, Sp. P	22	21	1	3,45%	7	14	33,33%
13	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	29	25	4	13,79%	8	17	32,00%
14	drg. Bhakti Sp.Ortho	17	17	0	0,00%	5	12	29,41%
15	dr. Catur Elvi, Sp.P	9	9	0	0,00%	2	7	22,22%
16	dr. Huda Sp.KJ	78	78	0	0,00%	17	10	21,79%

17	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	30	30	0	0,00%	6	24	20,00%
18	dr. Nimim, SpTHTBKL	38	33	5	13,16%	5	28	15,15%
19	dr Arianto Prabowo SpOT	8	8	0	0,00%	1	7	12,50%
20	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	26	25	1	3,85%	3	22	12,00%
21	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	29	28	1	1,85%	3	25	10,71%
22	dr. Eko N, Sp. KFR	54	54	0	0,00%	5	49	9,26%
23	dr. Edi Wibowo, SpU	13	11	2	15,38%	1	12	9,09%
24	dr Pradana Nurhadi Sp.U	13	12	1	7,69%	1	12	8,33%
25	drg. Ajeng Sp.KGA	22	22	0	0,00%	1	21	4,55%
26	dr. Diah Puspita Rifasanti,Sp.M	18	13	5	27,78%	0	13	0,00%
27	dr Heriyatmo SpPD	26	25	1	3,85%	0	25	0,00%
28	dr Aida Musyarofah SpOG	22	22	0	0,00%	0	22	0,00%
29	dr Humaira Rahma, SpOG	38	35	3	7,89%	0	35	0,00%
30	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	4	4	0	0,00%	0	4	0,00%
31	dr. Dewi Maharani, Sp. S	22	17	5	22,73%	0	17	0,00%
32	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	26	24	2	7,69%	0	24	0,00%
33	dr. Didit Roesono, SpKJ	39	39	0	0,00%	0	14	0,00%
34	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	22	22	0	0,00%	0	22	0,00%
35	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	52	51	1	1,92%	0	52	0,00%
36	dr. Fiona Paramita Sp.A	22	22	0	0,00%	0	22	0,00%
37	dr Anton Setiadi SpB	48	48	0	0,00%	0	48	0,00%
38	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	9	9	0	0,00%	0	9	0,00%
39	dr. Andi Abdillah, SpB	9	9	0	0,00%	0	9	0,00%
40	dr. Adya Sp.DV	48	42	2	4,17%	0	42	0,00%
41	dr Rudi, SpOG	5	1	4	80,00%	0	1	0,00%
		994	931	59		174	684	

Rekap Data Dokter Terlambat September 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Fahimma, Sp. N	8	7	1	12,50%	7	0	100,00%
2	dr. Rossy Zaki, Sp B	15	15	0	0,00%	15	0	100,00%
3	dr. Miryanti, Sp.JP	24	20	4	16,67%	16	4	80,00%
4	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	24	23	1	4,17%	17	6	73,91%
5	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	12	7	5	41,67%	5	2	71,43%
6	dr Iwan, SpB	12	7	5	41,67%	4	3	57,14%
7	dr. Andi Abdillah, SpB	8	8	0	0,00%	4	4	50,00%
8	dr. Andy, Sp. P	20	19	1	2,38%	9	10	47,37%
9	dr. Nurhadi Sp.M	42	41	1	2,38%	19	22	46,34%
10	drg. Bhakti Sp.Ortho	16	16	0	0,00%	5	11	31,25%
11	drg. ega lucida Sp.Perio	12	10	2	16,67%	3	7	30,00%
12	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	20	14	6	30,00%	4	10	28,57%
13	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	29	29	0	0,00%	8	21	27,59%
14	dr. Meyrna, Sp.THBKL	12	11	1	8,33%	3	8	27,27%
15	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	12	12	0	0,00%	3	9	25,00%
16	dr. Nimim, SpTHTBKL	36	26	10	27,78%	5	21	19,23%
17	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	28	26	2	7,14%	5	21	19,23%
18	dr. Huda Sp.KJ	72	63	3	4,17%	10	11	15,87%
19	dr. Eko N, Sp. KFR	48	48	0	0,00%	7	41	14,58%
20	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	12	8	4	33,33%	1	7	12,50%
21	dr Pradana Nurhadi Sp.U	12	12	0	0,00%	1	11	8,33%
22	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	29	26	3	15,00%	2	24	7,69%
23	dr. Fiona Paramita Sp.A	20	19	1	5,00%	1	18	5,26%

24	dr Aida Musyarofah SpOG	21	21	0	0,00%	1	20	4,76%
25	dr. Adya Sp.DV	48	45	1	2,08%	1	14	2,22%
26	dr Rudi, SpOG	4	1	3	75,00%	0	1	0,00%
27	dr. Edi Wibowo, SpU	13	10	3	23,08%	0	10	0,00%
28	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	23	19	4	17,39%	0	19	0,00%
29	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	29	25	4	13,79%	0	25	0,00%
30	dr Arianto Prabowo SpOT	8	7	1	12,50%	0	0	0,00%
31	dr. Dewi Maharani, Sp. S	20	19	1	5,00%	0	19	0,00%
32	drg. Ajeng Sp.KGA	20	19	1	5,00%	0	19	0,00%
33	dr. Didit Roesono, SpKJ	36	33	1	2,78%	0	33	0,00%
34	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
35	dr Heriyatmo SpPD	24	24	0	0,00%	0	24	0,00%
36	dr Humaira Rahma, SpOG	35	35	0	0,00%	0	35	0,00%
37	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	4	4	0	0,00%	0	4	0,00%
38	dr. Catur Elvi, Sp.P	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
39	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	24	24	0	0,00%	0	24	0,00%
40	dr Anton Setiadi SpB	44	44	0	0,00%	0	44	0,00%
41	dr. Fachriy Balafif, SpBS	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
		900	821			156	586	

Rekap Data Dokter Terlambat Oktober 2024

No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Rossy Zaki,Sp B	19	17	2	10,53%	17	0	100,00%
2	dr. Miryanti, Sp.JP	27	27	0	0,00%	26	1	96,30%
3	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	13	12	1	7,69%	10	2	83,33%

4	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	23	21	2	8,70%	17	4	80,95%
5	dr. Andy, Sp. P	23	19	4	7,84%	15	4	78,95%
6	dr. Nurhadi Sp.M	51	45	6	11,76%	33	12	73,33%
7	dr. Meyrna, Sp.THBKL	14	11	3	21,43%	7	4	63,64%
8	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	27	24	3	11,11%	15	9	62,50%
9	drg. ega lucida Sp.Perio	14	11	3	21,43%	5	6	45,45%
10	drg. Bhakti Sp.Ortho	18	17	1	5,56%	7	10	41,18%
11	dr Iwan, SpB	13	13	0	0,00%	5	8	38,46%
12	dr. Fahimma, Sp. N	9	9	0	0,00%	3	6	33,33%
13	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	14	14	0	0,00%	4	10	28,57%
14	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	32	21	11	35,48%	5	16	23,81%
15	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	31	30	1	3,23%	6	24	20,00%
16	dr. Nimim, SpTHTBKL	40	27	13	32,50%	5	22	18,52%
17	dr. Huda Sp.KJ	81	81	0	0,00%	11	16	13,58%
18	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	31	31	0	0,00%	4	27	12,90%
19	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	13	8	5	38,46%	1	7	12,50%
20	dr Arianto Prabowo SpOT	9	9	0	0,00%	1	8	11,11%
21	dr Pradana Nurhadi Sp.U	14	14	0	0,00%	1	13	7,14%
22	dr. Eko N, Sp. KFR	54	32	22	40,74%	2	30	6,25%
23	dr Heriyatmo SpPD	26	26	0	0,00%	1	22	3,85%
24	dr Rudi, SpOG	4	0	4	100,00%	0	0	0,00%
25	dr Aida Musyarofah SpOG	23	23	0	0,00%	0	23	0,00%

26	dr Humaira Rahma, SpOG	41	38	3	7,32%	0	38	0,00%
27	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	5	5	0	0,00%	0	5	0,00%
28	dr. Catur Elvi, Sp.P	9	8	1	11,11%	0	8	0,00%
29	dr. Dewi Maharani, Sp. S	23	13	10	43,48%	0	13	0,00%
30	dr. Edi Wibowo, SpU	13	10	3	23,08%	0	10	0,00%
31	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	26	26	0	0,00%	0	26	0,00%
32	dr. Didit Roesono, SpKJ	39	39	0	0,00%	0	13	0,00%
33	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	26	17	9	34,62%	0	17	0,00%
34	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	31	31	0	0,00%	0	0	0,00%
35	dr. Fiona Paramita Sp.A	23	21	2	8,70%	0	0	0,00%
36	dr Anton Setiadi SpB	50	50	0	0,00%	0	50	0,00%
37	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	10	10	0	0,00%	0	10	0,00%
38	dr. Andi Abdillah, SpB	9	9	0	0,00%	0	9	0,00%
39	drg. Ajeng Sp.KGA	23	23	0	0,00%	0	23	0,00%
40	dr. Adya Sp.DV	57	57	0	0,00%	0	19	0,00%
41	dr. Fachriy Balafif, SpBS	8	6	2	25,00%	0	6	0,00%
		1016	905			201	531	

Rekap Data Dokter Terlambat November 2024

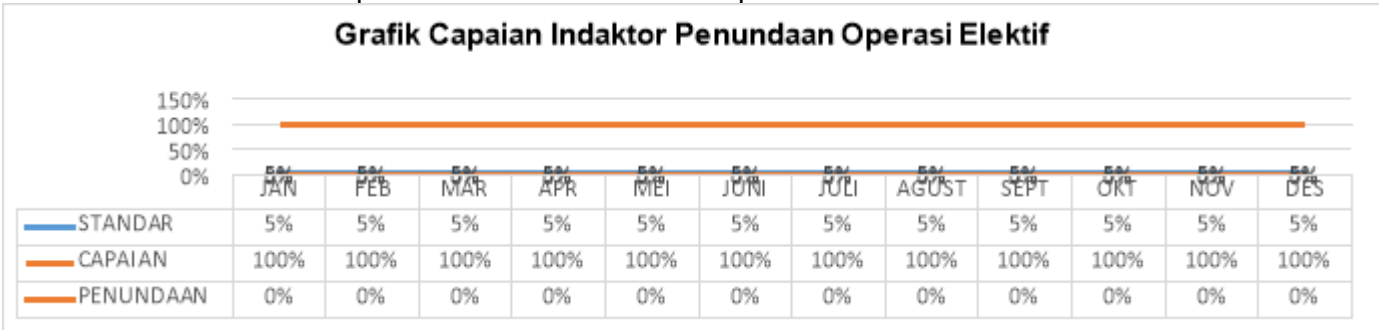
No	Nama DPJP	Jumlah jam praktek sesuai jadwal	Jumlah kehadiran	Jumlah ijin tidak praktek /tidak hadir	Presentasi kehadiran	Terlambat	Tidak Terlambat	% Terlambat
27	dr Rudi, SpOG	5	0	5	100,00%	0	0	0,00%
14	dr. Fachriy Balafif, SpBS	8	5	3	37,50%	1	4	20,00%
19	dr. Nimim, SpTHBKL	37	25	12	32,43%	3	22	12,00%

16	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	29	25	4	50,00%	4	21	16,00%
26	dr Arianto Prabowo SpOT	8	6	2	25,00%	0	6	0,00%
18	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	29	22	7	24,14%	3	19	13,64%
10	drg. ega lucida Sp.Perio	13	10	3	23,08%	4	6	40,00%
13	dr. Meyrna, Sp.THBKL	13	11	2	15,38%	3	8	27,27%
36	dr. Fiona Paramita Sp.A	20	18	2	10,00%	0	0	0,00%
41	dr. Adya Sp.DV	51	30	5	9,80%	0	12	0,00%
5	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	12	11	1	8,33%	9	2	81,82%
25	dr. Eko N, Sp. KFR	50	46	4	8,00%	1	45	2,17%
34	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	26	24	2	7,69%	0	0	0,00%
20	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	13	12	1	7,69%	1	11	8,33%
12	drg. Bhakti Sp.Ortho	17	16	1	5,88%	5	11	31,25%
8	dr. Andy, Sp. P	20	19	1	5,00%	10	9	52,63%
31	dr. Dewi Maharani, Sp. S	20	19	1	5,00%	0	0	0,00%
40	drg. Ajeng Sp.KGA	21	20	1	4,76%	0	20	0,00%
32	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	23	22	1	4,35%	0	22	0,00%
6	dr. Nurhadi Sp.M	50	48	2	4,00%	38	10	79,17%
15	dr. Huda Sp.KJ	26	25	1	3,85%	13	13	52,00%
35	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	29	28	1	3,45%	0	0	0,00%
33	dr. Didit Roesono, SpKJ	36	33	1	2,78%	0	12	0,00%
37	dr Anton Setiadi SpB	47	47	0	0,00%	0	47	0,00%
24	dr Humaira Rahma, SpOG	36	36	0	0,00%	1	35	2,78%
4	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	29	29	0	0,00%	25	4	86,21%
9	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	29	29	0	0,00%	13	16	44,83%
3	dr. Miryanti, Sp.JP	25	25	0	0,00%	23	2	92,00%
23	dr Heriyatmo SpPD	25	25	0	0,00%	1	24	4,00%

1	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	20	20	0	0,00%	19	1	95,00%
28	dr Aida Musyarofah SpOG	20	20	0	0,00%	0	20	0,00%
2	dr. Rossy Zaki,Sp B	15	15	0	0,00%	14	1	93,33%
7	dr Iwan, SpB	13	13	0	0,00%	7	6	53,85%
17	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	13	13	0	0,00%	2	11	15,38%
22	dr Pradana Nurhadi Sp.U	13	13	0	0,00%	1	12	7,69%
21	dr. Edi Wibowo, SpU	12	12	0	0,00%	1	11	8,33%
11	dr. Fahimma, Sp. N	8	8	0	0,00%	3	5	37,50%
30	dr. Catur Elvi, Sp.P	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
38	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
39	dr. Andi Abdillah, SpB	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
29	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	4	4	0	0,00%	0	4	0,00%
		889	808	63		205	476	

3.5.1.6 Penundaan Operasi Elektif

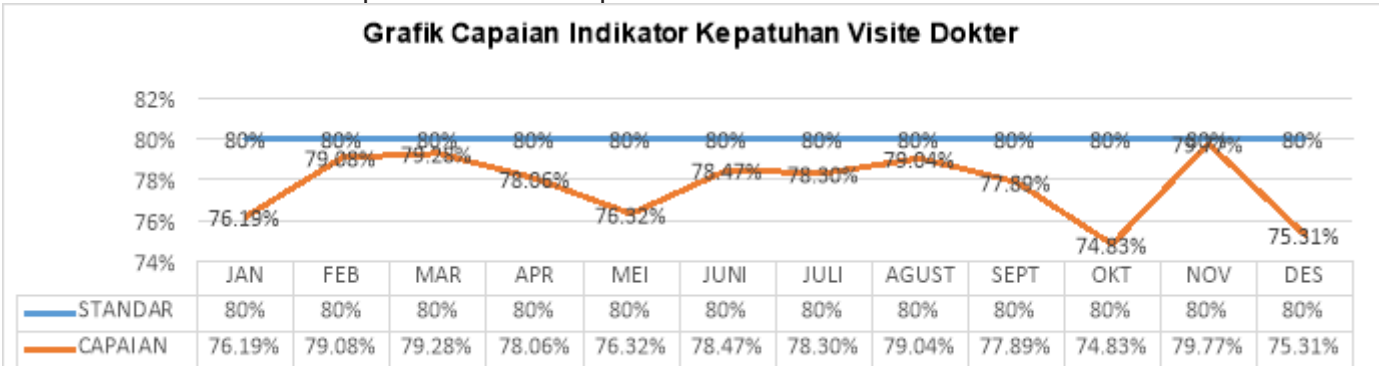
Gambar 3.5.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 3.5.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

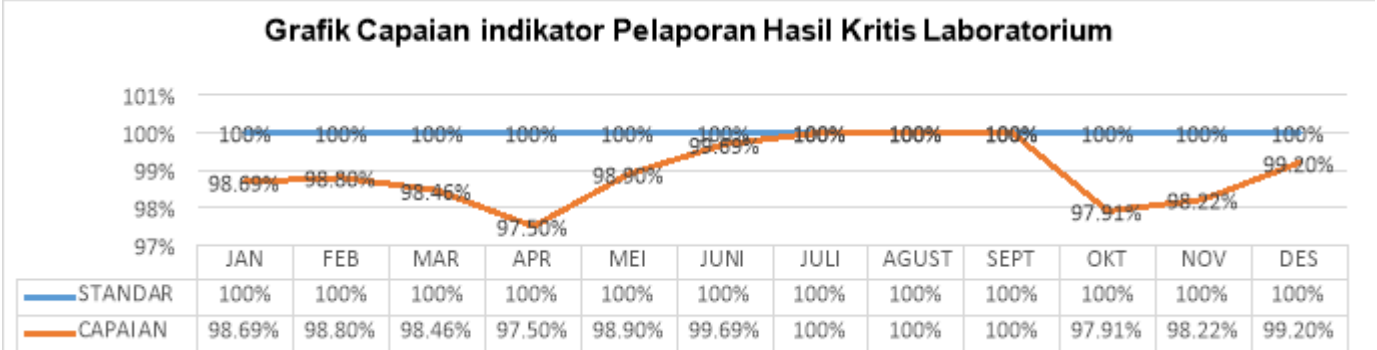


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 belum mencapai standart dengan rata-rata 77,71%. Dari hasil supervisi didapatkan.nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	- Satu Tahun

3.5.2 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 3.1.8 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%
------	---

DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Desember tahun 2024 belum mencapai standart dengan rata rata 98,94%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	- Satu Tahun

3.5.3 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

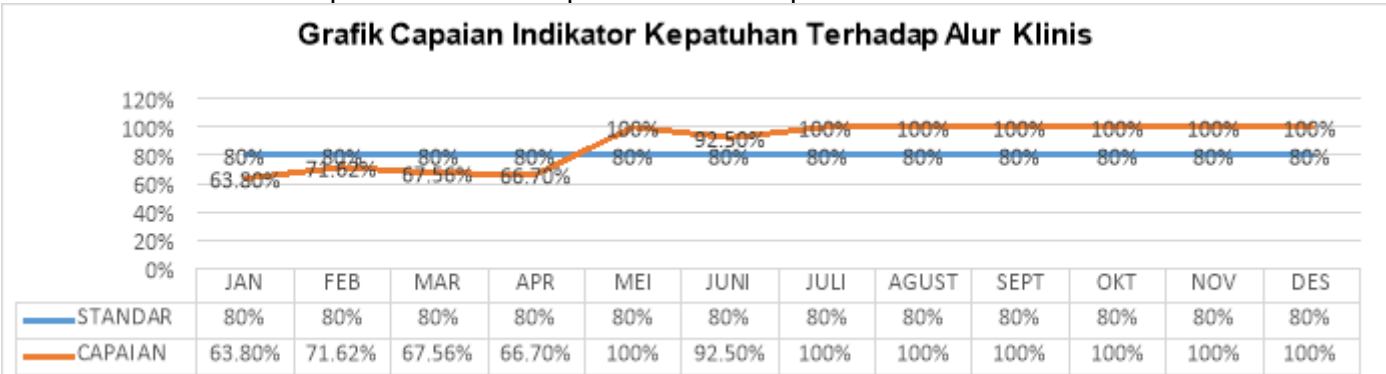
Gambar 3.1.9 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.4 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 3.1.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

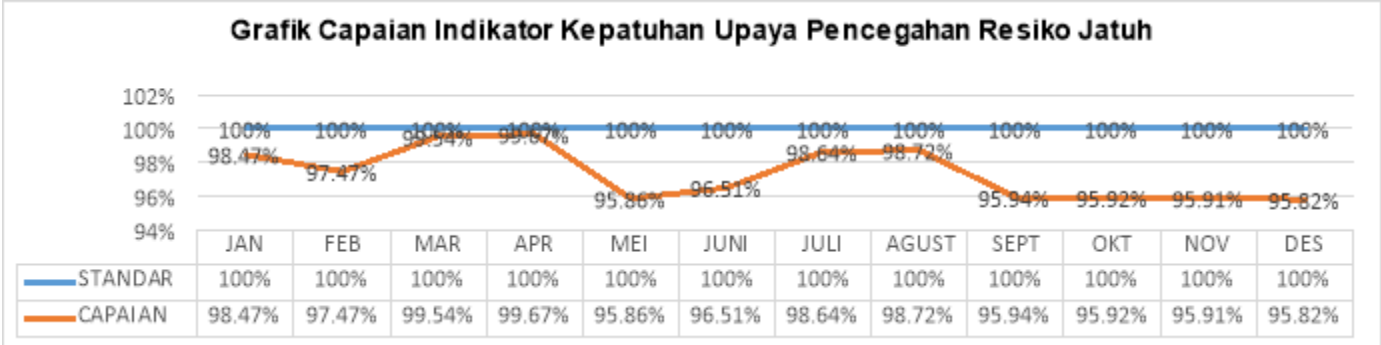
Daftar Clinical Pathway Bulan Desember 2024

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			

HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	19	19	0
Partus Normal	37	37	0
Jumlah	56	56	0

3.5.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 3.1.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



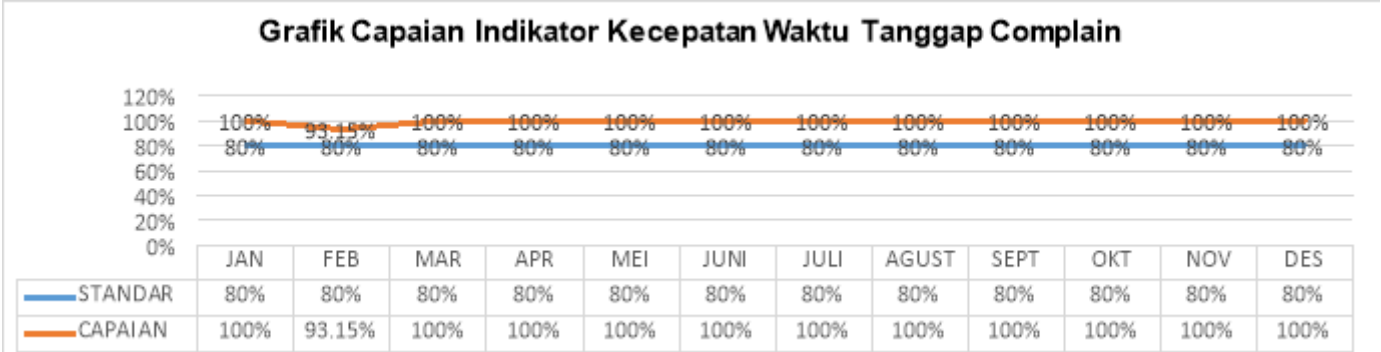
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 belum mencapai standart dengan rata-rata 97,85.% Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah

	memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Meningkatkan supervisi guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu Tahun

3.5.6 Kecepatan waktu tanggap complain

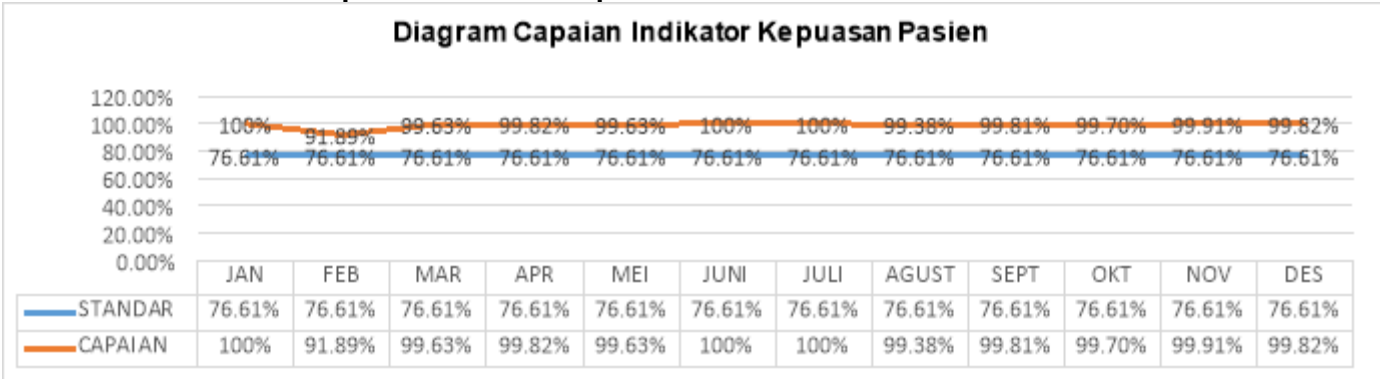
Gambar 3.1.12 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain



Dari grafik indikator waktu tanggap komplain bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait complain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.7 Kepuasan Pasien

Gambar 3.1.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



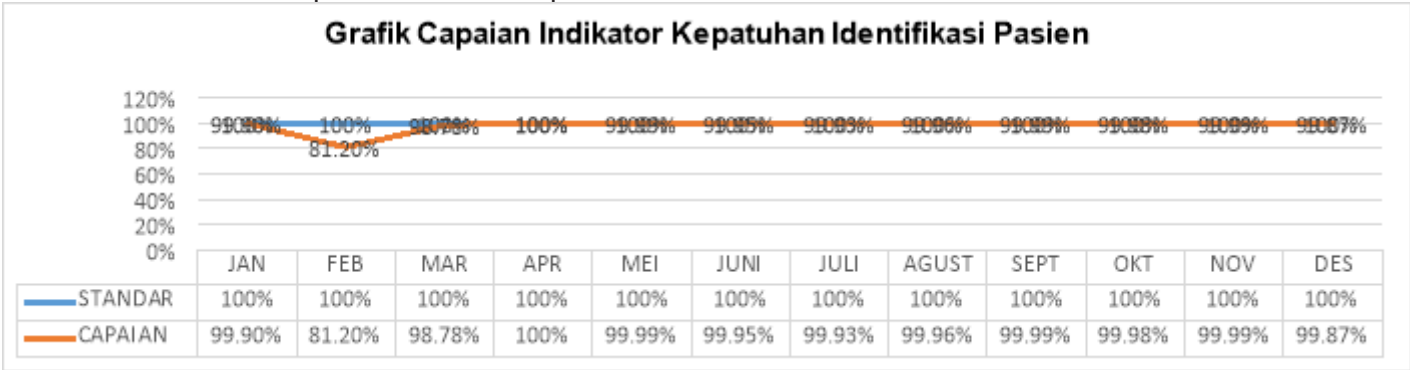
Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.2.1 Mutu Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des'24	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%	99,95%	99,93%	99,96%	99,99%	99,98%	99,99%	99,87%	98,29%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%	85,44%	85,41%	85,45%	85,44%	85,41%	85,45%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%	95,51%	98,64%	98,72%	95,94%	95,92%	98,72%	95,94%	95,92%

3.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

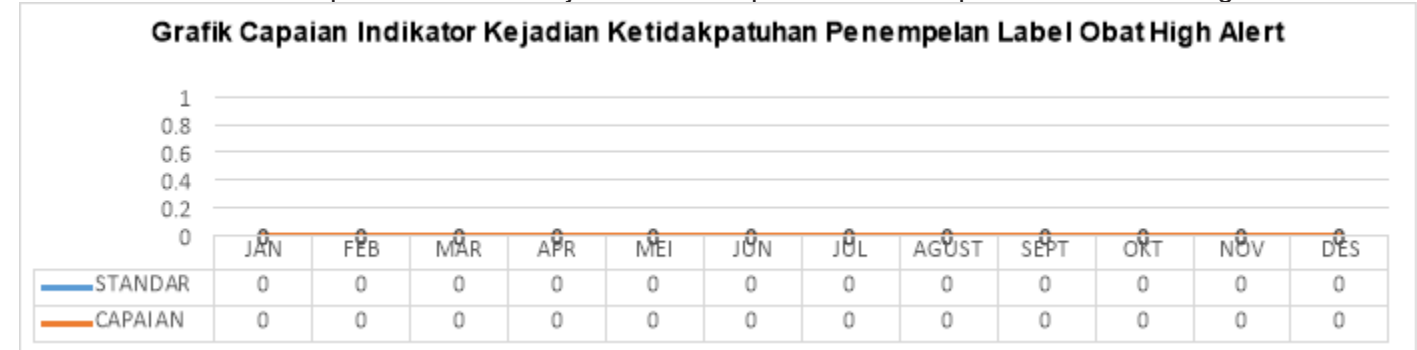


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah

STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan rata rata capaian setiap bulan sebesar 98,29%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu tahun

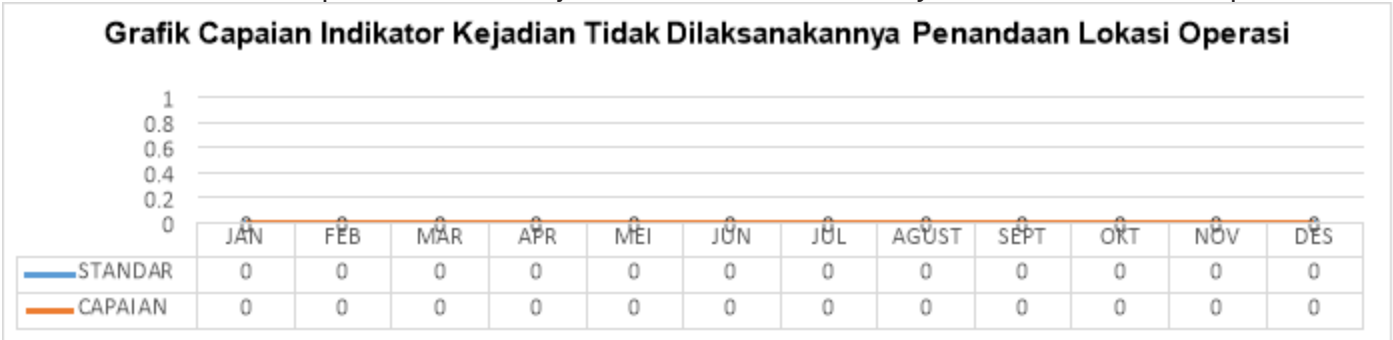
3.2.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert
 Gambar 3.2.2 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Dari grafik indikator kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh perawat instalasi rawat inap dan juga petugas farmasi yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert . Hasil tersebut sesuai dengan hasil supervisi pada unit rawat inap, di semua unit rawat inap tidak ditemukan obat obat haigh alert yang tidak berlabel. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.2.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

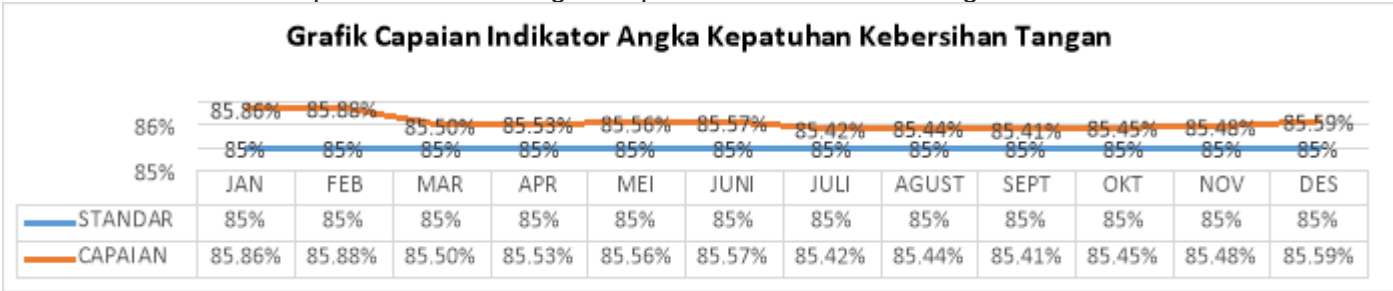
Gambar 3.2.3 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Dari grafik indikator kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh perawat instalasi rawat inap dan juga petugas instalasi kamar operasi yang telah bersinergi untuk selalu melakukan penandaan lokasi operasi dengan baik. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.2.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

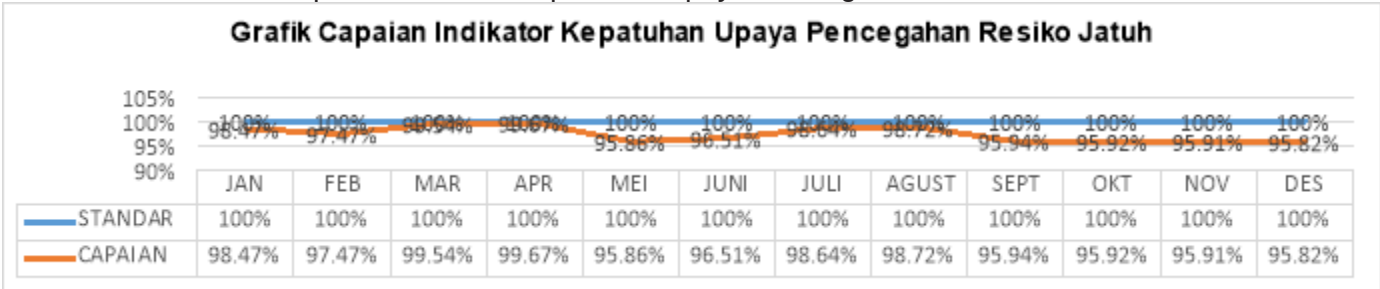
Gambar 3.2.4 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu diatas 85%, hal ini berkat kedisiplinan seluruh karyawan serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan kebersihan tangan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.2.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 3.2.5 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

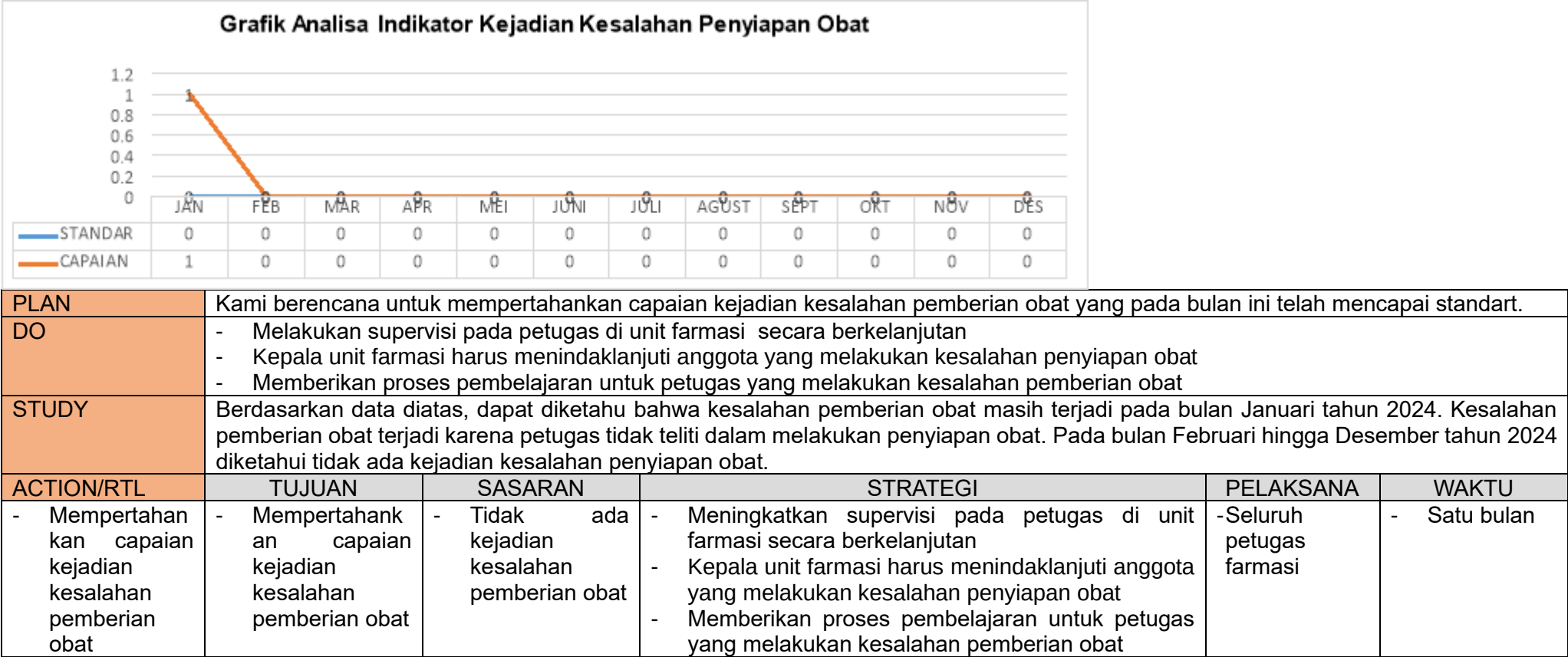
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 belum mencapai standart dengan rata-rata 97,85.% Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	supervisi guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	lasi rawat inap	Satu Tahun

3.5.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%	78,13%	74,88%	71,	72,73%	76,95%	74,36%	70,72%	63,94%	72,83%
4.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%	58,52%	54,92%	50,64%	53,25%	59,94%	50,92%	49,00%	41,86%	52,40%
5.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	1
6.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	2	0,58
9.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,15%

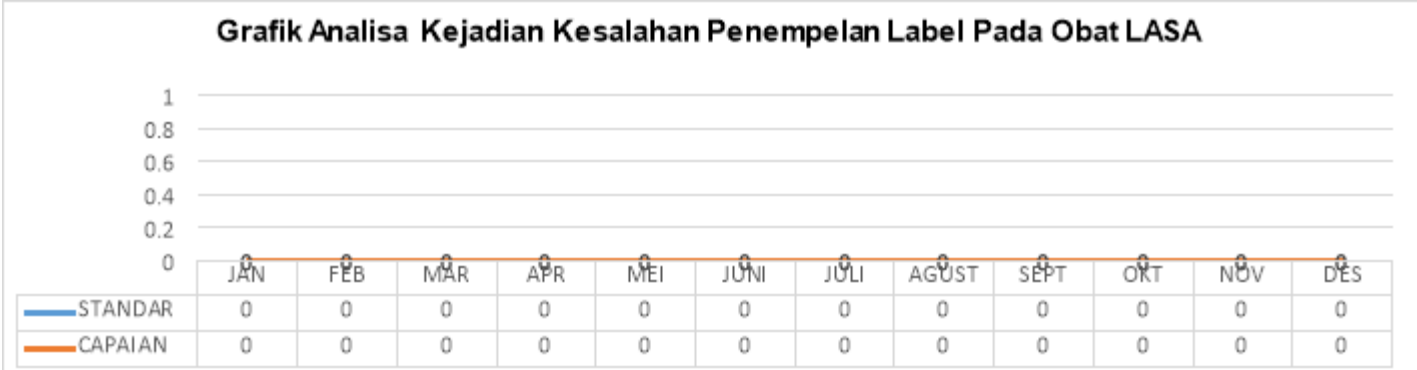
3.3.1 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

Gambar 3.3.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



3.3.2 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

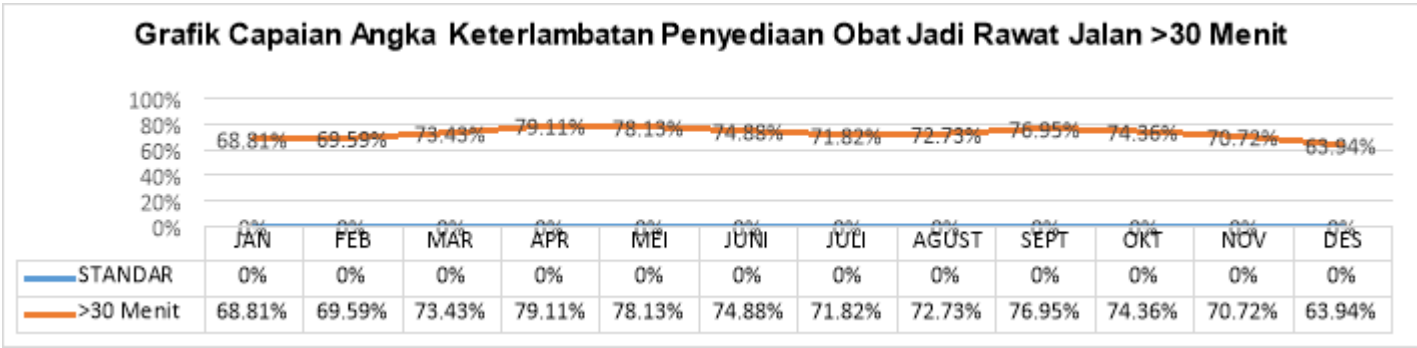
Gambar 3.3.2 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Berdasarkan grafik capaian indikator kejadian penempelan label pada obat LASA pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian telah mencapai standart, ini terjadi berkat kedisiplinan petugas farmasi dalam pengecekan dan penempelan obat LASA. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.3.3 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

Gambar 3.3.3 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	BULAN: Triwulan I
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Penyebab Masalah 1. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 2. Adanya tenaga TTK yang 50% staff orientasi khusus 3. Jumlah SDM belum terpenuhi 4. Terdapat staff yang izin tidak masuk karena kecelakaan 5. Terdapat staff yang sedang cuti melahirkan 6.	
Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi	
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	

2. Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan
3. Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan yang tinggi

Do

LEMBAR KERJA PDSA

TOPIK:
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi $\leq$ 30 menit

BULAN:
Triwulan II

UNIT KERJA:
Instalasi Farmasi

MENGETAHUI
Kepala Instalasi Farmasi

PLAN

Latar Belakang

Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai.

Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.

Rumusan Masalah

1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat
2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Penyebab Masalah

1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir
2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual
3. Proses ambil obat pasien di Tablet masih sering eror

Tujuan Perbaikan					
1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi					
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah					
1. Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu 2. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk					
Do					
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024	
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V			
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	
Study					
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke II ini yakni 77,37% PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem					

OUT PUT

1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 42 menit.

Action					
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024	
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V			
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk	V	V	V	
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	



Jl. Gunung Anyar Harapan Blok ZD No.31
Surabaya – Jawa Timur
delapanberuangmadu@gmail.com; official@beetu.id

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT DELAPAN BERUANG MADU
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN ANTAR OBAT**

No. Beetu : 007/PKS/VI/RS/PTDPM/MLG/24-25
Nomor RS : 197/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu dua Puluh Empat (12/06/2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **PT Delapan Beruang Madu**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia No PB - UMKU : 250122005849600020001 beralamat di Jl Gunung Anyar Blok ZD no.31, kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Gumewa Udiantoro**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama PT Delapan Beruang Madu, selanjutnya disebut sebagai "**BEETU**"; dan
2. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut "**FASYANKES**".

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	BULAN: Triwulan III
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus 5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.	
Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi	

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah				
1. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu 2. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi				
Do				
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V
Study				
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke III ini yakni 73,83% PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan system OUT PUT 1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.				
Action				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		September	Oktober	November
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan	V		

	obat terutama untuk resep rawat jalan				
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi $\leq$ 30 menit	BULAN: Triwulan IV
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
a. Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.	
b. Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
c. Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus 5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.	

d. Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi			
e. Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu 2. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi			
Do			
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan	
		Desember 2024	Januari 2025
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V
Study			
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).			
INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke IV ini yakni 69,67%			
PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem			

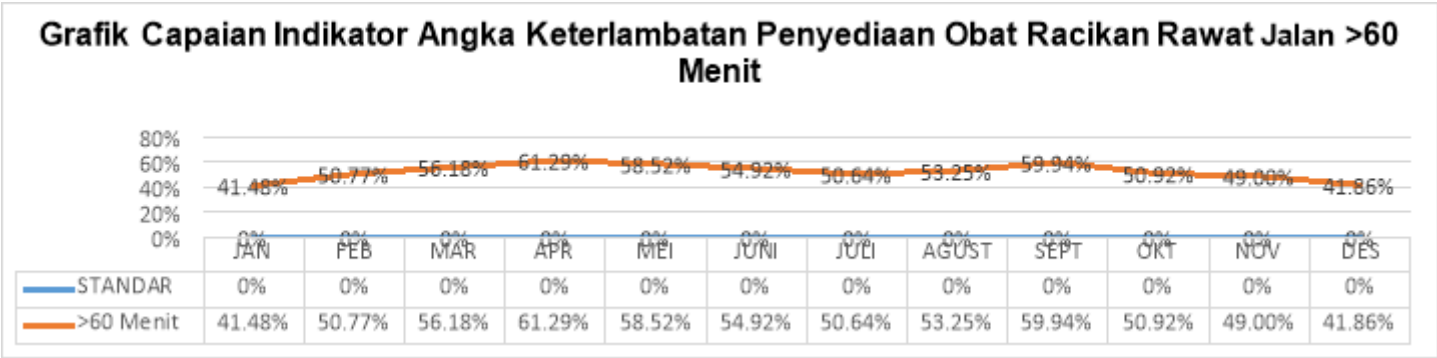
OUT PUT

1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.

Action			
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V

3.3.4 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

Gambar 3.3.4 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan I
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.	

Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes No 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit				
Penyebab Masalah 1. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 2. Adanya tenaga TTK yang 50% staff orientasi khusus 3. Jumlah SDM belum terpenuhi 4. Terdapat staff yang izin tidak masuk karena kecelakaan 5. Terdapat staff yang sedang cuti melahirkan				
Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi				
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian 2. Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan yang tinggi				
Do				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V		
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V		
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).				
INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100%				

3. Rata – Rata Waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke I ini yakni 49,47% PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. OUT PUT 1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 37 menit.

Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024		
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V			Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	v			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	v	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan II
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	

Latar Belakang

Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.

Rumusan Masalah

- Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat
- Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Penyebab Masalah

- Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir
- Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual
- Proses ambil obat pasien di Tablet masih sering eror

Tujuan Perbaikan

- Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan
- Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

- Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu
- Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk

Do

No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V		
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V

Study

Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).

INPUT

1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang . Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata-Rata waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke II ini yakni 58,24% PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem OUT PUT 1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 11 menit.	
Action	



Jl. Gunung Anyar Harapan Blok ZD No.31
Surabaya – Jawa Timur
delapanberuangmadu@gmail.com; official@beetu.id

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT DELAPAN BERUANG MADU
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN ANTAR OBAT**

No. Beetu : 007/PKS/VI/RS/PTDPM/MLG/24-25
Nomor RS : 197/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu dua Puluh Empat (12/06/2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **PT Delapan Beruang Madu**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia No PB - UMKU : 250122005849600020001 beralamat di Jl Gunung Anyar Blok ZD no.31, kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Gumewa Udiantoro**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama PT Delapan Beruang Madu, selanjutnya disebut sebagai "**BEETU**", dan
2. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut "**FASYANKES**".

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan III
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus 5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.	
Tujuan Perbaikan Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi	
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu 2. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	

3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi				
Do				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		September	Oktober	November
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V
Study				
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT 4. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60menit 5. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat racikan ini adalah 100% 6. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan obat racikan selama triwulan ke III ini yakni 54,61% PROSES 4. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 5. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. 6. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan system OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.				

Action**LEMBAR KERJA PDSA**

TOPIK:
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan $\leq$ 60 menit

BULAN:
Triwulan IV

UNIT KERJA:
Instalasi Farmasi

MENGETAHUI
Kepala Instalasi Farmasi

PLAN**b. Latar Belakang**

Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai.

Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.

c. Rumusan Masalah

1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat
2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

e. Penyebab Masalah

1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir
2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual
3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani
4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus
5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.

f. Tujuan Perbaikan

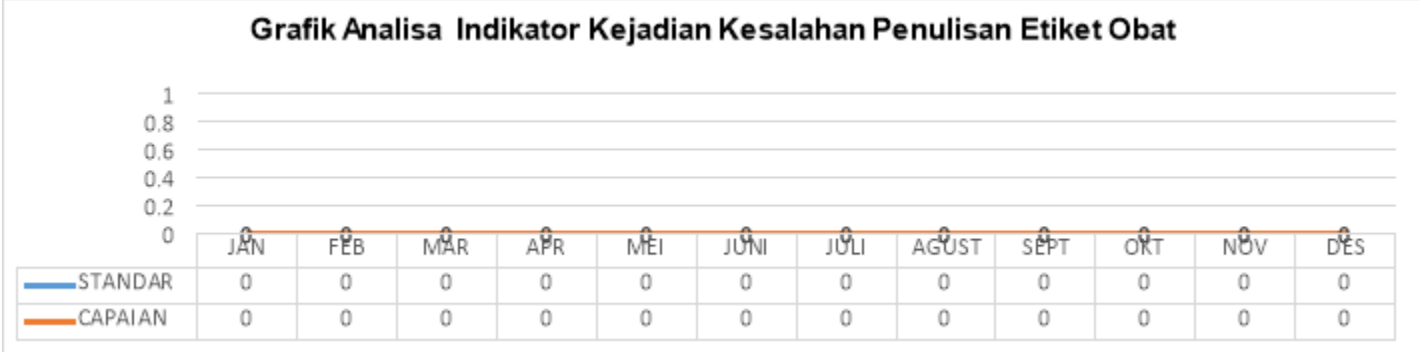
1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan
2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi

f. Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah			
4. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu 5. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 6. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi			
Do			
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan	
		Desember 2024	Januari 2025
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V
Study			
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).			
INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke IV ini yakni 47,26%			
PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem			
OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.			

Action				
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan			
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	

3.3.5 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

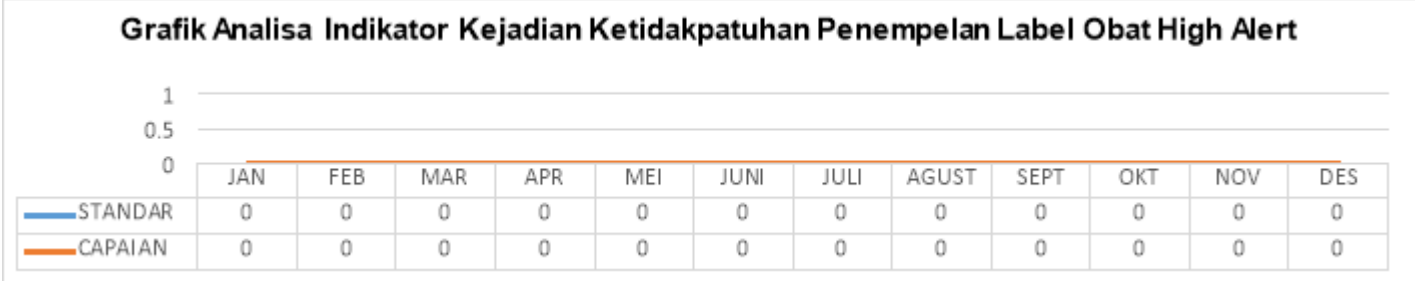
Gambar 3.3.5 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Berdasarkan grafik capaian indikator kejadian penempelan label pada obat LASA pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian telah mencapai standart, ini terjadi berkat kedisiplinan petugas farmasi dalam pengecekan dan penempelan obat LASA. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025

3.3.6 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

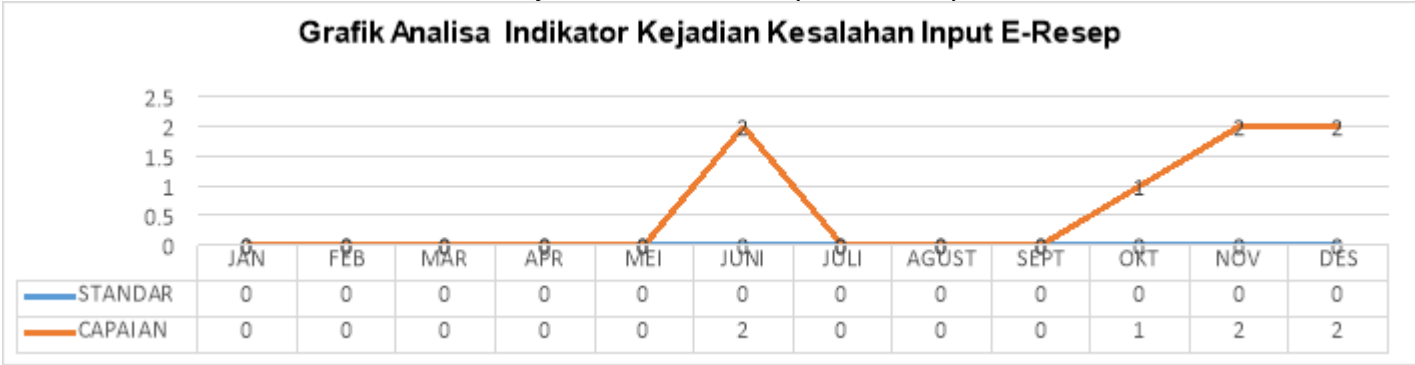
Gambar 3.3.6 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Berdasarkan grafik capaian indikator kejadian penempempelan obat high alert pada bulan Januari – Desember Tahun 2024 capaian telah mencapai standart, ini terjadi berkat kedisiplinan petugas farmasi dalam pengecekan dan penempelan obat high alert. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.3.7 Kejadian Kesalahan input e-resep

Gambar 3.3.7 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep

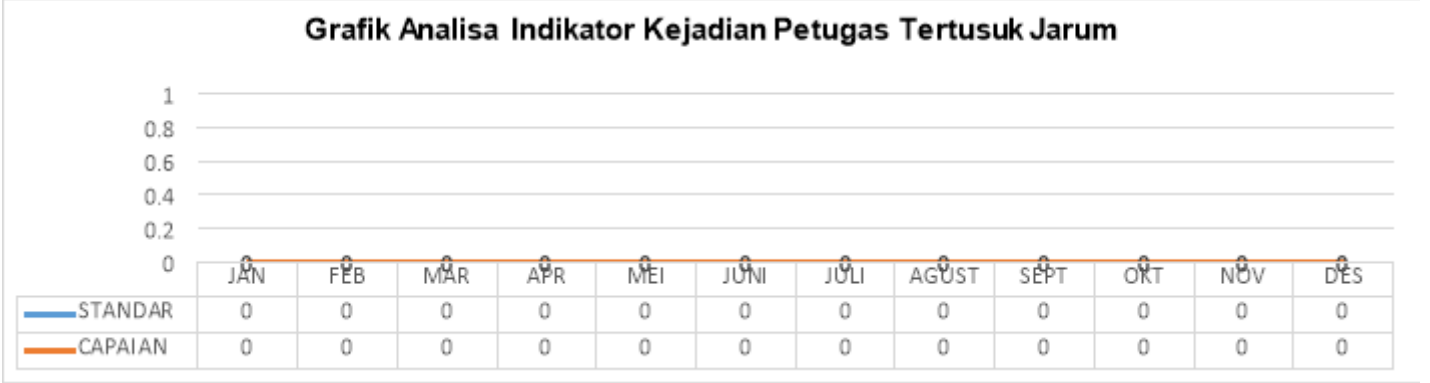


Analisis : Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa terdapat kejadian kesaalahan input e-resep pada bulan Juni, Oktober hingga Desember. Kejadian kesalahan input e-resep disebabkan karena DPJP seringkali menyalin resep pasien dari kunjungan sebelumnya.

PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kejadian kesalahan input e-resep hingga mencapai standart yaitu 0 kejadian					
DO	- Meningkatkan ketelitian ketika menginput e-resep - Perawat poli membantu melakukan pengkajian sehingga dapat mengingatkan DPJP ketika memberikan obat					
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa terdapat kejadian kesaalahan input e-resep pada bulan Juni, Oktober hingga Desember. Kejadian kesalahan input e-resep disebabkan karena DPJP seringkali menyalin resep pasien dari kunjungan sebelumnya.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU
- Mengurangi angka kejadian kesalahan input e-resep	- Mengurangi angka kejadian kesalahan input e-resep	- Tidak ada kejadian kesalahan input e-resep	- Meningkatkan ketelitian ketika menginput e-resep - Perawat poli membantu melakukan pengkajian sehingga dapat mengingatkan DPJP ketika memberikan obat		-DPJP	- Satu bulan

3.3.8 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

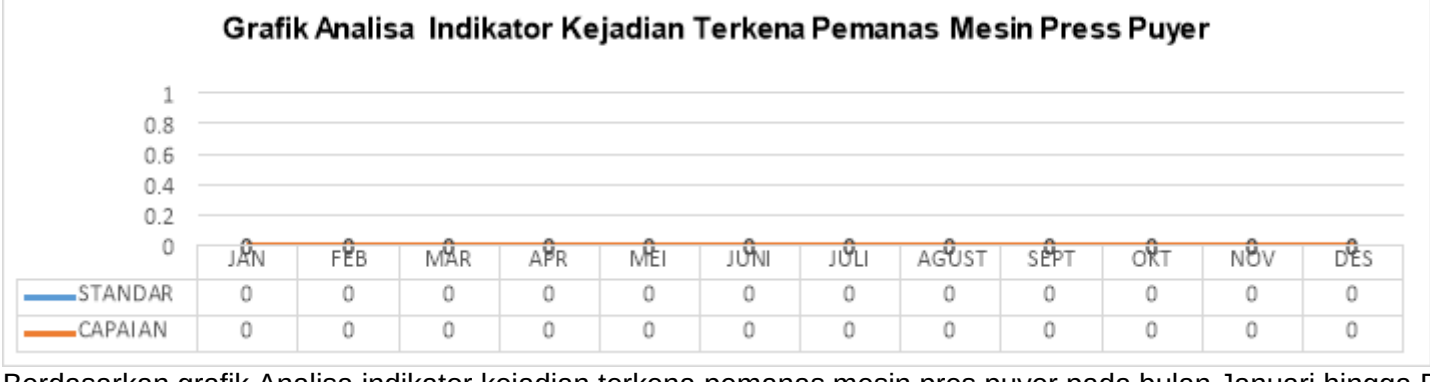
Gambar 3.3.8 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



Berdasarkan grafik analisa indikator kejadian petugas tertusuk jarum pada bulan Januari hingga Desember tahun 2024 telah mencapai standart. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.3.9 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

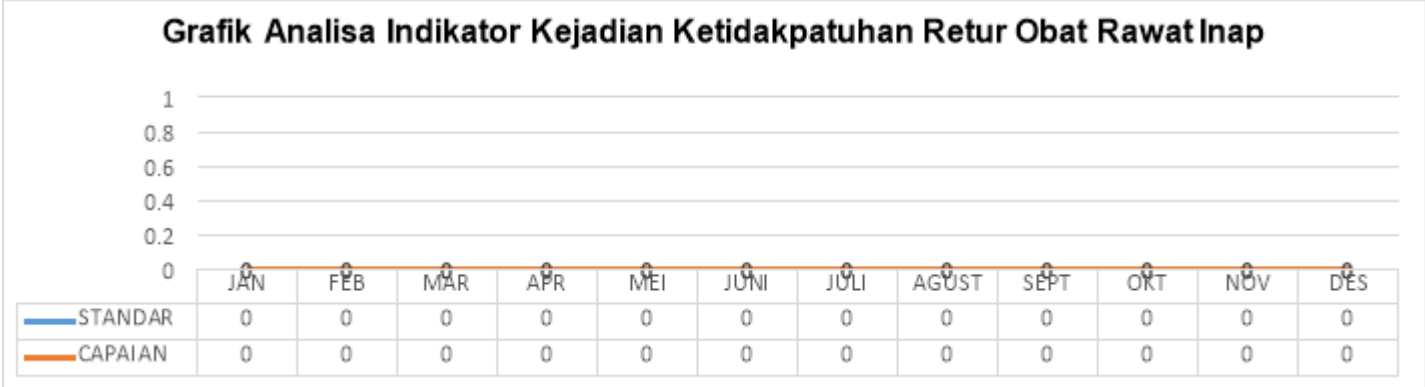
Gambar 3.3.9 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Berdasarkan grafik Analisa indikator kejadian terkena pemanas mesin pres puyer pada bulan Januari hingga Desember tahun 2024 telah mencapai standart. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.3.10 Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

Gambar 3.3.10 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

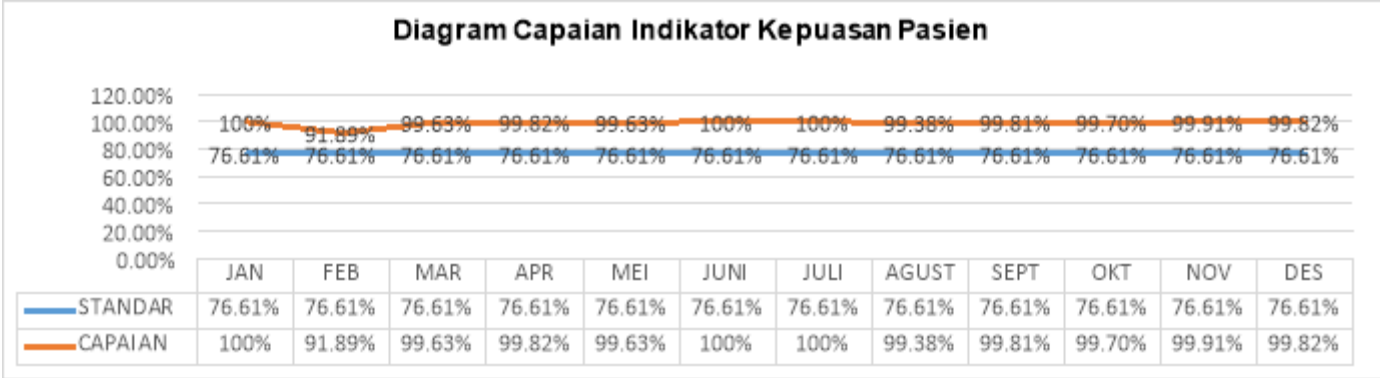


Berdasarkan grafik analisa indikator kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap pada bulan Januari hingga Desember Tahun 2024 telah mencapai standar. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan ditahun 2025.

3.5.2.3 Mutu Terkait Tujuan Strategis Rumah Sakit

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%	100%	100%	99,38%	99,81%	99,7%	99,91%	99,82%	99,13%

Gambar 3.4.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



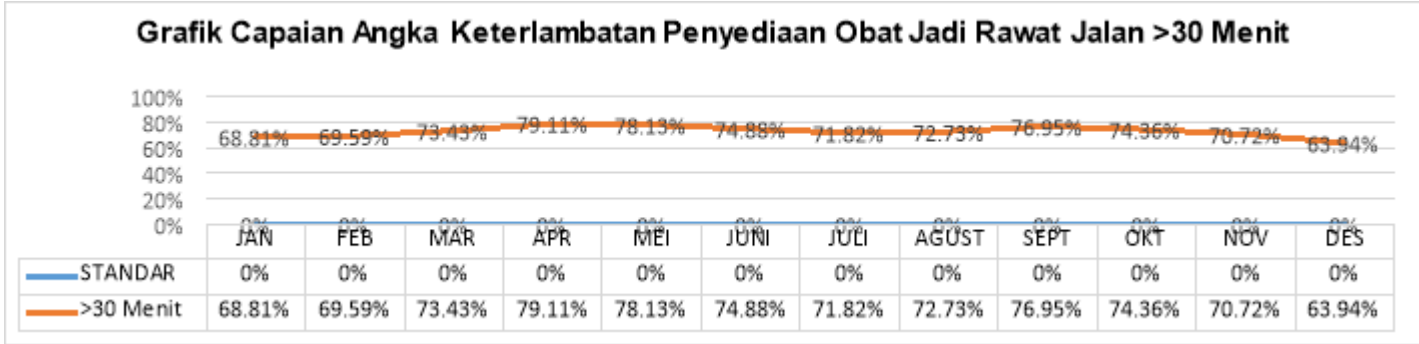
Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari – Desember tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.2.4 Mutu terkait Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%	78,13%	74,88%	71,	72,73%	76,95%	74,36%	70,72%	63,94%	72,83%
2.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%	58,52%	54,92%	50,64%	53,25%	59,94%	50,92%	49,00%	41,86%	52,40%

3.5.1 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

Gambar 3.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi $\leq$ 30 menit	BULAN: Triwulan I
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Penyebab Masalah 1. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 2. Adanya tenaga TTK yang 50% staff orientasi khusus 3. Jumlah SDM belum terpenuhi 4. Terdapat staff yang izin tidak masuk karena kecelakaan 5. Terdapat staff yang sedang cuti melahirkan	

Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi				
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian 2. Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan yang tinggi				
Do				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V		
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V		
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V
Study				
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).				
INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata rata waktu tunggu obat jadi <30 menit jadi pada Triwulan 1 adalah 70,61% 4. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 5. PIC memastikan pada saat waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep.				

OUT PUT

1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 50 menit.

Action

No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024		
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V			Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	v			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	v	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	

LEMBAR KERJA PDSA**TOPIK:**

Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi $\leq$ 30 menit

BULAN:

Triwulan II

UNIT KERJA:

Instalasi Farmasi

MENGETAHUI

Kepala Instalasi Farmasi

PLAN

Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.				
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit				
Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Proses ambil obat pasien di Tablet masih sering eror				
Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi				
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu 2. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk				
Do				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V		
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V

3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V
Study				
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).				
INPUT				
1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit				
2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100%				
3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke II ini yakni 77,37%				
PROSES				
1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien.				
2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep.				
3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem				
OUT PUT				
1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 42 menit.				
Action				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V		
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk	V	V	V

3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt
----	--	---	---	---	--



Jl. Gunung Anyar Harapan Blok ZD No.31
Surabaya – Jawa Timur
delapanberuangmadu@gmail.com; official@beetu.id

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT DELAPAN BERUANG MADU
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN ANTAR OBAT**

No. Beetu : 007/PKS/VI/RS/PTDPM/MLG/24-25
Nomor RS : 197/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu dua Puluh Empat (12/06/2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **PT Delapan Beruang Madu**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia No PB - UMKU : 250122005849600020001 beralamat di Jl Gunung Anyar Blok ZD no.31, kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Gumewa Udiantoro**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama PT Delapan Beruang Madu, selanjutnya disebut sebagai "**BEETU**"; dan
2. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut "**FASYANKES**".

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	BULAN: Triwulan III
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus 5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.	
Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi	

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah				
1. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beutu 2. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi				
Do				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		September	Oktober	November
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beutu	V	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V
Study				
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke III ini yakni 73,83% PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan system OUT PUT 1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.				

Action					
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab
		September	Oktober	November	
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan bea	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	BULAN: Triwulan IV
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
c. Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.	

d. Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit			
g. Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus 5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.			
h. Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi			
g. Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu 2. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi			
Do			
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan	
		Desember 2024	Januari 2025
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V
Study			
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).			

INPUT

- 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit
- 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100%
- 3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke IV ini yakni 69,67%

PROSES

- 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien.
- 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep.
- 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem

OUT PUT

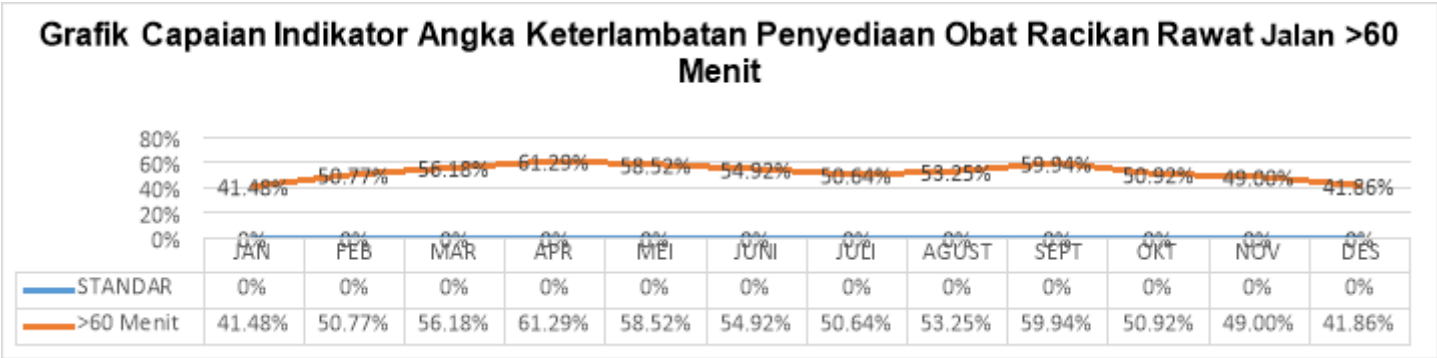
- 1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.

Action			
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan	
		Desember 2024	Januari 2025
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V

Penanggung jawab

3.5.2 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

Gambar 3.5.2 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan I
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes No 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Penyebab Masalah 1. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 2. Adanya tenaga TTK yang 50% staff orientasi khusus 3. Jumlah SDM belum terpenuhi 4. Terdapat staff yang izin tidak masuk karena kecelakaan 5. Terdapat staff yang sedang cuti melahirkan	

Tujuan Perbaikan

1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan
2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi

Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

1. Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian
2. Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan
3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan yang tinggi

Do

No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V		
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V		
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V

Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).

INPUT

1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60 menit
2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100%
3. Rata – Rata Waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke I ini yakni 49,47%

PROSES

1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien.

2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep.						
OUT PUT						
1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 37 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Maret 2024	April 2024	Mei 2024		
1.	Mengajukan perhitungan beban kerja kembali untuk memenuhi pelayanan kefarmasian	V			Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	v			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.	
3.	Plot jadwal dilakukan se efisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	v	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan II
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak boleh lebih dari 30 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	

Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Proses ambil obat pasien di Tablet masih sering eror				
Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi				
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu 2. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk				
Do				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V		
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V
Study				
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).				
INPUT 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang . Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100% 3. Rata-Rata waktu tunggu Pelayanan Obat Racikan selama triwulan ke II ini yakni 58,24%				
PROSES 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep.				

3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem OUT PUT 1. Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 1 jam 11 menit.						
Action						
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab	Kendala
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024		
1.	Membuat kerja sama jasa antar obat yakni Beetu	V			Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS	
2.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar beetu untuk	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	
3.	Meminta bantuan IT-SIMRS saat terkendala Tablet yang error	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt	



Jl. Gunung Anyar Harapan Blok ZD No.31
Surabaya – Jawa Timur
delapanberuangmadu@gmail.com; official@beetu.id

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT DELAPAN BERUANG MADU
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PELAYANAN ANTAR OBAT**

No. Beetu : 007/PKS/VI/RS/PTDPM/MLG/24-25
Nomor RS : 197/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu dua Puluh Empat (12/06/2024), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **PT Delapan Beruang Madu**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia No PB - UMKU : 250122005849600020001 beralamat di Jl Gunung Anyar Blok ZD no.31, kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Gumewa Udiantoro**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama PT Delapan Beruang Madu, selanjutnya disebut sebagai "**BEETU**", dan
2. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - a. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut "**FASYANKES**".

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan III
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.	
Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus 5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.	
Tujuan Perbaikan Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi	
Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu 2. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	

Do				
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan		
		September	Oktober	November
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V
Study				
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan). INPUT - Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60menit - Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat racikan ini adalah 100% - Rata-rata waktu tunggu Pelayanan obat racikan selama triwulan ke III ini yakni 54,61% PROSES - PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien. - PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep. - PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan system OUT PUT Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.				

Action					
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan			Penanggung jawab
		September	Oktober	November	
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan	V			Novia Ainur Pratiwi, S.KM.
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V	V	Ramadhan Rizki Putranto, S. Farm., Apt

LEMBAR KERJA PDSA	
TOPIK: Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit	BULAN: Triwulan IV
UNIT KERJA: Instalasi Farmasi	MENGETAHUI Kepala Instalasi Farmasi
PLAN	
a. Latar Belakang Dalam pelayanan kefarmasian terdapat dispensing sediaan farmasi di rawat jalan dan rawat inap. Untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di instalasi Farmasi dan juga efektifitas terapi dimana bisa dikatakan semakin cepat pelayanan obat di suatu Instalasi Farmasi maka terapi obat yang diharapkan akan segera tercapai. Sehingga dalam pelayanan kefarmasian dalam peraturan perundang-undangan diatur untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak boleh lebih dari 60 menit.	

b. Rumusan Masalah 1. Apakah sudah memenuhi syarat Standar Minimal Pelayanan di Rumah sakit dalam pelayanan obat 2. Apakah Waktu tunggu pelayanan obat sudah memenuhi standar Permenkes no 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit			
c. Penyebab Masalah 1. Terdapat beberapa DPJP yang sedang melakukan pelayanan poli bersamaan dan peresepan menumpuk di Farmasi di bagian akhir-akhir 2. Proses penulisan daftar Obat di KPO (kartu pengambilan Obat) masih tulis tangan manual 3. Beban kerja yang terlalu banyak dimana ketidakseimbangan staff dengan resep yang ditangani 4. Adanya tenaga TTK yang staff orientasi khusus 5. Jumlah SDM belum terpenuhi, karena ada yang resign.			
d. Tujuan Perbaikan 1. Tercapainya standar minimal untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan 2. Meminimalisir complain dari pasien mengenai waktu tunggu pelayanan obat di Instalasi Farmasi			
e. Rencana Solusi/ Kegiatan Perbaikan Yang Akan Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah 1. Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu 2. Mengajukan penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan 3. Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi			
Do			
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan	
		Desember 2024	Januari 2025
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V
Study			
Lakukan Analisis Data; Apa yang dipelajari? Apakah Data Menunjukkan Proses Perbaikan? Apakah Masih Diperlukan Perubahan/Perbaikan (Lampirkan grafik capaian perbaikan).			

INPUT

- 1. Standar Pelayanan Farmasi untuk waktu tunggu pelayanan obat yang dibuat di Instalasi Farmasi RS Prima Husada Malang. Untuk waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari 60 menit
- 2. Standar pelayanan dari Indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi ini adalah 100%
- 3. Rata-rata waktu tunggu Pelayanan Obat Jadi selama triwulan ke IV ini yakni 47,26%

PROSES

- 1. PIC memantau staf farmasi untuk memastikan menekan tombol “Pelayanan Selesai” yang menandakan bahwa resep yang disiapkan sudah selesai diberikan kepada pasien.
- 2. PIC memastikan pada saat waktu waktu injuri time staf farmasi yang melakukan cukup dan tidak ada penumpukan resep.
- 3. PIC ketika tablet sering error memanggil IT untuk perbaikan sistem

OUT PUT

Waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi masih belum memenuhi syarat yakni dengan rata-rata 40 menit.

Action			
No	Pelaksanaan/ Implementasi Kegiatan (Sesuai Rencana Solusi pada Plan)	Rencana Waktu Kegiatan	
		Desember 2024	Januari 2025
1.	Mengarahkan pasien untuk menggunakan jasa antar obat dengan beetu	V	V
2.	Rekrutmen penambahan staff farmasi pada saat pelayanan obat terutama untuk resep rawat jalan		
3.	Plot jadwal dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan jam kebutuhan pelayanan tinggi	V	V

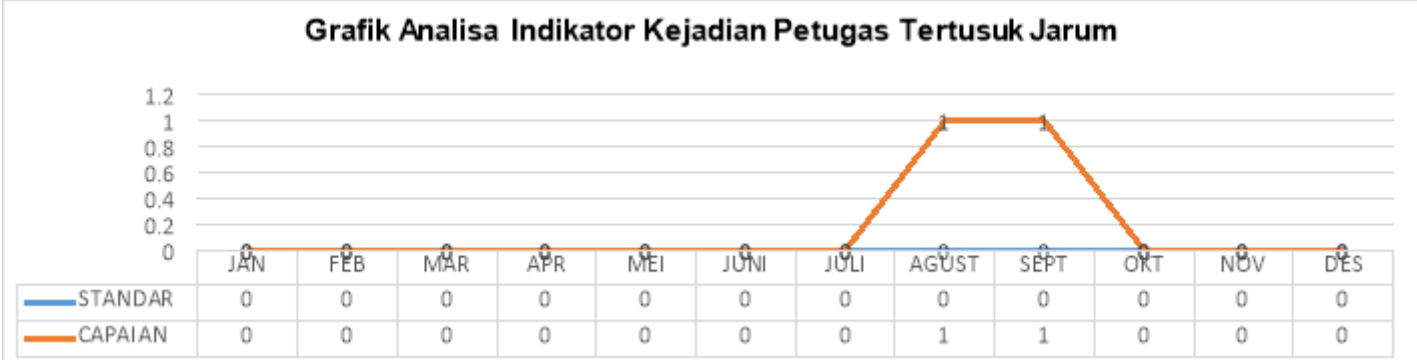
Penanggung jawab

3.5.2.5 Manajemen Resiko

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0,16
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum (Pajanan)

Gambar 3.6.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum (Pajanan)



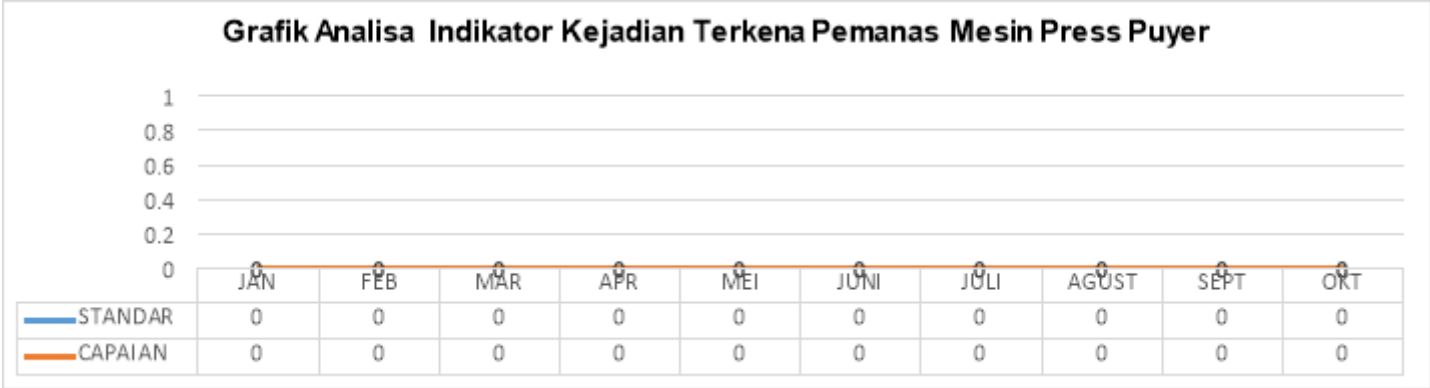
Berdasarkan grafik analisa indikator kejadian petugas tertusuk jarum pada bulan Januari hingga Desember tahun 2024 masih belum mencapai standart karena masih ada kejadian petugas tertusuk Jatum di bulan Agustus dan September, untuk itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	- Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. - Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. - Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. - Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan Agustus terdapat 1 kejadian petugas tertusuk jarum dan pada bulan September terdapat 1 kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	- Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien. - Supervisi petugas terkait pembuangan jarum bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu Tahun
-----------------------------	---	---	---	----------------------------------	------------

3.6.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

Gambar 3.6.2 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Berdasarkan grafik Analisa indikator kejadian terkena pemanas mesin pres puyer pada bulan Januari hingga Desember tahun 2024 telah mencapai standart. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.5.3 Mutu Prioritas Internal Unit

3.5.3.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25%	100%	100%	100%	100%	97,35%	100%	100%	100%	96,69%	100%	99,19%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17%	0%	0,28%	0,15%	0,67%	0,15%	0,29%	5,2%	5,27%	5,87%	0%	1,5%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,08%	91,35%	100%	100%	98.53%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85%	0,61%	0,73%	0,5%	2,61%	1,62%	1,82%	2,82%	1,82%	4,1%	2,13%	1,55%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.1 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%					97,64%	100%	100%						99,21%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%					45,54%	76,92%	90%						70,82%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%					-	-	-						-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%					100%	100%	100%						100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%					0%	0%	0%						0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%						100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%						100%

4.3 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18%	89,4%	91,28%	80,29%	87,79%	91,45%	86,99%	84,21%	82,22%	86,5%	89,87%	83,93%	87,17%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,61%	100%	100%	97,41%	97,12%	100%	99,43%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96%	87,65%	82,43%	83,94%	89,17%	91,45%	93,15%	92,11%	86,67%	87,73%	85,09%	90,7%	80,84%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.4 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84%	78,23%	86,54%	86,84%	89,19 %	95%	95%	92,86%	90,16%	86,36%	85,15%	66,36%	87,21%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,20%	80,81%	94,77%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,85%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,49%	97,60%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.5 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41%	100%	97,22%	100%	100%	100%	100%	100%	94,32%	90,91%	96,63%	81,82%	96,19%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53%	74,84%	73,57%	73,23%	62,6%	62,6%	62,6%	81,55%	66,94%	80,67%	72,89%	72,08%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93%	100%	93,75%	100%	100%	100%	87,5%	95,6%	96,12%	92,86%	96,4%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,03%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,08%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%	97,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,18%	89,9%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	86,36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%

4.6 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	97,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,78%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%	0%	0,39%	0%	0,94%	0,43%	0,42%	0,41%	0%	0,24%

6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.7 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07%	66,86%	64,86%	55,35%	67,48%	67,48%	66,67%	68,42%	75,76%	59,24%	74,87%	77,14%	67,68%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	100%	100%	100%	100%	98,8%	98,51%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%	0%	0%	0%	0%	0,52%	0,52%	0%	0%	0,4%	0,27%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13%	97,75%	93,02%	96,38%	95,58%	95,58%	94,59%	96,33%	95,99%	93,56%	97,38%	96,48%	95,98%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,87%

4.8 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11%	79,63%	84,92%	83,21%	82,79%	76.47%	71,01%	79,69%	77,27%	76,54%	84,09%	85,99%	78,56%

3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,39%	100%	89,52%	100%	97,62%	98,37%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	3,57%	3,85%	0%	0%	0%	1,9%	0,83%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.9 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Sept '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,22%	76,67%	75%	84,56%	76,74%	63,78%	72,73%	72,44%	69,54%	65,79%	91,26%	88,39%	74,59%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,67%	100%	100%	100%	97,12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,48%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	0%	0,9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	86,52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,87%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,25%

4.10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	92,21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,35%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39%	78,49%	81,45%	84,56%	71,76%	75,93%	82,14%	89,23%	90,14%	96,55%	76,92%	67,07%	86,56%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15%	100%	100%	96,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,87%	97,08%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	98,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,90%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.11 ICU

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '23	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Juni '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%	100%	100%	100%	100%	100%	98,5%	100%	100%	94,8%	99,29%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7%	100%	100%	94,4%	98,8%	97,2%	100%	98%	93%	98,34%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%													
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8%	92,53%	86%	90,4%	100%	100%	80%	90,2%	73,7%	85,96%	85,96%	78,7%	87,10%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	83,33%	100%	100%	100%	80%	92,77%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%	90,7%	95,4%	94,4%	100%	100%	100%	100%	94,8%	97,94%

7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,3%	0%	0,10%
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-------

4.12. HCU

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	98,80%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-						
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	96,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,69%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	97,5%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4.13 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75%	100%	95,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,55%	99,58%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74%	52,7%	63.8%	72,8%	80,97%	85,74%	88,65%	82,77%	74,14%	80,22%	%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	73,5%	72,83%	75,54%	79,41%	76,18%	75,36%	77,15%	73,47%	71,37%	58,67%	53,12%	82,5%	%

4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%	37,03%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	%
---	--------------------------------	----	----	----	----	----	--------	----	----	----	----	----	----	----	---

4.14 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,95%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,63%	100%	94,67%	100%	100%	100%	100%	99,44%
6	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0,3
10	Kejadian partus lama	0	1	0	0	0	0	3	4	1	0	1	2	1	1,08
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0	0	0	0	4	5	7	4	7	2,58
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,08
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85%	11,38%	5,77%	15,49%	11,54%	4,85%	7,4%

16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85%	11,38%	5,77%	15,49%	11,54%	4,85%	7,4%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,54%	0%	0%	0,10%

4.15 NICU

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des'24	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92%	90,63%	84,72%	90,8%	84,82%	82,35%	88,79%	81,01%	84,81%	93,75%	78,48%	78,79%	85,40%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,62%
6	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	0%	0%	3,7%	1,28%	4,55%	0%	7,41%	3,57%	2,94%	0%	2,95%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.16 IKO

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Juni '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi > 30 menit	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	8,33%

5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08%	0%	0%	20,3%	20,96%	23,81%	0%	0%	0%	14,66%	8,56%

4.17 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Juni '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48%	97,5%	98,9%	99,68%	100%	98,03%	100%	97,91%	98,22%	99,2%	98,78%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2	2	12	15	11	4	7	8	2	6
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,08

5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
---	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4.18 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agus '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,79%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%	3,81%	3,81%	1,63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,6%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08

4.19 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agus '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0,75
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0,25

4.20 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%	78,13%	75,45%	71,82%	71,82%	76,95%	74,36%	71,13%	63,95%	72,83%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%	58,52%	54,92%	50,64%	50,64%	59,94%	50,92%	49,00%	41,84%	52,40%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	1
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	2	0,58
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.21 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,15%

4.22 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %	0,24 %	0 %	0,25 %	0,52%	0,54%	0,25%	0,28%	0,3%	0,30%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	1,27‰	0‰	0,10‰

4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 ‰	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%	0,15%	0,15%	0,04%	0,15%	0,08%	0,11%	0,03%	1,18%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53 ‰	85,62%	85,62%	85,42%	85,44%	85,41%	85,45%	85,48%	85,59%	85,56%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%	93,73%	93,73%	93,92%	93,24%	92,15%	92,21%	92,77%	92,94%	93,13%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%	92,19%	92,18%	92,07%	91,94%	91,99%	91,6%	92,58%	92,10%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0,25

4.23 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,42%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%	99,63%	99,63%	99,38%	99,81%	99,38%	99,91%	99,82%	99,04%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94%	75,31%	57,76%	52,92%	55,36%	55,36%	43,54%	38,63%	44,13%	36,01%	27,91%	22,66%	49,71%

4.24 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99%	98,97%	99,14%	98,76%	95,9%	98,93%	98,96%	99,62%	98,66%	98,61%	98,64%	98,93%	90,37%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%	4,12%	5,09%	3,88%	3,48%	3,48%	3,54%	5,69%	1,66%	4,73%

4.25 Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65%	93,04%	94,08%	93,81%	93,56%	92,8%	91,52%	91,6%	92,43%	91,19 %	93,06%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06%	9,44%	7,88%	5,68%	4,56%	5,91%	8,35%	7,07%	7,16%	8,25%	74%

4.26 Keuangan

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Des '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim	0%	7,7%	6%	3,86%	10,98%	1,57%	0,78%	0,81%	1,1%	0,9%	0,54%	0,76%	0,51%	3,02%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4.27 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu'24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des'24	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08

4.28 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04%	0,78%	0,97%	0,87%	0,62%	0,89%	0,26%	0,26%	0,45%	3,14%	5,79%	1,35%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04%	2,17%	1,66%	2,55%	1,66%	1,31%	2,21%	2,21%	1,71%	2,04%	2,32%	1,9%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57%	0,44%	0,42%	0,47%	0,46%	0,55%	0,26%	0,26%	2,01%	0,29%	0,9%	1,36%
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0,41

4.29 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%	89,47%	91,67%	91,67%	91,84%	100%	100%	100%	100%	100%	87,05%

4.30 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3	6	6	2	2	3	2	7	8	4,41

2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2	4	5	9	6	1	4	4	8	5,25
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

4.31 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	0,25%	1,67%	29,17%	28,95%	91,67%	3,45%	8,7%	18,75%	0%	0%	8,77%	8,25%	16,63%

4.32 KESEKRETARIATAN

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21%	0%	20,69%	78,38%	48,72%	26,67%	36,59%	42,5%	40%	29,27%	55,32%	48,98%	38,44%
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5%	71,83%	56,25%	41,67%	0%	68,75%	31,25%	30,77%	28,57%	21,43%	44,83%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71%	86,21%	22,73%	17,86%	0%	12,82%	33,33%	28%	39,39%	22,86%	32,41%

4.33 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95%	4,19%	1,35%	1,48%	0,96%	2,42%	2,29%	4,5%	2,25%	2,32%	2,4%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.34 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agu '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	3	1	1	1,08

4.35 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '24	Feb '24	Mar '34	Apr '24	Mei '24	Juni '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	100%	99,17%	90,88%	100%	100%	100%	98,65%	99,64%	99,8%	100%	99,4%	99,84%	99,71%	98,92%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	100%	93,71	100%	92,82%	92,82%	91,73%	87,44%	94,21%	92,72%	90,69%	93,3%	92,77%	93,11%	92,94%

4.36 IT

No	Judul	Standart	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Jul '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Respontime penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,74%

4.37 Kamar Jenazah

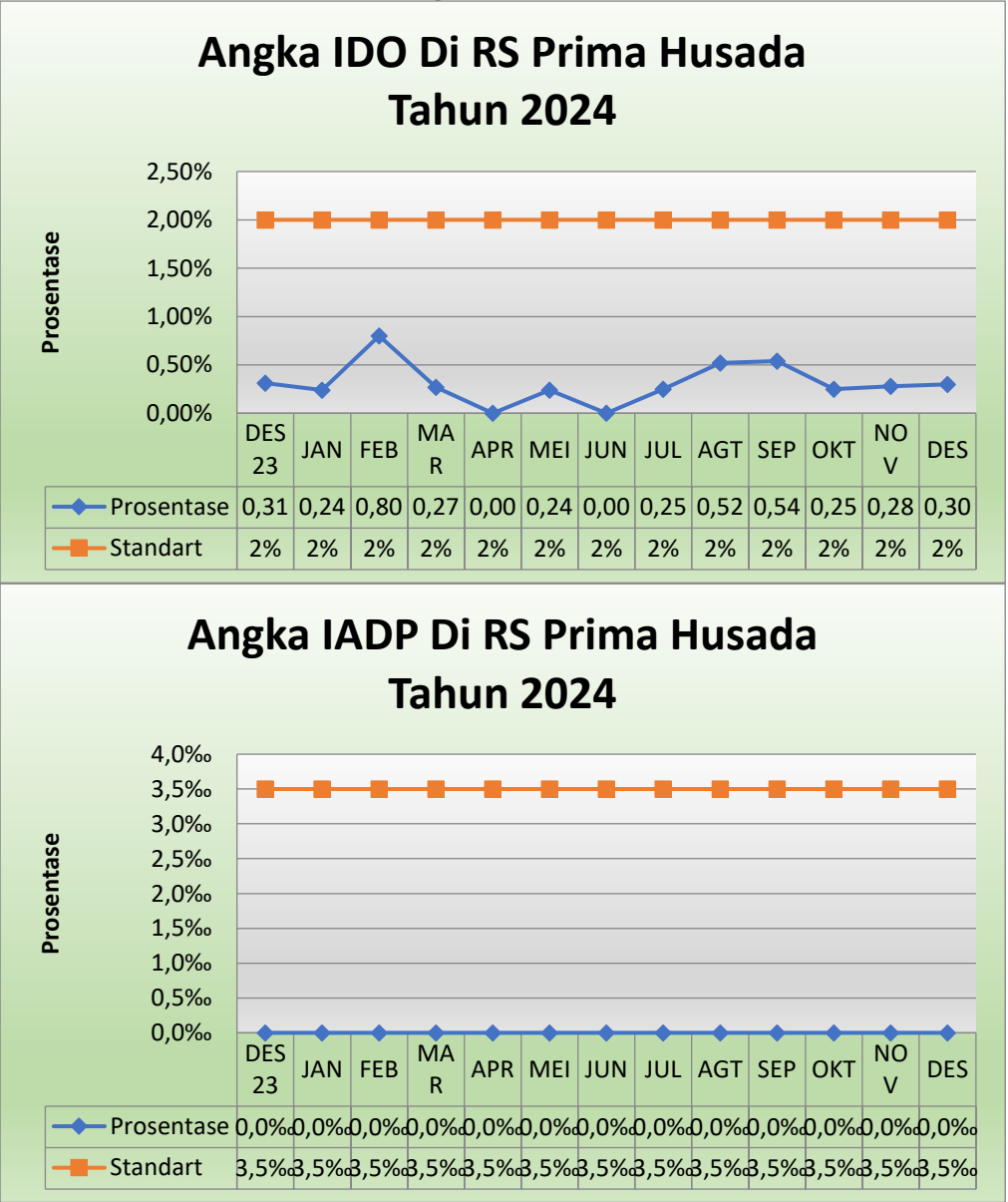
No	Judul	Standart	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sept '24	Okt '24	Nov '24	Des '24	Rata-Rata
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.6 Kinerja Produktifitas Komite PPI

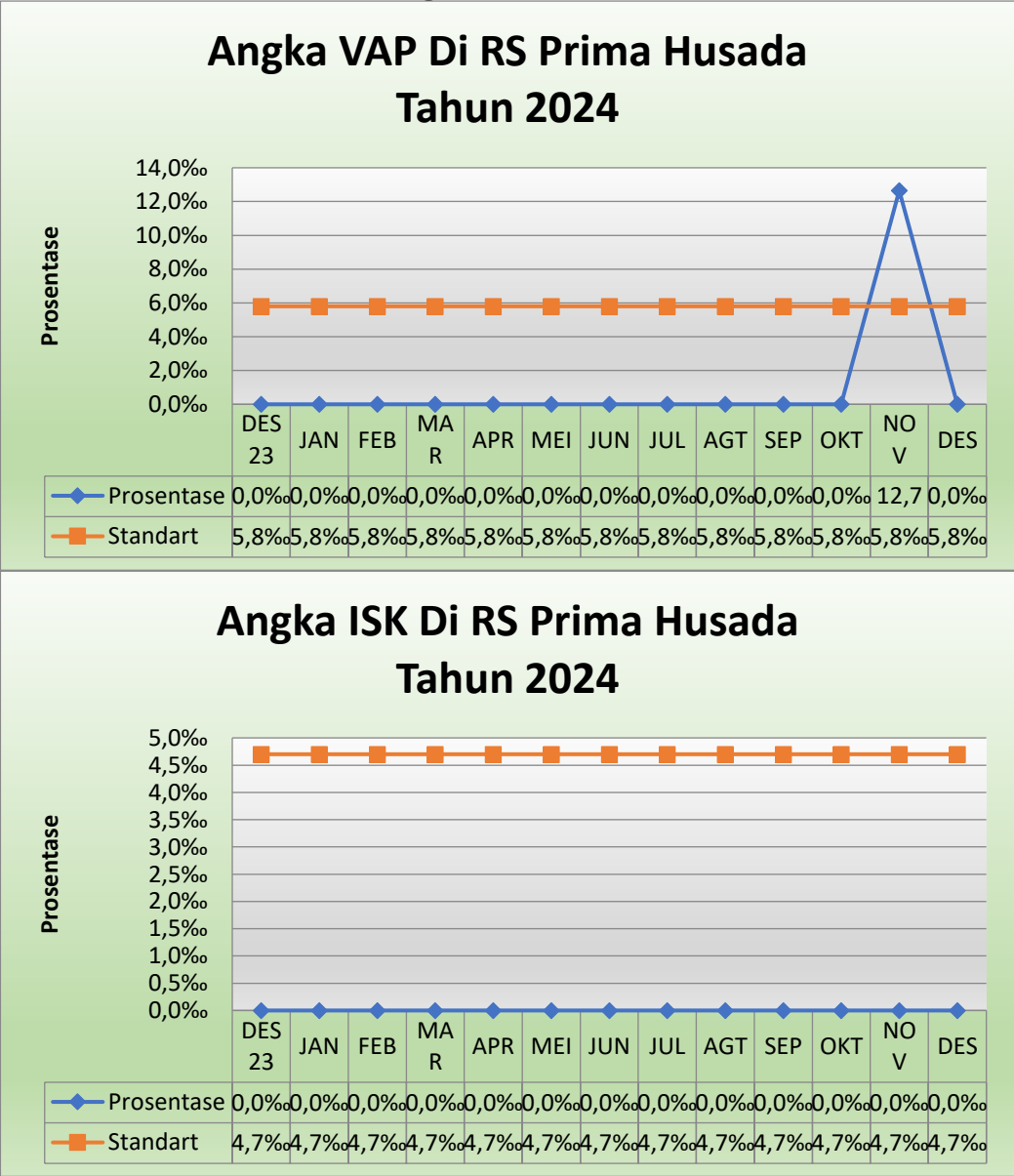
3.3.2.1 Tabel Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI dan Mutu PPI bulan Januari – Desember 2024

Jenis HAI's & Mutu PPI	Standart Nasional	Rate Infeksi % atau ‰ (Tahun 2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0%	0,24%	0%	0,25%	0,52%	0,54%	0,25%	0,28%	0,3%
IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	12,65‰	0‰
ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%	0,15%	0,15%	0,04%	0,15%	0,08%	0,11%	0,03%
Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,50%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%	85,44%	85,41%	85,45%	85,48%	85,59%
Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,30%	93,52%	93,73%	93,8%	93,92%	93,24%	92,15%	92,21%	92,77%	92,94%
Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%	92,21%	92,18%	92,07%	91,94%	91,99%	91,60%	92,58%
Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

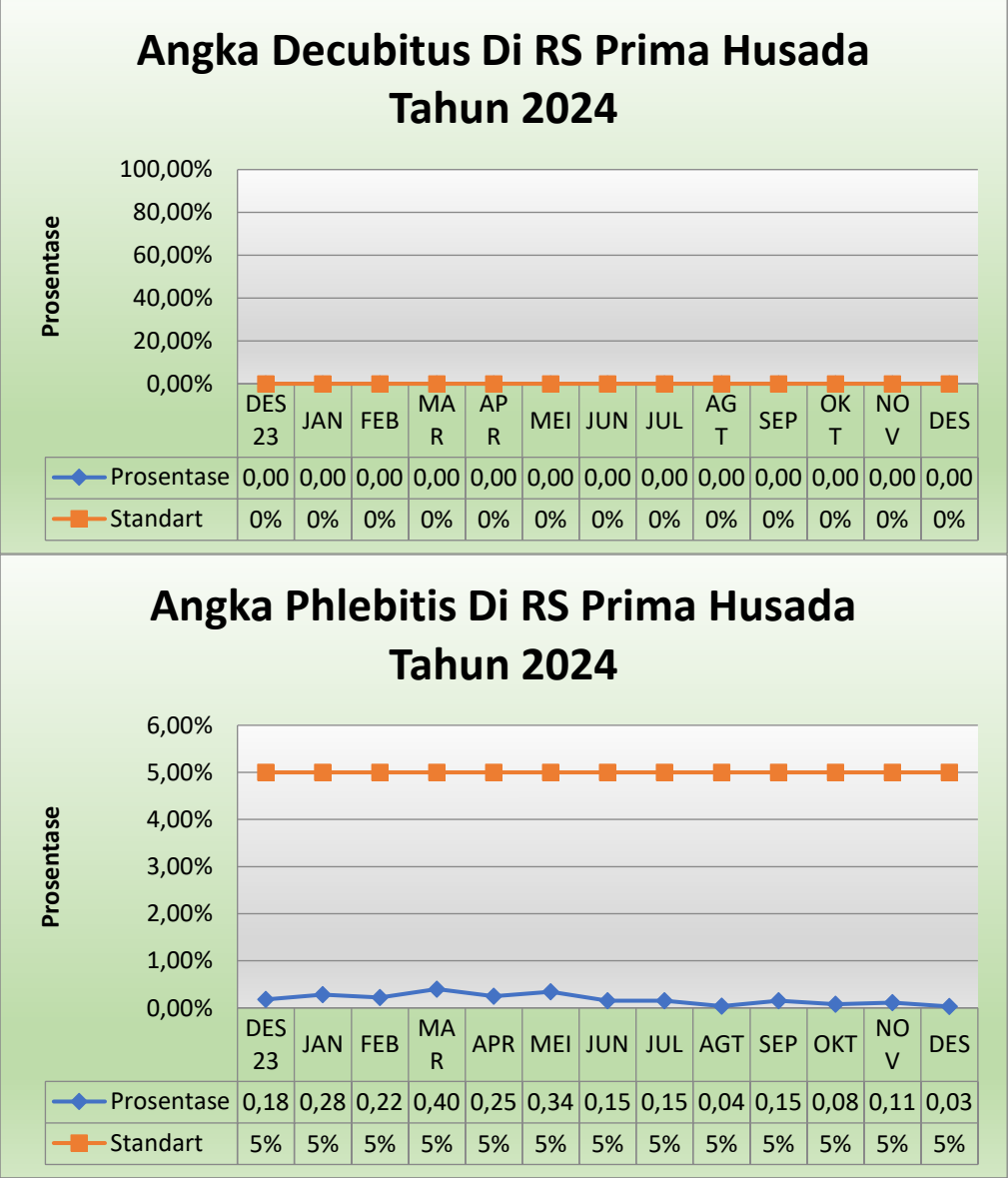
Gambar 3.3.2 Grafik Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI Tahun 2024



Gambar 3.3.2 Grafik Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI Tahun 2024



Gambar 3.3.2 Grafik Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI Tahun 2024



Analisa:

Angka HAIs di Rumah Sakit Prima Husada masih memenuhi standar yang ada, hanya saja pada awal tahun sekitar bulan November 2024 terjadi peningkatan kasus VAP yang melebihi standart maksimal dimana pasien mengalami pneumonia akibat dari pemasangan ventilator pada hari ke 4 pemasangan. Pasien mengalami gejala demam dan produksi secret purulen. Saat dilakukan rontgent thorak didapatkan hasil bacaan Pneumonia (lesi baru), leukosit juga mengalami peningkatan (11.020), fiO2 60% (kurang dari 250%) dan saat dilakukan pengecekan preparate gram didapatkan bakteri coccus gram positif.

Dari hasil monitoring audit bundle, pada pasien ini jarang sekali dilakukan oral hygiene, dengan ditandai mukosa bibir pasien yang kering. Untuk tindakan suction sudah rutin dilakukan sebanyak 3x sehari setelah dilakukan terapi nebulasi. Suction yang digunakan juga sudah menggunakan closed suction. Ditambah lagi penggunaan ventilator pada tahun ini memang mengalami peningkatan.

Evaluasi: Sudah dilakukan rencana tindak lanjut berupa koordinasi dengan kabid perawatan dan petugas perawatan unit untuk melakukan bundle VAP dengan baik terutama terkait oral hygiene dan sudah dibuatkan aturan untuk mewajibkan semua pasien yang terpasang ventilator untuk dilakukan asuhan keperawatan oral hygiene dan didokumentasikan pada lembar observasi pasien. Tidak lupa pula untuk melakukan edukasi pada keluarga pasien untuk juga berperan aktif mengingatkan petugas untuk melakukan oral hygiene untuk mempercepat kesembuhan pasien.

3.3.1 Evaluasi Program Edukasi Pasien, Keluarga Pasien, dan Pengunjung.

Evaluasi:

- 1) Edukasi terhadap pasien dilakukan oleh seluruh unit perawatan dengan materi hand hygiene dan etika batuk serta materi yang berhubungan dengan PPI lainnya pada seluruh pasien dengan didokumentasikan pada lembar edukasi pada rekam medis menggunakan media leaflet dan praktek langsung.
- 2) Edukasi secara kelompok pasien/keluarga/pengunjung terdokumentasi dengan baik mulai bulan Januari 2024 dengan jadwal minimal 8x/bulan dilakukan di ruang tunggu rawat jalan maupun rawat inap dengan capaian edukasi sebanyak 549 orang yang teredukasi dalam edukasi kelompok.

3.3.2 Evaluasi Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan PPI.

- 1) Upaya menurunkan risiko infeksi pada pelayanan pasien.

a) Pemantauan kualitas udara.

Evaluasi: dilakukan pemantauan udara pada bulan Mei 2024 di ruang IKO 1, IGD, Isolasi 5C, CSSD dan ICU dengan hasil memenuhi syarat kecuali pada ruang IKO 1 dan CSSD dimana hasilnya kurang memenuhi syarat dan membutuhkan rencana tindak lanjut khusus termasuk pembersihan filter hepa dan AC yang ada di dalamnya dilakukan oleh petugas IPSRS. Evaluasi dilakukan pada akhir Desember 2024 dan masih menunggu hasilnya.

b) Pemantauan kualitas air.

Evaluasi: Pemeriksaan mikrobiologi air bersih dilakukan pada 2 sumber air dengan sampling air di ruang IKO (sumber sumur bor) dan air kran di Gedung DPM dengan hasil memenuhi syarat. Pemeriksaan juga dilakukan pada sumber air minum yang digunakan di RS Prima Husada dengan hasil memenuhi syarat.

c) Pemantauan kebersihan lantai & dinding.

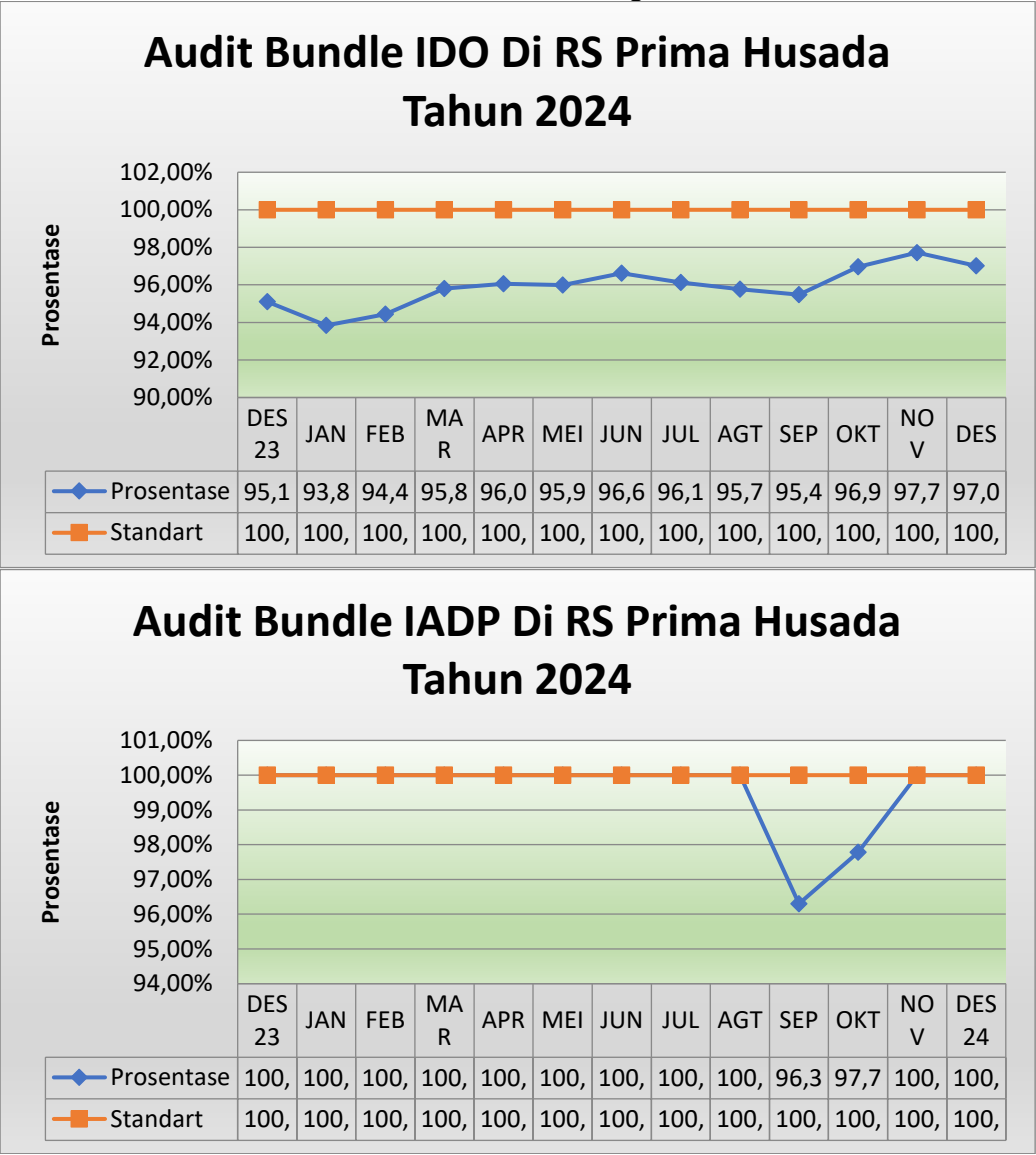
Evaluasi: Sudah dilakukan pemeriksaan swab lantai dan dinding secara rutin pada bulan Mei 2024 pada unit seperti: CSSD, IGD, IKO 1, IRJA Obygyn, IRNA 3A, Isolasi 5C, Lab, ICU, Tindakan Maternitas, Dapur (R. Pemorsian) dengan hasil semuanya memenuhi syarat. Desember 2024 dilakukan kembali pemantauan lantai dan dinding namun masih menunggu hasil.

d) Pemantauan sterilitas alat medis, linen, dan meja operasi.

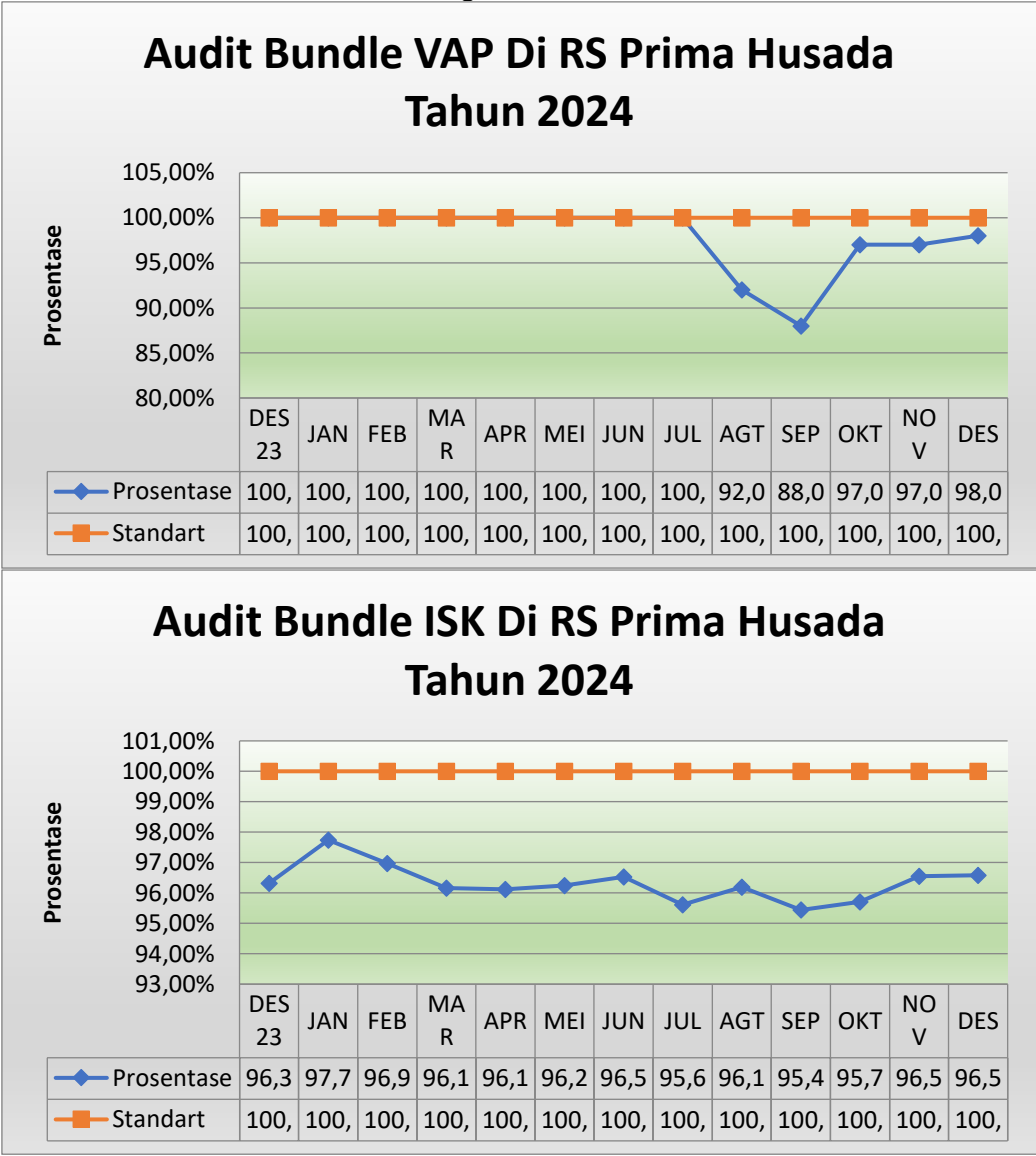
Evaluasi: Sudah dilakukan rutin pemeriksaan swab alat medis steril, linen steril, dan meja operasi pada bulan Mei 2024 dan didapatkan hasil memenuhi syarat yang dilakukan oleh Lab Dinkes Kab. Malang. Untuk swab alat re-use (Jackson Rees 1x pakai) ditemukan hasil yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dianjurkan untuk dire-use. Desember 2024 dilakukan kembali pemantauan namun masih menunggu hasil.

e) Monitoring Audit Bundle HAIs.

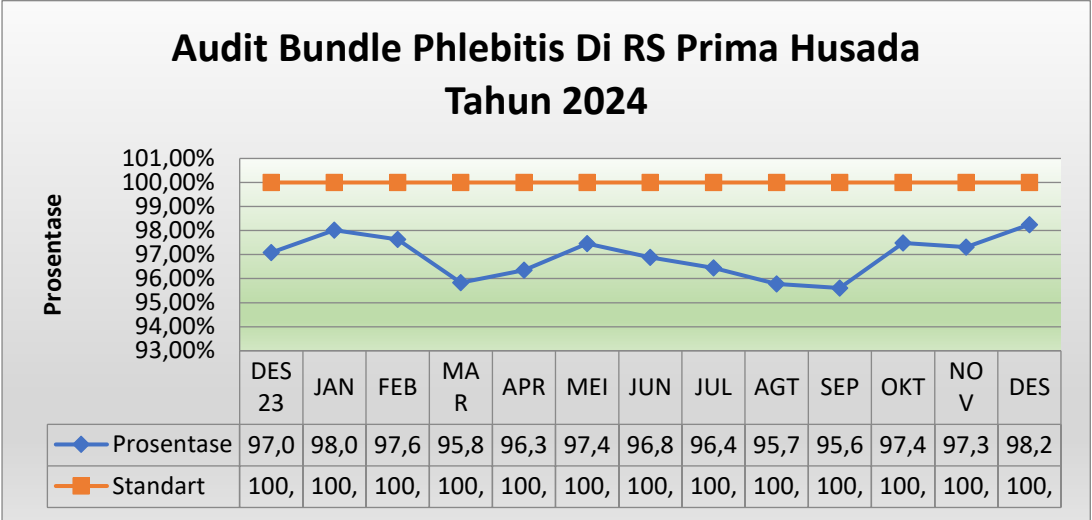
Gambar 3.3.4.1 Grafik Monitoring Audit Bundle HAIs



Gambar 3.3.4.1 Grafik Monitoring Audit Bundle HAIs



Gambar 3.3.4.1 Grafik Monitoring Audit Bundle HAIs



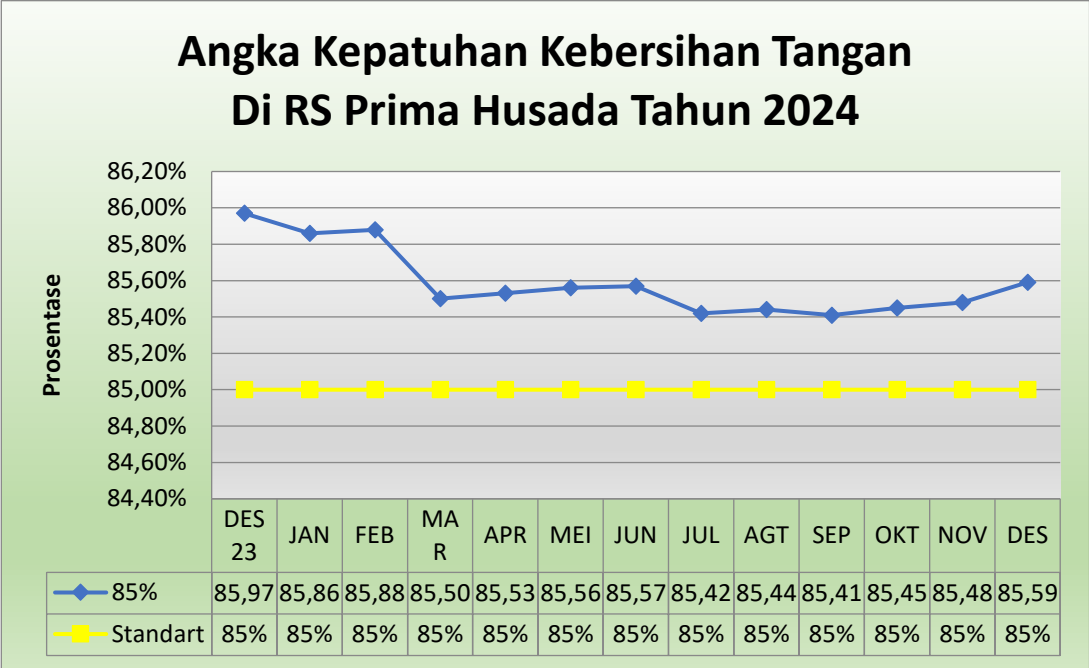
Evaluasi: Kegiatan pencegahan risiko infeksi (Audit Bundle HAIs) sudah dilakukan dengan baik oleh petugas di unit, namun masih ada beberapa unit yang tidak tertib mendokumentasikan pada form audit bundle HAIs dan Sebagian petugas hanya mengandalkan IPCLN untuk pengisiannya. Rencananya akan dihubungkan dengan register unit sehingga semua petugas wajib mengisi dan menjalankan.

f) Melaksanakan pengkajian dampak renovasi / pembongkaran / pembangunan Gedung dengan program ICRA.

Evaluasi: Program ICRA belum berjalan dengan baik, perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dikoordinasikan dengan PPI maupun K3RS. Proses PCRA belum dapat berjalan maksimal, akibatnya program ICRA Bangunan pun belum berjalan dengan baik, meskipun dokumentasi sudah mulai dilakukan. Namun pada tahun ini sudah cukup berjalan perencanaan Pembangunan seperti pada renovasi poli Paru dan vinyl IKO.

- 2) Upaya menurunkan risiko infeksi pada petugas kesehatan.
- a) Monitoring Kebersihan Tangan bulan Januari – Desember 2024:

Gambar 3.3.4.2 Grafik Monitoring Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan bulan Januari – Desember 2024



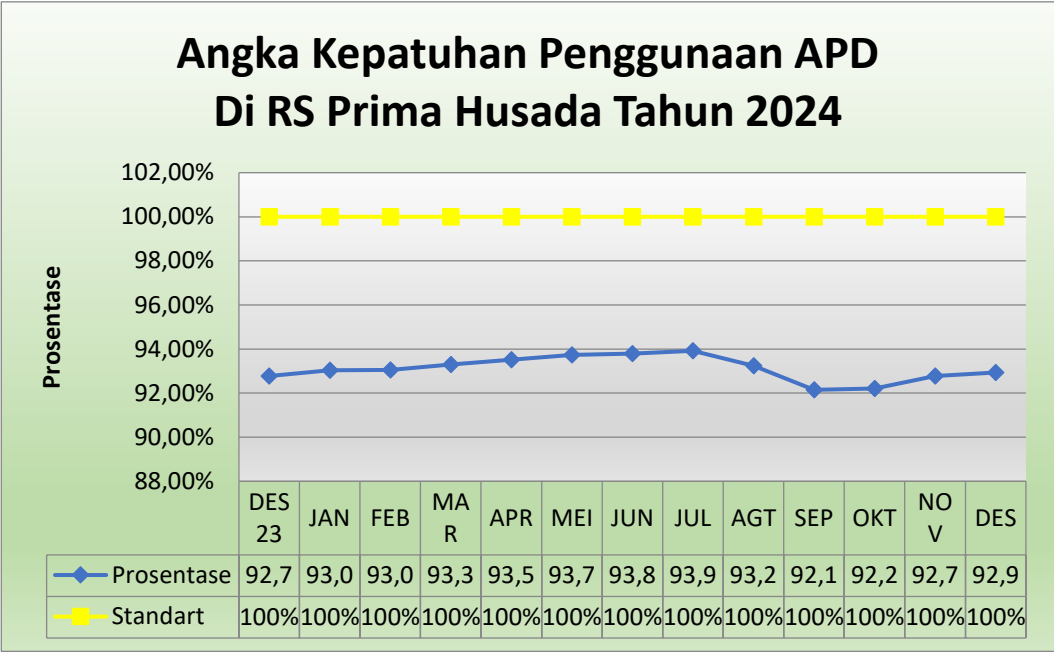
Analisa: Kepatuhan kebersihan tangan di Rumah Sakit Prima

Husada sudah memenuhi standar nasional kepatuhan kebersihan tangan, namun pada beberapa bulan prosentasenya masih ada yang turun meskipun tidak terlalu signifikan.

Evaluasi: Kepatuhan kebersihan tangan perlu dipertahankan diatas standar, sosialisasi terkait kebersihan tangan terus ditingkatkan kepada sesama petugas terutama five momen cuci tangan, terutama pada momen sebelum kontak dengan pasien yang memang masih sering tidak dilakukan oleh petugas karena beranggapan tangannya masih dalam kondisi bersih.

b) Monitoring Kepatuhan penggunaan APD bulan Januari – Desember 2024:

Gambar 3.3.4.2 Grafik Kepatuhan penggunaan APD RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2024



Analisa: Kepatuhan penggunaan APD di RS prima Husada belum memenuhi standart (100%) mulai bulan Januari – Desember 2024. Kepatuhan terendang ada pada petugas dapur khususnya pengolah makanan yang sering tidak memakai masker dan handglove saat memasak. Selain itu juga petugas CS yang masih ada yang menggunakan handscoon bedah untuk membersihkan ruangan. Disisi lain terdapat DPJP yang sering memakai APD tidak sesuai dengan transmisi dan Tindakan yang akan dilakukan seperti hanya visite pada pasien biasa namun memakai handscoon dan skort. Hal tersebut juga terjadi pada nakes lainnya, yang beberapa kali masih ditemukan melakukan Tindakan dengan memakai handscoon padahal Tindakan tersebut tidak memerlukan handscoon (TTV pasien biasa). Namun semakin sering diingatkan, kepatuhan APD petugas juga semakin mengalami peningkatan.

Evaluasi: Supervisi berjenjang sudah dilakukan baik dari PIC PPI, Kepala Ruang, maupun Kepala Bidang, dengan rutin supervise dan mengingatkan saja diharapkan kesadaran petugas pentingnya pemakaian APD dengan benar dapat tertanam dengan baik.

c) Pemeriksaan kesehatan petugas secara berkala.

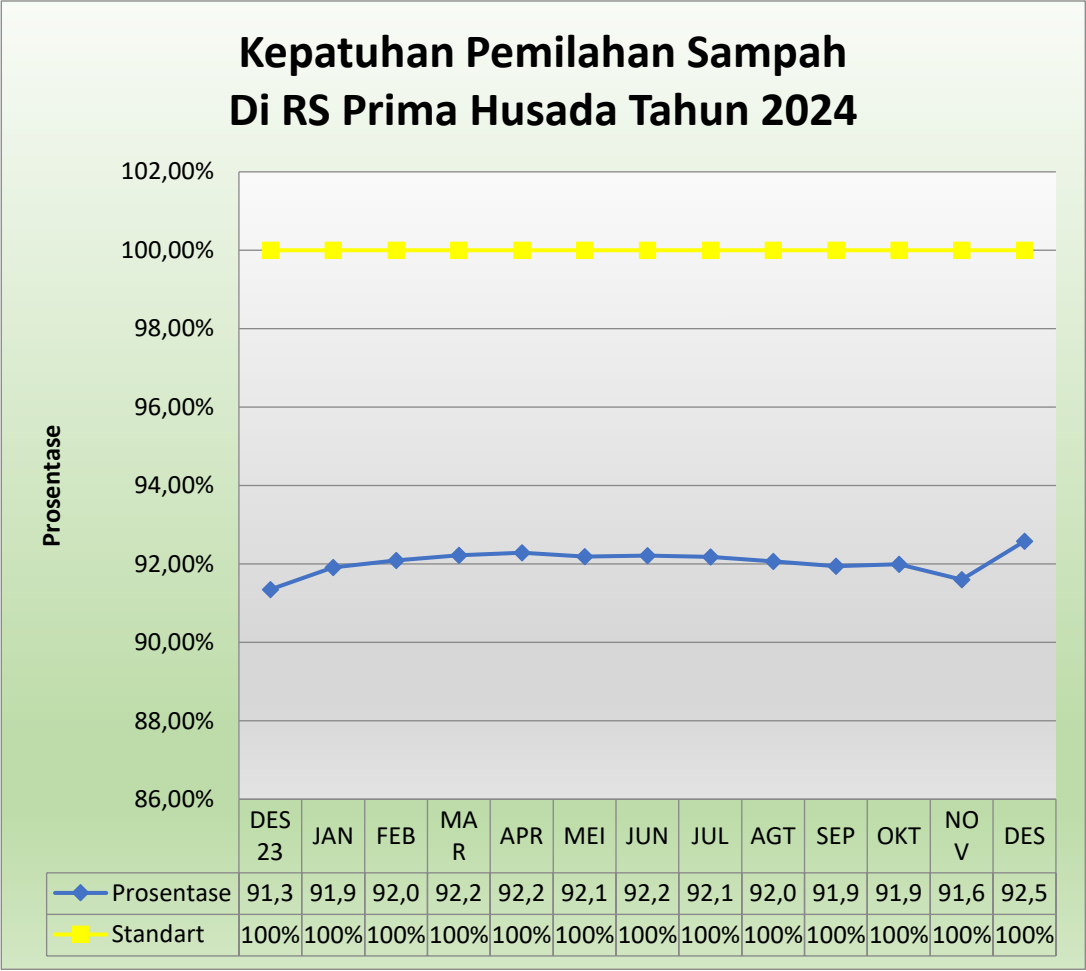
Evaluasi:

- Pemeriksaan kesehatan karyawan untuk tahun ini sudah dilakukan mulai tanggal 22 – 26 April 2024, dimana pemeriksaan yang dilakukan meliputi anamnesa & pemeriksaan vital sign, skrining DM (cek GDP), dan pemeriksaan papsmear khusus bagi karyawan Wanita yang sudah menikah dan tidak sedang hamil/menstruasi. Dengan evaluasi kehadiran yang lebih menurun dari tahun lalu dimana didapatkan 78 orang tidak melakukan MCU rutin tahunan ini, dan bagi yang tidak mengikuti sudah diberikan peringatan oleh SDM dan diwajibkan untuk memberikan hasil tes kesehatan secara mandiri.

- Belum dilakukan pemeriksaan khusus untuk pendengaran pada petugas laundry, hanya pemeriksaan fisik saja area pendengaran petugas pada saat MCU dan hasilnya masih baik.
- Sudah dilakukan pemeriksaan rectal swab khusus pada petugas penjamah makanan rutin pada bulan Juli 2024, dengan hasil ada 3 penjamah makanan yang memiliki hasil kuman pathogen (*Salmonella thypi*). Hygiene penjamah makanan sangat penting diperhatikan karena dapat menjadi sumber pembawa penyakit pada pasien. Ketiga penjamah makanan tersebut sudah dikonsultasikan pada dokter untuk memperoleh pengobatan.

d) Monitoring Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan

Gambar 3.3.4.2 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2024

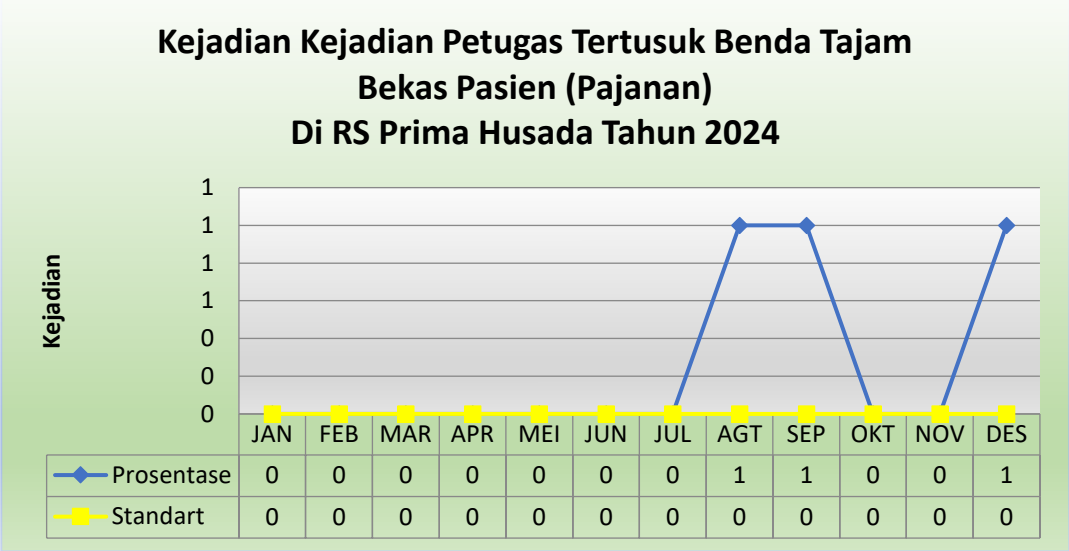


Analisa: Kepatuhan pemilahan sampah di RS prima Husada belum memenuhi standart (100%) mulai bulan Januari – Desember 2024. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukannya petugas yang membuang bungkus alkes (bungkus spuit, bungkus alcohol swab, plastic obat, dll) ke dalam sampah infeksius, seharusnya pada saat akan melakukan Tindakan, petugas bisa menggunakan 2 bengkok untuk memilah yang infeksius dan non infeksius pada saat melakukan tindakan.

Evaluasi: Pemahaman terkait jenis sampah pada petugas sebenarnya sudah baik, namun karena beberapa petugas yang malas melakukan pemilahan, dampaknya kepatuhan pemilahan tidak bisa berjalan 100%. Dibutuhkan supervise langsung dan teguran langsung terutama dari Karu/PJ shift pada saat melakukan Tindakan, terutama untuk merubah kebiasaan tidak benar dari petugas yang sulit sekali untuk dirubah.

e) Penanganan pasca pajanan dari pasien (Terkena benda tajam bekas pasien)

Gambar 3.3.4.2 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2024



Evaluasi: masih ditemukan 3 kejadian pajanan infeksius pada tahun ini dan 2 diantaranya dikarenakan kecerobohan staf yang tidak melakukan pemilahan sampah benda tajam dengan baik saat melakukan tindakan. 1 orang lainnya mengalami pajanan tusukan jarum karena safety box yang tembus jarum, karena pada saat petugas memegang badan safety box, petugas tersebut terkena jarum yang menebus lapisan safety boxnya

3.7 Kinerja Produktifitas Tim PKRS

3.7.1 Tabel Capaian Kegiatan Edukasi Kelompok PKRS Tahun 2024

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	KIE Individu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Edukasi Kelompok Tm PKRS Unit												
	- IRNA 2C	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%
	- ICU HCU	100%	0%	50%	0%	25%	50%	50%	50%	0%	100%	0%	0%
	- IRNA 3C	25%	50%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- MATERNITAS	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- PERINATOLOGI	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
	- IRNA 5C	100%	25%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- IRNA 2A 3A 4A	100%	100%	100%	50%	50%	75%	100%	100%	100%	75%	75%	75%
	- IRNA 6A7A8A	100%	75%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	50%	25%
	- FARMASI	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%	100%
	- GIZI	100%	75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	25%	100%	100%	75%
	- IRJA	100%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
3	Kontrolling Papanisasi PKRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Edukasi Kelompok PROGNAS												
	- KBRS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	- STUNTING	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
	- HIV	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	- PONEK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	- TBDOTS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Edukasi Kelompok PPI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Komunitas												
	- Shirothul Jannah Laki-Laki	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Shirothul Jannah perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	- Senam Hamil	100%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Senam Lansia	100%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa :

Tabel Produktivitas Tim Komite PKRS Prima Husada Malang , hasil analisa menunjukkan bahwa capaian Kinerja Edukasi Kelompok Tim PKRS Unit selama Tahun 2024 Sebesar 86%, Edukasi Individu 100%, Kegiatan Komunitas tercapai seluruhnya dan untuk Edukasi Kelompok PROGNAS Sangat tidak tercapai.

- Rencana Tindak Lanjut :
1. Koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan dan Pelayanan untuk dapat meningkatkan kegiatan edukasi Kelompok dengan rutin
 2. Melakukan Supervisi secara berkelanjutan
 3. Koordinasi dengan SDM untuk pemberian Punishment kepada unit yang tidak melakukan edukasi kelompok secara patuh

3.8 Kinerja Produktifitas Komite Farmasi Terapi

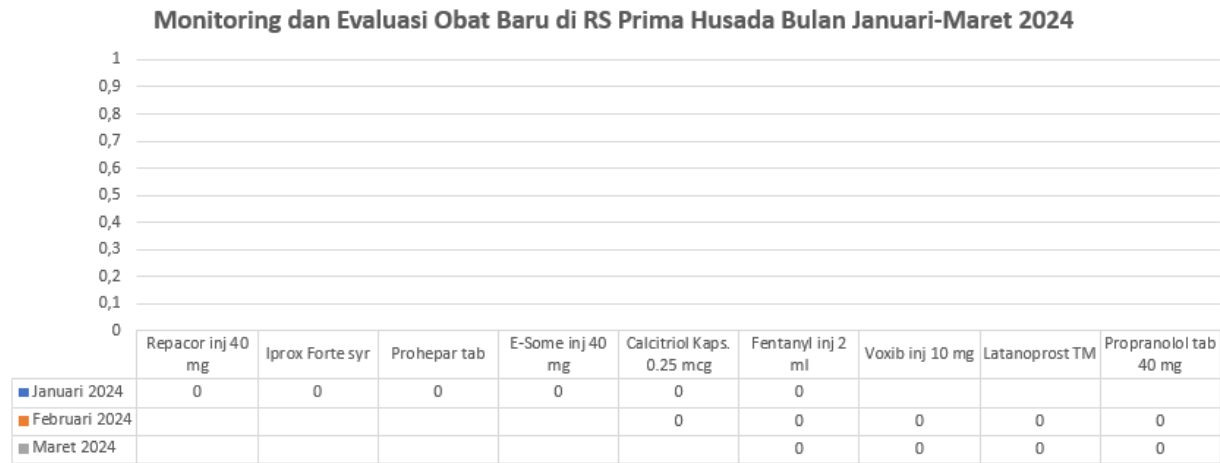
3.8.1 Kinerja Produktifitas Komite Farmasi Terapi Januari – Maret 2024

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2024

No	Nama Obat	Pemantauan Bulan			Temuan	Keterangan
		Nov 2023	Des 2023	Jan 2024		
1	Repacor inj 40 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Iprox Forte syr	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Prohepar tab	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
4	E-Some inj 40 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Temuan	Keterangan
1	Calcitriol Kaps. 0.25 mcg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Temuan	Keterangan
1	Fentanyl inj 2 ml	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Feb 2024	Mar 2024	April 2024	Temuan	Keterangan
1	Voxib inj 10 mg	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Latanoprost TM	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Propranolol tab 40 mg	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan

Grafik

Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2024



- Evaluasi :
- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi obat baru.
 - 2) Hasil monitoring penggunaan obat baru selama 3 bulan tidak ditemukan terjadinya efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD.
 - 3) Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

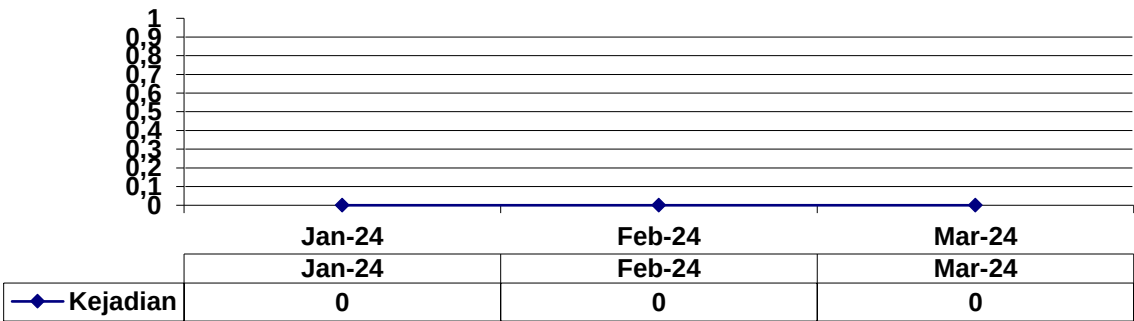
- Rencana dan Tindak Lanjut :
- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
 - 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
 - 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).

- Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- Menganalisa laporan ESO.
- Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2024

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	SMF	Tindak Lanjut
1	Januari 2024	-	0	-	-
2	Februari 2024	-	0	-	-
3	Maret 2024	-	0	-	-

Grafik
Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2024



Evaluasi :

- Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi peresepan di luar formularium.
- Hasil monitoring peresepan diluar formularium selama 3 bulan tidak ditemukan peresepan diluar formularium RSPH. DPJP patuh dalam meresepkan obat sesuai formularium RS.

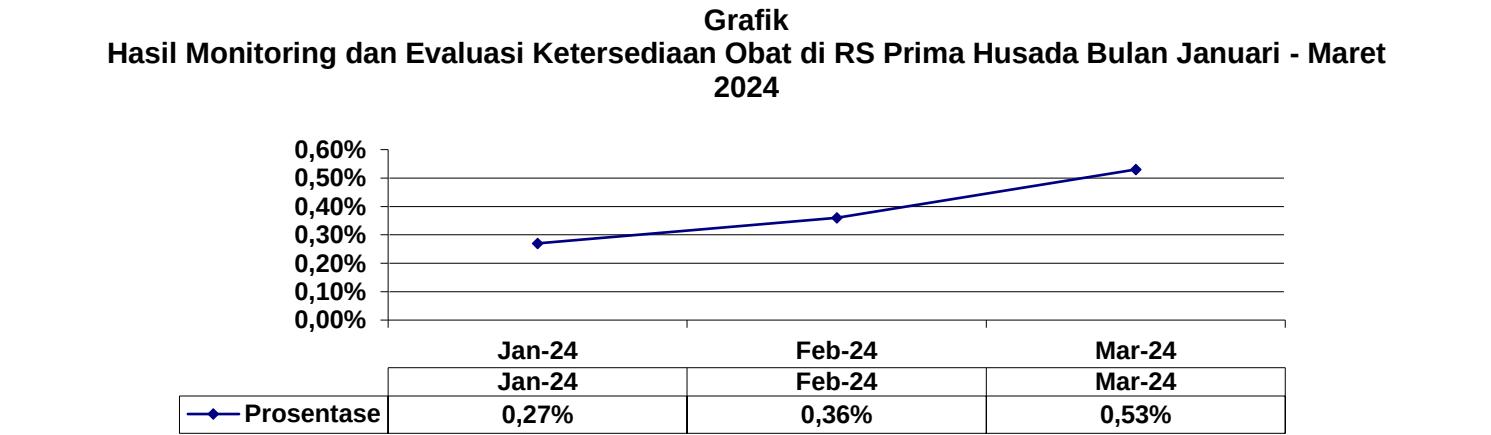
Rencana dan Tindak Lanjut :

- Kolaborasi dengan komite medik agar DPJP patuh menggunakan formularium RS yang sudah tersedia dan terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS.
- Dokter yang melakukan peresepan di luar formularium karena obat tidak tersedia dan pasien membutuhkan obat tersebut maka DPJP mengajukan form pengajuan sediaan farmasi baru.
- Sesuai standar akreditasi maka pengadaan obat di RS / apotek rekanan. Disepakati obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tidak perlu diadakan di RSPH agar dibuatkan perjanjian kerjasama dengan RS atau apotek rekanan.

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2024

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/1/2024 - 4/1/2024	Cefuroxime inj	Antibiotik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
2	1/1/2024 – 31/1/2024	Phenobarbital inj	Anti epilepsi – anti konvulsi	PT. Rajawali Nusindo	Tanpa saran substitusi
3	13/1/2024 – 25/1/2024	Uperio tab 100 mg	Anti hipertensi sistemik	PT. Rajawali Nusindo	Substitusi ke Uperio tab 200 mg
4	21/1/2024 - 25/1/2024	Symbicort rapihaler	Anti asma	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	Tanpa saran substitusi

5	21/1/2024 - 25/1/2024	Symbicort turbuhaler	Anti asma	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Januari 2024 = 0.27%					
1	1/2/2024 – 29/2/2024	Phenobarbital inj	Anti epilepsi – anti konvulsi	PT. Rajawali Nusindo	Tanpa saran substitusi
2	17/2/2024 – 29/2/2024	Trifluoperazine tab 5 mg	Anti psikosis	PT. Merapi Utama Pharma	Substitusi ke Stelosi tab 5 mg
3	20/2/2024 – 29/2/2024	Nitrokaf tab 2.5 mg	Anti angina	PT. Kimia Farma	Substitusi ke Nitrokaf kaps 5 mg
4	21/2/2024 – 29/2/2024	Phinev inj	Syok kardiogenik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
5	24/2/2024 – 29/2/2024	Latanoprost eye drop	Miotik dan antiglaukoma	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Februari 2024 = 0.36%					
1	1/3/2024 – 31/3/2024	Phenobarbital inj	Anti epilepsi – anti konvulsi	PT. Rajawali Nusindo	Tanpa saran substitusi
2	1/3/2024 – 14/3/2024	Trifluoperazine tab 5 mg	Anti psikosis	PT. Merapi Utama Pharma	Substitusi ke Stelosi tab 5 mg
3	1/3/2024 – 14/3/2024	Nitrokaf tab 2.5 mg	Anti angina	PT. Kimia Farma	Substitusi ke Nitrokaf kaps 5 mg
4	1/3/2024 – 14/3/2024	Phinev inj	Syok kardiogenik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
5	8/3/2024 – 14/3/2024	Ceftriaxone inj 1 gram – ogb Mahakam	Antibiotik	PT. Merapi Utama Pharma	Tanpa saran substitusi
6	8/3/2024 – 14/3/2024	Metilprednisolon inj 125 mg	Kortikosteroid	PT. Lab Medika Sejahtera	Substitusi ke Meproson inj 125 mg
7	23/3/2024 – 31/3/2024	Metamizol inj 1 gram	Analgesik	PT. Parit Padang Global	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Maret 2024 = 0.53%					



Evaluasi :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi ketersediaan obat.
- 2) Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, dsb
- 3) Obat yang mengalami kekosongan obat didistributor yaitu

Pada bulan Januari 2024 : Cefuroxime inj, Phenobarbital inj, Uperio tab 100 mg, Symbicort raphaler, Symbicort turbuhaler.

Pada bulan Februari 2024 : Phenobarbital inj, Trifluoperazine tab 5 mg, Nitrokaf tab 2.5 mg, Phinev inj, Latanoprost eye drop.

Pada bulan Maret 2024 : Phenobarbital inj, Trifluoperazine tab 5 mg, Nitrokaf tab 2.5 mg, Phinev inj, Ceftriaxone inj 1 gram – ogb Mahakam, Metilprednisolon inj 125 mg, Metamizol inj 1 gram.

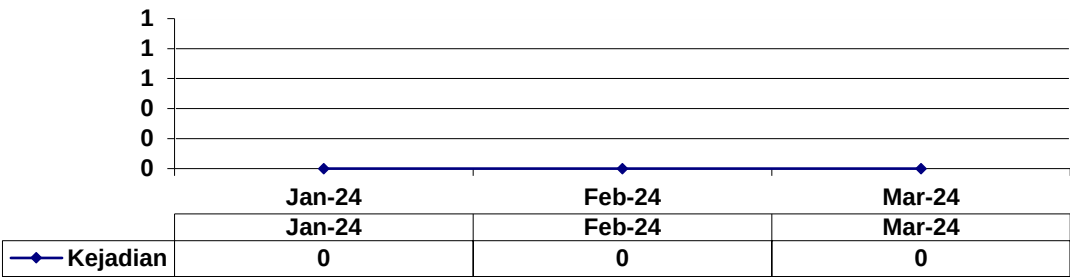
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2) Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3) Memberi informasi kekosongan obat dan substitusinya ke DPJP melalui surat edaran.
- 4) Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.

Tabel Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2024

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	ESO	Tindak Lanjut
1	Januari 2024	-	0	-	-
2	Februari 2024	-	0	-	-
3	Maret 2024	-	0	-	-

Grafik 4
Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2024



Evaluasi :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan oleh PIC di unit terkait dalam form MESO dan form IKP.
- 2) Hasil monitoring pelaporan MESO tidak ditemukan terjadinya efek samping obat.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

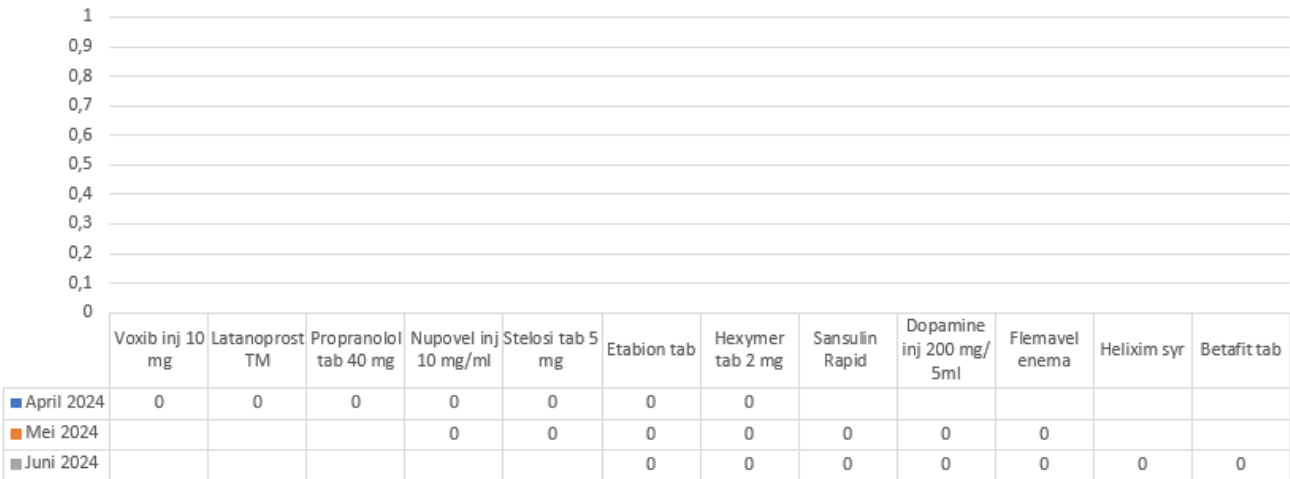
3.8.2 Kinerja Produktifitas Komite Farmasi Terapi April - Juni 2024

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024

No	Nama Obat	Pemantauan Bulan			Temuan	Keterangan
		Feb 2024	Mar 2024	April 2024		
1	Voxib inj 10 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Latanoprost TM	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Propranolol tab 40 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Mar 2024	April 2024	Mei 2024	Temuan	Keterangan
1	Nupovel inj 10 mg/ml	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan

2	Stelosi tab 5 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Temuan	Keterangan
1	Etabion tablet	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Hexymer tab 2 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Temuan	Keterangan
1	Sansulin Rapid	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Dopamine inj 200 mg/ 5ml	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Flemavel enema	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Juni 2024	Juli 2024	Ags 2024	Temuan	Keterangan
1	Helixim sirup	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Betafit tablet	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan

Grafik
Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024
Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024



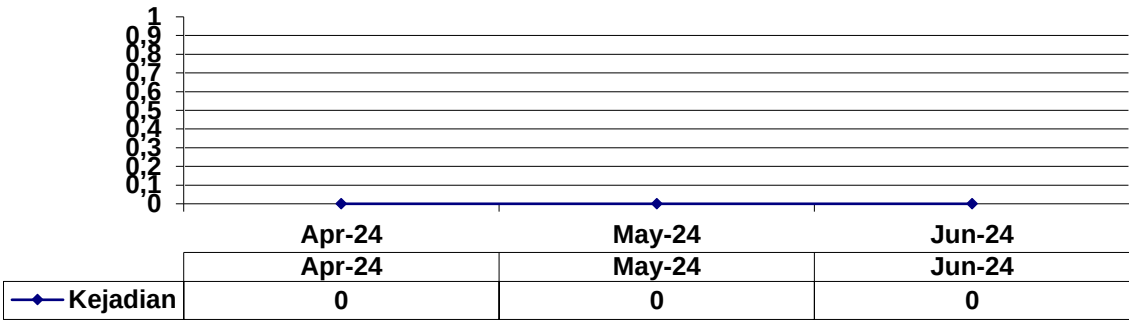
- Evaluasi :**
- 3. Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi obat baru.
 - 4. Hasil monitoring penggunaan obat baru selama 3 bulan tidak ditemukan terjadinya efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD.
 - 5. Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1. Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan
 - 2. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
 - 3. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
 - 4. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO
 - 5. enganalisa laporan ESO.
 - 6. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
 - 7. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	SMF	Tindak Lanjut
1	April 2024	-	0	-	-
2	Mei 2024	-	0	-	-
3	Juni 2024	-	0	-	-

Grafik
Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024



Evaluasi :

- 1. Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi peresepan di luar formularium.
- 2. Hasil monitoring peresepan diluar formularium selama 3 bulan tidak ditemukan peresepan diluar formularium RSPH. DPJP patuh dalam meresepkan obat sesuai formularium RS.

Rencana dan Tindak Lanjut :

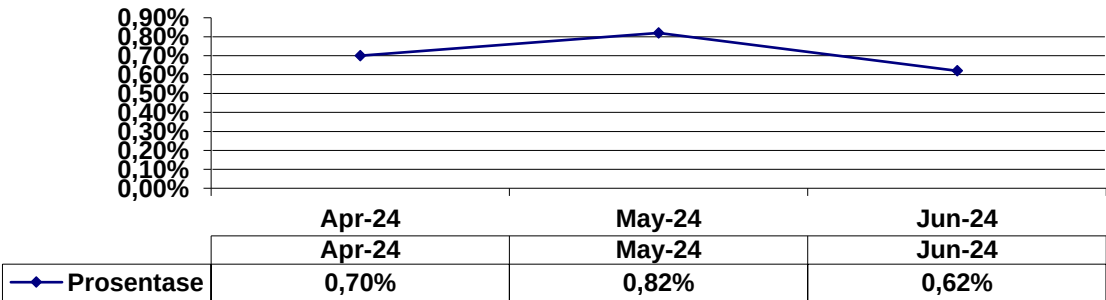
- 1. Kolaborasi dengan komite medik agar DPJP patuh menggunakan formularium RS yang sudah tersedia dan terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS.
- 2. Dokter yang melakukan peresepan di luar formularium karena obat tidak tersedia dan pasien membutuhkan obat tersebut maka DPJP mengajukan form pengajuan sediaan farmasi baru.
- 3. Sesuai standar akreditasi maka pengadaan obat di RS / apotek rekanan. Disepakati obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tidak perlu diadakan di RSPH agar dibuatkan perjanjian kerjasama dengan RS atau apotek rekanan.

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/4/2024 – 30/4/2024	Phenobarbital inj	Anti epilepsi – anti konvulsi	PT. Rajawali Nusindo	Tanpa saran substitusi
2	1/4/2024 – 30/4/2024	Phinev inj	Syok kardiogenik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
3	1/4/2024 – 30/4/2024	Metilprednisolon inj 125 mg	Kortikosteroid	PT. Lab Medika Sejahtera	Substitusi ke Meproson inj 125 mg
4	5/4/2024 – 30/4/2024	Amitriptilin tab 25 mg – Yarindo	Antidepresi Nyeri neuropatik	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Tanpa saran substitusi
5	5/4/2024 – 30/4/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
6	25/4/2024- 30/4/2024	Tremenza tab	Batuk, Pilek, Flu	PT. Bina San Prima	Substitusi ke Alerfed tab
Total prosentase April 2024 = 0.7%					
1	1/5/2024 – 31/5/2024	Phenobarbital inj	Anti epilepsi – anti konvulsi	PT. Rajawali Nusindo	Tanpa saran substitusi
2	1/5/2024 – 31/5/2024	Amitriptilin tab 25 mg – Yarindo	Antidepresi Nyeri neuropatik	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Tanpa saran substitusi

3	1/5/2024 – 31/5/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
4	1/5/2024 – 31/5/2024	Indop inj - Fahrenheit	Syok kardiogenik	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Dopamin inj
5	1/5/2024 – 31/5/2024	Infus D5 ½ NS	Larutan elektrolit	PT. Merapi Utama Pharma	Tanpa saran substitusi
6	1/5/2024 – 31/5/2024	Infus D5%	Larutan elektrolit	PT. Merapi Utama Pharma	Tanpa saran substitusi
7	1/5/2024 – 31/5/2024	Infus Kaen 3B	Larutan elektrolit	PT. Merapi Utama Pharma	Tanpa saran substitusi
8	1/5/2024 – 31/5/2024	Infus ringer asetat	Larutan elektrolit	PT. Merapi Utama Pharma	Tanpa saran substitusi
9	1/5/2024 – 31/5/2024	Clobazam tab Clofritis tab	Anti anxietas	PT. Anugrah Argon Medica PT. Merapi Utama Pharma	Tanpa saran substitusi
10	1/5/2024 – 31/5/2024	Erphafilin tab	Anti asma	PT. Pangestu Farmino Muliatama	Tanpa saran substitusi
11	1/5/2024 – 31/5/2024	Eterfix infus	Anti piretik	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi ke Paracetamol inf
Total prosentase Mei 2024 = 0.82%					
1	1/6/2024 – 30/6/2024	Velutin nebulas 2.5 mg	Anti asma	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi ke Ventasal inh 2.5 mg
2	1/6/2024 – 30/6/2024	Erphafilin tab	Anti asma	PT. Pangestu Farmino Muliatama	Tanpa saran substitusi
3	1/6/2024 – 30/6/2024	Amitriptilin tab 25 mg – Yarindo	Antidepresi Nyeri neuropatik	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Tanpa saran substitusi
4	1/6/2024 – 30/6/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
Total prosentase Juni 2024 = 0.62%					

Grafik
 Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan April - Juni 2024



Evaluasi :

- Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi ketersediaan obat.
- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Amitriptilin tab 25 mg – Yarindo dan Haloperidol tab 5 mg – Yarindo sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.

Rencana dan Tindak Lanjut :

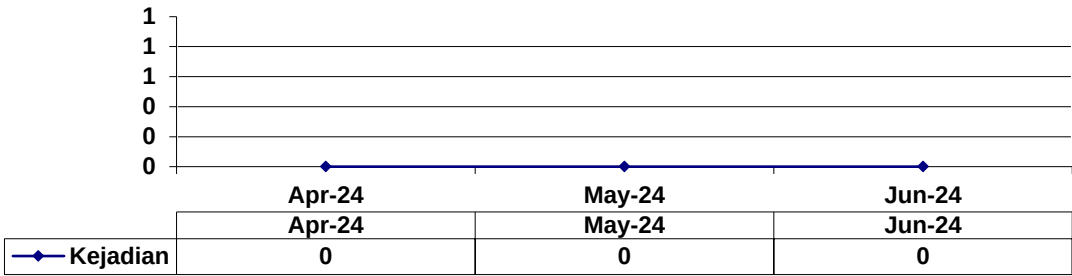
- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Memberi informasi kekosongan obat dan substitusinya ke DPJP melalui surat edaran.

13) Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.

Tabel Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	ESO	Tindak Lanjut
1	April 2024	-	0	-	-
2	Mei 2024	-	0	-	-
3	Juni 2024	-	0	-	-

Grafik
Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan April – Juni 2024



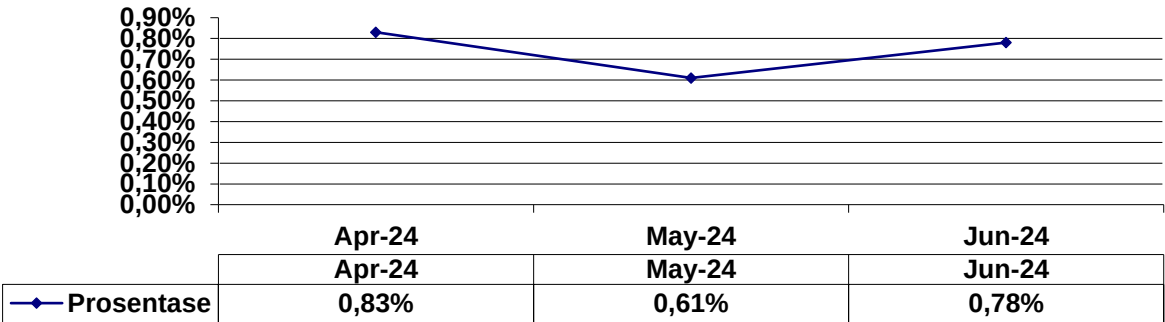
Evaluasi :

- 1. Pencatatan monitoring dilakukan oleh PIC di unit terkait dalam form MESO dan form IKP.
- 2. Hasil monitoring pelaporan MESO tidak ditemukan terjadinya efek samping obat.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- 2. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5. Menganalisa laporan ESO.
- 6. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Grafik
Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketidaklengkapan Pemulisan Resep di RS Prima Husada Bulan April - Juni 2024



Evaluasi :

- 1) Pencatatan monitoring ketidaklengkapan penulisan resep dilakukan setiap hari oleh petugas farmasi.
- 2) Dari data di atas masih banyak ditemukan resep yang tidak lengkap.
Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep
Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.
- 3) Dokter yang menginput e-resep tidak lengkap terbanyak pada bulan April – Juni 2024 dari segi farmasetik yaitu dr. Ardhi Bustami, Sp. PD, dr. Arianto Prabowo, Sp.OT, dr. Heriyatmo, Sp. PD, dr. Aida Musyarrofah, Sp.OG, dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N, dr. Antonius Setiadi, Sp. B, dr. Andy, Sp.P, dr. Miryanti Cahyaningtias, Sp. JP, dr. Nur Rohman.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS.
- 2) Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).
- 3) Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

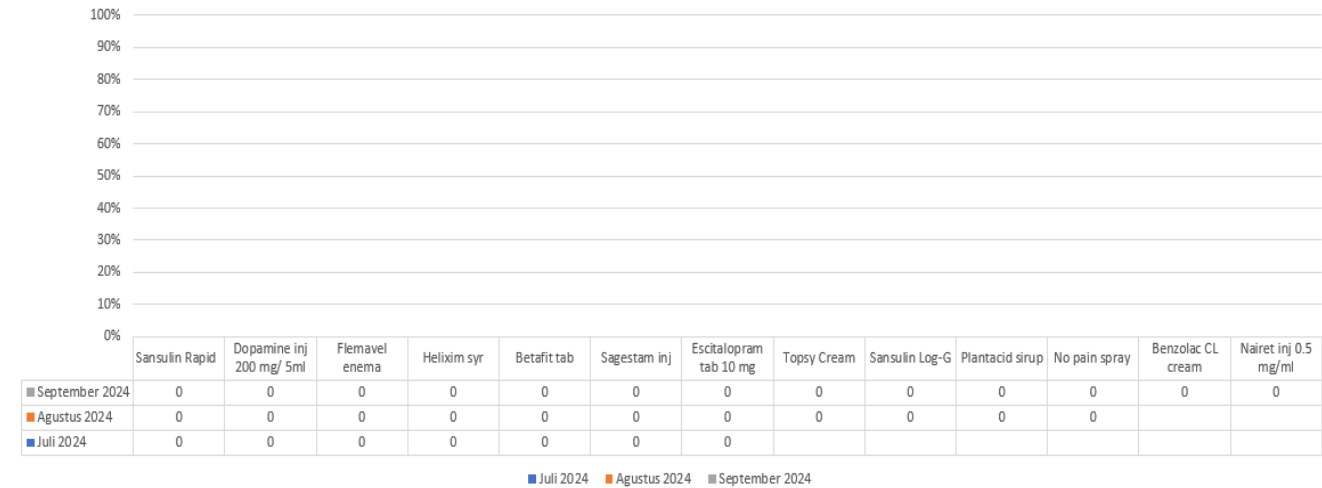
3.8.3 Kinerja Produktifitas Komite Farmasi Terapi Juli – September 2024

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024

No	Nama Obat	Pemantauan Bulan			Temuan	Keterangan
		Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024		
1	Sansulin Rapid	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Dopamine inj 200 mg/ 5ml	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Flemavel enema	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Juni 2024	Juli 2024	Ags 2024	Temuan	Keterangan
1	Helixim sirup	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Betafit tablet	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Juli 2024	Ags 2024	Sep 2024	Temuan	Keterangan
1	Sagestam inj	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Escitalopram tab 10 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Ags 2024	Sep 2024	Okt 2024	Temuan	Keterangan
1	Topsy Cream	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Sansulin Log-G	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Plantacid sirup	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
4	No pain spray	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Temuan	Keterangan
1	Benzolac CL cream	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Nairet inj 0.5 mg/ml	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan

Grafik 1
Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024

Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Juli – September 2024



Evaluasi :

- Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi obat baru.
- Hasil monitoring penggunaan obat baru selama 3 bulan tidak ditemukan terjadinya efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD.
- Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

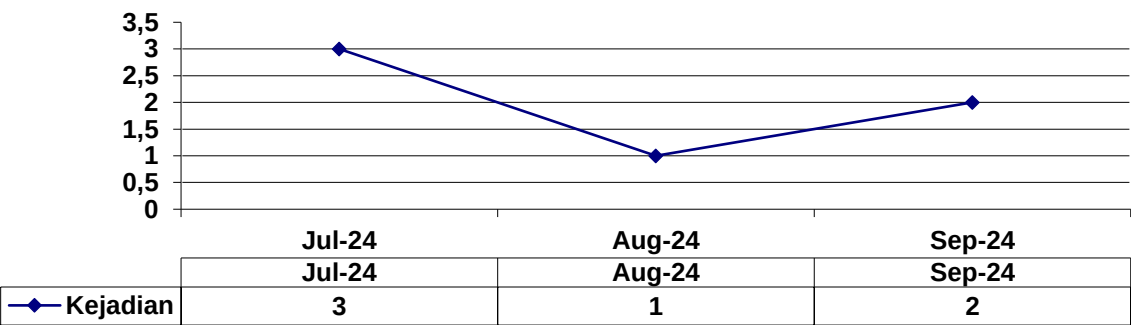
Rencana dan Tindak Lanjut :

- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- Menganalisa laporan ESO.
- Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	SMF	Tindak Lanjut
1	Juli 2024	Nairet inj 0.5 mg/ml	3	dr. Yunita, Sp.P	Pembelian di rs rekanan dan DPJP mengajukan form obat baru agar obat disediakan di farmasi
2	Agustus 2024	D10/NS	1	dr Dicky, Sp.A	Substitusi ke sediaan infus lain yang tersedia di RS
3	September 2024	Methotrexate tab 2.5 mg	2	dr. Zoraida, Sp.PD	Pembelian di apotek rekanan dan DPJP mengajukan form obat baru agar obat disediakan di farmasi

Grafik
Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024



Evaluasi :

- Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi peresepan di luar formularium.
- Hasil monitoring peresepan diluar formularium selama 3 bulan ditemukan masih terjadi peresepan diluar formularium RSPH karena obat dibutuhkan pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

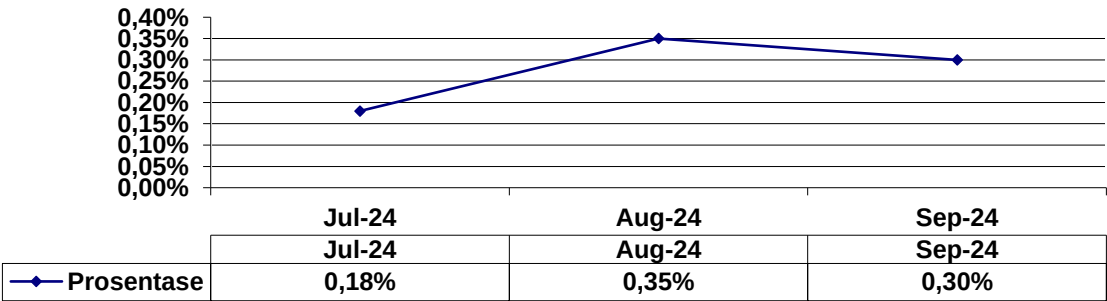
- Kolaborasi dengan komite medik agar DPJP patuh menggunakan formularium RS yang sudah tersedia dan terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS.
- Dokter yang melakukan peresepan di luar formularium karena obat tidak tersedia dan pasien membutuhkan obat tersebut maka DPJP mengajukan form pengajuan sediaan farmasi baru.
- Sesuai standar akreditasi maka pengadaan obat di RS / apotek rekanan. Disepakati obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tidak perlu diadakan di RSPH agar dibuatkan perjanjian kerjasama dengan RS atau apotek rekanan.

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/7/2024 – 4/7/2024	Amitriptilin tab 25 mg – Yarindo	Antidepresi Nyeri neuropatik	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Tanpa saran substitusi
2	1/7/2024 – 31/7/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
3	24/7/2024 – 31/7/2024	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi ke Spironolakton tab 25 mg
Total prosentase Juli 2024 = 0.18%					
1	1/8/2024 – 31/8/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2	8/8/2024 – 31/8/2024	Mylacid susp 60 ml	Anti ulkus	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi ke Plantacid susp 100 ml
3	16/8/2024 – 31/8/2024	Hydrochlorothiazide tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
4	16/8/2024 – 31/8/2024	Isosorbide Dinitrate 10 mg	Anti angina	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Isosorbide Dinitrate 5 mg
5	24/8/2024 – 31/8/2024	Ethylchloride Spray	Anestesi lokal	PT. Mitra Meditama Abadi	Substitusi ke No Pain Spray
6	24/8/2024 – 31/8/2024	Asam Salisilat	Keratolitik dan keratoplastik	PT. Brataco	Tanpa saran substitusi
7	24/8/2024 – 31/8/2024	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
8	24/8/2024 – 31/8/2024	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi

9	24/8/2024 – 31/8/2024	Isosorbide Dinitrate 5 mg	Anti angina	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Agustus 2024 = 0.35%					
1	1/9/2024 – 30/9/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2	1/9/2024 – 20/9/2024	Asam Salisilat	Keratolitik dan keratoplastik	PT. Brataco	Tanpa saran substitusi
3	1/9/2024 – 30/9/2024	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi ke Spironolakton tab 100 mg dengan konversi dosis 25 mg
Total prosentase September 2024 = 0.3%					

Grafik
Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024



Evaluasi :

- 14) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi ketersediaan obat.
- 15) Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Amitriptilin tab 25 mg – Yarindo, Haloperidol tab 5 mg – Yarindo, Spironolakton tab 25 mg dan Spironolakton tab 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.

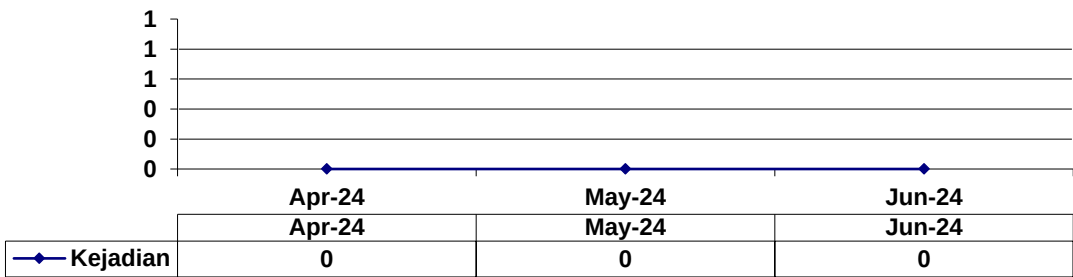
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 16) Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 17) Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 18) Memberi informasi kekosongan obat dan substitusinya ke DPJP melalui surat edaran.
- 19) Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.

Tabel Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	ESO	Tindak Lanjut
1	Juli 2024	-	0	-	-
2	Agustus 2024	-	0	-	-
3	September 2024	-	0	-	-

Grafik
Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September 2024



Evaluasi :

- Pencatatan monitoring dilakukan oleh PIC di unit terkait dalam form MESO dan form IKP.
- Hasil monitoring pelaporan MESO tidak ditemukan terjadinya efek samping obat.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
2. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
3. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
4. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
5. Menganalisa laporan ESO.
6. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
7. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA

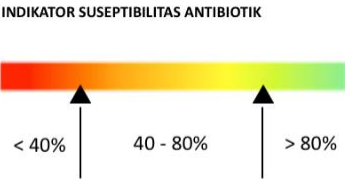
3.11.1 Pola Kuman yang di ambil dari Rumah Sakit yang Mempunyai Karakteristik Paling Mirip dengan RS. Prima Husada

Spesimen Darah – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN DARAH - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																											
Mikroba	N	AMK	AMC	AMP	SAM	ATM	CZO	FEP	CTX	FOX	CRO	CIP	DOR	ETP	GEN	IPM	LVX	MEM	TZP	RIF	TCY	TCC	TGC	TOB	SXT	VAN	
		%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	
Acinetobacter baumannii	67	46,3	-	1,5	30,3	0	1,5	19,7	0	-	6,1	21,2	-	-	22,4	-	100	27,3	11,1	76,5	78,9	33,3	76,4	-	42,3	100	
Klebsiella pneumoniae	67	72,3	25	0	9,5	16,4	8,9	16,4	14,6	75	16,4	44,4	100	63,5	26,9	100	75	65,7	39,6	69,2	57,1	33,3	73,7	25	41	100	
Escherichia coli	28	100	100	14,8	29,2	58,3	16,7	58,3	59,1	100	53,6	60	100	95,8	81,5	100	25	96,4	90,5	42,9	87,5	0	87,5	100	60	87,5	
Enterobacter cloacae	14	84,6	0	0	0	15,4	0	30,8	10	0	14,3	100	100	69,2	35,7	100	100	71,4	63,6	0	33,3	-	66,7	0	42,9	100	

Data primer PDS PatKLIn

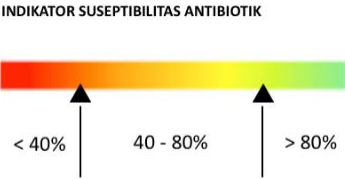
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Darah – Jenis Bakteri Gram Positif

SPESIMEN DARAH - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF																																		
Mikroba	N	AMK	AMC	AMP	SAM	CZO	FEP	CFP	CTX	FOX	CRO	CIP	CLR	CLI	DOR	DOX	ETP	ERY	GEN	IPM	LVX	LNZ	MEM	NAF	OFX	OXA	TZP	RIF	TCY	TGC	SXT	VAN	CHL	
		%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S		
Staphylococcus haemolyticus	136	77,8	7,8	14,3	7,3	2,2	7,1	7,3	7	1,8	7	20,4	18,9	17,6	0	20	2,2	21,2	30,4	2,2	24,1	95,6	6,7	2,2	22,9	6,2	9,1	66,7	56	66,7	50,4	95,8	-	
Staphylococcus hominis	109	-	27,2	0	27	27,8	27	27	27	3,7	27	65,9	30,8	42,4	25	57,7	27,8	28,6	96,3	27,8	67,1	94,4	27	27,8	72,4	26,1	28,6	71,4	50	89,9	50,6	88	-	
Staphylococcus epidermidis	59	-	6,8	-	7,7	10,5	7,7	7,7	7,7	0	7,7	31,8	25	19,6	15,4	45,5	10,5	20	58,1	10,5	31,1	96,6	7,7	10,5	41,7	7,7	9,1	50	83,3	80,4	40	100	-	
Staphylococcus aureus	41	66,7	65,7	75	68,8	75	68,6	67,7	68,6	33,3	67,6	72,7	76,9	64,5	71,4	85,7	75	69,4	76,7	80	68,6	100	70,3	75	76,9	69,4	75	0	33,3	60	44,8	66,7	100	
Kocuria kristinae	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,9	66,7	80,6	53,3	100	-	
Micrococcus luteus	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	66,7	50	33,3	100	-	
Enterococcus faecium	23	-	19	19	19	-	-	-	-	-	-	19	-	0	-	100	-	0	-	-	9,5	95,5	-	-	-	-	50	40	0	66,7	53,3	100	-	
Enterococcus faecalis	20	-	90	90	90	-	-	-	-	-	-	75	-	0	-	-	-	10	-	83,3	85	100	-	-	-	-	83,3	50	60	72,2	58,8	100	-	
Staphylococcus cohnii	12	-	0		14,3	50	14,3	14,3	14,3	0	14,3	100	0	0	50	100	50	0	100	50	100	100	14,3	50	100	12,5	-	0	100	90,9	45,5	100	-	

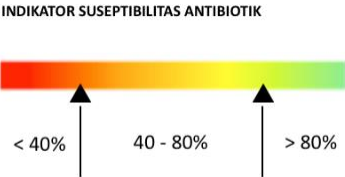
Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Sputum – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN SPUTUM - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																													
Mikroba	N	AMK	AMC	AMP	SAM	ATM	CZO	FEP	CTX	FOX	CPO	CRO	CXM	CIP	DOR	DOX	ETP	GEN	IPM	LVX	MEM	OFX	TZP	TCY	TGC	TOB	SXT	CHL	
		%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	
Acinetobacter baumannii	361	34,9	0	0,6	23,8	0	0	21,3	0	0	-	5,1	-	23,8	15,4	23,1	-	27,7	21,4	25	21,4	0	20,6	55,7	75,4	53,8	45,2	0	
Klebsiella pneumoniae	279	82,4	50	0,7	26,3	23,6	4,8	25,5	24	81,2	50	26,5	100	47	91,7	83,3	67,5	54,2	81,2	76,2	69,2	33,3	48,8	46,4	76,4	75	41,2	62,5	
Pseudomonas aeruginosa	185	61,2	0	0,6	3,5	26	0	56,3	0	0	-	0	-	47,7	33,3	0	-	49,4	14,3	37,5	42,5	100	33,5	44,7	84,3	83,3	52,7	-	
Escherichia coli	45	93,2	80	2,3	15,4	5,1	0	7,7	11,1	60	-	8,9	-	17,5	100	20	84,6	52,3	100	33,3	86,7	0	57,1	54,5	79,4	60	51,4	-	
Enterobacter cloacae	42	90,2	0	2,5	6,1	45,5	0	63,6	36,1	14,3	0	41,5	-	82,4	71,4	57,1	72,7	67,5	71,4	50	80,5	50	64,9	16,7	79,3	14,3	46,4	0	
Stenotrophomonas maltophilia	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5	-	-	-	16,7	62,5	-	72	-	

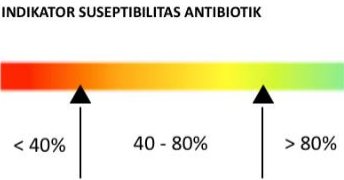
Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Sputum – Jenis Bakteri Gram Positif

SPESIMEN SPUTUM - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF																																						
Mikroba	N	AMK	AMX	AMC	AMP	SAM	CZO	FEP	CFP	CTX	FOX	CPO	CRO	CXM	CIP	CLR	CLI	CLO	DIC	DOR	DOX	ETP	ERY	FOS	GEN	IPM	LVX	LNZ	MEM	OFX	OXA	TZP	RIF	TCC	TGC	SXT	VAN	CHL
		%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
Staphylococcus haemolyticus	37	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,9	10	9,7	0	0	0	58,3	0	5,6	-	23,3	0	11,1	83,3	0	11,1	0	0	50	0	76	39,3	70	100
Staphylococcus aureus	18	100	12,5	68,8	-	78,6	100	80	76,9	71,4	66,7	-	68,8	78,6	66,7	100	66,7	100	100	100	100	100	70,6	-	66,7	100	64,7	94,4	75	75	68,8	88,9	0	100	85,7	56,2	25	-
Staphylococcus epidermidis	15	-	7,7	8,3	-	8,3	12,5	8,3	0	8,3	22,2	0	8,3	8,3	46,2	50	60	12,5	12,5	12,5	100	12,5	60	0	86,7	12,5	53,3	93,3	8,3	62,5	21,4	12,5	75	12,5	91,7	60	54,5	100
Enterococcus faecalis	13	-	81,8	81,8	81,8	81,8	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	-	0	-	-	-	-	9,1	-	-	90	45,5	100	-	-	-	90	-	-	90	0	88,9	-	

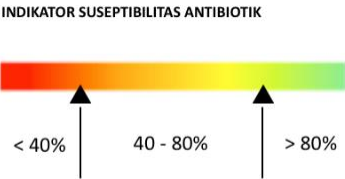
Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Urine – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN URINE - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																								
No	Mikroba	N	AMK	AMC	AMP	SAM	ATM	CZO	FEP	FOX	CRO	CIP	ETP	FOS	GEN	IPM	LVX	MEM	OFX	TZP	TCY	TCC	TGC	SXT
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Escherichia coli</i>	200	97,4	60,9	12,2	19,9	52,3	33,1	51,8	57,1	50,8	41,3	97,4	100	75,1	93,8	21,2	96,4	43,8	70	57,9	66,7	69,4	32,9
2	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	82	93,6	0	0	22,1	29,3	18,8	31,2	0	28,8	48,7	89,3	100	63,3	100	33,3	91,5	100	55,4	58,3	0	83,9	38,7
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20	65	0	0	0	31,2	0	61,1	0	0	44,4	-	100	38,9	33,3	33,3	61,1	0	62,5	20	0	83,3	54,5
4	<i>Proteus mirabilis</i>	16	100	60	28,6	50	44,4	16,7	33,3	50	50	80	55,6	100	76,9	0	80	66,7	0	58,3	-	0	50	50
5	<i>Enterobacter cloacae</i>	16	100	0	0	0	53,8	0	76,9	0	43,8	92,3	76,9	-	81,2	100	100	87,5	-	53,8	50	0	83,3	66,7
6	<i>Acinetobacter baumannii</i>	15	66,7	0	0	50	0	0	35,7	0	0	28,6	-	-	53,3	0	0	46,7	-	44,4	0	0	62,5	42,9

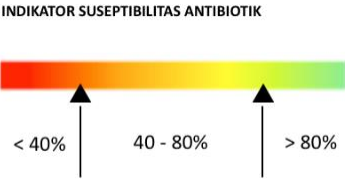
Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Urine – Jenis Bakteri Gram Positif

SPESIMEN URINE - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF																															
No	Mikroba	N	AMK	AMX	AMC	AMP	SAM	FEP	CTX	CRO	CIP	CLI	DOX	GEN	IPM	LVX	LNZ	NT	OFX	OXA	TZP	RIF	TCY	TGC	SXT	VAN	CXM	CEP	HAP	CED	CLR
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	Staphylococcus haemolyticus	44	88,9	2,8	2,8	0	3,2	3	5,7	3,1	42,3	18,8	100	53,6	3,7	38,2	85,7	97,1	44,4	2,7	5,6	25	57,1	100	57,1	45,5	3,4	3,7	3,7	3,7	38,5
2	Enterococcus faecalis	24	0	78,9	76,2	76,2	78,9	0	0	-	27,8	0	100	-	80	33,3	91,7	90,9	-	-	76,5	0	10	76,9	33,3	80	-	-	-	-	-

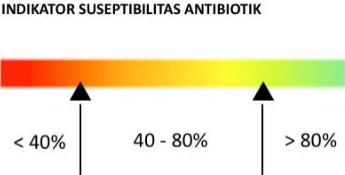
Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Pus – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN PUS - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																						
No	Mikroba	N	AMK	AMX	AMC	AMP	SAM	FEP	CTX	FOX	CRO	CIP	ETP	GEN	IPM	LVX	MEM	NIT	TZP	TCY	TGC	SXT
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Escherichia coli</i>	141	98,5	15,1	61,5	15,2	34,2	54	51,4	63,6	51,4	43,1	97,5	76,7	84,6	33,3	94,9	92,2	77,8	54,2	72	40
2	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	97	91,4	4,9	66,7	1,1	29,4	52,4	41,5	80	45,7	53,3	89,2	68,9	80	61,5	88,5	29,6	76,8	50	68,1	38,9
3	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	55	79,2	0	0	4,2	0	66,7	0	0	22,2	66	-	65,3	66,7	69,2	75,9	0	52	61,5	65,6	37,8
4	<i>Acinetobacter baumannii</i>	48	41,3	-	0	0	28,3	6,5	0	0	4,3	6,4	-	14,6	0	0	29,2	0	4,5	18,2	60	51,4
5	<i>Enterobacter cloacae</i>	30	89,7	0	0	0	0	48	26,9	0	27,6	50	72	51,7	66,7	50	73,3	36	36,4	83,3	66,7	57,1
6	<i>Enterobacter aerogenes</i>	13	100	0	-	0	0	33,3	12,5	-	30,8	58,3	83,3	58,3	-	-	83,3	33,3	100	25	100	42,9
7	<i>Proteus mirabilis</i>	13	100	25	-	16,7	45,5	27,3	33,3	-	33,3	33,3	63,6	36,4	-	0	66,7	0	60	75	75	50

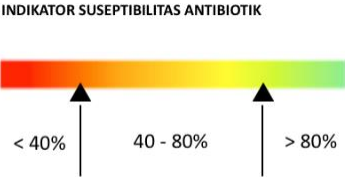
Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Pus – Jenis Bakteri Gram Positif

SPESIMEN PUS - JENIS BAKTERI GRAM POSITIF																																					
No	Mikroba	N	AMK	AMX	AMC	AMP	SAM	AZM	CZO	CTX	FOX	CRO	CXM	CIP	CLR	CLI	CLO	DIC	DOR	DOX	ETP	ERY	GEN	IPM	LVX	LNZ	MEM	OFX	OXA	TZP	RIF	TCY	TCC	TGC	SXT	VAN	CHL
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	Staphylococcus aureus	98	60	14,3	62,1	14,3	61,1	75,5	66,7	59,3	31	57,8	62,3	60,4	76,5	65,5	65,7	64,7	73,3	78,9	66,7	71,6	65,2	67,5	60,6	92,8	58,8	73,5	58,2	68,9	77,8	54,2	100	78,6	55,1	64,7	80
2	Staphylococcus haemolyticus	38	75	0	6,2	0	5,6	18,8	0	9,1	5,3	9,1	5,6	0	0	6,7	0	0	0	66,7	0	15,8	14,3	0	10,5	80,6	9,1	7,7	4,8	6,7	66,7	50	11,1	75	62,5	64,7	-
3	Staphylococcus epidermidis	16	-	0	40	-	50	40	57,1	50	0	44,4	50	71,4	40	50	57,1	57,1	57,1	100	57,1	33,3	100	57,1	83,3	100	44,4	83,3	50	40	66,7	75	40	72,7	46,2	87,5	-
Data primer	Staphylococcus epidermidis	13	76,9	41,7	22,2	33,3	-	45,5	-	20	36,4	0	-	50	-	50	-	-	100	-	-	18,2	-	100	30	92,3	27,3	50	28,6	38,5	-	-	0	-	66,7	100	100

Data primer
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan



Spesimen Feses – Jenis Bakteri Gram Negatif

SPESIMEN FESES - JENIS BAKTERI GRAM NEGATIF																
No	Mikroba	N	AMK	SAM	ATM	CZO	FEP	CTX	CRO	CIP	ETP	GEN	MEM	TZP	TGC	SXT
			%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S	%S
1	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	12	100	8,3	33,3	18,2	33,3	11,1	25	58,3	91,7	75	91,7	87,5	50	25

Data primer PDS PatKLIn
Catatan: (-) = Antibiotik tidak diujikan

3.13 Kinerja Produktifitas Komite Medis

3.13.1 Pengembangan Pelayanan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN	STANDART	TARGET	HASIL	KET
1	Kedisiplinan pengurusan SIP dokter	1. Pendataan SIP yang akan habis 2. Follow up pengurusan	100%	Terpenuhi	1. Mendata SIP DPJP yang akan habis pada tahun 2023 2. Melakukan follow up pengurusan STR 3. Koordinasi dengan SDM terkait kelengkapan apa sjaa yang dibutuhkan untuk pengurusan SIP 4. Membantu membuat surat keterangan jumlah pasien/Tindakan untuk pengurusan STR	
2	Pelaksanaan E-RM	1. Sosialisasi E-RM pada dokter spesialis 2. Koordinasi dengan programmer 3. Membuat fitur aplikasi E-RM 4. Melakukan trial secara bertahap 5. Melakukan monitoring dan eksekusi apabila ada kendala 6. Melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan	100%	E-RM rawat Jalan 100% terpenuhi	1. Rehab medik sudah ERM full sejak Juli 2024 2. Ada aplikasi baru V-claim di rehab medik, sehingga setiap kunjungan wajib diinput di V-claim 3. Koordinasi dengan IT agar rehab medik support jaringan untuk pelaksanaan aplikasi terbaru	
3	Kredensial dokter baru	1. Menyiapkan berkas kelengkapan kredensial termasuk draft RKK 2. Mengajukan pada ketua komdik untuk dilakukan kredensial sesuai instruksi direktur 3. Pengisian draft RKK diserahkan bisa softcopy maupun hardcopy 4. Sekomdik mengajukan draft RKK ke Sub Kredensial dan disetujui oleh Ketua Komite Medik 5. Direktur menerbitkan surat penugasan klinis	100%	Terpenuhi	Dokter yang melakukan proses kredensial tahun 2024 : 1. drg. Ajeng Poerborani Dityaningtyas, Sp.KGA - Mei 2024 2. dr. Sheila Dyah Prasetyo - Mei 2024 3. dr. Yeni Octavia - Agustus 2024 4. dr. Naufal Farid Dwi Rendragraha - Agustus 2024 5. dr. Robby, Sp.An-TI - September 2024 6. dr. Ardityo Rahmat Ardhany,	

		jika RKK sudah ditandatangani oleh sub kredensial dan ketua komdik			Sp.PD-KGH - Oktober 2024 7. dr. Virginia Ainurridlo Nugroho, Sp.KFR - November 2024 8. dr. Isrotul Anisa - Desember 2024	
4	Proporsi	Kebijakan PT terkait tarif proporsi dilakukan per September 2023	100%	Sudah berjalan 100%	1. Rapat dan diskusi dilakukan oleh PT untuk kedua RS, RPHM dan RSPHS 2. Tarif proporsi dikenakan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap 3. Jika ada pasien yang melebihi plafon inacbg's maka DPJP akan dikenakan tarif proporsi, sedangkan jika DPJP melakukan perawatan pada pasien dibawah inacbgs, makan akan surplus 4. Karena banyak DPJP yang tidak puas dengan adanya tarif proporsi, diadakan rapat diskusi baik offline door to door maupun zoom yang dilakukan untuk menjembatani agar kebijakan proporsi dapat diterima dengan bijak 5. Perubahan tarif obat, tindakan maupun ruangan di review ulang oleh PT 6. Diharapkan DPJP dapat bekerjasama dan koordinasi terkait kendala dan solusi dari kebijakan proporsi, agar kebijakan tersebut tetap safety di dpjp maupun pasien	

3.14 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kesehatan Lain

No	Kegiatan Pokok	Pemenuhan rencana kegiatan
1	Kebutuhan SDM	Perubahan pembentukan komite tenaga kesehatan lain.
2	Orientasi	Tidak ada karyawan baru yang perlu diorientasi.
3	Pendidikan dan Pelatihan	- Update ilmu dilakukan dengan mengikuti daring seminar. - Sosialisasi dilakukan oleh SDM kepada seluruh anggota komite nakes lain
4	Kredensialing	Kegiatan diikuti oleh seluruh tim komite dan unit (kredensial nakes lain dilakukan setiap 3 tahun sekali/jika ada penambahan atau perubahan kompetensi)

Analisis:

- 1. Ruang lingkup komite nakes lain meliputi kebutuhan SDM, orientasi, pendidikan dan pelatihan beberapa berjalan sesuai target pada tahun 2024.
- 2. Sosialisasi oleh SDM tetap dilakukan oleh para anggota komite nakes lain di unit.
- 3. Telah dilakukan kredensialing oleh komite tenaga kesehatan lain pada karyawan lama.

Perubahan Pembentukan Komite Tenaga Kesehatan Lain



Analisis :

- Tidak ada perubahan struktur komite.
- Struktur komite juga diharapkan komite KTKL lebih aktif dibanding dengan sebelumnya.

BAB IV
KINERJA KEUANGAN

4.1 Pendaptan Tahun 2024 (Tarif RS)
4.1.1 Tabel Pendapatan Tahun 2024 (Tarif RS)

No	Jaminan	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024	APRIL 2024	MAY 2024	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTIMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	YTD 2024
1	Umum	675.252.400	601.132.641	796.711.044	651.768.029	875.195.652	787.407.684	960.323.585	950.059.428	697.975.329	710.628.285	716.414.315	961.275.516	9.388.444.307
2	BPJS Kes	8.017.884.809	8.042.049.635	8.215.376.080	7.906.058.332	8.717.005.360	7.926.490.601	7.995.665.169	7.547.774.708	7.914.588.980	8.138.300.408	8.066.886.654	8.002.466.652	96.490.489.329
	Obat kronis	526.543.739	509.960.649	475.687.757	482.893.426	499.716.708	492.645.221	516.207.012	502.008.195	498.080.417	543.684.139	504.141.291	500.481.307	6.050.049.861
	Lupis(Ambulance)	7.810.000	6.923.750	6.557.500	4.350.000	6.823.750	6.945.000	9.136.250	7.910.000	6.411.250	6.222.500	9.738.750	4.710.000	85.538.750
	Lupis(Alkes)	12.485.000	3.795.000	3.678.750	3.630.000	3.464.953	8.470.000	6.784.861	6.160.000	8.907.211	8.690.000	5.775.000	3.465.000	75.283.815
3	BPJS TK	455.734.749	377.592.616	539.157.699	643.955.887	454.736.552	505.124.335	513.841.299	599.648.325	617.037.266	565.965.394	749.270.304	543.078.789	6.565.543.408
4	Jasa Raharja	107.447.815	152.615.193	237.339.659	242.106.626	70.977.005	329.483.902	82.661.384	238.087.616	134.252.968	194.439.771	68.059.969	146.825.332	2.004.297.238
5	Kemenkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Asuransi Swasta	212.264.905	178.335.021	216.265.088	134.652.348	232.842.338	230.637.919	240.331.495	233.036.486	174.348.092	239.247.730	178.911.645	172.048.904	2.442.922.972
7	Perusahaan	25.430.335	67.202.145	44.086.093	56.538.692	48.555.566	28.478.220	30.531.766	14.255.327	111.998.614	115.547.031	21.616.685	48.004.613	612.245.089
	Penunjang Perusahaan	8.888.250	88.552.600	10.450.300	13.526.246	9.063.339	15.059.550	8.873.300	6.528.450	21.104.400	4.662.750	8.919.350	12.148.250	207.776.985
	Total	10.050.042.003	10.030.559.850	10.547.387.963	10.139.479.587	10.918.382.403	10.330.742.431	10.364.336.121	10.105.468.536	10.182.704.527	10.527.388.008	10.331.735.963	10.394.444.362	123.922.591.754
1	Obat-obatan	-	-	-	-	6.558.303	-	-	-	48.857.014	-	-	68.235.306	123.650.623
2	Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Radiologi Umum	2.661.000	5.557.000	3.926.500	4.885.000	13.032.500	3.913.000	9.021.500	6.742.000	10.489.000	5.849.000	7.100.000	9.185.000	82.361.500
4	IKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MCU	129.600.500	5.426.000	14.821.500	864.000	-	10.390.000	79.544.000	-	144.000	4.214.000	31.412.000	43.901.500	320.717.500
6	Ambulance	-	1.562.100	450.000	1.400.000	975.000	225.000	225.000	300.000	813.700	635.550	1.760.704	622.500	9.169.554
7	Home Care	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.500	-	-	257.500
8	Parkir	84.381.000	84.843.000	89.701.000	89.755.000	100.274.000	89.209.000	92.262.000	90.271.000	87.197.000	88.478.500	87.823.000	89.858.000	1.074.052.500
9	Pelayanan	2.240.500	80.500	300.000	177.250	2.680.000	1.667.850	875.000	300.000	-	300.000	300.000	-	9.121.200
10	Primantara	-	1.056.700	3.125.060	4.577.900	7.548.000	7.302.200	8.559.100	10.562.500	11.262.400	11.001.900	11.895.600	10.116.000	87.028.960
11	ATM	-	26.999.999	-	3.956.050	853.794	854.721	825.266	935.859	47.251.480	1.971.383	2.317.427	2.172.378	98.138.257
12	Lain-Lain	254.800	431.100	238.400	259.250	382.850	333.450	669.900	383.450	1.249.100	1.242.900	233.850	312.012	6.181.162
	Total	219.137.800	136.146.399	112.562.460	105.874.250	132.524.447	113.895.221	192.381.766	109.494.809	207.263.694	114.156.733	142.842.581	223.464.696	1.810.678.856
	Grand Total	10.269.179.803	10.166.706.249	10.659.950.423	10.245.353.837	11.050.906.850	10.444.637.652	10.556.737.887	10.214.963.345	10.389.968.221	10.641.538.741	10.474.578.544	10.618.949.058	125.733.270.610

Analisa :
Pada tahun 2024, pendapatan perbulan cenderung stabil pada angka yang hampir sama yaitu rata-rata Rp. 10.477.772.550. Grafik omzet lebih stabil dan cenderung mendatar. Stabilitas ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah menemukan pola operasional yang lebih konsisten baik dari segi sistem maupun pengelolaan SDM. Hal ini yang seringkali diinginkan dalam jangka panjang karena akan memudahkan perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan pengendalian biaya. Pendapatan yang konsisten dan dapat diprediksi membantu dalam perencanaan strategis, alokasi anggaran, dan pengembangan bisnis yang lebih terarah.

Rencana Tindak Lanjut :
Mempertahankan kinerja operasional dengan tetap monitoring dan evaluasi

CARA BAYAR	PENDAPATAN	PROPORSI
Umum	9.388.444.307	7%
BPJS Kes	96.490.489.329	77%
BPJS Obat Kronis	6.050.049.861	5%
BPJS Lupis	160.822.565	0%
BPJS TK	6.565.543.408	5%
Jasa Raharja	2.004.297.238	2%
Kemenkes	-	0%
Asuransi Swasta	2.442.922.972	2%
Perusahaan	820.022.074	1%
Radiologi Umum	82.361.500	0%
MCU	320.717.500	0%
Ambulance	9.169.554	0%
Parkir	1.074.052.500	1%
PRIMANTARA	87.028.960	0%
Lain - Lain	237.348.842	0%
TOTAL	125.733.270.610	100%

Analisa :
77% pendapatan bersumber dari BPJS Kesehatan dan 7 % Umum.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitroing dan evaluasi

4.2 Biaya Tahun 2024
Data disampaikan oleh PT. Disa Prima Medika

4.3 Rasio Keuangan
Data disampaikan oleh PT. Disa Prima Medika

4.4 Kinerja Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG							
									a	b	(a-b-c= d)	e	f		(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI
PERIODE DESEMBER 2024 :																					
1	Asuransi	222.051.899	135.922.907	83.659.535	142.783.969	21.932.274	119.944.933	203.604.469	177.641.309	709.648	21.900.904	1.814.426	1.738.181		203.604.469						
2	Perusahaan	210.885.044	112.293.086	98.198.417	184.440.547	15.350.000	169.090.547	267.288.964	191.709.391	15.748.222	34.155.194	2.063.692	23.812.465		267.288.964						
3	Mandiri Inhealth	103.587.639	45.968.985	56.648.234	26.958.918	-	26.958.918	83.607.153	83.235.113	-	-	-	372.039		83.607.153						
4	Jasa Raharja	106.777.477	106.797.126	920.917	119.996.273	-	119.996.273	120.917.190	119.996.273	920.917	-	-	-		120.917.190						
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.442.773.264	1.239.847.050	202.926.667	542.812.928	-	542.812.928	745.739.595	741.531.234	-	497.635	513.240	3.197.502		745.739.611						
															1.421.157.387						

- Keterangan :
- Cut Off Piutang per 31 Desember 2024 Rp 1.421.157.387,-
 - Piutang Asuransi dan Perusahaan sudah bersurat :
 - c. Mandiri Inhealth rencana pembayaran Januari 2025
 - d. PT Karya Bina Sentausa rencana pelunasan Januari 2025

4.4.1 Tabel Daftar Pembayaran Piutang Asuransi Non BPJS Desember 2024

Asuransi	157.855.181
Perusahaan	127.643.086
Mandiri Inhealth	45.968.985
Jasa Raharja	106.797.126
BPJS Ketenagakerjaan	1.238.236.300
Total Penerimaan	1.676.500.678

NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND	NILAI PENDING
1	JULI 24	RJ	12.689	12.689	2	-	0,0%	0
		RI	1.002	993	-	9	1%	69.125.600
2	AGT 24	RJ	12.175	12.169	7	6	0%	3.472.200
		RI	950	942	-	8	1%	46.355.500
3	SEPT 24	RJ	11.573	11.447		126	1%	36.302.300
		RI	1.011	922		89	9%	46.089.600
4	OKT 24	RJ	11.710	11.379	3	331	3%	76.986.800
		RI	997	929		68	7%	276.904.000
5	NOV 24	RJ	11.855	11.214	3	641	5%	152.539.100
		RI	1.030	925		105	10%	376.338.700
								1.084.113.800

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814		-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779		-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702		-
	FPK PEND REGULER FEBRUARI	373.212.100	10.06.2024	19.06.2024	373.212.100		-
	FPK PEND II FEB 2024	58.112.500	09.07.2024	17.07.2024	58.112.500		-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
	FPK AMBULANCE MARET 24	5.280.000	14.06.2024	10.06.2024	5.280.000		-
	FPK ALKES MARET 24	3.465.000	14.06.2024	10.06.2024	3.465.000		-
	FPK OR MARET 24	471.764.386	15.07.2024	22.07.2024	471.764.386		-
	FPK PEND MARET 2024	383.291.100	09.07.2024	17.07.2024	309.918.000	73.373.100	-
	FPK PEND MARET 2 2024	90.791.600	20.08.2024	29.08.2024	90.791.600		-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500	-
	FPK OBAT KRONIS APRIL 2024	477.096.910	26.07.2024	05.08.2024	477.096.910		-
	FPK AMBULANCE APRIL 24	3.270.000	14.06.2024	10.06.2024	3.270.000		-
	FPK ALKES APRIL 24	3.630.000	14.06.2024	10.06.2024	3.630.000		-
	FPK Pending April 2024	289.580.800	07.08.2024	19.08.2024	289.580.800		-
	FPK Pending II April 2024	125.899.300	10.09.2024	18.09.2024	125.899.300		-
	FPK Pending III April 2024	4.353.500	10.10.2024	21.10.2024	4.353.500		-
	FPK Obat Pend April 2024	5.989.571	06.09.2024	17.09.2024	5.989.571		-
5	FPK MEI 2024	7.537.333.400	23.06.2024	01.07.2024	7.493.109.800	44.223.600	-
	FPK OBAT KRONIS MEI 2024	487.109.484	26.07.2024	12.08.2024	487.109.484		-
	FPK Alkes Mei 2024	3.465.000	24.07.2024	07.08.2024	3.465.000		-
	FPK Ambulance Mei 2024	5.145.000	24.07.2024	07.08.2024	5.145.000		-
	FPK Obat Pend Mei 2024	10.593.498	06.09.2024	17.09.2024	10.593.498		-
	FPK PEND MEI 2024	334.480.400	23.09.2024	30.09.2024	296.561.200	37.919.200	-
	FPK PEND II MEI 2024	67.517.700	05.11.2024	13.11.2024	67.517.700		-
6	FPK JUNI 2024	6.959.035.980	24.07.2024	31.07.2024	6.868.943.180	90.092.800	-
	FPK Alkes Juni 2024	8.470.000	24.07.2024	07.08.2024	8.470.000		-
	FPK Ambulance Juni 2024	6.945.000	24.07.2024	07.08.2024	6.945.000		-
	FPK Obat Kronis Juni 2024	468.625.741	15.09.2024	23.09.2024	468.625.741		-
	FPK Pending I Juni 2024	406.675.400	15.11.2024	25.11.2024	406.675.400		-
	FPK Pending Obat Kronis Juni 2024	10.909.672	15.11.2024	25.11.2024	9.479.776	1.429.896	-
	FPK Pending II Juni 2024	95.247.300	12.12.2024	23.12.2024	95.247.300		-
7	FPK JULI 2024	7.160.148.298	20.08.2024	29.08.2024	7.122.971.498	37.176.800	-
	FPK Alkes Juli 2024	6.655.000	25.09.2024	09.10.2024	6.655.000		-
	FPK Ambulance Juli 2024	8.085.000	25.09.2024	09.10.2024	8.085.000		-
	FPK Obat Kronis Juli 2024	498.756.047	24.10.2024	04.11.2024	490.002.657	8.753.390	-
	FPK Pending Juli 2024	291.190.700	12.12.2024	24.12.2024	291.190.700		-
8	FPK Reguler Agustus 2024	6.671.460.900	25.09.2024	02.10.2024	6.662.482.200	8.978.700	-
	FPK Alkes Agustus 2024	6.160.000	25.09.2024	09.10.2024	6.160.000		-
	FPK Ambulance Agustus 2024	6.510.000	25.09.2024	09.10.2024	6.510.000		-
	FPK OR Agustus 2024	486.971.257	04.12.2024	16.12.2024	486.971.257		-
	FPK Pending Agustus 2024	315.773.900	12.12.2024	20.12.2024	315.773.900		-
9	FPK Reguler Ri September 2024	4.225.116.643	22.10.2024	28.10.2024	4.219.384.343	5.732.300	-
	FPK Reguler RJ September 2024	2.700.053.100	31.10.2024	13.11.2024	2.692.209.100	7.844.000	-
	FPK Ambulance September 2024	4.500.000	04.12.2024	27.12.2024	4.500.000		-
	FPK Alkes September 2024	8.855.000	04.12.2024	27.12.2024	8.855.000		-
10	FPK Reguler Oktober 2024	7.115.971.438	21.11.2024	28.11.2024	7.115.971.438		-
	FPK Ambulance Oktober 2024	4.575.000	04.12.2024	27.12.2024	4.575.000		-
	FPK Alkes Oktober 2024	8.690.000	04.12.2024	27.12.2024	8.690.000		-
11	FPK Reguler November 2024	6.816.237.444	23.12.2024	30.12.2024	6.816.237.444		-
	FPK Ambulance November 2024	8.415.000	24.12.2024				8.415.000
	FPK ALKES November 2024	5.775.000	24.12.2024				5.775.000
12	Belum FPK Desember 2024 (Pengajuan)	7.340.311.100					7.340.311.100
		101.119.895.534			93.364.837.648	400.556.786	7.354.501.100

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Rumah Sakit Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sarana dan prasarana maupun dari sisi Sumber Daya Manusia supaya pelayanan Kesehatan di RS Prima Husada Malang lebih baik lagi. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya perubahan regulasi di bidang Kesehatan, masih terdapat beberapa kendala baik dari kelompok tenaga Kesehatan dan juga kelompok non tenaga Kesehatan terutama dari segi administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara penempatan SDM di Rumah Sakit masih terdapat penempatan karyawan yang belum sesuai dengan kompetensi dan sertifikasinya, sehingga terjadi beberapa rotasi dan mutasi di lingkup RS Prima Husada Malang. Situasi proporsi jumlah antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap di Rumah Sakit, Dimana jumlah karyawan kontrak/tidak tetap yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah karyawan tetap di RS Prima Husada Malang, hal ini diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Struktur Organisasi dan TataKelola Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah terpenuhi untuk unsur jajaran Direksi sampai dengan bulan Desember, Dimana secara SOTK Rumah Sakit jajaran Direksi terdiri dari Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Disamping beberapa jabatan non Struktural di Rumah Sakit seperti Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite etik, Komite mutu dan beberapa Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Kinerja RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan di tahun sebelumnya meskipun dalam penilaian indikator Mutu Rumah Sakit ada beberapa indikator yang belum tercapai, salah satu diantaranya adalah kepatuhan DPJP dalam visite pasien dan kepatuhan dalam Clinical pathway. Hal ini juga mempengaruhi kualitas mutu layanan di Rumah Sakit. Untuk jumlah kunjungan di Rumah Sakit Prima Husada Malang masih didominasi oleh pasien JKN selama tahun 2024.

5.2 SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Rumah Sakit
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite dan Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway untuk meningkatkan mutu layanan di Rumah Sakit
5. Memperbaiki proses recruitment staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit
6. Meningkatkan skills dan pengetahuan SDM dengan giat mengikuti mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
7. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke Rumah Sakit Prima Husada Malang
8. Menjalin lebih banyak Kerjasama dengan stakeholder dari luar Rumah Sakit Prima Husada Malang

BAB VI

PENUTUP

Laporan kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang merupakan laporan tertulis atas penyelenggaraan rumah sakit yang baik, ini menggambarkan kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran dan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya laporan kinerja Rumah Sakit Prima Husada ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja RS Prima Husada kepada pihak-pihak terkait dan pemilik maupun representasi pemilik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam pelayanan rumah sakit

Malang, 22 Januari 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

RBA RS PRIMA HUSADA TAHUN 2025

1. Rincian Kegiatan Program Unit Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN		RINCIAN ANGGARAN		TOTAL ANGGARAN
			PROFESI	JUMLAH	KEBUTUHAN	NOMINAL	
1	Diklat Internal	Penyiapan Obat IV dan Teknik Aseptik	Perawat	170	Fee Pemateri (staf)	Rp0	
			Bidan	30	Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	
			Apoteker	20	Konsumsi air mineral	Rp1.000	
			TTK	30			
			Total Peserta	250	Total Anggaran		
		PPRA	Perawat	170	Fee Pemateri (staf)	Rp0	
			Bidan	30	Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	
			Apoteker	20	Konsumsi air mineral	Rp1.000	
			TTK	30			
			Total Peserta	250	Total Anggaran		
		Pelatihan Pemberian Sedasi	Perawat	170	Fee Pemateri (staf)	Rp0	
			Bidan	30	Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	
						Konsumsi air mineral	
			Total Peserta	200	Total Anggaran		
		Pelatihan Koding	Rekam Medis	13	Fee Pemateri (staf)	Rp0	
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	

			Total Peserta	13	Total Anggaran		Rp13.000
Pelatihan E-RM			PPA		Fee Pemateri (staf)	Rp0	
			Perawat	170	Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	
			Bidan	30	Konsumsi air mineral	Rp1.000	
			Apoteker	20			
			TTK	30			
			Ahli Gizi	10			
			Total Peserta	260	Total Anggaran		Rp260.000
Pelatihan Down Time			IT	4	Fee Pemateri (staf)	Rp0	
			Perawat	170	Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	
			Bidan	30	Konsumsi air mineral	Rp1.000	
			Apoteker	20			
			TTK	30			
			Ahli Gizi	10			
			Total Peserta	264	Total Anggaran		Rp264.000
Pelatihan Hygine dan Sanitasi Pangan		Gizi dan Dapur	20	Fee Pemateri (staf)	Rp0		
				Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0		
				Konsumsi air mineral	Rp1.000		
		Total Peserta	20	Total Anggaran		Rp20.000	
Pelatihan K3RS MFK			Seluruh Staf	450	Fee Pemateri (staf)	Rp0	

					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	
			Total Peserta	450	Total Anggaran		Rp450.000
2	Diklat Eksternal	PPGDON	Bidan	2	Biaya diklat eksternal	Rp3.500.000	Rp7.000.000
		BTCLS	Perawat		Biaya oleh peserta	Rp2.500.000	
		ACLS	Dokter		Biaya oleh peserta	Rp4.000.000	
		ESQ	Staf baru		Biaya oleh peserta	Rp700.000	
		ICU Dasar	Perawat ICU	3	Biaya diklat eksternal	Rp15.000.000	Rp45.000.000
		Manajemen Bangsal	Kepala Ruang	3	Biaya diklat eksternal	Rp4.000.000	Rp12.000.000
		NICU	Perawat NICU	1	Biaya diklat eksternal	Rp15.000.000	Rp15.000.000
		PICU	Perawat PICU	1	Biaya diklat eksternal	Rp15.000.000	Rp15.000.000
		Instrumen	Perawat	3	Biaya diklat eksternal	Rp5.000.000	Rp15.000.000
		Teknik Kelistrikan RS	Staf IPSRS	1	Biaya diklat eksternal	Rp5.000.000	Rp5.000.000
		Teknik Bangunan RS	Staf IPSRS	1	Biaya diklat eksternal	Rp3.500.000	Rp3.500.000
		Teknik Tata Kelola Udara RS	Staf IPSRS	1	Biaya diklat eksternal	Rp3.500.000	Rp3.500.000
		Pelatihan Pengelolaan IPAL dan B3	Staf IPSRS	1	Biaya diklat eksternal	Rp3.500.000	Rp3.500.000
		Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Staf IPSRS	1	Biaya diklat eksternal	Rp3.500.000	Rp3.500.000
		Perceptorship	Kepala Ruang	3	Biaya diklat eksternal	Rp1.750.000	Rp5.250.000
			MOD	1	Biaya diklat eksternal	Rp1.750.000	Rp1.750.000
		APN	Bidan	2	Biaya oleh peserta		Rp0

		CTU	Bidan	4	Biaya oleh peserta		Rp0
		MU	Bidan	3	Biaya oleh peserta		Rp0
		CWCC	Perawat Asisten Poli Bedah	1	Biaya oleh peserta		Rp0
		Pelatihan Dispensing	Apoteker	1	Biaya oleh peserta		Rp0
		Resusitasi Neonatus	Perawat	2	Biaya diklat eksternal	Rp4.000.000	Rp8.000.000
		Perawatan Bayi BBLR	Perawat	2	Biaya diklat eksternal	Rp4.000.000	Rp8.000.000
		Instrumen Kamar Bedah	Perawat IKO	1	Biaya diklat eksternal	Rp15.000.000	Rp15.000.000
		MPP	Perawat	1	Biaya diklat eksternal	Rp4.000.000	Rp4.000.000
3	K3RS Staf	Pemeriksaan Kesehatan Staf Baru	Staf baru		Biaya oleh peserta		Rp0
		Pemeriksaan Kesehatan Berkala	Seluruh Staf	450	Biaya oleh perusahaan	Rp150.000	Rp67.500.000
		Pemeriksaan Dokter Umum			Thorax		
		Pemeriksaan Lanjutan			HBSAg		
		Pemeriksaan Anti HIV		450	Biaya oleh perusahaan	Rp266.200	Rp119.790.000
		Pemeriksaan Rectal Swab (2 x setahun)	Petugas Dapur	20	Biaya oleh perusahaan	Rp290.400	Rp5.808.000
4	Asuransi Center	Pelatihan optimalisasi koding serta analisis pencegahan dan deteksi dini Fraud pada ERA JKN	2 koder Rawat Jalan + Rawat Inap	2	Biaya diklat eksternal	Rp5.000.000	Rp10.000.000
		Review updating koding serta ERM	Unit Asuransi Center dan Rekam Medis	21	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral + Snack	Rp4.000	Rp84.000
5	Komite PPI	PPI Dasar	Seluruh Staf	450	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0

					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp450.000
		IPCN Advance					Rp0
		IPCD					Rp0
							Rp0
6	Komite Etik	Etik					
7	Komite K3RS	Pelatihan K3RS	Seluruh staf	450	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp450.000
		MCU Staf dan Rectal Swab	Seluruh staf	450	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp450.000
		K3RS	Security	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp2.000.000	Rp2.000.000
8	ICU/HCU	Kriteria Keluar Masuk ICU	Perawat ICU	10	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp10.000
			Perawat HCU	4	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp4.000
9	IKO	Instrumen Kamar Operasi	Perawat IKO	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp15.000.000	Rp15.000.000
		Manajemen Kamar Bedah		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp5.000.000	Rp5.000.000
10	CSSD	CSSD Lanjutan	Staf CSSD	8	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp8.000

		Sterilisasi	Staf CSSD	8	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp8.000
11	Laundry	Manajemen Laundry	Staf Laundry	5	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp5.000
12	Laboratorium	Pelatihan Analis Laboratorium	Staf Laboratorium	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp8.000.000	Rp8.000.000
		Pelatihan Phlebotomy		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp5.000.000	Rp5.000.000
		Pelatihan BDRS		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp3.000.000	Rp3.000.000
13	Radiologi	Pelatihan Proteksi Radiasi	Staf Radiologi	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp9.000.000	Rp9.000.000
		Pelatihan CT Scan Angiografi Full Body		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp10.000.000	Rp10.000.000
14	Rekam Medis	Pelatihan Terminologi Medis Dasar, Pengenalan ICD 10, ICD 9 CM		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp5.000.000	Rp5.000.000
		Pelatihan Pengelolaan Sistem Rekam Medis		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp7.000.000	Rp7.000.000
		Pelatihan Penyusutan dan Pemusnahan Rekam Medis		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp4.000.000	Rp4.000.000
		Pelatihan Design Formulir Rekam Medis		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp6.000.000	Rp6.000.000
		Pelatihan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rekam Medis		1	Biaya Diklat Eksternal	Rp4.500.000	Rp4.500.000
15	SDM	Manajemen Stres	Seluruh staf	450	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp450.000
		Leadership	Kabid, Karu, PJ, Komite	35	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0

					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp35.000
		Character Bulding	Seluruh staf	450	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp450.000
16	Keperawatan	ACLS	Perawat		Biaya oleh peserta		Rp0
		BTCLS	Perawat		Biaya oleh peserta		Rp0
		PPGD	Bidan		Biaya oleh peserta		Rp0
		PPGDON	2 Bidan Maternitas (Fifi ,Aneta)	2	Biaya Diklat Eksternal	Rp6.000.000	Rp12.000.000
		CWCCA	2 Perawat Poli (Betdi, Yuni)	2	Biaya Diklat Eksternal	Rp4.500.000	Rp9.000.000
		MU	3 (2 Bidan poli dan 1 Maternitas)	3	Biaya Diklat Eksternal	Rp1.500.000	Rp4.500.000
		CTU	4 Bidan (Ara, Wahyu,Dita,Deya)	4	Biaya Diklat Eksternal	Rp5.000.000	Rp20.000.000
		APN	2 Bidan (Rida, Deya)	2	Biaya Diklat Eksternal	Rp7.000.000	Rp14.000.000
		MPP	Perawat	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp5.000.000	Rp5.000.000
		Pelatihan ICU dasar	1 .Perawat ICU (Agus Widodo)	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp5.000.000	Rp5.000.000
		Pelatihan Picu	1 Perawat (IKA)	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp6.000.000	Rp6.000.000
		Perawat Nicu	1 Perawat Nicu	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp6.000.000	Rp6.000.000
		Asuhan Pasien:	Perawat, Bidan	150	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
		Pemasangan infus			Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
		Pemasangan kateter			Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp150.000

		NGT					
		OGT					
		Restrain					
		Hecting					
		Rawat Luka					
		Sasaran Keselamatan Pasien	Seluruh staf dan MS	500	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
		Pelatihan Phaco	1 Perawat (Andra-IRJA)	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp30.000.000	Rp30.000.000
		Triage	PPA	250	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
		Transfer & Rujukan			Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
		PPK CP			Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp250.000
		Manajemen Risiko Tinggi					Rp0
		EWS	Perawat, Bidan, Dokter Umum	160	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp160.000
		BHD Advance	Perawat Tim Code Blue	20	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp20.000
		Manajemen Nyeri		160	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0

		Asuhan Pasien Menjelang Akhir Kehidupan	Perawat, Bidan, Dokter Umum		Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
		Injeksi Anestesi & Sedasi			Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp160.000
		Komunikasi Efektif untuk PPS					Rp0
		Pengisian Dokumen Rekam Medis	Perawat, Bidan, Dokter Umum	160	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp160.000
							Rp0
17	Seluruh Unit	PPI Dasar	Seluruh staf dan MS	500	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
		PMKP Dasar	Seluruh staf dan MS	500	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
		Komunikasi Efektif	Seluruh staf dan MS	500	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
		MFK	Seluruh staf dan MS	500	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
		BHD Advance	Seluruh staf dan MS	500	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0

					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
					Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
		SKP	Seluruh staf dan MS	500	Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
					Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
		Hak Pasien Keluarga	Seluruh staf dan MS	500	Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp500.000
					Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
18	Farmasi	Medication Error	Perawat, Bidan, Apoteker, TTK, Dokter Umum, dan MS	260	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp260.000
		Penyiapan Obat IV dan Teknik Aseptik	Perawat, Bidan, Apoteker, TTK, Dokter Umum	210	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp210.000
		PPRA	Perawat, Bidan, Apoteker, TTK, Dokter Umum	210	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp210.000
19	Laboratorium	Phlebotomy	Analisis Kesehatan	1	Biaya diklat eksternal	Rp5.000.000	Rp5.000.000
		Penanganan Sample dan POCT		1	Biaya diklat eksternal	Rp3.000.000	
		Pelatihan BDRS	Analisis Kesehatan	1	Biaya diklat eksternal	Rp5.500.000	Rp5.500.000
20		PONEK Maternal	Bidan	30	Fee Pemateri	Rp300.000	Rp300.000

	Program Nasional				Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral dan snack peserta	Rp4.000	Rp120.000
					Konsumsi pemateri	Rp30.000	Rp30.000
		PONEK Neonatal	Bidan	30	Fee Pemateri	Rp300.000	Rp300.000
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral dan snack peserta	Rp4.000	Rp120.000
					Konsumsi pemateri	Rp30.000	Rp30.000
		HIV	PPA	250	Fee Pemateri	Rp300.000	Rp300.000
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral dan snack peserta	Rp4.000	Rp1.000.000
					Konsumsi pemateri	Rp30.000	Rp30.000
		TBC	PPA	250	Fee Pemateri	Rp300.000	Rp300.000
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral dan snack peserta	Rp4.000	Rp1.000.000
					Konsumsi pemateri	Rp30.000	Rp30.000
		Stunting	PPA	250	Fee Pemateri	Rp300.000	Rp300.000
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral dan snack peserta	Rp4.000	Rp1.000.000
					Konsumsi pemateri	Rp30.000	Rp30.000

		KB	PPA	250	Fee Pemateri	Rp300.000	Rp300.000
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral dan snack peserta	Rp4.000	Rp1.000.000
					Konsumsi pemateri	Rp30.000	Rp30.000
21	Neonatologi	Resusitasi Neonatus	Bidan	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp4.000.000	Rp0
		Perawatan Bayi BBLR	Bidan	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp7.000.000	Rp0
22	Gizi	Hygine dan Sanitasi Pangan	Ahli Gizi	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp1.000.000	Rp0
23	Komite Medik	ATLS	1 dokter IGD		Biaya oleh peserta		Rp0
		ACLS	1 dokter IGD		Biaya oleh peserta		Rp0
		Pelatihan EKG	1 dokter IGD		Biaya oleh peserta		Rp0
24	Komite Keperawatan	Pelatihan Komite Keperawatan	Perawat	2	Biaya Diklat Eksternal	Rp3.500.000	Rp7.000.000
		Assesor Kompetensi Perawat	Perawat	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp6.000.000	Rp6.000.000
25	Humas Marketing	Marketing Managemen	Marketing	1	Biaya Diklat Eksternal	Rp6.000.000	Rp6.000.000
26	Asuransi Center	Pelatihan optimalisasi koding serta analisis pencegahan dan deteksi dini Fraud pada ERA JKN	Koder	2	Biaya Diklat Eksternal	Rp6.000.000	Rp12.000.000
		Review updating koding serta ERM	Unit Asuransi Center dan Rekam Medis	25	Fee Pemateri (staf)	Rp0	Rp0
					Sertifikat Peserta (soft file)	Rp0	Rp0
					Konsumsi air mineral	Rp1.000	Rp25.000
TOTAL RBA							Rp 625.534.000

Mengetahui
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Verifikator
Kepala Bidang Umum dan Keuangan



drg. Endy Wira Pradana, M.MRS

Pelaksana Program
Kepala Ruang SDM

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi